患者与家属的循证治疗科普

焦虑症治疗

从惊恐发作到社交焦虑，再到治疗、复发与危机管理

13 个模块 · 64 篇 · V1.0 / 2026-10

本资料库仅用于科普学习，不能替代精神科医生面诊、诊断与处方。

出现自杀念头、意识障碍、严重过敏、胸痛晕厥等情况，请立即拨打 120 或前往急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

使用边界与安全声明

这是一本写给患者和家属的治疗科普书。它把焦虑症治疗拆成 13 个模块，覆盖从初诊、选药、心理治疗、物理治疗，到疗程、停药、复发和危机应对的完整路径。

它不能替代面诊、诊断和处方。所有具体用药、剂量、减量、住院与特殊人群决策，都必须由具备资质的精神科医生结合个体情况作出。

请先记住三件事

- SSRI/SNRI 这类一线药物通常需要 2–4 周甚至更久才逐步起效，早期出现的是副作用，不一定是疗效。
- 不要自行突然停药、减量、换药或叠加药物；停药需要在医生指导下缓慢进行。
- 出现自杀念头、自伤行为、意识障碍、高热、严重过敏、胸痛、晕厥、抽搐，立即拨打 120 或去急诊。

版本与引用

版本 V1.0，最后更新 2026-10。指南、药物适应证、医保政策与热线号码会变化；与面诊医生或最新指南不一致时，以医生和最新指南为准。引用请注明《焦虑症治疗资料库》V1.0，并附具体篇目。

书中案例均为合并、改写后的示意，不对应任何真实个人。

总目录

按模块顺序排列。每篇正文都可独立阅读；书末附 60 个术语与主要指南来源。

使用说明

00 使用说明与免责声明

模块 1：基础与总论

1.1 焦虑与焦虑障碍：正常反应还是疾病

1.2 焦虑障碍的分类与诊断框架

1.3 流行病学、病程与共病

1.4 常见名词与误区

模块 2：临床表现与评估

2.1 广泛性焦虑障碍 GAD

2.2 惊恐发作与惊恐障碍

2.3 广场恐惧与回避行为

2.4 社交焦虑障碍

2.5 特定恐惧、分离焦虑与选择性缄默

2.6 儿童青少年焦虑与躯体化表现

模块 3：病因与机制

3.1 遗传、气质与家族风险

3.2 神经生物学：杏仁核、HPA 轴与递质

3.3 学习、条件反射与回避的维持

3.4 认知模型：威胁评估与灾难化

3.5 环境、养育、创伤与生活压力

模块 4：就医与诊断

4.1 就诊渠道与就诊时机

4.2 初诊准备与症状时间线

4.3 医生如何诊断与评估

4.4 鉴别诊断：甲亢、心律失常、低血糖等

模块 5：心理治疗

5.1 心理治疗总览与证据

5.2 CBT 的认知重构与行为实验

5.3 暴露疗法：分级、重复与停止回避

5.4 惊恐障碍的 CBT 与内感受暴露

5.5 社交焦虑的 CBT 与注意力训练

5.6 GAD 的 CBT、正念与担忧管理

5.7 ACT、元认知治疗、心理动力与团体家庭治疗

模块 6：药物治疗

6.1 药物总览：什么情况用药、用什么、用多久

6.2 SSRI：一线选择与使用要点

6.3 SNRI：文拉法辛与度洛西汀

6.4 苯二氮䓬类：短期救火与依赖风险

6.5 丁螺环酮、坦度螺酮与普瑞巴林

6.6 β 受体阻滞剂、抗组胺药与曲唑酮

6.7 三环类、MAOI 与难治性焦虑

6.8 起效、疗程、副作用与危险反应

6.9 停药、撤药与用药问答

模块 7：物理与辅助治疗

7.1 呼吸训练与放松训练

7.2 生物反馈与心率变异性训练

7.3 运动处方

7.4 睡眠、咖啡因、酒精与尼古丁

7.5 营养补充、中医与物理治疗证据

模块 8：特殊人群

8.1 儿童青少年焦虑

8.2 老年焦虑

8.3 孕产期与哺乳期焦虑

8.4 躯体疾病、ASD 与 ADHD 共病

模块 9：共病

9.1 焦虑合并抑郁

9.2 焦虑合并双相

9.3 焦虑合并 PTSD 与 OCD

9.4 焦虑合并失眠、疼痛与物质使用

模块 10：风险管理

10.1 惊恐发作的现场应对
10.2 自杀风险与安全计划
10.3 苯二氮䓬依赖、戒断与酒精
10.4 血清素综合征、跌倒与驾驶风险

模块 11：疗程、复发与停药

11.1 为什么要足疗程
11.2 维持治疗与复发预防
11.3 停药计划与撤药管理

模块 12：危机、生活与权益

12.1 急诊指征与危机资源
12.2 费用、医保、病假与复工复学
12.3 隐私、权益与家庭支持

模块 13：误区、问答与工具

13.1 焦虑日记与惊恐记录
13.2 常用量表：GAD-7、PDSS、LSAS、SPIN
13.3 复诊沟通单
13.4 常见误区与高频问答

附录：术语与参考文献

A 术语表
B 参考文献与指南版本

使用说明

00 使用说明与免责声明

> 这是一套写给焦虑障碍患者和家属的治疗科普资料，共 13 个模块、64 篇。它想帮你把“焦虑”这件事看清楚：哪些是正常反应、哪些已经构成障碍、有哪些治疗选择、每个选择能做什么、风险在哪里、什么时候必须就医。它**不能替代面诊、诊断和处方**。

这套资料想解决什么问题

焦虑最容易被两句话耽误：一句是“你就是想太多”，一句是“忍忍就过去了”。前者把痛苦说成性格问题，后者把可治疗的问题拖成慢性问题。

这套资料想把焦虑拆成可以理解、可以讨论、可以执行的小块：

- **知道焦虑的边界**：正常紧张、焦虑症状、焦虑障碍不是一回事。
- **知道不同类型的差别**：广泛性焦虑、惊恐障碍、社交焦虑、特定恐惧、分离焦虑，治疗重点并不相同。
- **知道治疗的全貌**：心理治疗、药物、生活方式调整和危机应对各自站在什么位置。
- **知道怎么和医生合作**：初诊说什么、复诊看什么、哪些变化必须报告。
- **知道什么时候危险**：惊恐发作、自杀念头、苯二氮䓬戒断、酒精戒断、严重药物反应，分别怎么处理。
- **知道怎么预防复发**：症状好转后还要走多远，停药怎么停，早期信号怎么看。

它不是什麼

- 不是诊断工具。对照症状给自己或家人“确诊”，很容易把甲状腺问题、心律失常、低血糖、药物副作用当成焦虑障碍。
- 不是处方集。本资料刻意不写起始剂量、加量速度和减量方案，这些必须由医生结合诊断、年龄、体重、肝肾功能、合并用药和既往反应决定。
- 不是“深呼吸就能好”的安慰手册。呼吸训练、运动、睡眠有证据，但不能替代中重度焦虑障碍的规范治疗。
- 不是“焦虑都是心理问题”的证明。焦虑可以是躯体疾病、药物或物质引起的，先排除这些原因，是负责任的第一步。
- 不是法律或保险意见。病假、医保、伤残、隐私争议，以当地政策和经办机构答复为准。

三种读法

第一种：从头读。 适合刚被诊断、时间比较充裕的人。按模块 1 → 2 → 4 → 5 → 6 → 11 的顺序，先理解焦虑，再看评估、治疗和疗程。

第二种：带着问题查。 适合已经在治疗中的人。直接看总目录里“这一页解决什么”，找到对应篇目；每篇都能独立阅读。

第三种：只看最要紧的。 如果现在正被惊恐发作、失眠或强烈担忧困住，先读三页：

1. 10.1 惊恐发作的现场应对
2. 12.1 急诊指征与危机资源
3. 1.1 焦虑与焦虑障碍：正常反应还是疾病

五种内容标签

标签	含义	你该怎么用
【指南】	NICE、中国焦虑障碍防治指南等有明确推荐	可以作为和医生讨论的依据
【研究】	随机对照试验、系统综述支持，但未必进入所有指南	可以了解，别当成唯一答案
【临床经验】	临床常见做法，个体差异大，证据等级较低	参考，不要照搬
【待验证】	机制推测、小样本研究、争议观点	保持开放，别当结论
【个人体验】	康复者或家属的主观感受	共情用，不代表普遍规律

标签不是“真假”的判决，而是提醒你：**这条信息有多硬，适不适合拿来指导自己的治疗。**

安全声明（请先读）

焦虑本身通常不直接危及生命，但有些情况不能等：

- **首次出现、突发的剧烈胸痛、胸闷、气短、大汗、晕厥、心悸**：先按躯体急症处理，立即拨打 120 或去急诊，不要默认“只是焦虑”。
- **出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划**：不要独处，联系信任的人陪着，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- **苯二氮䓬类突然停药后出现抽搐、意识混乱、极度兴奋、高热**：立即急诊；不要自行硬戒。
- **长期大量饮酒后突然停酒，出现手抖、大汗、幻觉、抽搐**：立即急诊；酒精戒断可能危及生命。
- **服药后高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识改变、心跳很快**：可能是血清素综合征，立即急诊。
- **严重过敏（皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难）、晕厥、抽搐**：立即呼叫 120。

如果你不确定“算不算严重”，按严重处理。**宁可白跑一趟，不要赌。**

关于治疗：三句最重要的话

1. **焦虑障碍是一类可治疗的疾病，不是性格缺陷。** 心理治疗和药物都有证据，很多人能恢复到正常生活。
2. **治疗需要时间。** 心理治疗通常以周计，SSRI/SNRI 起效也常要几周；不要做几次、吃几天就下结论。
3. **苯二氮䓬类不是长期解决方案。** 它们能快速缓解，但长期使用有依赖、耐受、认知和跌倒风险，通常只短期、按需、在医生指导下使用。

关于心理治疗

心理治疗不是“聊聊天”。CBT、暴露疗法、行为实验、正念认知治疗都有证据。焦虑障碍的一线心理治疗通常需要结构、练习和暴露，不只是放松。它和药物不是二选一：中重度焦虑常常需要两者联合。具体怎么选，看 5.1 心理治疗总览与证据。

关于隐私与案例

文中出现的“小 A”“一位来访者”等，都是合并、改写后的示意案例，不对应任何真实个人。你自己的焦虑日记、用药记录属于敏感信息，分享给医生之外的人之前，先想清楚边界。

如何纠错与更新

- 本资料版本：V1.0，最后更新 2026-10。
- 指南会更新，药物适应证会变化，热线号码会调整。看到与医生说法不一致时，**以面诊医生的个体化判断和最新指南为准**，并把差异告诉医生。
- 如果发现事实错误、失效链接、表述可能误导，请在资料库维护记录里标注“待核”，不要直接照用。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 1：基础与总论

先分清正常焦虑、焦虑症状和焦虑障碍，理解分类与共病，再决定要不要就医、看什么科。

1.1 焦虑与焦虑障碍：正常反应还是疾病

很多人第一次走进精神科，是因为一次半夜的心跳加速，或者连续几个月停不下来的担心。坐下来以后，最常问的一句是：我这是正常紧张，还是已经病了？这一页把“焦虑”拆成三层——正常的警报、值得注意的症状、需要治疗的障碍——并给出可以对照的边界。

读完你能带走三件事：知道焦虑为什么存在；知道判断“病没病”主要看哪几个维度；知道什么情况下不该再忍，该去哪个科室。

焦虑本来是一套保命的警报

人脑对威胁的检测，比对手头事情的核对要快得多。夜里看到地上一截弯弯的东西，身体会先跳开，再回头确认那是不是一根绳子。这套“先反应、后核实”的机制由大脑里的杏仁核等结构负责，它通过交感神经和肾上腺素把身体调成两种状态：打，或者跑。心跳加快是为了给肌肉送血，呼吸变快是为了多拿氧气，出汗是为了散热，肌肉绷紧是为了随时发力。

这套反应在真遇到危险时救过命，所以它被保留下来，写在几乎每个人的身体里。焦虑不是这套系统“出了故障”，而是它在没有明确危险的时候也启动了，或者启动得比需要的更久、更响。

日常语言里，恐惧和焦虑常被混着用，但两者指向不同：恐惧通常对着眼前具体的东西，焦虑对着“还没发生、可能会发生”的事。焦虑需要一种能力——想象未来。你能为下个月的房租发愁，是因为你可以在脑子里预演下个月。所以焦虑不是性格缺陷，它是预测能力的副产品。

一定程度的焦虑还有用。考试前紧张，会让人多复习一遍；上台前心跳加快，注意力会更集中。心理学里常提到一条“倒 U 形”曲线：唤醒水平太低，人提不起劲；太高，手脚发僵；中间一段表现最好【待验证】。所以问题从来不是“有没有焦虑”，而是这套警报的音量、时长和触发范围，是否已经和现实里的危险对不上了。

三层：正常焦虑、焦虑症状、焦虑障碍

正常焦虑通常有几个特点：有明确对象，比如面试、体检、家人晚归；程度与现实大致成比例；事情过去以后能回落；难受，但不改变你原本要做的事。

焦虑症状是中间地带。身体和情绪上已经有焦虑的表现，但可能强度不够、时间不够，够不上诊断；也可能只有一部分症状，比如反复心慌却并不担心什么；还可能由别的原因引起，比如甲状腺功能异常、心律失常、低血糖、某些药物、咖啡因、酒精或戒断。

焦虑障碍是一组有明确诊断标准的疾病。它们的共同点是：焦虑持续到一定程度、当事人很难控制、造成明显痛苦或功能损害，并且不能被其他躯体疾病、物质或药物更好地解释【指南】。

需要强调：三层是连续的，不是两个物种。“还没到诊断标准”不等于没事，难受就是难受，也值得处理；“到了诊断标准”也不等于很严重，更不等于没救。

维度	正常焦虑	焦虑症状	焦虑障碍
有没有明确对象	通常有	可有可无	常泛化到多件事
与现实的匹配	大致成比例	略超前	明显超出
持续时间	事情结束就回落	数天到数周	数月以上
能否停下来	能，稍费力	有时能	很难
对生活的影响	轻微	开始影响	明显损害
回避行为	少	偶有	常见且不断扩大

判断边界，主要看四件事

第一件：时间。 诊断标准里有一些时间门槛，比如广泛性焦虑要求多数日子都存在担忧、持续半年以上；社交焦虑和特定恐惧通常也要求持续半年以上；惊恐障碍要求的是一次发作之后，持续一个月以上担心再发、或因此明显改变行为。分离焦虑在儿童约四周、成人约半年。

这些数字是“诊断门槛”，不是“熬够半年才配看病”。任何时候，只要它已经在影响你的生活，就可以去就诊，不必等到满足某一条标准。

第二件：强度与可控性。 可以用 0 到 10 分给自己的焦虑打分，再看两件事：能不能靠转移注意力停下来；担心里有多少是“万一”接“万一”的连锁推演，而不是眼前真有的问题。

第三件：功能损害。 这是诊断里最实在的一条，也是治疗效果的衡量标准。看工作或学习效率有没有下降、有没有请假、成绩有没有掉、聚会推掉多少、家务还能不能做、睡眠够不够、最近跑了多少次医院、和家人吵了多少架。

第四件：回避。 回避是焦虑留在地上最清楚的脚印，也是让焦虑长期不退的关键。短期躲开确实舒服，但每躲一次，大脑就把“这件事很危险”记得更牢。回避的形式很隐蔽：不坐地铁、不排队、不去人多的地方、开会坐门口、让人陪着才敢出门、出门必须带药、反复查身体。这些都可以列成一张清单，具体做法见 13.1 焦虑日记与惊恐记录。

焦虑在身体里长什么样

焦虑很少只停留在脑子里。常见的身体表现有：心悸、胸闷、气短或憋气、出汗、手抖、发抖、头晕、站不稳、手脚发麻、口周发麻、恶心、腹泻或便秘、尿频、吞咽时觉得堵、肌肉紧张、肩颈酸痛、头痛、入睡困难、容易醒、疲劳、注意力不集中、容易发火、坐立不安。

这些感觉是真实的生理变化，不是“想出来的”。比如惊恐时呼吸会又快又浅，二氧化碳排出过多，就会出现头晕、手麻、口周发麻，这些又会加重“我要出事了”的判断，形成一个圈。

但“症状真实”不等于“一定有病”，也不等于“一定是焦虑障碍”。同样是胸闷气短，可能是焦虑，也可能是心律失常、贫血、甲亢、哮喘。分辨靠检查，不靠意志。

身体感觉	常见的生理机制	需要优先排除的情况
心跳快、心悸	交感神经兴奋、肾上腺素升高	心律失常、甲亢、贫血
气短、胸闷	呼吸变快变浅、胸壁肌肉紧张	心绞痛、肺栓塞、哮喘
头晕、手麻、口周麻	过度换气、二氧化碳偏低	低血糖、脑血管问题、电解质紊乱
手抖、出汗	肾上腺素作用	甲亢、低血糖、药物副作用
胃肠不适、恶心	消化道血流减少、肠蠕动改变	消化道疾病
肌肉紧张、肩颈痛	长期肌肉收缩	颈椎病、肌筋膜疼痛

什么时候该就医

下面这张清单可以自己勾一遍。勾中的项目越多，越说明值得找医生谈一次，而不是继续忍。

- ☐ 担心或紧张几乎每天出现，已经持续数周以上
- ☐ 因为焦虑请过假、推掉聚会、不敢出门或不敢开车
- ☐ 睡眠受影响，每周三次以上，持续一个月以上
- ☐ 反复心慌胸闷，做过检查但没有明确结论
- ☐ 需要喝酒、吃安眠药或镇静药才能应付日常
- ☐ 出现“活着没意思”的念头
- ☐ 家人说你“变了”，你也觉得自己不像以前
- ☐ 已经影响到考试成绩、工作表现或亲密关系

就诊方向：精神科、心理科、心身医学科都可以作为入口；如果躯体症状突出，也可以先到内科或全科做基础排查，再带着检查结果去看精神科。两条路不冲突，先走哪条取决于你最难受的是什么。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即拨打 120 或去最近医院急诊：**首次突发的剧烈胸痛、压榨样疼痛或放射到左臂、下颌的疼痛；突然严重气短、咯血；晕厥或差点晕倒、眼前发黑；心跳极快且伴黑矇；单侧肢体无力、口角歪斜、说话不清；高热、抽搐、意识模糊；面唇肿胀、呼吸困难等严重过敏表现；出现自杀念头或自伤行为。

> **24 到 72 小时内联系医生**：焦虑明显加重，已经无法工作或出门；惊恐发作频率上升；回避的场景越来越多；服药后出现新的不适；饮酒量或镇静药用量在增加；情绪持续低落两周以上。
>
> 惊恐发作本身多数不致命，但第一次突发的胸痛、气短、晕厥，必须先按躯体急症处理，排除心脏和肺部问题之后，再讨论是不是惊恐发作。

为什么“想开点”解释不了焦虑

“想开点”这句话，出发点是好的，但它默认了一件事：焦虑是一个想法，想法可以随时换掉。实际情况不是这样。

焦虑涉及可以测量、可以观察的过程：遗传和气质带来的高敏感（比如从小就容易害羞、怕生、对陌生环境反应强烈）；下丘脑—垂体—肾上腺轴对应激的反应；杏仁核与前额叶之间“警报”和“刹车”的配合；以及条件反射式的学习——某次在地铁里惊恐发作后，地铁这个场景本身就被标记成了危险。这些不是观点，是有研究支持的机制【研究】。让一个人靠意志把警报关掉，难度接近让近视的人“努力看清”。

这句话还有副作用。它把痛苦归因于“你不够想得开”，于是患者开始隐藏症状、责怪自己，家属以为不用就医，问题被拖成慢性。

家属想帮忙，可以换几种说法：

- 把“别想那么多”换成“你现在最担心的是什么？”
- 把“这有什么好怕的”换成“我陪你走一趟，走不动我们就回来”
- 把“你就是太闲了”换成“最近是不是有件事一直压着你？”
- 把“吃药会吃坏脑子”换成“要不要先去问一下医生，问完再决定”

容易踩的坑

- 把“我还能上班”当成“我没问题”。功能损害是渐进的，很多人是撑到撑不住才就诊。
- 把“检查都正常”当成“我在装病”。检查正常恰恰是焦虑障碍常见的情形，说明需要换一个方向查。
- 把“忍过去”当成治疗。忍过去的是这一次，下一次通常来得更快。
- 把网络上的症状清单当成诊断。对照清单只能提示“值得去看看”，不能替代面诊。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113

- WHO. Anxiety disorders fact sheet.
  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.2 焦虑障碍的分类与诊断框架

拿到诊断书，上面写着“广泛性焦虑障碍”或者“惊恐障碍”，很多人第一反应是：这两个有什么不一样？为什么一起候诊的人，诊断名和我不同？分类不是为了把人分三六九等，而是因为不同类型的焦虑，怕的东西不同、回避的方式不同、治疗的重点也不同。

这一页讲三套常用的分类体系各自怎么分、差别在哪里，以及为什么“分类”不等于“贴标签”。读完你会更清楚医生在病历上写的那几个字是什么意思，也更知道复诊时该问什么。

分类是为了选治疗，不是排队

分类至少有三种用处。

第一种是沟通。同一个词，医生、心理治疗师、医保和研究者说的是同一件事，才能对话。

第二种是选治疗。社交焦虑的暴露对象是“被人看着”，惊恐障碍的暴露对象是“身体感觉本身”，广泛性焦虑的重点是“对担忧的信念”和“不确定性耐受”。同样是暴露，靶子完全不同。分错类，治疗就容易打偏。

第三种是判断风险。惊恐障碍要留意广场恐惧的合并，社交焦虑要留意酒精使用，广泛性焦虑要留意抑郁和失眠，分离焦虑在儿童身上要留意拒学。

但分类也有天生的局限：人的痛苦是连续的，诊断是把连续的东西切成一格一格；同一个诊断名底下，两个人的差别可能比两个诊断之间还大；诊断还会随时间移动。

目前国际上主要用两套体系：世界卫生组织的《国际疾病分类》第十一次修订本（ICD-11），和美国精神医学会的《精神障碍诊断与统计手册》第五版文本修订版（DSM-5-TR）。国内临床两者都参考，另有自己的防治指南。

DSM-5-TR：焦虑障碍这一章包括什么

DSM-5-TR 的“焦虑障碍”一章，主要收录这些类别：

- 分离焦虑障碍
- 选择性缄默
- 特定恐惧症
- 社交焦虑障碍（社交恐惧症）
- 惊恐障碍
- 广场恐惧症
- 广泛性焦虑障碍
- 物质或药物所致焦虑障碍

- 由于其他躯体疾病所致焦虑障碍
- 未特定的焦虑障碍

这里有一个很多人不知道的变化：从 DSM-5 开始，强迫症、创伤后应激障碍、急性应激障碍被移出了焦虑障碍章节，各自独立成章。原因是它们虽然都有强烈的焦虑，但核心机制和治疗重点是另一套——强迫症的核心是强迫思维和用来抵消它的仪式，治疗核心是暴露与反应阻止；创伤后应激障碍的核心是创伤记忆的再体验和回避。

这不代表它们和焦虑无关，而是说“都焦虑”不足以把它们归成一类。同一个人同时有焦虑和强迫，拿到两个诊断，并不矛盾【指南】。

ICD-11：名字和边界有些调整

ICD-11 的章名叫“焦虑及恐惧相关障碍”，收录的类别与 DSM-5-TR 大体对应：广泛性焦虑障碍、惊恐障碍、广场恐惧症、社交焦虑障碍、特定恐惧症、分离焦虑障碍、选择性缄默，以及物质或药物所致、由于其他躯体疾病所致的焦虑障碍。

几处值得注意的差别：

第一，ICD-11 更强调“必需特征＋持续时间或反复发作＋功能损害”这三件事同时成立，并允许用限定词标注严重程度和病程（比如发作性的还是持续性的）。也就是说，它更愿意描述“多重”，而不是只给一个名字。

第二，ICD-11 保留了“混合性抑郁和焦虑障碍”这一类，用于焦虑和抑郁症状同时存在、但各自都够不上单独诊断的情况。这在门诊非常常见，也更贴近实际。

第三，反复出现躯体不适、查不出明确的器质性原因、并为此持续担忧的情况，ICD-11 另有“躯体不适障碍”这一类，不直接算成焦虑障碍。这一点对中国人尤其重要，因为很多人最先表现出来的是胃不舒服、心慌、头晕，而不是“我很担心”。

要提醒的是，DSM-5-TR 和 ICD-11 不能逐条对应。看到不同来源的资料时，先确认它用的是哪套体系，再比较。

中国指南的口径

《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》（2023）沿用了国际分类的主要类别，并结合国内临床实际，在筛查、诊断、治疗上给出分级推荐【指南】。临床上常见的诊断写法包括：广泛性焦虑障碍、惊恐障碍、广场恐惧症、社交焦虑障碍（社交恐惧症）、特定恐惧症、分离焦虑障碍、选择性缄默、物质或药物所致焦虑障碍、躯体疾病所致焦虑障碍。

共病通常会并列写在诊断里，比如“焦虑障碍伴抑郁”“焦虑障碍伴失眠”。这不是医生偷懒，而是提醒后续治疗要同时考虑两条线。

本页只做框架介绍，不复制指南原文，也不作为诊断依据。具体条目、分级和推荐强度，以正式出版物和面诊医生的判断为准。

一张表看清各类型的核心特征

类型	核心的怕	典型回避	时间门槛
广泛性焦虑障碍	多件事长期担忧，且担心本身失控	拖延决定、反复确认、过度准备	多数日子存在，约半年以上
惊恐障碍	突如其来的发作、身体感觉、怕死怕疯	回避运动、咖啡、独处、封闭空间	发作后约一个月持续担心或行为改变
广场恐惧症	难以逃离或得不到帮助的场所	地铁、公交、商场、排队、独自外出	通常半年以上
社交焦虑障碍	被审视、被负面评价、当众出丑	发言、聚餐、面试、当众写字进食	半年以上
特定恐惧症	某个具体对象或情境	直接躲开该对象	半年以上
分离焦虑障碍	与依恋对象分离	不愿独睡、不愿上学上班、反复确认	儿童约四周，成人约半年
选择性缄默	在特定场合开口说话	在学校或陌生场合完全不说话	一个月以上（入学首月不算）
物质或药物所致	由物质中毒或戒断引起	视具体情况	与使用时间相关
躯体疾病所致	由躯体疾病直接引起	视具体情况	与疾病病程相关

看这张表时注意两点：一是“时间门槛”是诊断用的门槛，不是就医的门槛；二是很多人同时符合两三条，这在临床上很常见。

分类不是贴标签：四个必须知道的限制

第一，诊断要先排除。 焦虑可以是甲状腺功能亢进、心律失常、低血糖、贫血、哮喘、某些药物或咖啡因酒精引起的。医生在给出焦虑障碍诊断之前，通常会问躯体病史、用药史、咖啡和酒的用量，必要时安排检查。跳过这一步直接下诊断，是不负责任的。

第二，门槛是人为划的。 差了半个月不够半年，不代表你的痛苦比较轻。诊断标准是为了研究和沟通的方便，不是为了衡量谁更值得被帮助。

第三，共病是常态，不是例外。 焦虑合并抑郁、合并失眠、合并酒精使用、合并 ADHD 或孤独症谱系特征，都很常见。只盯着一个诊断，容易漏掉真正拖后腿的那一条。

第四，诊断会移动。 今天写广泛性焦虑，两年后可能加上抑郁；今天写惊恐障碍，之后可能出现广场恐惧。这不说明当初诊断错了，而是病程在变。每隔一段时间重新评估，是负责任的做法。

复诊时可以请医生说明的几件事

- ☐ 我的诊断具体是哪一类，主要依据是哪几条
- ☐ 有没有需要先排除的躯体原因或药物因素

- ☐ 有没有共病需要一起处理
- ☐ 这个诊断对应的治疗重点是什么，要面对的具体是什么
- ☐ 我需要观察哪些变化，下次复诊带来
- ☐ 诊断以后会不会调整，什么情况下需要重新评估

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**首次突发的剧烈胸痛、严重气短、晕厥或濒临晕倒；意识模糊、抽搐、高热；单侧肢体无力、说话不清；出现自杀念头或自伤行为；严重过敏表现。
>
> **尽快联系医生：**诊断后症状仍在加重；出现新的躯体症状（尤其是体重明显下降、持续发热、心悸伴消瘦）；开始出现明显的情绪低落或兴趣丧失；对诊断有疑问、想调整方案；准备自行停药或换药之前。

容易踩的坑

- 拿着诊断标准逐条对照，给自己或家人“确诊”。标准是给受过训练的临床医生用的，很多条目需要判断。
- 把强迫症、创伤后应激障碍当成“焦虑的一种”，按焦虑的办法处理，结果核心症状没被碰到。
- 认为拿到诊断就是终身标签。诊断是当前状态的描述，不是判决书。
- 只看诊断名，不看功能损害。同样是广泛性焦虑，有人还能上班，有人已经出不了门，治疗强度不一样。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.3 流行病学、病程与共病

焦虑障碍是最常见的一类精神障碍，但“常见”两个字经常被误读成“轻”。很多人因此拖了很多年才就诊，回头一看，最难受的那几年本来是可以处理的。

这一页讲三件事：谁更容易在什么年龄遇上它；如果不处理，它通常怎么走；以及它为什么经常和别的病一起来。文中不给具体百分比——不同研究的口径差别很大，数字给错方向，比不给更糟。

谁更容易遇上：年龄、性别与起病时间

焦虑障碍在人群中相当常见【指南】。它不分城市农村、不分学历收入，但分布并不均匀。

性别。 女性被诊断为焦虑障碍的比例普遍高于男性，尤其是广泛性焦虑、惊恐障碍、广场恐惧和特定恐惧；社交焦虑的性别差别相对小一些。这里有真实的生物学差异，也有求助行为的差异：男性更少因为“心里难受”去看医生，更常用喝酒、发火、硬扛来处理，所以统计上的数字可能低估了男性患者。家属如果觉得“男人不会得这个”，容易把问题拖过去。

起病年龄。 不同类型的起点不一样，这一点对识别很有用。

类型	常见起病年龄	常见走向
特定恐惧症	儿童期多见	很稳定，很少自行消失
分离焦虑障碍	儿童期，也可成年起病	儿童期治疗后多能缓解
选择性缄默	多在学龄前	越早干预越好
社交焦虑障碍	青少年期多见	常持续多年，起病越早越易慢性
惊恐障碍	青少年后期到三十多岁	可间歇发作，也可长期波动
广泛性焦虑障碍	成年早期多见，也可中老年首发	常呈波动性、慢性病程

两个特别要提醒的情况。

一是老年首次出现明显焦虑。这时候不能默认“人老了就爱担心”，要优先排查躯体疾病（甲状腺、心脏、呼吸、疼痛）、药物副作用（某些激素、支气管扩张剂、兴奋类药物）、抑郁、认知功能下降，以及酒精和镇静药的戒断。

二是儿童青少年的焦虑常不以“我担心”说出来，而是肚子痛、头痛、不想上学、发脾气、黏人。只按“纪律问题”处理，往往越处理越僵。

文化因素。 在中文语境里，很多人描述焦虑时说的是“胸闷”“胃不舒服”“脖子发紧”“睡不着”，而不是“我焦虑”。这不代表他们不焦虑，只是表达通道不同。医生问躯体症状，不是绕开心理，而是从你熟悉的入口进去。

病程：为什么它容易拖成慢性

焦虑障碍的一个特点是“会自己长大”。不处理的情况下，常见几种走向：

- 波动性慢性：好一阵、坏一阵，遇到压力就加重，几年下来一直在低水平运转。广泛性焦虑常是这种。
- 发作性：一段时间密集发作，之后平静几个月甚至几年，再被某件事点燃。惊恐障碍常见。
- 持续稳定：症状强度变化不大，但一直存在，社交焦虑和特定恐惧常如此。
- 缓解：确实有一部分人不治疗也好转了，尤其在应激源消失、生活条件改善之后。但不能把“有人会好”当成“我可以等”。

影响走向的因素，临床上反复看到这么几条【临床经验】：起病越早、病程越长，越容易慢性；回避范围越广，越难好转；共病越多（尤其合并抑郁、物质使用、人格问题），治疗越复杂；持续的现实压力（照顾重病家人、长期加班、经济困难、家庭冲突）会不断给症状加油；社会支持越弱，恢复越慢。

还有一个常被低估的因素：**延迟就诊**。很多人从第一次明显症状到第一次看精神科，中间隔了好几年。这几年里，回避在扩大，酒量在增加，身体被反复检查，工作机会在流失。焦虑本身不会因为拖延而变成绝症，但拖延会让它更难治。

需要说清楚的是：治疗能改变轨迹。规范治疗后，相当一部分人可以达到缓解，也就是症状基本消失、功能恢复；也有一部分人是明显减轻但仍有残留。焦虑障碍的病程常常是波动的，好转之后遇到压力再次出现，不等于前功尽弃，而是提醒该复查和调整维持方案。关于疗程，可以看 11.1 为什么要足疗程。

功能损害：不只是“心情不好”

焦虑障碍真正消耗人的地方，往往不是那阵心慌，而是它悄悄改掉了你的生活半径。

- **学业与职业**：注意力下降、效率变低、反复检查、拖延、频繁请假、放弃晋升或考试。
- **经济**：收入减少、医疗支出增加、反复做检查、因回避失去机会。
- **人际**：推掉聚会、不敢发言、不敢谈恋爱、怕麻烦别人、逐渐与朋友断联。
- **家庭**：需要家人反复保证、因回避引发争吵、育儿时过度保护。
- **健康服务**：反复就诊、多次急诊、重复检查，既花钱也可能带来不必要的风险。
- **共病风险**：长期焦虑会增加抑郁、失眠、物质使用和心血管问题的风险。

功能损害有一个讨厌的特点：**它很隐蔽，而且会被自己合理化**。“我不太喜欢热闹”“那个会我让别人去”“我开车容易紧张”——每一句都讲得通，加起来就是生活越来越小。

所以在评估严重程度时，功能损害比“症状有几条”更好用。可以问自己三个问题：这半年我放弃了什么？我为了绕开焦虑多花了多少时间和钱？如果我完全不焦虑，我的生活会有什么不同？

共病：焦虑很少单独出现

临床上，单纯只有焦虑、别的什么都没有的人并不多。共病不是“病得更多”，而是同一个人的不同问题互相喂养。

共病	相互影响	治疗上要注意什么
抑郁	最常见；焦虑久了容易低落，低落又会加重无望和回避	需要一起评估，尤其要问自杀念头
其他焦虑障碍	一个人可能同时符合两三种	治疗要抓最影响功能的那一条
酒精与镇静药	短期像在帮忙，长期加重焦虑并产生依赖	必须如实告诉医生用量，不能自行硬戒
失眠	睡不好会放大第二天的焦虑和躯体感觉	睡眠问题要单独处理，不只靠加药
慢性疼痛、胃肠不适	焦虑放大疼痛和腹部症状，症状又加重焦虑	需要躯体科与精神科一起看
心血管、呼吸疾病	心慌气短既可能是焦虑也可能是病情变化	新发或变化的症状要先排查器质性原因
孤独症谱系、ADHD	焦虑表现常被当成“行为问题”或“不专心”	识别不足，需要专门评估
双相障碍	抗抑郁药可能诱发转躁	用抗抑郁药前要筛查既往躁狂或轻躁狂
创伤后应激、强迫症	症状重叠，容易互相掩盖	治疗顺序和重点不同，需要区分

还有一类共病容易被漏掉：**睡眠呼吸暂停**。打鼾严重、白天困倦、夜里憋醒的人，焦虑和疲劳可能有一部分来自缺氧，而不是单纯的心理问题。

初诊时值得主动交代的线索

- ☐ 最近三个月喝过多少酒，有没有为了助眠喝
- ☐ 有没有长期吃安眠药、镇静药、止痛药
- ☐ 每天咖啡、浓茶、功能饮料大概多少
- ☐ 有没有甲状腺、心脏、血糖、贫血方面的病史或检查异常
- ☐ 有没有一段时期特别兴奋、话多、睡得少但精力旺盛
- ☐ 有没有经历过重大创伤，或者反复闪回
- ☐ 有没有反复检查、计数、清洗这类仪式动作
- ☐ 家里有没有人得过焦虑、抑郁、双相或精神分裂症

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊**：首次突发的剧烈胸痛、严重气短、晕厥；意识模糊、抽搐、高热；单侧肢体无力或说话不清；出现自杀念头、自伤行为或“不想活了”的具体计划；酒精或镇静药突然停用后出现发抖、大汗、心跳极快、幻觉。
>
> **尽快联系医生**：焦虑持续加重并影响工作生活；新出现体重明显下降、持续发热、心悸伴消瘦；情绪低落超过两周；饮酒或镇静药用量明显增加；准备自行减药或停药。

容易踩的坑

- 用“发病率高”安慰自己，也用它吓自己。群体数字说明这件事常见，不说明你的情况轻或重。
- 把共病当成“治不好了”。共病需要的是更完整的评估，不是更悲观的结论。
- 只治焦虑，不处理失眠和饮酒。这两件事不处理，焦虑很难稳定。
- 相信“过了这个阶段就好”。有些阶段确实会过去，但持续半年以上的功能损害，值得主动处理。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders
- NIMH. Anxiety Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（仅用于焦虑合并抑郁部分）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.4 常见名词与误区

焦虑这件事，被说错的次数比被说对的次数多。“你就是想太多”“深呼吸就好了”“社恐不就是内向”“惊恐发作会死人”——这些话有的出于关心，有的出于误解，共同点是都会让人错过该做的事。

这一页把最容易混的几组词、最常见的十来种说法，一条条摊开说清楚。它不是让你去跟人辩论，而是让你在自己心里有个准星：哪些话可以听，哪些话听过就算。

先把几个词分开

- **焦虑**：一种情绪，指向“还没发生、可能会发生”的威胁。人人都有。
- **焦虑症状**：焦虑在身体和心理上的具体表现，比如心慌、肌肉紧张、反复担心。
- **焦虑障碍**：一组有诊断标准的疾病，要求症状持续、难以控制、造成功能损害，并且不能用其他疾病或物质更好解释。
- **惊恐发作**：一次急性的、在很短时间内冲到顶点的强烈恐惧，伴随心悸、气短、头晕、手麻、濒死感或失控感。它是一种症状事件，不是诊断。
- **惊恐障碍**：反复出现意外性惊恐发作，并且持续担心再发或因此明显改变行为，才构成诊断。
- **恐惧**：通常指向眼前具体的对象或情境，比如蛇、高处、打针。
- **强迫**：反复出现的想法（强迫思维）加上用来抵消它的动作（仪式）。在 DSM-5 之后，它已经从焦虑障碍里独立出去。
- **回避**：为了减少焦虑而不去做某件事、不去某个地方。短期有效，长期让恐惧更牢。
- **安全行为**：必须带着某个东西、或必须有某个人陪着，才敢面对某个场景。比如出门必须带药、开会必须坐门口。

这几个词经常被混着用，但混用会带来实际后果：把惊恐发作当成心脏病，会反复跑急诊；把焦虑障碍当成“想太多”，会拖到慢性；把强迫当成焦虑，会用错方法。

十组最容易混淆的说法

说法	常见的误解	更准确的理解
焦虑症就是焦虑	把情绪当病，或把病当情绪	焦虑是普遍情绪；焦虑障碍要求持续、难控、有功能损害，并排除其他原因
惊恐发作等于心脏病	发作时以为要心梗，或反过来把心梗当惊恐	两者症状高度重叠；首次发作、有心脏病史、症状不典型，必须先排查心脏和肺部
社恐就是内向	以为只是性格，不用处理	内向的人独处舒服；社交焦虑是怕被评价、主动回避、事后反复回想，很痛苦
强迫症就是焦虑症	按焦虑的路子治，漏掉核心症状	强迫症已独立成章，核心是强迫思维与仪式，治疗重点是暴露与反应阻止
放松训练能替代治疗	只练呼吸，不去面对	放松是辅助手段，能降低唤醒；中重度

说法	常见的误解	更准确的理解
		焦虑需要心理治疗和/或药物
焦虑是想太多	把责任推给性格	涉及遗传气质、神经回路、应激激素和学习性条件反射，不是“想不想”的问题
吃药就是软弱	病耻感，拒绝有效治疗	药物调节的是神经递质和回路，性质接近眼镜和降压药，不是意志力比赛
焦虑久了会变成精神病	怕自己“疯了”	焦虑障碍不会转成精神分裂症；惊恐时的“我要疯了”是发作体验，不是事实
焦虑症一辈子好不了	绝望，放弃治疗	多数人经规范治疗可以缓解；复发可以预防，波动不等于失败
量表分数高就是有病	拿筛查工具给自己确诊	量表只提示“值得评估”，诊断要靠面诊、病史和排除其他原因

就诊时你会听到的词

术语	大白话
广泛性焦虑障碍（GAD）	长期、对很多事担心，停不下来
惊恐发作	十几分钟内冲到顶的强烈恐惧，伴心慌气短
惊恐障碍	反复发作，并且一直怕再发作
广场恐惧	怕人多、怕被困住、怕逃不掉、怕没人帮
社交焦虑障碍	怕被看、怕被评价、怕当众出丑
特定恐惧症	怕某个具体的东西或场景
回避	为了不难受而躲开
安全行为	靠某个人或某样东西才敢面对
内感受暴露	主动体验心慌、头晕这类感觉，练到不怕
认知行为治疗（CBT）	一类结构化的心理治疗，改想法也改行为
SSRI	一类常用抗抑郁药，也用于治疗焦虑障碍
共病	同时存在两种或以上的问题

自查：这些话你对自己说过吗

- ☐ “再忍忍就过去了，不用看医生”
- ☐ “别人都能扛，就我不行”
- ☐ “我是不是太矫情了”
- ☐ “等这阵忙完就不焦虑了”
- ☐ “我不能让别人知道我在吃药”
- ☐ “查了都没事，那肯定是我瞎想”
- ☐ “我不能去那个地方，去了肯定出事”
- ☐ “只要不发作，我就不算有病”

勾中三条以上，说明你已经在用某套解释安抚自己。这些解释不必被批判，但值得拿出来和医生对一遍。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊**：首次突发的剧烈胸痛、压榨样疼痛或放射到手臂下颌的疼痛；突然严重气短、咯血；晕厥或差点晕倒；心跳极快伴眼前发黑；单侧肢体无力、口角歪斜、说话不清；抽搐、意识模糊、高热；严重过敏表现；出现自杀念头或自伤行为。
>
> **尽快联系医生**：症状持续数周不缓解；回避的场景越来越多；开始靠喝酒或吃安眠药应付；体重明显下降、持续发热、心悸伴消瘦；情绪低落超过两周。

容易踩的坑

- 把“我查过，没事”当成“我不用治”。检查排除的是器质性疾病，不排除焦虑障碍。
- 把“我能上班”当成“我还好”。功能损害是渐进的，很多人撑到撑不住才来。
- 用某一个名词解释全部问题。焦虑、抑郁、失眠、饮酒常常是一起来的。
- 拿网络段子当科普。“社恐”“强迫症”“抑郁了”这些词在网络上被用得很轻，容易让人低估真正的病。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 2：临床表现与评估

不同类型的焦虑，表现和治疗重点不一样。这一模块帮你认出自己更像哪一类，但不下诊断。

2.1 广泛性焦虑障碍 GAD

如果你已经担心了大半年，担心的事情一件接一件，从工作进度、家里的钱、父母的体检报告，到明天会不会堵车、刚才那句话是不是说错了，而且明明知道担心也没用，却怎么也停不下来——这一页可能对你有用。这一页讲广泛性焦虑障碍（GAD）的典型样子、它和“正常操心”的界线、它对生活的消耗，以及 GAD-7 这个量表能做什么、不能做什么。读完你大概能分清自己是“最近事情多”，还是“担忧已经变成了一个关不掉的开关”，也知道下一步该找谁。

一、GAD 的核心：担忧失去了开关

担心本身是有用的。它让人提前检查门窗、提前准备考试、在危险来临前躲开。正常的担心有一个起点，也有一个终点：事情过去了，担心就慢慢退下去。

广泛性焦虑障碍不一样。它的核心不是“担心”这个动作，而是担忧变得**范围过宽、停不下来、持续时间很长，并且带来了身体上的紧张和生活上的影响**。医学上通常要满足几个条件：对多个方面过度担心，几乎每天都在担心，持续至少 6 个月，自己控制不住，同时伴有坐立不安、容易累、注意力难集中、容易发脾气、肌肉紧张、睡眠不好中的几项【指南】。诊断要由医生做，这里说的只是“典型样子”，不是让你对号入座。

需要说明的是，不是每个人都会凑齐所有症状。有人主要是肩颈僵硬、头痛、下颌咬得紧；有人主要是入睡困难、半夜易醒；有人主要是脑子里反复出现“如果……怎么办”，身体反而不明显。表现不同，不代表谁轻谁重。

担忧的内容：像接力，不像一件事

GAD 的担心往往不是一件具体的事，而是一串。工作的事刚放下，马上接到家里的事；家里的事还没结果，又开始担心自己的身体。很多人形容“脑子从来没有真正空过”，即使在休息、在看剧、在度假，背景里也总有一层“还有什么事没做好”。

这种担心有几个特点：

- **指向未来，且以“万一”开头**：万一检查结果不好、万一被辞退、万一孩子在学校出事。
- **对不确定性的耐受很低**：事情没有百分之百的保证，就反复想、反复确认。
- **担心本身让人更累**：想了很久，问题没解决，人已经耗空了。

- **明知道过头，也停不下来**：这一点最折磨人——不是不懂道理，是道理不管用。

身体：紧张是真实的，不是“想出来的”

长期处在“随时准备应对”的状态，身体会一直绷着。常见的有：肩颈和背部发紧、头痛、下巴酸、手抖、坐不住、来回踱步、容易疲劳、胃口变化、腹胀、出汗、心慌、入睡困难、睡眠浅、早醒。注意力也会受影响，看书看不进去，别人说话听一半就走神。

这些不是“装出来的”，也不是“意志力不够”。它们和身体长期处于应激状态有关，是真实的生理反应。理解这一点很重要：**你不是在夸大，你的身体确实在付出代价。**

一个示意

小 A 是一家公司的项目主管，外人看来做事稳妥。她每天早上醒来第一件事是“过一遍今天可能出什么问题”，通勤路上反复检查手机有没有漏消息，开会前担心自己说错话，下班后担心明天。她的体检做了好几次，除了颈椎不好，没查出什么。她说最难受的不是哪件事，而是“没有一刻是松的”。这是一个合并改写的示意，不对应任何真实个人。

二、和“正常操心”的界线在哪里

很多人会问：“我这样算不算病？”下面这张表可以帮你理一理，但它不是诊断标准。

维度	正常的操心	更接近广泛性焦虑
担心的对象	具体，和现实事情相称	弥散，涉及多个方面，常与现实不成比例
能不能停下来	事情有结果后能放下	难，明知没必要也停不下来
持续时间	几天到几周，随事情起伏	半年以上，多数日子都有
身体反应	轻微、短暂	持续的肌肉紧张、睡眠差、易疲劳
对生活的影响	基本不影响	影响工作、学习、社交、家庭
自己的感受	“我最近想多了”	“我控制不住，很累，甚至因此自责”

界线不在于“担不担心”，而在于三个词：**可控性、持续时间、功能损害**。担心到吃不下睡不着、无法专注、反复请假、和家人冲突，就已经不是“性格问题”了。

还要提醒一句：长期紧张不一定就是 GAD。抑郁症常伴担心和坐立不安；创伤后应激障碍会有警觉性增高；强迫症有反复的念头和检查；甲状腺功能亢进、心律失常、咖啡因摄入过多、某些药物的副作用，也会让人心慌手抖、睡不好。这也是为什么不能只看一张症状表就给自己下结论。

三、病程与功能损害：它消耗的是“余量”

GAD 常常起病较早，慢慢发展，容易被当成“从小就这样”。它的病程往往是波动的：压力大的时候重，生活平稳的时候轻，但很少彻底消失。正因为“还能上班、还能照顾家”，它常被低估——外人看不出，本人一直在用额外的力气维持正常。

功能损害通常体现在这些地方：

- **效率**：同样的活要花更长时间，因为反复检查、反复推翻。
- **决策**：小决定也拖很久，怕选错。
- **睡眠**：入睡难、易醒，第二天更累，形成循环。
- **关系**：反复寻求保证，家人一开始安慰，后来疲惫、争执。
- **医疗**：反复检查、反复就诊，查不出问题，更焦虑。
- **回避**：推掉出差、聚会、升职机会，生活半径慢慢变小。

GAD 还常和其他问题一起出现，最常见的是抑郁、其他类型的焦虑障碍、失眠和酒精使用。合并抑郁时，自杀风险会升高，这一点需要认真对待，不能只当作“想太多”。

四、GAD-7：一把筛子，不是诊断书

GAD-7 是一个 7 条目的自评量表，问的是**过去两周**的情况，每条按“完全不会”到“几乎每天”记 0 到 3 分，总分 0 到 21 分【指南】。它问的是：紧张、担心、无法停止担心、难以放松、坐立不安、容易烦躁、害怕发生可怕的事。

常用的分段大致是：0 到 4 分提示无明显焦虑，5 到 9 分轻度，10 到 14 分中度，15 分以上中重度。这些数字是**筛查用的参考线**，不是诊断线。

总分	大致含义	可以怎么用
0–4	目前焦虑水平较低	不代表永远没问题，可定期自评
5–9	轻度	观察、调整睡眠与咖啡因，必要时咨询
10–14	中度	建议就诊评估，别只靠自评
15 以上	中重度	尽快就诊，通常需要系统治疗

GAD-7 有用，但局限也很明显：

- 它**不能区分** GAD、惊恐障碍、社交焦虑，也不能区分焦虑和抑郁。
- 它**不能排除**甲亢、心律失常、药物副作用等躯体原因。
- 分数受最近两周的情绪、睡眠、事件影响，一次高分不等于有病，一次低分也不等于没事。
- 它不能用来决定吃什么药、吃多久。

正确的用法是：**把分数当作线索和追踪工具，带给医生看，而不是拿它给自己开诊断。**

五、自查清单与就医时机

可以照着做的自查清单

下面这份清单不是诊断，只是帮你在就诊时说清楚。

- ☐ 过去 6 个月，我大多数日子都在担心，且担心的方面不止一个。
- ☐ 我很难让担心停下来，越劝自己“别想了”越停不下。

- ☐ 我经常肩颈发紧、头痛、下巴酸，或者坐不住。
- ☐ 我入睡困难、睡不踏实，或早醒后很难再睡。
- ☐ 我容易累，注意力下降，看书或工作时总走神。
- ☐ 我因为担心推掉过工作、聚会或出行。
- ☐ 我反复检查身体，查不出问题还是不放心。
- ☐ 我用喝酒、抽烟、喝浓茶咖啡来撑住或放松。
- ☐ 家人说我“想太多”，我听了更难受。

如果勾了四项以上，并且已经影响生活，值得预约一次精神科或心理科门诊。勾得少但很难受，也可以去，不需要“够严重”才配看医生。

什么时候需要联系医生或去急诊

出现以下情况，请立即拨打 120 或去最近的急诊：

- 突发剧烈胸痛、胸口压榨感，或疼痛放射到手臂、后背、下颌；
- 突然严重气短、喘不上气、口唇发紫；
- 晕倒，或差点晕倒、眼前发黑伴冷汗；
- 心跳极快且伴胸痛、头晕、意识模糊；
- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了计划；
- 连续多天几乎不吃不喝、无法入睡。

建议尽快到精神科或心理科门诊：

- 担心持续半年以上，明显影响工作、学习、睡眠或关系；
- 反复因心慌、胸闷、头晕做检查，结果都正常，仍然不放心；
- 同时有情绪低落、兴趣减退、什么都不想干；
- 需要靠喝酒或加量吃药才能撑过一天；
- 一天中大部分时间都在担心，自己已经无法调节。

如果拿不准，先打 12356 心理援助热线咨询，或去综合医院全科、心身医学科首诊，由医生判断需不需要转诊。**宁可白跑一趟，不要赌。**

六、常见问题与容易踩的坑

“担心是不是因为我性格不好、太脆弱？”不是。GAD 是一种可以被识别、被治疗的状态，和性格有关，但不是性格缺陷。把责任全放在“我不够坚强”上，只会让人更不敢求助。

“是不是必须吃药？”不一定。轻中度可以考虑结构化的心理治疗，中重度常需要心理治疗联合药物，具体由医生结合病情、躯体情况、既往反应和本人意愿决定。药物种类和用法必须由医生处方，不能照别人的经验买药。

“GAD-7 我测了 12 分，是不是确诊了？”不是。量表只说明“最近两周焦虑水平偏高”，确诊需要医生访谈、看病程和功能损害、排除其他原因。

“是不是忍一忍就过去了？”有一部分人确实会随环境变化缓解，但长期、明显的 GAD 很少自己彻底消失。拖着的代价是睡眠、效率、关系和机会一点点被磨掉。

“治好了是不是就永不复发？”不能这样承诺。规范治疗可以让大多数人明显缓解、恢复正常生活；但焦虑有一定的复发可能，需要维持治疗和识别早期信号。目标不是“再也不紧张”，而是“紧张回来时，我知道怎么办”。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 2006.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.2 惊恐发作与惊恐障碍

很多人第一次惊恐发作是在地铁上、在开会时、在半夜醒来时：心突然狂跳，胸口像被压住，气吸不进来，手脚发麻，脑子里冒出一个念头——“我要死了”“我要疯了”。几分钟后慢慢缓过来，但那种恐惧会一直留着。这一页讲惊恐发作时身体到底发生了什么、发作的规律、为什么有人会发展成惊恐障碍，以及最要紧的一件事：**怎么区分“又一次惊恐”和“真的躯体急症”**。读完你应该知道发作时能做什么、什么时候必须去医院，以及下一步怎么治。

一、惊恐发作是什么：一次“假警报”，但身体反应是真的

惊恐发作是一阵突然出现的强烈恐惧或不适，在几分钟内达到高峰，同时出现一组身体和想法上的症状【指南】。医学上常提到的症状包括：

- **心脏和呼吸**：心悸、心跳很快、胸闷、胸痛、气短、觉得透不过气、哽住感。
- **神经和肌肉**：出汗、发抖、手脚或嘴唇发麻、刺痛、头晕、站不稳、发冷或发热。
- **胃肠**：恶心、腹部不适。
- **感受和想法**：周围不真实、觉得自己不真实、害怕失控或“发疯”、害怕死掉。

一次发作通常至少要有其中四项，才算典型的惊恐发作。但**症状数量不是重点**，重点是那种“突然、猛烈、我控制不了”的体验。

要理解的是：这是身体警报系统的一次误触发。肾上腺素一下子升高，心跳加快、呼吸变快、肌肉绷紧，这些都是真实的生理变化，不是“想出来的”，也不是“矫情”。**身体没有坏，是警报器太敏感了。** 这句话对很多人是有用的，因为它把“我是不是得了绝症”换成了“我的警报系统出了问题，而这是可以治的”。

二、一次发作的时间表

知道发作有“形状”，本身就能减轻恐惧。典型的经过大致是这样：

阶段	大致表现	通常持续
前兆	一点心慌、胸口发紧、头晕，或完全没有预兆	几秒到几分钟
上升	心跳猛地加快，呼吸变浅变快，恐惧迅速升高	几十秒到几分钟
高峰	最强烈的恐惧，常伴濒死感、失控感	数分钟
回落	症状逐渐减轻，人很累、发抖、想哭	十几分钟到半小时
后遗	疲惫、肌肉酸痛、害怕再来一次	数小时到数天

多数发作在 10 分钟内达到高峰，通常在数分钟到半小时内缓解，超过 1 小时还没有缓解的并不常见【临床经验】。夜间发作也常见，人从睡梦中惊醒，心跳剧烈，更容易被误认为心脏病。

但“通常会缓解”不等于“这次也一定没事”。 时间表是用来理解发作的，不是用来自我诊断的。

三、从一次发作到惊恐障碍

偶尔一次惊恐发作并不等于有病。很多人在一生中经历过一两次，尤其在压力大、睡眠差、咖啡因摄入多的时候。

惊恐障碍的诊断要点是两条【指南】：

1. **反复出现、出乎意料的惊恐发作**（不是只在特定场合才发作）；
2. 发作后至少一个月里，持续担心再次发作、担心发作的后果（比如“是不是心脏病”“会不会死”），或者因为发作而明显改变行为（不敢坐地铁、不敢独自出门、不敢运动）。

注意第二条。**真正把人困住的，往往不是发作本身，而是发作之后开始的“防着它”。** 有人开始随身带药、带水、查最近的医院；有人不敢喝咖啡、不敢运动、不敢一个人待着；有人反复做心电图。这些行为短期能降低恐惧，长期却让大脑更确信“这件事很危险”。

惊恐障碍常和广场恐惧、抑郁、其他焦虑障碍一起出现，也常被误认为心脏病而反复就诊。它通常在青少年后期到成年早期起病，女性更常见，病程容易波动、慢性化。

对再次发作的恐惧，和随之而来的回避

惊恐障碍有一个很典型的循环：

1. 一次发作，留下强烈记忆；
2. 开始过度关注身体：数心跳、量血压、注意每一次胸闷；
3. 一点点不适被解释成“要发作了”；
4. 于是回避可能触发的场景：地铁、电梯、超市、电影院、运动、独处；
5. 回避让恐惧暂时下降，但“我其实能应付”的经验再也没有机会出现；
6. 恐惧泛化，生活半径缩小。

这个循环里，**“安全行为”**很关键。安全行为是指那些“觉得不这样做就会出事”的小动作：必须带着药才敢出门、必须坐在靠门的位置、必须有人陪、必须一直喝水、必须查手机信号。它们看起来无害，实际上在告诉大脑：“你一个人确实不行。”

治疗的重点之一，就是逐步减少这些安全行为，让身体重新学到“这些感觉虽然难受，但不会要命”。这部分的具体做法在 5.4 惊恐障碍的 CBT 与内感受暴露，本页不展开。

四、惊恐发作和心脏病，边界在哪里

这是最需要说清楚的一节。**惊恐发作本身通常不致命，但这不能成为忽视胸痛、气短、晕厥的理由。** 下面这张表可以帮助理解两者的典型差别，但它**不能用来给自己排除心脏病**。

线索	更像惊恐发作	更需要警惕心脏问题
诱因	常在静息、睡眠中、情绪波动时出现	常在活动、劳累、寒冷、情绪激动时出现
胸痛性质	针刺样、位置会变、几秒到几分钟	压榨样、闷痛、像被石头压住，持续不缓解
放射	少见	可放射到左臂、后背、下颌、上腹
伴随	麻木、过度换气、濒死感、手脚发凉	大汗淋漓、恶心、面色苍白、濒死感
缓解	十来分钟到半小时自行缓解	休息可缓解，或持续加重
既往	有焦虑史、类似发作史	有高血压、糖尿病、吸烟、心脏病家族史

问题在于，两者的重叠比想象中大：惊恐发作也会有胸痛、出汗、濒死感；心肌缺血也可能表现为心慌、气短而没有典型胸痛。**所以真正的判断不能靠感觉，要靠风险因素、体格检查、心电图和必要时的化验。**

以下情况，第一次出现就必须按急症处理：

- 首次发作，尤其是 40 岁以后第一次出现；
- 胸痛剧烈、持续不缓解，或伴大汗、恶心、面色苍白；
- 气短明显，休息也不缓解，或嘴唇发紫；
- 晕倒，或差点晕倒；
- 心跳极快且伴胸痛、头晕、黑朦；
- 有已知心脏病、高血压、糖尿病、吸烟史，或家族早发心脏病史。

五、发作时怎么做，什么时候必须就医

第一次发作时，可以照着做

- ☐ 先停下来，找个安全的地方坐下或靠墙，不要开车、不要登高。
- ☐ 看一下时间，记住发作从什么时候开始。
- ☐ 如果胸痛剧烈、气短明显、快要晕倒，或这是第一次发作——**直接拨打 120**，不要等它自己过去。
- ☐ 如果已经有过多次类似发作、医生也评估过，可以告诉自己：“这是惊恐发作，它会在十几分钟内下去。”
- ☐ 把呼吸放慢，重点是**呼气变长**，不要拼命大口吸气。
- ☐ 把注意力放到外界：说出眼前看到的五样东西、听到的三种声音。
- ☐ 不要做的事：反复量血压、反复查手机、立刻吃别人的药、喝酒压惊。
- ☐ 发作后记一笔：时间、地点、当时在做什么、第一个感觉、持续多久、怎么缓解。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **出现以下任一情况，请立即拨打 120 或去最近的急诊，不要先按“焦虑”处理：**

- 突发剧烈胸痛、胸闷、压榨感，持续不缓解，或放射到手臂、后背、下颌；
- 突然严重气短、喘不上气、口唇发紫；
- 晕倒、意识丧失，或差点晕倒伴冷汗；
- 心跳极快且伴胸痛、头晕、眼前发黑；
- 第一次出现这样的发作，尤其是中老年人；
- 发作超过 1 小时仍不缓解，或一次接一次没有间歇；
- 出现自杀念头或自伤行为。

建议尽快到精神科或心理科门诊：

- 反复发作，且发作后一直担心再来一次；
- 因为害怕发作而回避地铁、电梯、商场、独处、运动；
- 反复检查心脏，结果正常仍不放心；
- 随身带药、带水、查医院，生活被“防发作”占满；
- 合并情绪低落、失眠、喝酒增多。

不确定时，先打 12356 心理援助热线，或去急诊做基本检查。**先排除危险，再谈焦虑，顺序不能反。**

六、常见问题与容易踩的坑

“我是不是心脏有问题，只是没查出来？”这个担心很常见，也值得认真对待。如果已经做过心电图、心脏超声、动态心电图，医生也结合风险因素判断过，那么“反复检查”本身可能已经成了焦虑的一部分。可以和医生明确问一句：“以我的风险因素，还需要查什么？查完之后，如果结果正常，我们怎么处理这个担心？”

“发作时我会不会死？”惊恐发作本身通常不会造成心脏骤停或死亡【指南】。但这句话不能用来安慰一个第一次发作、有胸痛或晕厥的人——那种情况必须先排除急症。

“深呼吸是不是一定有用？”不一定。对一部分人，刻意大口深呼吸反而会加重头晕和麻木，因为它改变了血液中的二氧化碳水平。更稳妥的是**放慢呼吸、延长呼气**，而不是用力吸气。具体方法在 7.1 呼吸训练与放松训练。

“是不是不能运动了？”不是。运动时心跳加快，容易被误认为“要发作了”，于是有人彻底不动。长期不动会让体能下降，稍微一动就心慌，反而更怕。建议在医生评估心脏没问题后，从低强度开始，逐步恢复。具体见 7.3 运动处方。

“要不要随身带药？”有些人短期需要“救命药”带来的安全感，这可以和医生讨论。但长期依赖“必须带着药才敢出门”，会变成安全行为，阻碍康复。用药与停药必须由医生决定，不要自行加减。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.3 广场恐惧与回避行为

有些人不是怕某一个地方，而是怕“在那个地方出事，却跑不掉、也没人帮”。于是地铁不坐了，商场不去了，队不敢排，一个人不敢出远门，活动范围从一座城缩到一个小区、再到一间房。这一页讲广场恐惧（也叫场所恐惧）到底怕的是什么、“回避地图”是怎么一点点扩大的、它和惊恐障碍是什么关系，以及家人“陪着”为什么既帮忙又可能帮倒忙。读完你大概能认出自己或家人的回避模式，也知道该从哪一步开始松动了。

一、广场恐惧不是“怕广场”

这个名字容易误导。广场恐惧的核心不是广场、不是人多，而是**害怕在某个场合出现惊恐样症状或失能时，无法逃离、无法获得帮助**。怕的其实是三件事：

- **跑不掉**：地铁到站之间、飞机上、高速上、排队中间，出不去。
- **没人帮**：独自在家、独自走路、在陌生地方，晕倒了没人知道。
- **丢脸**：在人前发作、摔倒、呕吐，被人围观。

所以同一个地点，对不同的人意义完全不同：有人怕商场，是因为人多闷热；有人怕商场，是因为出口难找；有人怕的其实是“我一个人去”。理解这一点很重要——**治疗的对象不是“商场”，而是“我不能跑掉”这个信念和随之而来的回避。**

二、典型场所与“回避地图”

广场恐惧常涉及五类场合：公共交通（地铁、公交、火车、飞机）、开阔或空旷的地方（停车场、广场、桥上）、封闭的地方（电梯、隧道、影院、理发椅）、人群或排队、独自离家【指南】。

回避往往不是一下子发生的，而是一格一格退。下面这张“回避地图”可以帮助你或家人看清退到了哪一步。

场合	担心的具体情形	常见的回避或“安全行为”
地铁	隧道里发作、下一站太远、门关上出不去	改坐公交、只坐地面线路、必须有人陪
商场	人多、闷、找不到出口、晕倒没人管	只在人少时去、快去快回、一直看出口
排队/结账	中途走开很尴尬、站久了头晕	让家人排、挑最短的队、随时准备撤
电梯	困住、缺氧、发作没人知道	只走楼梯、必须有人同乘
开车	高架、隧道、堵车时发作	只走熟悉的路、不上高速、不开远路
飞机/高铁	起飞后下不去、恐慌无处可逃	改签、取消行程、必须靠过道
独处/离家	出事没人发现	家里必须有人、出门必须报备、随时打电话

很多人的“地图”不是按场合分的，而是按距离分的：家附近 500 米可以去，1 公里就不行；有家人陪可以去，自己不行。**回避地图越画越细，生活就越缩越小。**

和惊恐障碍是什么关系

过去，广场恐惧常被当作惊恐障碍的附属。现在更倾向于把两者看作**可以各自独立、也常常同时出现**的两种问题【指南】：

- 有惊恐障碍的人，因为怕发作，逐渐回避那些“不好逃”的场合，发展出广场恐惧；
- 也有人的广场恐惧并不以惊恐发作为核心，而是怕头晕、怕摔倒、怕失禁、怕迷路、怕被撞，或者单纯怕“一个人应付不了”；
- 两者共病很常见，共病时功能损害通常更重，治疗上需要同时处理“怕身体感觉”和“怕场合”两条线。

需要提醒的是：**没有惊恐发作，不代表不是广场恐惧。** 有些人从来没有典型的心悸濒死感，只是越来越不敢独自出门，也值得被认真评估。

三、回避是怎么把焦虑维持下去的

回避的逻辑很“合理”：不去，就不会发作。短期看，它确实有效——恐惧立刻下降。问题在于，长期看它做了三件事：

1. **它让大脑失去了反证的机会。** 不去坐地铁，就永远不会知道“我其实能坐完三站”。
2. **它让恐惧泛化。** 今天怕地铁，明天怕公交，后天怕走出小区，因为“发作”被当成随时可能发生的灾难。
3. **它让身体更敏感。** 长期不活动、不外出，体能下降，稍微走快一点就心慌，于是更确信“我身体不行”。

这就是焦虑的“负强化”循环：回避带来解脱，解脱强化了回避。**每一次成功躲开，都在给恐惧投票。**

还有一层常被忽略：**过度关注身体**。总在扫描心跳、注意胸口、检查手有没有抖，会把正常的身体波动放大成“要发作了”的信号。注意力越向内，越容易“发现”症状。

四、“陪同”的两面性：家人的难处

家人陪着出门，是最自然的帮助，也是最容易变成“安全行为”的帮助。

好的一面：陪同能让人走出家门、维持基本生活、减少孤立；在治疗早期，它可以是“过渡的拐杖”。

麻烦的一面：如果每次都必须有人陪，大脑学到的就是“我一个人不行”；陪同越周到，独立的机会越少；家人也会被拖进日程，疲惫、怨气、争执随之而来。很多家属说：“我不陪，他就出不了门；我陪，他就永远要我陪。”

更有效的做法，是把“陪着”慢慢改成“并肩练习”：

- **先约定目标**：不是“今天陪你逛街”，而是“今天你自己走完这段路，我在后面跟着”。
- **逐步退后**：从并肩，到隔几米，到在出口等，到不同车厢，到不同地点。
- **不替对方做决定**：不抢着按电梯、不替对方问路、不在对方还没求助时就冲上去。
- **不隐瞒、不欺骗**：“我就在附近”要说清楚在哪里，不要说“我不走”然后偷偷走掉。
- **允许难受**：焦虑上升不等于失败，停留一会儿再离开，比立刻撤退更有价值。

五、面对回避的原则与就医时机

分级、停留、重复

具体方案应由医生或心理治疗师制定，这里只说原则，避免自己“硬闯”。

- **分级**：把“最怕的”和“稍微有点怕的”排成阶梯，从 3 分难度的开始，不是从 10 分开始。
- **停留**：在场景里待够时间，让焦虑自然下降，而不是一难受就撤。撤得太快，大脑只记住了“很可怕”。
- **重复**：一次成功不算数，要重复到“这件事变得平常”。
- **去掉安全行为**：不靠“必须带药”“必须有人”“必须坐门口”来完成，否则学到的是“靠这些东西才行”。
- **不强迫**：被推着、被骂着、被突然丢进恐惧场景，通常只会加重恐惧和不信任。强迫暴露不是治疗，是伤害。

这些原则在5.3 暴露疗法：分级、重复与停止回避里有更细的步骤。

什么时候需要联系医生或去急诊

出现以下情况，请立即拨打 120 或去急诊：

- 突发剧烈胸痛、压榨感、气短、大汗，或疼痛放射到手臂、下颌；
- 晕倒、意识丧失，或反复差点晕倒；
- 在公共场合发作后出现意识模糊、摔倒受伤、无法自行回家；
- 出现自杀念头、自伤行为；
- 长期几乎不出门，出现明显脱水、营养不良、卧床。

建议尽快到精神科或心理科门诊：

- 因为害怕发作而放弃工作、上学、社交，或活动范围明显缩小；
- 出门必须有人陪，否则不敢离开家；
- 反复因头晕、心慌、胸闷就诊，检查结果正常仍不放心；
- 合并情绪低落、失眠、喝酒增多；
- 家人已经被“陪同”拖到无法正常生活。

如果暂时无法出门，可以先考虑**远程医疗**做初始评估（见4.1 就诊渠道与就诊时机），但首次诊断和躯体检查通常仍需要线下完成。

可以照着做的观察清单

给自己：

- ☐ 我最近三个月，有没有因为“怕出事”而放弃某个场合？
- ☐ 我出门是否必须带某样东西、必须有人陪、必须坐某个位置？
- ☐ 我是否总在扫描身体，一有心跳变化就紧张？
- ☐ 我的活动范围，比一年前小了还是大了？
- ☐ 我回避的场合，是“真的危险”，还是“怕发作”？

给家属：

- ☐ 我是否每次都陪，且从不讨论“什么时候可以少陪一点”？
- ☐ 我是否替对方做了本可以自己做的事？
- ☐ 我是否因为不耐烦而说过“你就是矫情”？
- ☐ 我是否愿意和对方、和医生一起定一个“逐步退后”的计划？

六、常见问题与容易踩的坑

“我是不是太胆小了？”不是胆子的问题。广场恐惧是一种可以被识别、被治疗的状态，核心是“逃不掉”的恐惧和回避形成的循环，不是意志力薄弱。

“只要不去那些地方，不就好了？”短期舒服，长期缩小生活。回避会让恐惧泛化，最后连原本不怕的地方也不敢去。

“必须一下子坐到最怕的场景里才叫勇敢吗？”不需要，也不建议。分级、重复、停留，比“一次硬闯”更安全、更持久。硬闯失败一次，可能让人更不敢尝试。

“家人到底该陪还是不陪？”陪，但要“有计划地陪”。目标是让对方逐渐能不靠陪同完成，而不是把陪同变成永久条件。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.4 社交焦虑障碍

开会轮到自己发言，声音发抖、脸发烫、脑子一片空白；在食堂吃饭怕别人看；打电话要先在心里演练三遍；发一条消息反复删改，发完又后悔。很多人把这种状态叫“社恐”，当成性格标签一笑而过。但如果它已经让你推掉面试、放弃升职、躲开聚会，甚至靠喝酒才能开口，那就不是“内向”两个字能概括的。这一页讲社交焦虑障碍的核心、常见场景、回避与“安全行为”、它和内向害羞的区别，以及什么时候该认真对待。

一、核心不是“不爱社交”，是怕被否定

社交焦虑障碍的核心，是**对可能被他人审视、评价的社交场合，产生明显的、持续的恐惧**，并且害怕自己的表现会带来负面评价——出丑、丢脸、被看不起、被拒绝【指南】。

几个要点：

- **怕的是“被看见”**，不一定是社交本身。独处时并不难受，一想到“别人在看我”就紧张。
- **明知过头也控制不住**。很多人清楚“别人没那么在意我”，但身体反应照样来。
- **持续时间长**。通常要持续 6 个月以上，且造成明显痛苦或功能损害，才考虑诊断。
- **不是所有场合都一样**。有人只怕当众发言（表演型），有人怕几乎所有需要互动的场合（广泛型）。

二、常见场景：从“发言”到“吃饭”

社交焦虑的触发点比想象中细。下面这张表列出常见场景和背后的担心，你可以对照看看自己属于哪一类。

场景	典型的担心	常见表现
当众发言/汇报	说错话、被提问答不上、声音抖被听出来	提前几天焦虑、背稿、不敢抬头
参加聚会/饭局	没话说、尴尬、被冷落	早到或迟到、坐角落、提前离场
当众进食/喝水	手抖、呛到、被看	只点不需要动手的菜、不喝汤
当众写字/操作	手抖被发现、做错被看笑话	让别人签、避开需要现场操作的场合
打电话/视频	突然被问住、语气不对	只发消息、不接陌生电话
见陌生人/约会	被拒绝、没魅力、冷场	不主动、靠对方找话题
面试/答辩	被否定、被追问	拖延投简历、临场发挥失常
路上遇到熟人	不知道说什么、被评价	绕路、假装没看见

注意最后一条。社交焦虑不只发生在“大场面”，也发生在走廊、电梯、小区门口这些日常瞬间。**越是日常，越容易被忽视，也越容易被当成“性格古怪”。**

三、回避与“安全行为”：看不见的拐杖

为了不紧张，人会做很多事，这些事叫**安全行为**——做了才敢进入场合的小动作：

- 提前把要说的话背下来，逐字念；
- 坐在最边上、靠门的位置；
- 一直看手机，避免眼神接触；
- 穿高领、不化妆、不穿亮色，尽量不引人注意；
- 全程不说话，或只和熟人说话；
- 事先喝酒、吃镇静药；
- 反复检查自己的表现，事后在脑子里“回放”很久。

安全行为的问题是：**它们让你把“没出事”归功于拐杖，而不是归功于自己。** 下次还得靠，而且越来越依赖。更麻烦的是“事后反刍”——事后反复回放自己哪句话说错了、表情是不是很怪，把一次普通互动加工成“我今天丢死人了”。

还有一层：社交焦虑的人常把注意力放在**自己身上**（心跳快不快、脸红不红、手抖不抖），而不是放在对话上。注意力一转向内，就更容易“发现”自己表现不好，也更容易错过对方其实挺友好的信号。

四、和内向、害羞的区别

“内向”是一种性格偏好：独处能恢复精力，社交不是不能，是没那么想要。“害羞”是一种气质倾向：面对陌生人和新情境时先退缩、先观察，慢慢能适应。

社交焦虑障碍则是**怕被负面评价，并因此痛苦、回避、影响生活**。三者可以重叠，但不是一回事。

维度	内向	害羞	社交焦虑障碍
核心	偏好独处、社交耗能	慢热、面对新情境退缩	怕被评价、怕出丑
是否痛苦	通常不痛苦	轻度、短暂	明显痛苦，常伴躯体症状
是否想社交	不太想，但需要时能应对	想，但需要时间	想，但怕，常常躲
独处时	放松、恢复	放松	可能仍在反刍、担心下次
对生活的影响	小	小	可能影响学业、工作、恋爱
是否需要治疗	通常不需要	多数不需要	达到诊断标准时需要

一个简单的自问：**如果没有人会评价你，你还怕吗？** 内向的人多半会答“那挺好啊”；社交焦虑的人常常答“那就不怕了”——这提示怕的是评价，不是社交本身。

五、共病、评估与就医时机

抑郁和酒精最常一起出现

社交焦虑常常起病早（多在青少年期），如果不处理，容易慢性化，并带来几个常见的共病【指南】：

- **抑郁**：长期回避、孤立、觉得自己不行，容易发展成抑郁；两者共病时自杀风险升高。
- **酒精使用**：酒能短暂“壮胆”，于是有人开始“喝一点再去”。这条路很容易滑向依赖，而酒精本身又会加重焦虑和失眠，形成恶性循环。
- **其他焦虑障碍**：惊恐障碍、广泛性焦虑、特定恐惧常同时存在。
- **回避型人格特质**：长期的社交回避可能让人越来越孤立，但两者不是同一个诊断。

需要特别提醒：**用酒来应付社交场合，是社交焦虑最常见的“自我治疗”，也是最需要早点跟医生说的事。** 酒精依赖的戒断可能危及生命，不能自行硬戒。

量表只是筛查，不是诊断

常用的自评量表有 LSAS（利博维茨社交焦虑量表）和 SPIN（社交恐惧量表），它们能帮助评估范围、严重度和治疗前后的变化【指南】。但和所有自评量表一样：

- 它们不能替代医生的临床访谈；
- 不能区分社交焦虑和抑郁、回避型人格、单纯害羞；
- 分数高不代表一定有病，分数低也不代表不痛苦；
- 不能用来自己决定吃不吃药。

量表最好的用法，是**填好带去给医生看**，作为描述“我在哪些场合、怕到什么程度”的辅助材料。具体条目和计分见13.2 常用量表：GAD-7、PDSS、LSAS、SPIN。

什么时候需要联系医生或去急诊

出现以下情况，请立即拨打 120 或去急诊：

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了计划；
- 靠大量饮酒才能应对社交，停酒后出现手抖、大汗、幻觉、抽搐（酒精戒断可危及生命）；
- 服药后出现高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识改变；
- 在公共场合因过度换气晕倒、摔倒受伤。

建议尽快到精神科或心理科门诊：

- 因为怕被评价而回避上学、上班、面试、恋爱；
- 一提到要发言就提前几天失眠、恶心、想吐；
- 必须喝酒才能社交，或酒量明显增加；
- 合并持续的情绪低落、兴趣减退；

- 已经影响到工作表现或人际关系，自己却一直用“我就是内向”解释。

如果只是偶尔紧张、不影响生活，可以先通过阅读、练习和自助资源调整；如果已经“躲”成了生活的主旋律，就值得一次专业评估。

可以照着做的观察清单

- ☐ 我害怕的场合，是不是都有一个共同点——可能被人评价？
- ☐ 我在这些场合，会做什么来“保命”（背稿、坐角落、看手机、喝酒）？
- ☐ 事后我会不会反复回放，越想越觉得自己糟糕？
- ☐ 我有没有因为回避，放弃过机会（面试、表白、发言、升职）？
- ☐ 我是否靠酒精或药物才能应付社交？
- ☐ 我独处时是放松的，还是仍在担心下一次？
- ☐ 这种状态持续多久了？半年以上吗？

六、常见问题与容易踩的坑

“多去几次就习惯了，不用治。”对轻度害羞可能有用，对社交焦虑障碍往往不够。没有方法的“多去”，可能只是反复体验失败，反而强化“我不行”。结构化的心理治疗（尤其是认知行为治疗和暴露练习）有明确证据【指南】。

“我是不是性格有问题？”不是。社交焦虑是一种可以被治疗的状态，和性格有关，但不是人格缺陷。把它当成“我就是这样的人”，会让人错过本来可以改善的部分。

“喝酒能壮胆，是不是可以偶尔用？”偶尔一杯和“靠酒才能出门”是两回事。后者是依赖的高风险信号，而且酒精会加重焦虑、破坏睡眠。不要用酒当药。

“吃药会不会上瘾？”一线药物通常不是苯二氮䓬类，成瘾风险与药物种类有关。具体用什么、用多久，必须由医生评估，不要自行购买或停用。相关风险见6.4 苯二氮䓬类：短期救火与依赖风险。

参考来源

- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- Liebowitz MR. Social phobia. Modern Problems of Pharmacopsychiatry, 1987.（LSAS 量表原始文献）

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.5 特定恐惧、分离焦虑与选择性缄默

怕打针怕到晕过去、怕坐飞机怕到取消行程、孩子上学抱着妈妈不撒手、在家里话很多一到学校就一个字不说——这些表现看起来差别很大，但都属于焦虑障碍谱系里“怕得很具体、躲得很明显”的一类。这一页讲三种情况：特定恐惧、分离焦虑、选择性缄默，重点是怎么识别、什么时候该就医，以及为什么“逼一逼就适应了”往往适得其反。

一、特定恐惧：怕的对象很明确

特定恐惧是指对某个特定对象或情境产生明显、持续的恐惧，一遇到就几乎立刻紧张，能躲就躲，而且这种恐惧与实际危险不成比例，通常持续 6 个月以上并影响生活【指南】。

常见的有五类：

类型	例子	特点
动物型	狗、蛇、蜘蛛、昆虫	常起病于童年，怕被咬、怕突然出现
自然环境型	高处、雷雨、水、黑暗	怕失控、怕坠落、怕被困
血液-注射-损伤型	打针、抽血、看到伤口、牙科	常出现头晕、恶心、面色苍白，可能晕倒
情境型	飞机、电梯、隧道、开车、幽闭空间	怕逃不掉、怕发作、怕出事
其他	呕吐、窒息、生病、玩偶、气球	怕特定身体反应或物体

血液-注射-损伤型需要单独说一句：它和其他类型不同，很多人不是心跳加快，而是先心跳加快、随后血压下降，出现头晕、眼前发黑甚至晕厥。这解释了为什么有人“一打针就晕”。这种情况有专门的应对方法（如应用肌肉紧张法），可以在就诊时请医生或心理治疗师指导，不要靠“硬扛”。

特定恐惧的特点是“知道不合理，但控制不住”。很多人一辈子绕着它走：不坐飞机、不体检、不洗牙、不住高层。只要不影响生活，未必要治疗；但一旦影响健康（比如因为怕针而不去抽血、因为怕电梯而不去复诊），就值得处理。

二、分离焦虑：不只是小孩子的事

分离焦虑的核心，是**与依恋对象（通常是父母，也可能是伴侣、孩子）分离时产生过度、持续的痛苦和担忧**。

在儿童身上，常见表现是：

- 离开家、离开父母就哭闹、发脾气、身体不舒服；
- 反复担心父母会出事、会离开自己；
- 拒绝独自睡觉、拒绝去学校、拒绝去朋友家；
- 做与分离有关的噩梦；
- 分离前就表现腹痛、头痛、恶心，甚至呕吐；

- 紧跟、黏人，父母上厕所都要跟着。

要区分“正常的发展阶段”和“障碍”。幼儿在特定年龄出现分离哭闹是正常的，通常会随年龄缓解。判断要看四点：**是否与年龄不相称、是否持续（儿童青少年通常至少 4 周）、是否造成明显痛苦、是否影响上学和日常生活【指南】**。

分离焦虑也不只发生在儿童。成人也会有，表现为过度担心伴侣出事、不敢出差、不敢独居、孩子上学后坐立不安。成人诊断通常要求持续 6 个月以上。

三、选择性缄默：不是“不想说”，是“说不出来”

选择性缄默是指：孩子在**某些场合能正常说话**（通常是在家里、和最亲近的人），但在**另一些需要说话的场合**（学校、陌生人面前）持续地不说话。注意几个关键词：

- **选择性**：不是完全不会说，而是分场合；
- **持续**：通常至少一个月；入园/入学初期要观察是否持续存在，不能把最初几天的适应困难直接当成选择性缄默；
- **影响**：已经影响学习、社交或日常交流；
- **不是不会**：孩子具备相应的语言能力，也不是故意对抗。

选择性缄默常被误认为“胆小”“没礼貌”“故意不理人”，甚至被老师批评。实际上，它和社交焦虑关系密切，很多孩子同时有社交焦虑的表现，比如回避眼神、僵硬、躲藏、在需要说话时脸红或发抖。它也可能和语言发育、双语环境、入学适应等因素交织在一起。

最关键的一句话：不要强迫孩子说话。 被点名、被追问、被承诺“说了就奖励”、被当众比较，往往会让孩子更紧张，把“说话”和“威胁”绑得更紧。有效的做法通常是：先降低压力、建立安全感，再从“能发出声音”“能耳语”“能和一个人说”这样的小步骤开始，由专业人员指导逐步扩展。

四、什么时候该就医

情况	建议
怕打针、怕狗，但能绕开，不影响生活	可以先观察，不必急于治疗
因为怕而回避必要的医疗（抽血、体检、牙科）	建议就诊，处理恐惧本身
孩子分离哭闹，但能上学、能睡觉，几周内缓解	多数是发展性，可先支持、观察
分离焦虑持续一个月以上，拒绝上学、不敢独睡、频繁躯体不适	建议儿童精神科或心理科评估
孩子在某些场合完全不说话，持续一个月以上，影响课堂	建议尽快评估，越早干预越好
成人因分离焦虑无法工作、无法独处	建议精神科或心理科评估
出现晕厥、摔倒受伤、拒食拒水、自伤	尽快就医或急诊

五、不要强迫暴露，以及什么时候该求助

为什么“推一把”常常失败

“把他扔进泳池就会游了”“多上台几次就不怕了”“不说话就别回家”——这类做法在短期内可能“逼”出一次行为，但代价往往是更高的恐惧、更强的回避，甚至对帮助者失去信任。

对这三类问题，更稳妥的原则是：

- **分级**：从最不害怕的一小步开始，而不是从最怕的开始；
- **允许退出**：事先说好“难受可以说停”，而不是“必须撑住”；
- **不欺骗**：不偷偷离开、不骗孩子“妈妈在门口”然后走掉，这会破坏安全感；
- **奖励靠近，不只奖励结果**：孩子愿意走到校门口、愿意小声说一个字，都值得肯定；
- **不羞辱**：不说“这么大了还怕”“你看别人都不怕”；
- **专业指导**：暴露不是“硬闯”，具体节奏需要评估后制定。

对选择性缄默，尤其要避免“当众要求说话”。可以先从非言语互动、平行游戏、一对一、短时分离开始，让孩子在安全关系里一点点“出声”。这部分的具体方法属于专业治疗范畴，本页只讲原则。

什么时候需要联系医生或去急诊

出现以下情况，请立即拨打 120 或去急诊：

- 因恐惧导致晕厥、摔倒、受伤；
- 孩子长时间拒食、拒水，出现脱水、精神萎靡；
- 出现自伤行为或自杀念头；
- 分离时出现剧烈攻击、破坏、走失风险；
- 服药后出现高热、意识改变、肌肉僵硬。

建议尽快到儿童精神科、精神科或心理科门诊：

- 孩子持续一个月以上在特定场合完全不说话；
- 分离焦虑导致长期拒绝上学、无法独睡、频繁腹痛头痛；
- 成人因害怕分离无法正常工作、无法独处；
- 特定恐惧已经妨碍必要的医疗、出行或工作；
- 家长已经尝试多种办法，越劝越糟，亲子冲突加剧。

对儿童问题，**家长先就诊往往比“等孩子愿意”更有效**。医生可以先和家长工作，再安排适合孩子的评估方式。

给家长和成人的观察清单

- ☐ 害怕的对象/场合是否明确、是否每次都触发？
- ☐ 是否已经到了“能躲就躲”的程度？躲开了多少生活？

- ☐ 这种害怕持续多久了？有没有超过半年（儿童分离焦虑超过一个月）？
- ☐ 是否出现身体反应：腹痛、头痛、恶心、晕倒、发抖？
- ☐ 孩子在不同场合的说话表现，差别有多大？
- ☐ 家里是否有人长期用“逼”“激”“比”的方式处理？
- ☐ 学校是否了解情况，是否愿意配合调整？
- ☐ 有没有因为这个问题，错过疫苗、体检、上学、旅行？

六、常见问题与容易踩的坑

“孩子就是胆小，长大就好了。”有一部分会缓解，但持续回避、拒绝上学、完全不说话，很少靠“等”解决。越早干预，越省力。

“选择性缄默是不是自闭症？”不是一回事，但两者可能同时存在，也可能被混淆。自闭症的核心是社交沟通的持续困难、兴趣狭窄和重复行为；选择性缄默是“分场合不说话”，孩子在其他场合语言正常。判断需要专业评估，不要自行贴标签。

“分离焦虑是不是家长太宠了？”不是简单的“宠”造成的。气质、遗传、生活变动（搬家、转学、二胎、疾病）、养育方式都可能有关。把责任推给家长，通常只会让家庭更不敢求助。

“特定恐惧必须做暴露吗？”不是所有人都需要治疗。影响生活时，暴露是有效方法之一，但要在专业指导下分级进行；血液-注射-损伤型还需要针对晕厥的特殊处理。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.6 儿童青少年焦虑与躯体化表现

孩子说肚子疼，去医院查了血、做了 B 超，结果都正常，第二天早上又疼；一到周日晚上就开始头痛、恶心，周一早上怎么都叫不起来；平时挺活泼，一到考试就发烧、拉肚子。很多家长第一反应是“是不是装的”“是不是不想上学”。这一页讲儿童青少年的焦虑为什么常从身体表现出来、不同年龄的孩子各是什么样子、“拒学”背后可能是什么，以及家长和学校可以怎么观察、什么时候该带孩子就医。

一、孩子的焦虑，常常先“疼”出来

成年人焦虑会说“我很担心”，孩子往往说不清，身体先替他们表达。这在医学上叫**躯体化**：情绪上的紧张，通过身体症状表现出来。

常见的有：反复腹痛（尤其是脐周）、头痛、恶心、呕吐、食欲下降、胸闷、心慌、头晕、乏力、入睡困难、夜间惊醒。特点是：

- **查不出器质性原因**，或检查结果与症状严重程度不匹配；
- **和情境有关**：上学前、考试前、分离时加重，周末或假期减轻；
- **反复出现**，持续数周到数月；
- **孩子自己也很苦恼**，不是“演给谁看”。

需要强调的是：**“查不出原因”不等于“没有原因”，更不等于“装病”。** 孩子的疼痛是真实感受到的，只是驱动它的可能是焦虑，而不是阑尾或胃炎。理解这一点，家长的反应会完全不同——从“你别装了”变成“你是不是有什么担心的事”。

当然，前提是**该查的查过**。腹痛、头痛也可能是器质性疾病，尤其是伴发热、体重下降、夜间痛醒、呕吐物带血、走路不稳、视力改变时，必须先看儿科。

二、不同年龄，表现不一样

年龄段	常见表现	容易被误认为
学龄前（3–6 岁）	分离时大哭、黏人、夜惊、噩梦、退行（尿床、要喂饭）、反复问“你会不会走”	任性、被宠坏
学龄期（6–12 岁）	腹痛头痛、拒绝上学、反复确认、怕犯错、怕老师批评、上课不敢发言	装病、懒惰、不听话
青少年（12–18 岁）	社交回避、考试焦虑、过度担心未来、易怒、失眠、回避集体活动、用手机逃避	叛逆、脾气差、不合群

青春期的焦虑还常披着“易怒”的外衣。孩子不说不安，而是摔门、顶嘴、把自己关在房间。家长如果只看到对抗，很容易错过背后的恐惧。

三、“拒学”不是懒：先看它在回避什么

拒学（school refusal）是指孩子因为情绪痛苦而拒绝或难以到校，家长通常是知情的，孩子在家期间可能并无违纪行为。它和“逃学”不同：逃学的孩子往往隐瞒家长、在外游荡，也不一定有焦虑。

拒学背后常见四种功能，处理方式完全不同：

1. **回避焦虑**：怕分离、怕同学、怕被老师提问、怕考试。最常见。
2. **逃避社交或评价**：被孤立、被嘲笑、被霸凌，或社交焦虑。
3. **寻求家长关注**：一闹就能留在家里、得到陪伴。
4. **获得实际好处**：在家可以玩手机、不用面对困难。

这不是说孩子在“算计”，而是说**行为是被结果维持的**。如果每次拒学都能换来“留在家里+父母陪伴+不用面对”，这个行为就会被强化。所以处理拒学，既要减轻焦虑，也要调整“留在家里”的收益，两条腿走路。【临床经验】

还要留意**霸凌**和**学业压力**。有些孩子不是怕学校，是怕学校里的某个人、某一节课。先问清楚“学校里有没有让你难受的事”，比直接说“必须去”更有用。

四、三类常见的儿童青少年焦虑

分离焦虑：怕和父母分开，怕父母出事，拒绝独睡、拒绝上学、出门紧跟。幼儿期常见，若持续一个月以上并影响上学，需要评估（详见2.5 特定恐惧、分离焦虑与选择性缄默）。

社交焦虑：怕被同学看、怕发言、怕当众吃饭、怕被老师点名；可能表现为上课不说话、不参加集体活动、课间独自待着。常起病于青春期前后，容易被当成“内向”。

考试焦虑：考前失眠、心慌、腹泻、脑子空白；考后反复对答案、担心成绩。适度的紧张有助于发挥，但若每次考试都出现明显身体反应、影响发挥、并持续回避，就值得关注。

五、怎么区分、怎么观察、什么时候就医

和 ADHD、ASD、抑郁怎么区分

这几种情况常被混淆，也可能同时存在。下面这张表只作方向性参考，不能替代专业评估。

情况	核心特征	和焦虑的区分点
ADHD	注意力不集中、多动、冲动，跨场景持续	坐不住是“停不下来”，不是“怕被看”；焦虑的孩子在安全环境能安静
ASD	社交沟通持续困难、兴趣狭窄、重复刻板行为	社交困难是“读不懂规则”，不是“怕被评价”；焦虑常是共病
抑郁	情绪低落、兴趣减退、精力下降、自我否定	焦虑以“怕”为主，抑郁以“没劲、没意思”为主；两者常并存
焦虑	过度担忧、回避、躯体紧张	症状随压力波动，回避特定情境

需要提醒：**焦虑的孩子也可能注意力差**（因为脑子里在担心），**ADHD 的孩子也可能因为长期受挫而焦虑**。不要凭一张表下结论，学校老师、家长、医生三方的信息合起来看，才比较可靠。

家长和学校可以怎么观察

家长：

- ☐ 症状出现的规律：是不是总在周日晚上、考试前、分离时加重？
- ☐ 持续多久了：几周，还是几个月？
- ☐ 影响到什么程度：能不能上学、能不能睡觉、能不能和朋友玩？
- ☐ 孩子有没有说过“怕”“担心”“不想去”，具体怕什么？
- ☐ 家里最近有没有变动：搬家、转学、二胎、生病、父母冲突？
- ☐ 孩子有没有被欺负、被排挤、被老师批评？
- ☐ 我自己的反应是什么：安慰、追问、发火、妥协、还是回避？

学校：

- ☐ 孩子在课堂、课间、集体活动中的表现是否一致？
- ☐ 有没有突然不说话、不举手、不参加活动？
- ☐ 有没有被孤立、被嘲笑、被霸凌的迹象？
- ☐ 考试前后有没有明显身体不适或请假增多？
- ☐ 家长反映的情况，学校是否愿意配合调整（如暂时减少当众提问）？

什么时候需要联系医生或去急诊

出现以下情况，请立即就医或拨打 120：

- 剧烈腹痛、持续呕吐、便血、发热、意识改变；
- 体重明显下降、拒绝进食饮水、出现脱水；
- 出现自伤行为、自杀念头或计划；
- 突然出现走路不稳、视力改变、抽搐；
- 误服药物或过量服药。

建议尽快到儿童精神科、心理科或儿科门诊：

- 躯体症状反复，检查无明显异常，却持续影响上学；
- 拒学超过一周，或反复发作；
- 分离时反应剧烈，无法独睡、无法出门；
- 在特定场合完全不说话，持续一个月以上；
- 情绪低落、兴趣减退、睡眠明显改变；
- 家长已经尝试劝说、奖励、惩罚，都没有效果，亲子冲突加剧。

不要等“孩子自己想通”。 儿童的焦虑越早干预，越容易在较短时间内改善；拖到青春期，常合并抑郁、拒学、网络使用问题，处理起来更复杂。【指南】

六、常见问题与容易踩的坑

“查不出毛病，是不是就不用管了？”不是。查不出器质性问题，恰恰提示要关注情绪和压力。忽视躯体化，孩子可能学会“只有身体出问题，大人才会重视”。

“是不是我太惯着他了？”养育方式有影响，但不是唯一原因。气质、遗传、学校环境、生活事件都参与其中。把责任全归给家长，只会让家长更不敢求助，也帮不到孩子。

“不上学就让他待在家里，等他想通。”长期待在家里，回避会固化，作息会乱，社交会退。更有效的是“减少压力+逐步返校+专业支持”同时进行，而不是二选一。

“要不要吃药？”轻度焦虑通常先做心理治疗和家庭、学校调整；中重度或合并抑郁、严重影响功能时，医生可能考虑药物。儿童用药需要儿童精神科医生评估，家长不要自行购买或停用。

“孩子会不会是装的？”躯体症状是真实体验，但“获得关注、回避学校”的收益也可能在维持行为。这两件事可以同时成立。处理时既不指责“装”，也不只看身体，而是把情绪、行为和环境一起看。

参考来源

- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- Birmaher B, et al. The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED). Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 1997.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 3：病因与机制

焦虑不是“想出来的”，也不是单一原因造成的。这一模块讲遗传、神经生物学、学习、认知和环境如何叠加。

3.1 遗传、气质与家族风险

如果家里有人得过焦虑障碍，你可能会担心两件事：我会不会也得？我是不是把它传给了孩子？这一页想把这两个担心拆开讲清楚：家族聚集有多明显、遗传度到底是什么意思、气质在其中扮演什么角色，以及为什么“有风险”不等于“一定会发生”。读完你大概能分辨，哪些说法有研究依据，哪些只是吓唬人的推论。

先给结论

焦虑障碍确实有家族聚集现象，遗传因素也确实参与其中，但它不是单基因决定的病，不存在“焦虑基因”这回事。目前没有任何基因检测能预测你会不会得焦虑障碍，也没有任何检测能指导该吃哪种药。

更重要的是：遗传给的是“敏感度”，不是“剧本”。一个人可能天生对威胁更警觉，但是否发展成障碍、什么时候发展、严重到什么程度，还取决于后来的经历、压力、学习和社会支持。这些因素里，有一部分是可以改变的。

如果把焦虑理解成“命里注定”，人会放弃努力；如果理解成“全是环境造成的”，又会忽略真实的生物学差异。两种简化都不准确。

家族聚集：看到的事实和看不到的原因

家族研究反复发现，焦虑障碍患者的一级亲属（父母、子女、兄弟姐妹）患病风险高于一般人群，而且不同焦虑类型之间还会交叉聚集——比如家里有人是社交焦虑，亲属中出现惊恐或广泛性焦虑的风险也可能略高。抑郁、物质使用问题也常在同一个家族里出现。【研究】

但“家族聚集”不等于“遗传”。一个家庭共享的东西太多了：居住环境、经济状况、教养方式、对危险的看法、遇到困难时的应对习惯，甚至“身体不舒服就往坏处想”这种家庭内部的解释风格。孩子在这些环境里长大，学到的可能不是某个基因，而是一套评估威胁的方式。

这也是为什么家族史只能作为“风险提示”，不能当作“预言”。有家族史的人里，大多数人一生并不会发展成焦虑障碍；没有家族史的人，同样可能因为后来的经历而发病。

遗传度：一个最容易被误读的词

“遗传度”是行为遗传学里的一个群体指标，意思是：在某个特定人群中，某一时刻观察到的差异，有多大比例可以归因于基因差异。它描述的是群体，不是个人。

所以“焦虑障碍遗传度大约三成”这句话，不可以说成“你的焦虑有三成来自基因”。对任何一个具体的人，这个百分比都不成立——一个人的焦虑不是由若干份基因和环境按比例勾兑出来的。

双生子研究和家系研究给出的估计，不同病种、不同研究之间差别不小，大致落在中等水平，通常被描述为“三成上下”，惊恐障碍的估计常略高一些。【研究】这些数字需要谨慎看待，原因有几个：

- 估计值依赖样本。如果研究人群的环境比较相似，基因的作用就会被算得更大；环境差异越大，基因的占比看起来就越小。
- 焦虑障碍是一组病，不是一种病。广泛性焦虑、惊恐障碍、社交焦虑、特定恐惧的遗传结构并不完全相同。
- 遗传度不等于可改变性。身高的遗传度很高，但营养和疾病仍然能显著影响最终身高。遗传度高，只是说明“在这个环境里，基因差异解释了较多差异”，不说明“干预没用”。

目前的全基因组研究提示，焦虑相关特质涉及大量效应很小的基因变异，每个变异贡献一点点，没有哪个基因能单独决定结果。这类研究离临床应用还有距离，不能拿来指导个人的诊断或用药。【研究】

行为抑制气质：慢热的孩子

在发展心理学里，有一个被研究得比较多的气质叫“行为抑制”（behavioral inhibition）。它描述的是幼儿面对陌生环境、陌生人、新玩具时的典型反应：先退后、紧贴大人、沉默观察、身体紧绷，需要较长时间才能放松。有的孩子反应强烈，有的孩子只是慢热一点，构成一个连续的谱系。【研究】

纵向研究提示，行为抑制明显的孩子，后来出现社交焦虑的风险相对更高。但这句话有两个必须补上的后半句：

第一，大多数行为抑制的孩子并不会发展成焦虑障碍。气质是起点，不是终点。

第二，气质本身不是缺陷。谨慎、先观察再行动，在很多情境里是适应性的。问题不在于孩子慢热，而在于慢热如果被反复强化成“你不行”“外面很危险”，或者被硬推、被嘲笑，才更容易走向回避。

对这类孩子，有效的做法通常不是“多推几次就好了”，也不是“干脆别去了”，而是小步、可预测、有支持的接触：提前告诉他会发生什么、允许他先在场边看、约定一个可以退出的信号、每次比上次多待一会儿。这套小步接触的思路，和暴露疗法的分级练习是同一个方向。

基因和环境怎么交互

把基因和环境当成两笔独立的账，是常见的误解。实际上它们一直在互相塑造，至少有四种交互方式值得知道：

素质-压力模型：先天的敏感性加上后来的压力事件。敏感度高的人，可能在较小的压力下就出现明显焦虑；敏感度低的人，需要更大的压力。

差别易感性：同一类基因变异，在高压环境里提高风险，在支持性环境里却可能带来更好的适应。换句话说，某些“风险基因”更像“对环境更敏感”，而不是“注定出问题”。这个说法目前仍有争议，属于有待验证的框架。【待验证】

基因-环境相关：气质会影响一个人选择什么样的环境。一个怕被评价的孩子，会少参加聚会、少发言、少争取机会；练习少了，社交技能和信心就更难长出来，于是更怕。环境不是别人硬塞给他的，有一部分是他自己一步步走进去的。这一点很重要，因为它说明“回避”会自我加固。

表观遗传：早期压力可能通过基因表达的调控留下影响。这个方向在动物研究里比较清楚，在人类身上的证据还有限，不能据此推断“童年经历已经写死在身体里”。【待验证】

这四种交互指向同一个结论：基因提供倾向，环境提供触发器，学习提供维持机制。三者叠加，才构成一个人真实的焦虑轨迹。

一张表：常见说法和更准确的理解

你常听到的说法	哪里不准确	更准确的理解
焦虑症会遗传，我肯定也会得	把“风险升高”说成“必然发生”	家族史提高风险，但多数有家族史的人不会发病
抽个血查基因，就知道会不会焦虑	目前没有这样的检测	焦虑障碍是多基因加环境，不存在预测性基因检测
遗传度三成，说明三成是基因	把群体指标套到个人身上	遗传度描述群体差异，不能拆成个人的百分比
孩子从小慢热，是性格有问题	把气质当缺陷	行为抑制是气质差异，可以被支持，不需要被“纠正”
都是父母传给我的，改不了了	忽略环境和学习的作用	基因、环境、学习共同作用，后两者可以干预

知道这些，对治疗和养育有什么用

对患者本人：家族史可以成为“早点识别、早点处理”的理由，而不是“反正没救”的理由。如果你发现自己从二十几岁开始越来越怕社交场合，而家里也有人类似，这提示值得尽早找专业人员评估，而不是再忍五年。

对用药：一级亲属对某种药物反应特别好或特别差，有时会被医生当作参考，但这只是参考，不能保证你也会有同样反应。个体差异很大，以处方和面诊判断为准。【临床经验】

对父母：孩子有焦虑，不等于你“养错了”。反过来，父母也不必因为自己的焦虑而自责到不敢管教。真正有帮助的是：不替孩子回避、不嘲笑他的害怕、也不硬把他推到最怕的场合；把大目标拆小，陪他一次次完成。如果父母自己也在焦虑中，优先把自己的治疗安排上，这本身就是对孩子的帮助。

对备孕和孕期：有家族史不构成“不该生孩子”的理由。更实际的做法是提前和医生讨论：孕期如果焦虑加重怎么办、产后如何监测、哺乳期用药如何权衡。这些问题有讨论空间，不需要靠“赌”来解决。

可照做的清单

- ☐ 把家族里的情况写下来：谁、什么表现、大概从几岁开始、有没有治疗过。下次就诊时带给医生，比“好像我姑姑也这样”有用得多。
- ☐ 区分“家族史”和“家庭习惯”：家里是不是有一套“凡事往最坏想”的说法？这套说法可以改。
- ☐ 如果孩子明显慢热，先做“预告”和“陪在场边”，不硬推、不贴“胆小”的标签。
- ☐ 不购买任何宣称能检测焦虑基因的产品，也不据此调整治疗。
- ☐ 记录自己回避的场景清单，把它当作后面治疗的路线图，而不是羞耻清单。
- ☐ 家里有人正在治疗时，不拿“我们家都这样”当劝阻他吃药或做心理治疗的理由。

什么时候需要联系医生或寻求额外帮助

- 家族中有人因焦虑障碍住院、自杀未遂，或正在长期服用镇静类药物：建议尽早做一次专业评估，不要等到症状严重。
- 孩子出现持续两周以上的拒学、躯体不适（头痛、腹痛）却查不出原因，或明显退缩：看儿童精神科或心理科。
- 你自己出现“我肯定会像某某一样毁掉”的强烈预感，并因此失眠、无法工作：这不是“想多了”，值得就诊。
- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划：不要独处，立即联系信任的人，拨打 120 或去最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

常见问题

我父母都没有焦虑症，为什么我有？遗传只是风险因素之一。没有家族史的人，也可能因为长期压力、创伤、躯体疾病、药物或物质使用而出现焦虑障碍。家族史阴性不排除诊断。

要不要把家族史告诉伴侣或孩子？这属于个人选择。它的实际价值在于：让家人知道“这类问题在我们家出现得可能多一点”，从而更早识别、少一点指责。它不是“污点”，也不该被用来阻止恋爱、生育或求职。

知道“遗传”这件事，会不会让我更绝望？短期可能会。但更常见的反应是松一口气：原来不是我不够坚强。把焦虑理解成“体质敏感加环境触发加回避维持”，接下来的行动反而清楚了——该评估就评估、该治疗就治疗、该练习就练习。

我小时候一点也不慢热，为什么还是焦虑？行为抑制只是气质的一种，不是焦虑的唯一入口。青春期后的社交经验、重大事件、慢性压力、躯体疾病都可能改变轨迹。气质解释的是“起点差异”，不是“全部原因”。

参考来源

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NIMH. Anxiety Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.2 神经生物学：杏仁核、HPA 轴与递质

很多患者第一次听到“你这是神经递质的问题”，会觉得既安心又害怕：安心的是，原来这是身体的事，不是我软弱；害怕的是，脑子里出了问题，是不是修不好了。这一页讲焦虑在神经系统里大致发生了什么，也讲这些解释能说到哪一步、不能说到哪一步。读完你会知道，为什么“补一补递质”这种说法过于简单。

先把“化学失衡”放下

“焦虑是脑子里某种化学物质太少，吃药就是把它补回来”——这个说法流传很广，但它不准确，而且容易带来两个误解：一是以为吃药像往油箱里加油，加够了就好；二是以为只要查出“缺什么”就能对症补充。

更接近事实的描述是：焦虑涉及的是一套**回路**和**调节系统**，包括威胁检测、身体感觉的解读、应激激素的分泌、警觉水平的维持，以及负责“刹车”和“复核”的通路。神经递质是这套系统里的信号分子，它们影响回路怎么运转，但不是孤立的“情绪液体”。

一个常被忽略的证据是：SSRI 类药物在服药几小时内就改变了突触间隙的 5-羟色胺水平，但临床效果通常要两三周甚至更久才出现。【指南】如果焦虑只是“缺 5-羟色胺”，那不应该有这种时间差。更合理的解释是，药物先改变信号，再通过下游的受体适应和神经可塑性变化，慢慢改变回路的工作方式。这也解释了为什么不能“今天吃、明天评估”。

威胁检测回路：报警器、复核员和体感地图

杏仁核常被叫作大脑的“烟雾报警器”。它不需要你想清楚就能启动：一个突然的声音、一张愤怒的脸、心跳突然加快，都可能在几百毫秒内让它活跃，然后通过下丘脑和脑干启动心跳加快、血压上升、肌肉紧绷、瞳孔放大。它的作用是“先反应，后解释”，这在真实危险面前是救命的。

前额叶，尤其是腹内侧前额叶，更像“复核员”。它接收来自杏仁核的信号，结合情境判断“这是真危险还是误报”，然后向下发出抑制信号。焦虑的人常被描述为“报警器太灵敏、复核员压不住”，但更准确的说法是两者之间的**连接效率**和**情境校准**出了问题。【研究】这不是“前额叶坏了”，而是在特定情境下调节不足。

岛叶负责“内感受”，也就是把心跳、呼吸、胃肠蠕动、肌肉张力这些身体内部信号整合成一张“我现在身体怎么样”的地图。焦虑的人常常这张地图过于放大：心跳快一点就被读成“要出事了”，胃里翻一下就被读成“要吐了”。岛叶的过度活跃与惊恐、疑病体验有关。【研究】

蓝斑是脑干里去甲肾上腺素的主要来源，负责警觉和唤醒。它一活跃，人就进入“扫描危险”的状态：注意力变窄、对突然的刺激更敏感、睡不踏实。长期焦虑的人常常处在一种“低度但持续的警觉”里，这也是为什么他们会说“我明明没在想什么，但就是放松不下来”。

系统或结构	平时做什么	焦虑时可能怎样	你会感觉到什么
杏仁核	快速识别威胁，启动反应	对模糊信号也报警	一惊一乍、容易受吓
前额叶	结合情境复核，抑制误报	调节不足或连接效率下降	明知没必要，仍压不住
岛叶	整合身体内部信号	把正常体感放大成危险	心悸、胸闷、胃部不适
蓝斑与去甲肾上腺素	维持警觉和注意力	持续低度激活	紧绷、入睡难、易怒

HPA 轴：身体的应激激素系统

HPA 轴是“下丘脑—垂体—肾上腺”这条轴的简称。遇到压力时，下丘脑释放促肾上腺皮质激素释放激素，促使垂体分泌促肾上腺皮质激素，再让肾上腺皮质分泌**皮质醇**。皮质醇提高血糖、调动能量、抑制部分免疫和消化功能，让身体把资源集中到“应对眼前的事”上。压力过去后，皮质醇通过负反馈让这条轴慢下来。

长期压力下，这套系统可能出现几种改变：皮质醇的日内节律变得平坦、早晨峰值不明显、负反馈变迟钝，也就是“该收的时候收不住”。【研究】这些改变在抑郁症、创伤后应激障碍和部分焦虑障碍的研究中都有报告，但个体差异很大，而且不少研究结果并不一致。

必须说清楚的是：**抽血或查唾液皮质醇，不能用来诊断焦虑障碍**。皮质醇受采血时间、睡眠、进食、运动、药物、月经周期影响，单次结果说明不了什么。它在研究里是有用的指标，在门诊里不是诊断工具。市面上宣称“测压力激素、评估焦虑程度”的检测，多数缺乏临床验证，不要据此自行调整治疗。

递质：刹车、调节带宽和警觉

GABA 是中枢神经系统最主要的抑制性递质，可以理解成“刹车”。大脑里大约三分之一的神经连接使用 GABA，它让神经活动不至于失控。苯二氮䓬类药物作用于 GABA-A 受体的特定部位，增强 GABA 的作用，所以起效快、能迅速降低警觉和焦虑。但长期使用会出现耐受、依赖、戒断和认知影响，这也是它只能短期、按需、在医生指导下使用的原因。【指南】

5-羟色胺（5-HT） 参与情绪调节、威胁学习、冲动控制和睡眠。SSRI 通过抑制突触前膜对 5-羟色胺的再摄取来提高突触间隙的浓度。它对焦虑的疗效有大量证据，是一线药物之一，但起效慢，且不是对所有人都有效。【指南】

去甲肾上腺素（NE） 与警觉、交感神经激活、注意聚焦有关。焦虑时 NE 系统活跃，带来心跳加快、出汗、手抖、坐立不安。SNRI 类药物的作用之一就是调节 NE 和 5-羟色胺的通路。

把焦虑归结为“GABA 不足”或“5-羟色胺不足”，在科普里好懂，但在科学上过于粗糙。更准确的表述是：这些递质系统参与调节威胁回路和应激反应，药物通过改变它们来间接影响回路，而不是“缺什么补什么”。

交感神经：身体症状的来源

焦虑时那些让人害怕的身体感觉，大部分来自交感神经系统和肾上腺髓质。交感神经兴奋后：

- 心率加快、心肌收缩力增强，于是心慌、胸口发紧；
- 呼吸变快变浅，二氧化碳排出过多，于是头晕、手脚发麻、四肢发凉（呼吸性碱中毒）；
- 汗腺分泌增加，于是手心出汗、衣服湿透；
- 胃肠道蠕动改变，于是恶心、腹胀、腹泻或便秘；
- 肌肉张力升高，于是肩颈僵硬、头痛、下颌紧咬；
- 瞳孔放大、注意力变窄，于是怕光、觉得周围不真实。

这些症状是真实的生理变化，不是“想象出来的”。理解这一点本身就有治疗价值：很多惊恐障碍患者最害怕的“我要死了”“我要疯了”，其实是在解读这些变化时跑偏了，而不是身体真的正在崩溃。惊恐发作本身通常不致命，但首次出现、突发的剧烈胸痛、气短、晕厥，必须先按躯体急症处理，排除心脏和肺部问题。

机制解释的边界

讲机制很容易让人产生一种“已经搞清楚了”的错觉。下面几条边界值得记住：

相关性不等于因果。 研究发现焦虑的人杏仁核反应更强，但这可能是焦虑的结果，也可能是原因，还可能两者互为因果。横断面研究无法区分方向。

动物模型有局限。 小鼠的恐惧条件反射帮助理解了回路，但人类的焦虑包含预期、自责、对评价的担忧，这些无法在小鼠身上完整重现。

脑影像不能用来诊断。 目前没有任何脑影像检查可以诊断焦虑障碍。研究层面的组间差异，不能套到个人头上。

“神经可塑性”不是万能话术。 心理治疗和药物都可能带来回路层面的改变，这是有研究支持的【研究】，但“改变大脑”不等于“保证痊愈”，也不该被拿来推销任何产品。

递质假说仍在修订。 近年的综述对“抑郁症是 5-羟色胺失衡”提出了明确质疑，焦虑领域也类似。这不是否定药物有效，而是否定那种过度简化的因果叙事。【待验证】

看懂机制之后，可以做和不必做的事

- ☐ 把身体症状当成“警报系统的输出”，而不是“器官坏了的证据”。这不等于忽视症状，该查的仍然要查。
- ☐ 首次、突发的胸痛、气短、晕厥，先急诊排查，不要用“这是焦虑”说服自己不去。
- ☐ 不购买宣称“检测神经递质”“修复杏仁核”的检查或疗程。
- ☐ 不自行使用 GABA、5-HTP 等补充剂来替代药物；它们与处方药的相互作用并不清楚。
- ☐ 理解药物起效需要时间，不用前两周的感受给治疗下结论。
- ☐ 把“我需要放松”换成具体的动作：规律睡眠、减少咖啡因、每天一次二十分钟的快走。

什么时候需要联系医生或寻求额外帮助

- 首次出现剧烈胸痛、胸闷、大汗、晕厥、明显呼吸困难：立即拨打 120 或去急诊，先排除心脏和肺部急症。
- 心慌伴手抖、消瘦、怕热、腹泻：先查甲状腺功能，不要直接归因于焦虑。
- 服药后出现高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识改变：可能是血清素综合征，立即急诊。
- 长期使用苯二氮䓬类后想减药：必须由医生制定缓慢减量方案，自行硬停可能出现抽搐、意识混乱等严重戒断反应。
- 焦虑明显影响工作、睡眠、进食超过两周：看精神科或心理科，不必等到“撑不住”。

常见问题

我的焦虑是不是脑子坏了？不是。焦虑障碍是回路功能层面的调节问题，不是脑组织损坏。长期焦虑的人常抱怨注意力差、记性差，这多半与睡眠不足、警觉占用认知资源有关，治疗改善后往往能缓解。

为什么医生说我是焦虑，却让我去查甲状腺和心脏？因为甲亢、心律失常、低血糖、贫血、药物副作用都能制造几乎一样的症状。排查不是不信任你，而是负责任。

既然知道是杏仁核，能不能直接“训练”它？暴露疗法、CBT、呼吸和放松训练，确实是通过改变学习与调节过程来影响这套回路，这也是它们有效的原因之一。但“训练杏仁核”目前是一个比喻，不是可以精确操作的技术。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NIMH. Anxiety Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.3 学习、条件反射与回避的维持

很多焦虑的人都有过这种困惑：明明那件事已经过去很久了，为什么我还是怕？更奇怪的是，我越躲，它越凶。这一页用日常例子讲清楚两件事：恐惧是怎么被“学会”的，回避又是怎么把恐惧“养大”的。读完你会明白，回避不是懦弱，而是一种会自我强化的习惯；也正因为它有规律，才可以被反过来利用。

一次意外，怎么变成长期的怕

先看一个合并改写过的例子。小周，二十八岁，某天加班到很晚，进电梯时突然心慌、出汗、胸口发闷，觉得自己要晕过去，被同事扶了出来。到医院查了心电图和血常规，没有发现异常。

此后几个星期，他进电梯前就开始紧张。再后来，他改走楼梯；一个月后，他连地铁也不敢坐，因为地铁“门一关就出不去”；半年后，商场、电影院、理发店都变得困难。他出门必带一瓶水，必须有人陪，手机电量低于一半就焦虑。

这个变化过程里，没有新的器官病变，也没有新的创伤事件。改变的是**学习**：他的身体和大脑把“电梯”这个原本中性的场景，和“心慌、要晕倒”的反应连在了一起；然后，回避又把这个连接越绑越紧。

经典条件反射：身体先学会，脑子后解释

经典条件反射说的是：一个原本不会引起反应的中性刺激，如果反复和能引起反应的东西一起出现，之后单独出现也能引起反应。

用上面的例子拆开：

- **无条件刺激**：那次真实的心慌、闷、要晕的感觉。
- **无条件反应**：身体的警报反应——心跳加快、出汗、肌肉紧绷。
- **中性刺激**：电梯。本来它什么也不是。
- **条件反应**：现在只要看到电梯门、闻到电梯里的味道，身体就开始警报。

关键在于，这个过程不需要“想明白”。它发生在意识之前，速度快、能耗低，而且往往**一次就够**——这在进化上是有道理的：把“蛇”和“被咬”联系起来，一次就学会的人活了下来，需要学十次的人可能没有后代。所以，恐高、怕蛇、怕密闭空间，常常是一次不愉快经历后就形成了。【研究】

条件反射还有两个让患者很苦恼的特性：

泛化。电梯学会了，地铁、飞机、影院、MRI 检查舱也会被归进“密闭、出不去”这一类。于是恐惧的地图越画越大，这也就是为什么很多人的回避清单会从一项变成十几项。

消退不等于忘记。如果长期不进电梯，恐惧并不会因为“没用上”而自动消失。相反，它停留在原地，甚至因为想象而变得更可怕。恐惧的记忆很难被删除，能改变的是“在这个场景里其实不会出事”的新学习。新学习需要证据，而回避恰好不给证据。

操作性条件反射：回避是被“奖励”出来的

如果说经典条件反射解释了“为什么会怕”，操作性条件反射解释的是“为什么怕会一直持续”。

操作性条件反射的核心是：一个行为如果带来好结果，它就更可能再发生；如果它去掉了一个坏结果，它同样会更可能再发生。后者叫**负强化**——“负”指去掉，“强化”指行为增加，不是“惩罚”。

小周走楼梯，焦虑立刻从八十分降到三十分。这个“立刻舒服”就是奖励。于是下一次，他更可能选择楼梯。每一次回避，都是一次成功的负强化；每一次负强化，都让“走楼梯”这个习惯更牢一点。

负强化最麻烦的地方在于，它的效果是**即时的**，而代价是**延迟的**。走楼梯当下就轻松，代价是三个月后生活半径缩小、开始失眠、工作受影响。即时奖励总能赢过延迟代价，这不是意志力问题，是学习规律。

同样被负强化的还有那些“检查”和“确认”：反复查心电图、反复搜索症状、反复问家人“我刚才是不是不对劲”、反复确认门锁。查完的一瞬间安心，就是奖励；而安心只能维持很短时间，于是要查得更频繁。这条循环在疑病性焦虑和强迫检查里尤其明显。

安全行为：看不见的回避

大多数人能意识到“我不去坐地铁”是回避，却意识不到“我坐地铁但必须抓着扶手、必须靠门站、必须含着药、必须有人陪”也是回避。后一类叫**安全行为**：在恐惧场景里，为了让自己“撑住”而做的各种准备和小动作。

常见的安全行为包括：

- 随身带水、带药、带糖，虽然从来没用上；
- 必须坐在靠门、靠走道的位置；
- 进门先看出口在哪里，规划逃跑路线；
- 不停看手机、给家人报备位置；
- 喝酒、吃镇静药之后才敢出门；
- 说话时低头、少说话、提前离场；
- 有人陪才去，没人陪就不去；
- 反复查资料、反复问医生、反复自测心率。

安全行为的问题不在于“它没用”——它往往真的能降低当下的焦虑。问题在于，它让学习无法发生。如果你每次坐地铁都攥着那瓶水，那么“我没出事”这件事会被解释成“因为我带了水”，而不是“地铁本来就不会让我出事”。恐惧的预期没有被推翻，只是被绕过去了。

更隐蔽的是，安全行为会占用注意力。一个不停监控心跳的人，很难注意到周围其实是安全的；他的注意力全都向内，任何一点身体波动都会被捕捉、放大、解读。这本身就会让焦虑更容易发生。

为什么越躲越怕：五条叠加的路径

行为	短期效果	长期代价
回避场景（不走电梯、不坐地铁）	焦虑立刻下降	失去“其实不会出事”的证据，恐惧固化
安全行为（带水、靠门、有人陪）	当下能撑住	把安全归因于准备，而非环境本身
反复检查（查心率、搜症状）	短暂安心	强化“有危险需要查”的信念，频率上升
找人确认（问家人“我没事吧”）	得到安慰	依赖增加，自我效能下降
用酒精或药物压住	快速麻痹	耐受、依赖，焦虑基线反而升高

这五条路径会互相喂养。回避让生活范围缩小，缩小带来孤立和低落，低落又让焦虑更容易被触发；安全行为让自我效能感下降，“我一个人不行”的信念被反复确认；反复检查让身体被监控得更细，细到每一次心跳都被当成信号。

于是形成一个闭环：**怕 → 躲 → 暂时舒服 → 更怕 → 更躲**。这个环不需要新的坏事发生，它自己就能转下去。

消退不是删除：为什么好了还会反复

有人做过暴露、好了一阵，遇到压力大或者换了个环境，恐惧又回来了。这不代表前面的努力白费，而是因为恐惧学习的特点：旧的学习没有被删除，新的学习（“这里其实是安全的”）在旁边建立起来，两者并存，谁占上风取决于情境和状态。

三种常见的“回来”：

自发恢复：停止练习一段时间后，旧的恐惧反应自己冒头。所以暴露结束后仍需要偶尔复习，而不是“毕业就再也不碰”。

情境更新：在治疗室、在有人陪的情况下不怕了，换到真实的地铁、独自一人，恐惧又回来。所以练习要跨场景、跨状态，不能只在“最舒服的条件”下完成。

压力下的重现：睡眠不足、生病、工作危机、喝酒之后，旧的恐惧反应更容易被激活。这不是复发本身，而是一个提醒：这段时间需要把练习捡回来，也需要看看是不是该复诊。

理解这三点，能帮人少一点“我怎么又不行了”的自责，多一点“这是学习规律，我知道怎么处理”的把握。

把规律用反过来：可照做的清单

- ☐ 列出你的**回避清单**：哪些地方不去、哪些事不做、哪些人不在就不行。写得越具体越好。
- ☐ 列出你的**安全行为清单**：带什么、坐哪里、看什么、谁来陪、提前做什么。包括那些“我觉得不算回避”的小动作。
- ☐ 给每个场景打一个焦虑分数（0 到 100），从 30 到 40 分的先练，不要从最怕的开始。
- ☐ 每次练习只去掉一个安全行为，不要一次全撤。
- ☐ 练完之后记录：预期发生了什么、实际发生了什么、差别在哪里。这条记录比“我今天很勇敢”有用得多。
- ☐ 允许自己中途难受，但尽量待够时间，让身体有机会发现“峰值会过去”。
- ☐ 不把“今天没焦虑”当作成功标准，把“我去了、我待了、我没有立刻逃”当作成功标准。

什么时候需要联系医生或寻求额外帮助

- 因为回避已经无法上班、上学、出门，或连续两周以上不出家门：尽快看精神科或心理科，这通常不是“再忍忍”能解决的。
- 出现明显的抑郁、绝望、自杀念头：不要独处，立即联系信任的人，拨打 120 或去急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 靠喝酒或自行加用镇静药才能出门：这已经是需要专业介入的信号，酒精和镇静药戒断都可能危及生命，不能自行硬戒。
- 有心脏病、哮喘、癫痫、孕期等情况，准备做会明显提高心率或呼吸的练习前，先和医生讨论。
- 练习中反复出现解离、濒死感或强烈创伤画面：暂停自行练习，找受过训练的治疗师评估。

常见问题

我知道不该躲，但当时真的做不到，是意志力差吗？不是。回避是被即时缓解“奖励”出来的自动反应，和意志力关系不大。能改变它的不是狠下心，而是把练习拆小到“做得到但不舒服”的程度，让新学习有机会发生。

稍微躲一点，应该没关系吧？偶尔的回避不会毁掉一切。问题在于频率和趋势：如果回避在增加、场景在变多、需要更多准备才能出门，它就在自我强化。判断标准不是“有没有躲”，而是“躲的范围是不是在扩大”。

为什么别人遇到同样的事没事，我却这样？气质敏感度、当时的身体状态（睡眠、咖啡因、生病）、过去的经历、事后有没有人帮你解释，都会影响学习的速度和强度。同样的经历，不同的人学到的东西不一样，这不是谁更脆弱。

知道了这些，是不是就能自己治好？理解规律能帮你少走弯路，但恐惧的学习往往需要在真实情境里反复练习，而练习的设计、节奏和撤退计划，需要专业判断。把这一页当作“理解治疗为什么这样设计”的说明书，而不是自助疗程。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.4 认知模型：威胁评估与灾难化

“焦虑的人是想太多”——这句话有一半是对的，另一半非常伤人。对的那一半是：焦虑确实和“怎么评估危险”有关；错的那一半是：这不是你故意想出来的，也不是想一想就能停。这一页讲认知模型怎么解释焦虑：威胁放大、灾难化、不确定性不耐受、过度责任感、注意和解释偏向分别是什么，以及这个模型说不到的地方。

认知模型在说什么

认知模型的核心不是“你的想法是错的”，而是：**在同样的情境里，焦虑的人更倾向于高估威胁、低估自己的应对能力**。这个评估过程很快、很自动，往往在你意识到之前就完成了。

用一句话概括：危险本身是一回事，你对危险的“估价”是另一回事。焦虑障碍的问题通常出在估价系统——它把“可能”算成“很可能”，把“难受”算成“危险”，把“不确定”算成“不能忍”。

这个模型不是凭空来的。恐慌的认知模型（Clark 在 1986 年提出）认为，惊恐发作的核心是对身体感觉的灾难化解释：心跳快被解释成“心脏病发作”，头晕被解释成“要晕倒”，于是更紧张，身体反应更强，形成正反馈。广泛性焦虑的认知模型（Wells 提出）强调对担忧本身的信念——“担心能帮我避免出事”“担心停不下来”。社交焦虑的模型（Rapee 和 Heimberg 提出）强调“别人会负面评价我”的预期，以及把注意力转向自我监控。【研究】

这些模型有一个共同点：它们不否认现实风险，而是关注**风险评估的校准**。对真实危险保持适度焦虑是正常的，甚至是必要的；问题在于校准偏了，而且偏得很稳定。

威胁放大：概率和代价被同时调高

威胁放大（threat overestimation）通常包含两个方向：

高估概率：“这种事发生的可能性很大。”坐飞机的人把“空难”的概率估得远高于实际；担心自己得重病的人，把“头痛”与“脑瘤”的联系估得远高于流行病学证据。

高估代价：“一旦发生，我就完了。”即使概率不高，如果代价被想象成不可承受，焦虑也会很强。很多人不怕坐飞机失事，是因为“概率太低”；而怕公开演讲的人，往往不是觉得一定会搞砸，而是觉得“搞砸了我就彻底没脸见人了”。

这两个方向可以独立起作用。有些人概率估得不算离谱，但代价估得极高；有些人代价能接受，但觉得“太容易发生了”。治疗里要分开看：是“太可能”，还是“太可怕”，还是两者都有。

还有第三个常被忽略的变量：**低估应对能力**。“万一真发生了，我处理不了。”实际上很多人处理过比想象中更难的事，只是在焦虑状态下，这些经验调不出来。

灾难化：一条滑到谷底的链子

灾难化（catastrophizing）是把一件不舒服的事，沿着“那就会……那就会……”的链条，一路推到最坏的结局。

一个常见的链条：心跳有点快 → 心脏是不是有问题 → 会不会突然心梗 → 如果倒在路上没人救 → 孩子怎么办 → 我的人生完了。

这条链子有几个特点：

每一环都显得“有可能”。单独看，每一步都不是完全不可能，所以整条链子看起来合理。但概率是连乘的，每一步都“有可能”，不等于整条链“很可能”。

跳过了中间环节。从“心跳快”直接跳到“心梗”，中间省略了“我今年体检正常”“我刚才爬了楼梯”“我喝了三杯咖啡”这些信息。

终点是不可承受的。链条之所以有力量，不是因为推理严密，而是因为终点太可怕。人一旦看到那个终点，前面的每一步都会被恐惧染上颜色。

识别灾难化，不是要你证明“绝不会发生”，而是把链子摊开：哪一环是事实，哪一环是推测，哪一环被我跳过了，哪一环其实有别的解释。

不确定性不耐受：宁可担心，也不愿不知道

不确定性不耐受（intolerance of uncertainty）是指：把“不确定”本身当成一种威胁，认为“只有完全确定，我才能放松”。

它的典型句式是：“万一呢？”“如果我不能百分百确定，就不能掉以轻心。”“我得再查一下，确认没事。”

这种倾向会带来一套行为：反复检查、反复搜索、反复求证、反复计划、反复问别人。每一次求证都能带来短暂的确定感，但确定感维持不了多久，下一次的不确定又会触发新一轮求证。久而久之，人对“不确定”的容忍度越来越低，需要越来越多的保证才能过日子。

这里有一个反直觉的规律：**追求确定，会让不确定显得更可怕**。因为你每一次求证，都在告诉大脑“这件事需要确认，不确认就危险”。真正有效的方向不是获得更多确定，而是练习在“不确定”里待着，并发现“不确定也能过”。

这条原则在广泛性焦虑的治疗里是核心之一，也是暴露疗法在认知层面的对应物。【指南】

过度责任感与“想法等于事实”

过度责任感是指：把不属于自己控制范围的事，算成自己的责任。“如果我没想到那个风险，出了事就是我的错。”“我必须提醒他，不然他出事我难辞其咎。”这种信念在广泛性焦虑中很常见，它让担忧看起来像一种道德义务——不担心，就是不负责任。

问题是，过度责任感会把“担心”变成“必须做的事”，于是担忧停不下来；而它换来的控制感是虚假的，因为大多数风险根本不在你的掌控里。

“想法等于事实”（thought-action fusion）是指：把“想到”当成“发生”，或者把“想到”当成“说明我是这种人”。“我想到孩子出事，是不是我潜意识希望它发生？”“我一想到拿刀就害怕，是不是我有暴力倾向？”这类念头会带来强烈的羞耻和恐惧。

需要说明的是，这类现象在强迫症里更典型，焦虑障碍中也可能出现。区分点在于：强迫症的核心是反复的侵入性念头加仪式化行为，焦虑障碍的核心是预期性担忧。两者的治疗有重叠，但评估和方案不同，不要自行对号入座。

注意偏向与解释偏向：不是故意的

注意偏向：焦虑的人更容易注意到威胁相关的信息，而且一旦注意到，就更难把注意力移开。研究发现，焦虑个体对威胁词、愤怒面孔的探测更快，脱离更慢。【研究】这不是“你故意盯着坏消息”，而是注意力系统被调成了“威胁优先”。

解释偏向：面对模糊情境，焦虑的人默认做负面解释。老板发消息说“你来一下”，第一反应是“我是不是做错了什么”；朋友回复变慢，第一反应是“他是不是生我气了”。同一个模糊信号，可以有一百种解释，焦虑的人会稳定地选中威胁那一种。

这两种偏向会互相加强：你越容易注意到威胁线索，就越容易做负面解释；越做负面解释，就越觉得世界危险，注意力也就越警觉。它们和回避一起，构成一个自我维持的循环。

好消息是，偏向可以被训练，也可以通过行为实验被修正。注意力训练、外部聚焦练习、行为实验，都是在这个层面上工作。但要注意，单靠“想开点”改变不了偏向，因为偏向发生在意识之前；需要的是重复的练习和真实的经验。

一张表：常见认知偏误

偏误	具体表现	它想保护你什么	付出的代价
威胁放大	把“有可能”当成“很可能”	提前预警，避免措手不及	长期处于警戒，耗尽精力
灾难化	一路推到最坏结局	让你重视风险	被想象中的结局吓住
不确定性不耐受	必须确认，不能忍“万一”	追求掌控感	检查越来越多，自由越来越少
过度责任感	把别人的事算成自己的错	做一个负责的人	内疚、担忧、无法放手

偏误	具体表现	它想保护你什么	付出的代价
想法等于事实	想到就等于发生	保持道德警觉	羞耻、自我怀疑
注意偏向	先看到威胁，难移开	快速发现危险	世界看起来更危险
解释偏向	模糊信息默认负面	不做乐观的傻瓜	人际误会、持续紧张

认知模型的边界

它不是“都是你想出来的”。 认知模型说的是评估偏了，不是危险不存在。如果你真的处在不安全的环境里，焦虑是合理反应，需要的是改变环境或寻求帮助，不是“调整想法”。

它不是“积极思维”。 认知重构不是把“我可能会失败”换成“我一定会成功”，而是把“我一定会失败”换成“我可能会失败，也可能不会，我能做的是准备和尝试”。前者是自我催眠，后者是校准。

它不是唯一路径。 认知模型解释了“为什么怕”，但改变往往来自行为：暴露改变的是学习，行为实验改变的是证据，药物改变的是回路。只改想法不改行为，效果常常有限。

它容易被用来自责。 “原来是我认知扭曲”——这句话本身可能变成新的自我攻击。认知偏误是全人类共有的，只是在焦虑时被过度使用。你不是“有缺陷”，你是“系统调得太敏感”。

抓到担心时，可以问自己的六个问题

- ☐ 我担心的具体是什么事？把它写成一句话，不要写成一团感觉。
- ☐ 我估的概率是多少？有没有证据支持这个数字，还是它只是“感觉”？
- ☐ 如果真发生了，最坏、最好、最可能的结果分别是什么？
- ☐ 我跳过哪些信息？有没有别的解释能解释同样的现象？
- ☐ 如果朋友遇到同样的事，我会怎么跟他说？
- ☐ 除了担心，我现在能做的一件具体的事是什么？如果什么也做不了，我能不能先把它放下十分钟？

什么时候需要联系医生或寻求额外帮助

- 担忧已经占据每天大部分时间，影响工作、睡眠、进食超过两周：看精神科或心理科。
- 反复检查、反复求证已经影响到家人，或每天耗时超过一小时：需要专业评估，可能需要排除强迫症。
- 出现“活着没意思”“不如死了”的念头：不要独处，立即联系信任的人，拨打 120 或去急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 反复出现伤害自己或他人的侵入性念头，感到害怕和羞耻：这并不代表你会去做，但值得尽快找专业人员谈。
- 伴随明显体重下降、持续失眠、注意力无法集中：需要排查抑郁和躯体疾病。

常见问题

我是不是太悲观了？可能是“解释偏向”在起作用，而不是性格悲观。区别在于：悲观是一种长期的世界观，解释偏向是在焦虑状态下被激活的、可以被练习修正的加工方式。不必给自己贴性格标签。

改变想法，是不是自欺欺人？不是。自欺是“假装危险不存在”，认知重构是“把危险的证据和概率重新算一遍”。前者让你放松但脆弱，后者让你更准确地评估，从而做出更好的决定。

为什么别人能接受不确定，我不行？不确定耐受度受气质、经历、当前压力影响，人和人本来就不一样。它不是道德品质，是一项可以练习的能力。练习的方式不是“说服自己别在意”，而是反复在不确定中行动，并发现后果可承受。

我知道自己的想法不合理，但就是控制不住，怎么办？这很正常。认知层面的“知道”和行为层面的“学会”是两套系统。改变通常需要行为实验和反复练习，而不是靠更强的自我说服。如果一直卡住，可以请治疗师帮你设计实验。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NIMH. Anxiety Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.5 环境、养育、创伤与生活压力

“我这病是怎么来的？”这是门诊里最难回答、也最容易被回答错的问题。有人被告知“都是你父母管太严”，有人被告知“都是你自己想太多”，这两种说法都太省事，也都容易造成第二次伤害。这一页讲环境因素在焦虑里扮演什么角色，以及为什么更准确的说法是“风险叠加”，而不是“找到罪魁祸首”。

先说清楚：风险因素不是责任归属

在医学里，“风险因素”指的是**提高患病概率的条件**，不是“造成疾病的唯一原因”，更不是“谁的错”。吸烟是肺癌的风险因素，但吸烟的人不都得肺癌，不吸烟的人也可能得肺癌；这个表述既没有责怪患者，也没有否认吸烟的危害。

焦虑障碍也是如此。它通常是多个因素叠加的结果：先天的敏感度、童年的经历、成年后的压力、躯体疾病、睡眠、酒精和咖啡因、以及回避和担忧形成的维持机制。任何一个因素单独拿出来，都不足以解释全部；任何一个因素被拿掉，也不保证就不会发病。

这个区分之所以重要，是因为它决定了人往哪个方向走。如果相信“都是父母的错”，人容易停在愤怒里；如果相信“都是我自己不争气”，人容易停在羞耻里。两种归因都不能带来改变。更有用的问法是：**现在还有哪些因素在起作用，哪些是我能动的？**

养育方式：有关联，但方向不单一

研究确实发现，某些养育特征与子女焦虑相关：过度控制、过度保护、对孩子的批评和否定较多、鼓励回避而不是面对。【研究】这些关联在不同国家、不同样本里反复出现，不算弱。

但要把关联读成因果，会犯几个错误：

方向可能是反的。 一个天生慢热、容易害怕的孩子，会让父母更保护、更提醒、更替他把事情做好。是孩子的气质塑造了养育方式，而不只是反过来。纵向研究里，这两个方向往往同时存在。

遗传混杂。 父母和孩子共享基因。父母自己有焦虑倾向，可能既把基因传给孩子，也在行为上更谨慎。如果不控制这一点，很容易把遗传效应误算成养育效应。

效应量有限。 双生子研究提示，在成年焦虑障碍里，家庭共享环境（同一对父母、同一个家）解释的差异往往比人们想象的小。【研究】这不是说养育不重要，而是说“父母的一举一动决定孩子一生”这种说法夸大了。

文化差异很大。 什么叫“过度保护”，在不同家庭、不同文化里标准不同。在有的环境里，父母接送、替孩子做决定是常态；在另一个环境里，同样的行为可能被看作控制。脱离情境评判养育方式，很容易变成文化偏见。

所以更准确的说法是：养育方式会影响孩子学习“世界有多危险”“我能不能应付”“表达害怕会不会被接纳”，它是风险因素之一，不是命运判决书。对已经成年的患者，追溯养育经历的价值不在于定罪，而在于理解自己现在的模式从哪来，然后决定要不要改。

校园与职场：长期压力怎么变成焦虑

校园：持续的学业压力、被欺凌、被孤立、师生关系紧张、升学竞争，都可能让一个孩子长期处在警觉状态。欺凌的影响尤其值得重视，它不只是“同学间闹着玩”，而是反复的、权力不对等的伤害，与后来的焦虑、抑郁、拒学都有稳定关联。【研究】

职场：高强度加班、绩效压力、职场霸凌、裁员和失业的威胁、长期通勤、缺乏自主权，都是慢性压力源。慢性压力和急性事件不同：急性事件过去了就过去了，慢性压力每天都在消耗恢复能力。很多人不是“突然焦虑”，而是在持续消耗里，某一天发现自己撑不住了。

这两类压力的共同点是：**它们常常不在个人的完全掌控之内**。把职场焦虑说成“你抗压能力差”，和把校园拒学说成“孩子娇气”，都是把结构性问题个人化。个人能做的部分（设定边界、求助、换环境、治疗）很重要，但不代表问题全在个人。

创伤与重大事件

童年逆境（虐待、忽视、家庭暴力、父母精神疾病、父母离世、家庭功能严重失调等）与成年后的焦虑、抑郁风险升高有关，而且呈现“累积效应”：逆境越多，风险越高。【研究】这类研究（常被称为 ACE 研究）影响很大，帮助临床重视童年经历。

但引用这类研究时，必须同时说清几点：

它是概率，不是宿命。 有过童年逆境的人，大多数并没有发展成精神障碍；没有逆境的人，也可能发病。

回溯性报告有偏差。 成年后回忆童年，会受当前情绪和记忆重构影响。研究设计上的限制，不代表经历不真实，只代表数字不能当成精确的因果剂量。

创伤不等于创伤后应激障碍。 经历重大事件后出现焦虑、失眠、警觉，是常见的急性反应；只有当症状持续、形成闯入性回忆、回避、负性认知和警觉增高的一套模式时，才考虑 PTSD。两者的治疗重点不同，不能一概而论。

不要把所有焦虑都追溯到童年。 有的人童年平稳，焦虑来自成年后的疾病、药物、压力或没有任何明显诱因。找不到“原因”不代表病不真实，很多疾病本来就是多因素、无法精确定位的。

社会经济因素：被低估的一层

贫困、住房不稳定、债务、食品不安全、缺乏医疗保障、工作不稳定、居住环境嘈杂或不安全、遭受歧视——这些因素与焦虑的关联在流行病学研究里相当稳定。【研究】它们的作用方式很直接：持续的不安全感、无法预测明天、求助无门。

这一层常被忽略，因为它不像“想法”那样可以在诊室里讨论，也不像“基因”那样有生物学的光环。但对很多人来说，涨房租、担心被裁、看不起病，比童年经历更直接地决定了当下的焦虑水平。

承认这一层，有两个实际意义：一是不要把所有责任推给个人心理，二是治疗计划要考虑现实约束。一个每天打两份工、睡眠不足的人，很难坚持每周一次的心理治疗；这时候需要的是更现实的方案，而不是“你不够努力”。

疫情与重大事件：集体性的不确定性

新冠疫情是一个少见的自然实验。WHO 在 2022 年的估计认为，疫情第一年全球焦虑和抑郁的患病率上升了约四分之一。【研究】隔离、感染恐惧、失去亲人、收入中断、信息过载，同时作用于几乎所有人。

这类集体事件的特点是：它不是你一个人的问题，而是环境整体变差了。当外部世界真的更不确定时，焦虑升高是合理反应，不是“心理脆弱”。同时也应看到，多数人的症状会随环境稳定而缓解，少数人会持续，需要治疗。

风险因素与病因：一张表看清区别

因素	可能的作用方式	可改变程度
遗传与气质	提高对威胁的敏感度	不可改变，但可适应
养育方式	影响对世界的安全感和应对模式	成年后可重新学习
校园欺凌、职场压力	长期激活警觉与应激系统	部分可改变（换环境、维权、求助）
童年逆境与创伤	改变威胁学习和应激调节	已发生的事实不可改，影响可治疗
贫困、住房、歧视	持续的不安全感与资源匮乏	部分可改变，需要社会支持
睡眠不足、咖啡因、酒精	直接提高焦虑基线	高度可改变
回避与安全行为	维持恐惧，阻止新学习	高度可改变，是治疗重点

这张表想说明的是：**不是所有因素都能改，但也不是所有因素都不能改**。治疗通常从“可改变程度高”的那一栏入手——睡眠、咖啡因、回避、安全行为、求助方式；同时承认那些改不了的部分，不拿它来责怪自己。

可以调整的环境因素清单

- ☐ 睡眠：固定起床时间，比固定入睡时间更容易做到。
- ☐ 咖啡因：把下午的咖啡、浓茶、能量饮料减掉，观察两周。

- ☐ 酒精：不靠喝酒助眠或压焦虑；如果已经依赖，不要自行硬戒，先找医生。
- ☐ 信息摄入：把“反复刷症状、刷新闻”限定在固定时段，避免睡前。
- ☐ 支持网络：至少有一个可以说真话的人，不必多。
- ☐ 工作或学业边界：能不能减少一项非核心任务？能不能申请调整？
- ☐ 欺凌或暴力：如果正在发生，优先考虑安全和取证，而不是“调整心态”。
- ☐ 医疗可及性：了解当地精神科门诊、医保报销和 12356 热线。

什么时候需要联系医生或寻求额外帮助

- 正在遭受家庭暴力、性侵、职场霸凌或校园欺凌：优先保证人身安全，联系可信赖的人、报警或求助当地妇联、未保机构；这不是“心理问题”。
- 经历重大事件后持续两周以上失眠、闪回、极度警觉、回避相关场所：看精神科或心理科，评估是否为创伤后应激障碍。
- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划：不要独处，立即联系信任的人，拨打 120 或去急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 因为经济困难无法承担治疗费用：可以询问医院社工、门诊慢病或医保政策，也可先拨打心理援助热线获取转介信息。
- 焦虑伴随持续情绪低落、兴趣丧失、体重明显变化：需要评估是否合并抑郁。

写给家属：不互相归罪，才有帮手

如果你是家属，最没用的一句话是“当初要不是我们……”，第二没用的是“你就是想太多”。这两句话都会把对方推回孤立。

更有用的做法：

- 先问“你现在最难受的是什么”，而不是先给建议。
- 承认现实困难：如果是工作、学业、经济压力，先讨论能不能减轻，而不是只谈心态。
- 不替对方回避，也不硬推。可以陪同、可以商量小步骤，但不替他做决定。
- 照顾好自己的睡眠和情绪。家属也会被拖垮，这不是自私。
- 如果家里有孩子正在焦虑，父母不必互相指责“都是你惯的”。养育是两个人加一个环境的结果，改起来也需要一起改。

常见问题

是不是我父母把我养成了这样？养育可能是影响因素之一，但通常不是唯一原因，也不是“谁害了谁”的问题。成年之后，人有机会重新学习如何评估危险、如何面对不确定。把精力放在“现在能改什么”，比放在“当年该多好”更有用。

没有明显诱因，是不是说明我在装病？不是。很多焦虑障碍没有可识别的单一诱因，或者是多个小因素累积到某个阈值。找不到“那件事”，不代表病不真实。

环境压力这么大，治疗还有用吗？有用，但要看期待。治疗不能消除贫困或换掉一份糟糕的工作，但能提高承受力、减少回避、改善睡眠、让你更有余地做现实选择。有时候治疗的第一步，是帮人看清“这不是我一个人的问题”。

疫情过去了，我的焦虑为什么还在？环境稳定后多数人会缓解，但有些人的警觉模式、回避习惯和信息过载已经固化，需要主动干预。这不是“后遗症”式的必然，而是学习的结果，也就可以通过学习改变。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 4：就医与诊断

焦虑的躯体症状很像心脏病、甲亢、低血糖。这一模块讲去哪里看、医生会问什么、怎么排除“不是焦虑”的原因。

4.1 就诊渠道与就诊时机

心慌、胸闷、头晕了几个月，检查做了一堆，结果都正常，朋友说“你去看心理科吧”，你却不知道该挂哪个科；或者已经决定就医，却卡在“先看内科还是先看精神科”“要不要直接去急诊”。这一页把就诊路径讲清楚：什么情况先去急诊，什么情况先看内科，什么情况适合精神科或心理科，远程医疗能做什么、不能做什么，以及怎么挑一个适合自己的医生。

一、先分清几个科室

精神科、心理科、心身医学科、全科，名字相近，分工不同。不同医院设置也不一样，挂号前可以看一眼医院官网或导诊台的介绍。

科室	适合什么情况	能做什么	局限
精神科/精神心理科	需要明确诊断、评估用药、症状严重或共病复杂	诊断、处方、住院、危机处理	门诊时间紧，心理治疗时间有限
临床心理科/心理科	以心理治疗为主，或需要心理评估	心理评估、认知行为治疗等	部分科室不能开药，需与精神科协作
心身医学科	躯体症状突出、反复检查无异常、多种症状交织	综合评估、药物与心理干预	不是所有医院都有
全科/内科/神经内科	首诊、排查躯体疾病、不知道挂什么科	体检、化验、心电图、转诊	对焦虑障碍的专科治疗经验不一
急诊科	胸痛、气短、晕厥、自杀风险、戒断反应	紧急排查与处理	不做长期治疗，稳定后需转门诊

一个常见的误区是“看精神科就等于病得很重”。实际上，精神科门诊里大量是焦虑、抑郁、失眠这类常见问题；**是否需要看精神科，取决于症状和功能，而不是“面子”**。

另一个误区是“心理科就是聊聊天”。正规的心理治疗有结构、有目标、有作业，和普通聊天不同；但心理科医生不一定都能开药，需要药物时通常会转介精神科。

二、什么情况必须先看急诊

有些症状不能等门诊，必须先排除危及生命的情况。

> **出现以下任一情况，请立即拨打 120 或去最近医院急诊：**
>
> • 突发剧烈胸痛、压榨感，持续不缓解，或放射到手臂、后背、下颌；

> - 突然严重气短、喘不上气、口唇发紫；
> - 晕倒、意识丧失，或抽搐；
> - 心跳极快且伴胸痛、头晕、眼前发黑；
> - 自杀念头强烈、已有计划或自伤行为；
> - 大量饮酒或镇静药后突然停用，出现手抖、大汗、幻觉、意识混乱；
> - 服药后高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识改变；
> - 严重过敏：皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难。

“先排除急症”不是不信任你的焦虑，而是对所有可能都负责。 尤其第一次出现、症状剧烈、年龄偏大、有心血管危险因素的人，顺序不能反。

三、先看内科，还是看精神科

这些情况先看内科

焦虑的躯体症状和很多内科疾病高度重叠。以下情况，建议先到内科或相应专科排查，再考虑焦虑：

- 心悸、心跳不规则，尤其是活动时出现、伴头晕或晕厥；
- 明显消瘦、怕热、多汗、手抖、腹泻、月经紊乱（需查甲状腺）；
- 阵发性血压骤升，伴头痛、大汗、心悸；
- 反复低血糖感：出汗、手抖、心慌、饥饿、意识模糊；
- 气短、喘鸣、慢性咳嗽，或夜间憋醒；
- 眩晕、耳鸣、听力下降、走路不稳；
- 长期饮酒、使用镇静药、减肥药、激素、含咖啡因的饮品或药物；
- 老年人新出现的焦虑，尤其伴体重下降、疼痛、认知变化。

排查不是“多此一举”。甲状腺功能亢进、心律失常、低血糖、嗜铬细胞瘤、哮喘、前庭疾病、药物副作用，都可能表现为“像焦虑一样”。**先排除，再诊断，是负责任的做法。**

这些情况该看精神科或心理科

如果已经做过必要的躯体检查、排除了明显的内科原因，而下面这些情况仍然存在，就值得看精神科或心理科：

- 担心、紧张、恐惧持续数周以上，自己调节不了；
- 明显影响工作、学习、睡眠、社交或家庭生活；
- 反复因身体症状就诊，检查正常仍不放心；
- 出现回避行为：不敢出门、不敢坐车、不敢社交；
- 合并情绪低落、兴趣减退、失眠、喝酒增多；

- 有自伤、自杀念头（这种情况优先急诊或危机干预）；
- 已经确诊焦虑障碍，需要调整治疗方案。

如果当地没有精神科，可以先到综合医院全科或心身医学科，请医生评估后转诊。**不必等到“严重到不行”才去**，越早评估，选择越多。

四、远程医疗：方便，但有边界

近几年线上问诊、互联网医院越来越普遍。它确实解决了一部分问题，但也有明确局限。

适合远程	不太适合远程
复诊、调药后的随访	首次诊断，尤其症状不典型
轻中度焦虑的心理治疗	需要体格检查、化验、心电图
行动不便、异地、时间难协调	胸痛、气短、晕厥等急症
已经明确诊断的稳定期管理	自杀风险高、需要危机干预
家属参与的健康教育	儿童首次评估、需要观察互动

远程医疗的几个现实问题：

- **无法做体格检查和辅助检查**，容易漏掉躯体原因；
- **紧急情况处理能力有限**，出现危险症状仍需线下急诊；
- **平台资质参差**，要确认是否有医疗机构执业许可、医生是否有精神科执业资质；
- **隐私风险**，尽量在私密环境进行，注意平台的数据保护；
- **药物配送与处方规范**，精神科处方药有管理规定，不能随意网购。

比较稳妥的做法是：**首次尽量线下**，明确诊断和用药方案后，复诊可以线上线下结合。具体以就诊医院的安排为准。【临床经验】

五、选医生、隐私与就医时机

怎么选一个适合自己的医生

- ☐ 是否有精神科或心理科的执业资质（可在医院官网、卫健委平台查询）。
- ☐ 是否愿意听你把话说完，是否解释诊断依据和治疗选择。
- ☐ 是否会询问躯体情况、用药、饮酒、睡眠，而不是只看量表。
- ☐ 是否明确告诉你药物的作用、常见副作用、需要监测什么。
- ☐ 是否能提供或转介心理治疗，而不只是开药。
- ☐ 复诊是否相对固定，能否在出现问题时联系到人（或明确的求助渠道）。
- ☐ 你离开诊室时，是否知道“下一步做什么、什么情况要回来”。

好医生不一定“态度最好”，但通常**解释清楚、边界清楚、愿意合作**。如果一次就诊后你完全不知道自己的诊断是什么、药为什么吃、要吃多久，可以换一位，或带着疑问再问一次。

关于病耻感与隐私

很多人拖着不就医，不是不知道，而是怕被贴标签、怕影响工作、怕熟人知道。几点现实信息：

- 精神科门诊遵循隐私保护原则，病历属于个人隐私；
- 《中华人民共和国精神卫生法》对精神障碍患者的隐私、入学、就业等权益有规定；
- 用人单位一般无权随意调阅你的门诊病历，除非涉及特定岗位的法定体检要求；
- 需要病假、复工证明时，按医院和单位流程办理即可。

焦虑障碍和其他慢性病一样，需要复诊、需要调整方案。【指南】**越早面对，越少影响工作和生活。**

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 胸痛、气短、晕厥、抽搐、意识障碍；
- 自杀念头强烈、有具体计划，或已经自伤；
- 酒精、镇静药突然停用后出现戒断反应；
- 服药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变。

尽快联系医生（门诊或线上复诊）：

- 服药后出现新的不适，或原有症状明显加重；
- 出现情绪低落、兴趣减退、睡不着、吃不下；
- 开始自行减药、停药，或想停药；
- 出现新的躯体症状，不确定是否与药物有关；
- 准备怀孕、已经怀孕或正在哺乳。

六、常见问题

“我是不是应该先看心理科，不行再去看精神科？”都可以，取决于你更需要什么。想先做心理治疗、症状较轻，可以先看心理科；症状重、需要药物、共病复杂，直接看精神科更合适。很多医院两者会互相转介。

“看精神科会被记录在案，影响找工作吗？”门诊病历属于隐私，一般不会自动进入用人单位。特定岗位（如飞行员、部分公职）有法定体检要求，具体以招录规定为准。不要因为担心而延误治疗。

“线上开药靠谱吗？”要确认平台的医疗机构资质和医生执业资质，精神科处方药有管理规范。首次用药、调整方案、出现副作用，最好线下评估。

“急诊医生会不会觉得我小题大做？”不会。急诊的职责就是排除危险。**宁可白跑一趟，不要赌。**

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.2 初诊准备与症状时间线

很多人第一次走进精神科诊室，坐下就卡住了：从哪儿说起？说“我焦虑”够不够？医生问“什么时候开始的”，只记得“好像很久了”；问“发作几次”，答不上来；明明有一堆检查单，却翻不出来。结果十分钟过去，最重要的信息没说清。这一页给你一套可直接照抄的准备方法：带什么、怎么讲、时间线怎么画、家属怎么补充，以及哪些事必须主动说。

一、医生最想知道的六件事

不管医生问得多细，核心就是六块。你可以按这个顺序准备：

1. **起病**：第一次是什么时候？当时发生了什么？是突然出现，还是慢慢加重？
2. **症状**：身体上、想法上、行为上分别有什么？最难受的是哪一项？
3. **频率与规律**：多久一次？一天几次？和什么情境有关（早上、晚上、开会、独处、月经前后）？
4. **影响**：工作、学习、睡眠、社交、家庭受到了什么影响？有没有请假、回避、放弃机会？
5. **既往治疗**：看过哪些科、做过什么检查、吃过什么药、效果如何、有没有副作用。
6. **背景**：睡眠、咖啡因、酒精、吸烟、躯体疾病、家族史、重大生活事件、性格与应对方式。

这六块讲清楚，比“我很焦虑”重复十遍有用得多。

二、画一条症状时间线

时间线不用精确到天，关键是“顺序”和“变化”。可以按下面的格式写：

> 2024 年 3 月：换工作，开始睡不好，早上心慌。
>
> 2024 年 6 月：第一次在地铁上突然心跳很快、胸闷、手麻，持续约十几分钟，去急诊查心电图正常。
>
> 2024 年 7 - 9 月：又发作三四次，开始不敢坐地铁，改坐公交，出门要人陪。
>
> 2024 年 10 月：看心内科，动态心电图正常；医生建议看心理科，没去。
>
> 2025 年 1 月：担心加重，几乎每天下午心慌，开始失眠，喝酒助眠。
>
> 2025 年 3 月：第一次来看精神科。

这条线里有起病、有转机、有回避、有检查、有酒精使用，医生一眼就能看出“发作—恐惧—回避—功能下降”的链条。**时间线不需要文采，需要顺序和具体。**【临床经验】

三、怎么描述一次发作

用“五问”把一次发作讲清楚：

问题	可以怎么说
什么时候、在哪里、在做什么？	“上周二早上 8 点，地铁 2 号线，站着，没吃早饭。”
第一个感觉是什么？	“先是胸口发紧，然后心跳突然很快，像要跳出来。”
最难受的时候什么样？	“手麻、头晕、觉得要晕倒，怕自己死在车上。”

问题	可以怎么说
持续多久？怎么缓解？	“大概十几分钟，到站下车坐下，慢慢缓过来。”
之后发生了什么？	“当天不敢再坐地铁，第二天请假，之后改坐公交。”

注意最后两问。**“之后发生了什么”往往比发作本身更重要**，因为它暴露了回避和安全行为，而这两样正是维持焦虑的关键。

四、带什么去，以及一张纸模板

带什么去

- ☐ 身份证、医保卡、就诊卡。
- ☐ 既往检查报告：血常规、甲状腺功能、心电图、动态心电图、心脏超声、影像等（按时间排序）。
- ☐ 正在吃的药：药盒、处方、药名和用法（包括中药、保健品、减肥药、感冒药）。
- ☐ 自己记的症状日记或量表（GAD-7、PHQ-9 等），标好日期。
- ☐ 一张写好的时间线和问题清单（见下一节模板）。
- ☐ 家属或知情朋友（如果愿意，且医生允许陪同）。
- ☐ 笔和纸，或手机备忘录，记医生的关键交代。

如果检查单太多，挑**最近的、异常的、和这次症状相关的**，其余拍照存手机。医生不一定有时间全部翻完，但你有准备，问诊会顺很多。

一张纸模板

把下面这张表打印出来，或照着手写在纸上，初诊时递给医生。

项目	我的情况
主要困扰（一句话）	例如：反复心慌、胸闷，不敢坐地铁，怕自己猝死
第一次出现	年月、当时情境
到现在多久	例如：1 年 3 个月
发作频率	例如：近 1 个月每周 2–3 次
最难受的症状（按顺序）	心悸、胸闷、手麻、头晕、濒死感
什么情况容易诱发	独处、封闭空间、咖啡、熬夜、月经前
因为怕而回避的事	地铁、电梯、独自出门、运动
对生活的影响	请假、推掉出差、夫妻争吵
睡眠	入睡难、易醒、每晚睡几小时
咖啡因/酒精/吸烟	每天几杯咖啡、是否喝酒助眠
正在吃的药/保健品	名称、开始时间、效果、副作用
既往检查	做过什么、结果如何
既往治疗	心理治疗、药物、效果
希望医生帮我什么	例如：明确诊断、是否需要用药、怎么处理发作

这张纸的价值在于：**它把“我很痛苦”翻译成医生能快速处理的信息**，也避免你一紧张就忘。

五、必须主动说的事，家属怎么补充

这些事必须主动说

有些信息难以启齿，但对诊断和安全至关重要：

- **酒精**：喝多少、多久、是否用酒助眠或壮胆、有没有停酒后手抖出汗。
- **镇静药/安眠药**：是否自行加量、是否从别人那里拿药、是否想停。
- **咖啡因**：咖啡、浓茶、能量饮料、含咖啡因的感冒药或止痛药。
- **其他药物**：减肥药、激素、支气管扩张剂、含麻黄碱的制剂、保健品。
- **躁狂/轻躁狂史**：有没有过一段时间“精力特别好、睡得少也不困、话多、花钱大手大脚、冲动”。
- **创伤史**：有没有经历过事故、暴力、性侵、长期忽视。
- **自杀念头**：有没有想过死、有没有计划、有没有准备。
- **家族史**：直系亲属有没有焦虑、抑郁、双相、自杀、酒精问题。

这些不是“查户口”，而是直接影响诊断和用药安全。**你不需要一次说完，但不要说谎或省略。**

家属怎么补充

家属的观察常常比患者本人更客观，尤其是“变化”和“回避”。

- **说具体行为，不说评价**：“他这三个月没坐过地铁”“她每天晚上要检查门锁五六次”，比“他太焦虑了”有用。
- **说时间线**：“去年 10 月以后开始请假”，比“很久了”有用。
- **说功能变化**：“以前每周打球，现在不去了”“最近三个月瘦了十斤”。
- **说用药和饮酒**：有没有自行加量、有没有偷偷喝酒。
- **说风险**：有没有提到不想活、有没有自伤、有没有把东西送人。
- **不打断、不替患者回答**：医生问患者时，先让患者说，需要时再补充。
- **不当场指责**：诊室里说“他就是懒”，会让患者更难开口，也影响医生判断。

如果患者不愿意家属陪同，可以事先写一张纸条交给医生，或单独和医生沟通。

六、就医提示与常见问题

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 胸痛、气短、晕厥、抽搐、意识障碍；
- 自杀念头强烈、有具体计划，或已经自伤；
- 酒精、镇静药突然停用后出现手抖、大汗、幻觉、意识混乱；
- 服药后高热、大汗、肌肉僵硬、意识改变。

尽快联系医生：

- 初诊后症状没有按预期变化，或明显加重；
- 服药后出现新的不适、过敏、心慌加重；
- 出现情绪低落、失眠加重、坐立不安；
- 想自行减药或停药（先问，不要自己动手）；
- 准备怀孕、已经怀孕或哺乳。

常见问题

“我说不清楚，会不会影响诊断？”不会。医生受过训练，会用提问帮你梳理。你带着时间线和检查单，已经比大多数初诊患者准备得好。

“要不要把以前的诊断告诉医生？”要。包括别人给过的诊断、吃过的药、效果和副作用。误诊、改诊断在精神科并不罕见，信息越全，判断越准。

“家属能不能进诊室？”多数医院允许，但医生可能会先单独问患者，再请家属补充。提前问一句“需要家属一起吗”更稳妥。

“一次没说完，下次还要重新讲吗？”不用。初诊记录会留存，复诊时补充“这段时间的变化”即可。可以带一个固定的小本子，每次记三件事：变化、副作用、想问的问题。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.3 医生如何诊断与评估

“医生就问了我十几分钟，做了个量表，就说是焦虑症，靠谱吗？”这是初诊后最常见的疑问之一。有人觉得诊断太轻率，有人觉得医生问得太少。这一页讲精神科医生到底怎么做出诊断：访谈问什么、为什么要看病程和功能、量表在其中占什么位置、需要排除哪些情况，以及为什么“诊断”常常是一个随时间修正的过程。

一、诊断不是“做个量表”

量表是筛查和追踪工具，不是诊断工具。GAD-7 分数高，只能说明“最近两周焦虑水平偏高”；它不能区分广泛性焦虑、惊恐障碍、社交焦虑，也不能排除甲状腺问题、心律失常、药物副作用。**真正的诊断来自临床访谈：症状、病程、功能损害、排除其他原因，四块拼起来。**【指南】

可以这样理解：

- **量表**回答“有多重”；
- **访谈**回答“是什么、多久了、影响多大、还有什么”；
- **检查**回答“是不是别的病”；
- **时间**回答“治疗反应对不对、诊断要不要改”。

只做量表就下诊断，就像只看体温计就判断是肺炎还是流感——体温有用，但远远不够。

二、临床访谈会问什么

一次规范的精神科初诊，通常会覆盖这些方面：

维度	医生可能问什么	为什么重要
主诉	最难受的是什么？什么时候开始的？	确定核心问题
现病史	症状、频率、诱因、加重缓解因素	判断是否符合诊断标准
病程	持续多久？是持续存在还是发作性？	区分不同类型
功能	工作、学习、睡眠、社交受影响吗？	判断严重度与治疗强度
既往治疗	看过什么科、做过什么检查、用过什么药	避免重复、判断难治
躯体情况	有没有甲亢、心脏病、哮喘、糖尿病	排除躯体原因
物质使用	咖啡因、酒精、吸烟、镇静药、减肥药	排除物质所致
风险	有没有自杀念头、自伤、冲动	安全评估
家族史	直系亲属有没有焦虑、抑郁、双相	辅助判断
人格与应对	一贯的性格、遇到压力的方式	理解个体差异

访谈不是“查户口”，而是把碎片拼成一条能解释症状的线索。**一个好医生会追问细节**：不是“你焦虑吗”，而是“上次发作时，你第一个感觉到什么？当时在做什么？后来怎么处理的？”

三、病程和功能损害，是诊断的两根柱子

同样是“紧张、心慌”，持续三天和持续三年，意义完全不同；偶尔发作和每天发作，处理方式也不同。

病程帮助区分类型：

- 广泛性焦虑：长期、弥散、多数日子存在；
- 惊恐障碍：反复的意外发作，加上至少一个月担心再发或行为改变；
- 社交焦虑：特定社交情境、持续较长时间；
- 特定恐惧：特定对象、即时反应、回避；
- 分离焦虑：与依恋对象分离相关，儿童至少四周、成人至少六个月。

功能损害决定“算不算病”和“要不要治”。诊断标准里通常都要求“造成明显痛苦或功能损害”。功能包括：工作/学业、家庭、社交、睡眠、日常生活。**一个人还能上班，不代表没有损害**——可能是在用额外的力气硬撑。

四、需要排除的那些“看起来像焦虑”的情况

这是诊断中最容易被忽略、也最影响治疗的部分。

双相障碍：如果患者有过躁狂或轻躁狂发作（精力旺盛、睡眠需求减少、话多、思维奔逸、花钱冲动、行为鲁莽），单独用抗抑郁药可能诱发转躁或快速循环。所以医生会专门问“有没有一段时间状态特别高”。这一点必须主动说，不要因为“那段时间感觉挺好”就省略。

抑郁障碍：焦虑和抑郁常同时存在。抑郁以情绪低落、兴趣减退、精力下降为核心，焦虑以担忧、恐惧、紧张为核心。两者共病时，治疗顺序和药物选择会不同。

创伤后应激障碍（PTSD）：经历过重大创伤后，出现闪回、噩梦、回避、警觉性增高。如果只按焦虑治，不处理创伤，效果往往有限。

强迫症（OCD）：反复的念头（污染、伤害、对称）和重复行为（清洗、检查、计数）。强迫和焦虑有重叠，但治疗重点不同，需要区分。

物质或药物所致：咖啡因、酒精、尼古丁、减肥药、激素、含麻黄碱的感冒药、某些哮喘药，都可能引起心慌、手抖、失眠。酒精或镇静药戒断也会表现为焦虑。

躯体疾病：甲状腺功能亢进、心律失常、低血糖、嗜铬细胞瘤、哮喘、前庭疾病等。详见4.4 鉴别诊断：甲亢、心律失常、低血糖等。

其他：人格特质、孤独症谱系、注意缺陷多动障碍、痴呆早期、慢性疼痛、睡眠障碍，都可能以“焦虑”的面貌出现。

五、量表、检查与诊断过程

量表的位置：筛查、分级、追踪

常用的量表各有分工：

量表	测什么	主要用途
GAD-7	广泛性焦虑的严重度	筛查、追踪
PDSS	惊恐障碍的严重度	评估发作与回避
LSAS / SPIN	社交焦虑的范围与严重度	筛查、追踪
SCARED	儿童青少年焦虑	儿童筛查
PHQ-9	抑郁严重度	共病筛查
自评/他评功能量表	工作、社交、家庭功能	判断损害程度

量表的正确用法是：**治疗前测一次作为基线，治疗中定期复测看趋势**。单次高分不能确诊，单次低分也不能排除。量表还会受最近事件、睡眠、作答动机影响。

有些医院会做**结构化访谈**（如 SCID），由受过训练的人员逐条询问诊断标准，比自由访谈更系统，但耗时较长，不是每个门诊都做。

躯体检查：不是每个人都全套，但不能跳过该查的

精神科医生通常会做简单的体格检查（血压、心率、甲状腺触诊等），并根据病史安排化验。常见的有：

- 血常规、甲状腺功能、血糖、电解质、肝肾功能；
- 心电图，尤其是有心悸、胸痛、晕厥，或准备用可能影响心脏的药物时；
- 育龄女性可能需要妊娠试验；
- 有物质使用史时，可能需要尿检；
- 有晕厥、活动后气短时，可能需要动态心电图、心脏超声、肺功能。

不是所有焦虑患者都需要全套检查，但“该查的没查”和“查得过多”都是问题。前者漏诊，后者增加焦虑和费用。判断依据是病史、体征和风险因素。

诊断是一个过程，不是一次判决

精神科的诊断，更像一个**工作假设**：根据现有信息给出最可能的方向，开始治疗，观察反应，再修正。

几种常见情况：

- 一开始诊断为 GAD，治疗中发现反复的惊恐发作，诊断调整为惊恐障碍；
- 一开始只看到焦虑，后来出现明确的抑郁发作，需要同时处理；
- 治疗无效时，回头发现是双相、PTSD、OCD 或躯体疾病；
- 青少年早期诊断为社交焦虑，随发育发现同时有孤独症谱系特征。

所以复诊时医生会反复问：“这一个月怎么样？药有没有用？有没有新情况？”这不是“上次没看准”，而是精神科诊断的常态。**你可以主动提供信息，帮助医生修正判断。**

你可以问医生的几个问题

- ☐ 我的诊断是什么？依据是什么？
- ☐ 还需要排除哪些躯体或精神方面的问题？
- ☐ 需要做哪些检查？为什么做？
- ☐ 目前严重程度属于哪一档？对功能的影响有多大？
- ☐ 治疗选择有哪些？心理治疗、药物，还是联合？
- ☐ 起效大概要多久？怎么判断有没有效？
- ☐ 出现什么情况需要提前复诊或去急诊？
- ☐ 下次复诊前，我需要记录什么？

问这些问题不会“得罪”医生，反而能让你更清楚自己在治什么。

六、就医提示与常见问题

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 胸痛、气短、晕厥、抽搐、意识障碍；
- 自杀念头强烈、有具体计划，或已经自伤；
- 服药后高热、大汗、肌肉僵硬、意识改变；
- 酒精、镇静药突然停用后出现戒断反应。

尽快联系医生：

- 治疗数周后毫无改善，或症状明显加重；
- 出现新的症状，尤其是情绪高涨、睡眠需求减少、冲动行为；
- 出现药物不良反应；
- 想调整或停止治疗，先和医生讨论。

常见问题与容易踩的坑

“网上说我是焦虑症，还需要看医生吗？”需要。网络信息可以帮你描述问题，但不能排除躯体疾病、双相、PTSD、药物因素。自我诊断最大的风险不是“贴错标签”，而是漏掉真正需要处理的问题。

“量表分数正常，是不是就没病？”不是。量表测的是最近两周的典型症状，可能漏掉回避、躯体化、发作性症状。诊断看的是整体。

“医生只问了十分钟，是不是不认真？”时间长短不是唯一标准。有经验的医生会抓关键线索，配合量表、检查、既往资料。如果你觉得没说完，可以复诊时补充，或换一位医生再听一次意见。

“诊断会不会变？”会，而且不罕见。诊断随信息更新而修正，是负责任的表现，不是“庸医”。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.4 鉴别诊断：甲亢、心律失常、低血糖等

心慌、手抖、出汗、气短、头晕——这些症状既可能是焦虑，也可能是甲状腺、心脏、血糖、呼吸或前庭系统出了问题。把所有的“心悸”都归为焦虑，会漏掉真正需要处理的疾病；反过来，把所有的“心悸”都当成心脏病，又会让人陷入反复检查、越查越怕的循环。这一页讲哪些病容易和焦虑混淆、各自的线索是什么、哪些症状必须查，以及怎么和医生一起把边界划清楚。

一、为什么不能把所有心悸都归为焦虑

心悸是一种主观感受，可能来自心跳太快、太重、太乱，也可能来自对正常心跳的过度注意。焦虑会让人心跳加快、对心跳更敏感，所以“焦虑→心悸”这条路是成立的。

但反过来，“心悸→焦虑”不成立。甲状腺功能亢进、心律失常、贫血、低血糖、嗜铬细胞瘤、药物副作用，都可以直接引起心悸、手抖、出汗，而这些症状又会让人紧张，形成“病→怕→更难受”的叠加。**这时候只治焦虑，等于只处理了回声，没有处理声源。**

一个实用的原则：**首次出现、症状剧烈、有躯体危险因素、伴随“不像焦虑”的特征时，先查躯体原因。**【指南】

二、常见需要鉴别的疾病

疾病	典型线索	常做的检查
甲状腺功能亢进	怕热、多汗、手抖、体重下降、食欲增加、腹泻、月经紊乱、甲状腺肿大、突眼	甲状腺功能（TSH、FT4）
心律失常	心跳“漏一拍”、突发突止、活动时加重、伴头晕或晕厥	心电图、动态心电图、心脏超声
二尖瓣脱垂	心悸、胸闷、乏力，部分人有胸痛	心脏超声
低血糖	出汗、手抖、心慌、饥饿感、意识模糊，进食后缓解	血糖（发作时测最有价值）
嗜铬细胞瘤	阵发性血压骤升、剧烈头痛、大汗、心悸	血/尿儿茶酚胺代谢物、影像
哮喘/慢阻肺	气短、喘鸣、咳嗽、夜间憋醒、活动后加重	肺功能、峰流速
贫血	乏力、面色苍白、活动后心慌气短	血常规
前庭疾病	天旋地转、耳鸣、听力下降、体位改变诱发	前庭功能检查、听力检查
药物/咖啡因/酒精	心慌、手抖、失眠，和摄入时间相关	详细用药与饮酒史
戒断反应	停酒或停镇静药后手抖、大汗、心跳快、幻觉、抽搐	病史为主，必要时急诊处理

下面挑几个最常被混淆的说细一点。

甲状腺功能亢进

甲亢是“披着焦虑外衣”的典型。患者会心慌、手抖、出汗、睡不好、容易发脾气、注意力下降，和广泛性焦虑几乎一模一样。区别常在这些地方：

- **怕热、多汗**，而不是怕冷；
- **吃得多却瘦**，体重明显下降；
- **腹泻、大便次数增多**；
- **月经量减少或紊乱**；
- **脖子粗、眼睛突出**（不是每个人都有）；
- **心率持续偏快**，安静时也快。

如果你有以上任何一项，尤其是体重下降和怕热，值得先查甲状腺功能。甲亢不处理，焦虑治疗也很难见效。

心律失常与二尖瓣脱垂

心律失常的表现差别很大。有人是“突然一阵心跳飞快，几分钟后突然停”，有人是“心脏漏一拍、咯噔一下”，有人是持续的心跳乱。**突发突止、活动时诱发、伴头晕或晕厥**，更提示需要心脏评估。

二尖瓣脱垂是一种相对常见的心脏结构问题，多数人没有严重问题，但可能有心悸、胸闷、乏力。需要说明的是：**过去曾把二尖瓣脱垂和惊恐障碍紧密联系，后来的研究并不支持“二尖瓣脱垂导致惊恐障碍”这种简单因果关系**。两者可能同时存在，但处理上要分别评估，不能互相替代。【研究】

心电图正常不代表没有心律失常——普通心电图只记录几十秒。如果症状是阵发性的，医生可能安排动态心电图（佩戴 24 小时或更久）、事件记录器或运动负荷试验。具体做什么，由心内科医生根据症状频率和风险决定。

低血糖

低血糖的典型表现是出汗、手抖、心慌、饥饿、焦虑、注意力不集中，严重时意识模糊、行为异常。它和焦虑的区分点在于：

- 和**进食时间**有关，空腹或漏餐后出现，吃东西后缓解；
- 糖尿病患者使用降糖药或胰岛素时尤其要警惕；
- 发作时测血糖最有价值，事后测可能已经正常；
- 严重低血糖可能危及生命，不能只当焦虑处理。

如果你反复出现“手抖、出汗、心慌、必须马上吃东西才好”，建议和医生讨论是否需要查血糖，尤其是正在用降糖药的人。

嗜铬细胞瘤

这是一种少见的肾上腺肿瘤，会阵发性释放肾上腺素，引起**血压骤升、剧烈头痛、大汗、心悸**，发作时非常像惊恐发作。它罕见，但危险，漏诊后果严重。

提示点：发作时血压明显升高（而不是正常或偏低）、头痛剧烈、大汗淋漓、发作持续十几分钟到一小时；可能有家族史。医生如果怀疑，会查血或尿的儿茶酚胺代谢物，必要时做影像。**不要因为“我查过肾上腺没事”就永远排除，也不要因为“网上一查就是它”而过度恐慌**——它罕见，判断靠医生。

呼吸系统疾病

哮喘、慢阻肺、肺栓塞都可能表现为气短、胸闷、心慌。提示点：

- 喘鸣、咳嗽、夜间憋醒、活动后加重（哮喘、慢阻肺）；
- 突发气短伴胸痛、咳血、单侧腿肿（需警惕肺栓塞，属急症）；
- 对支气管扩张剂有反应；
- 肺功能、峰流速、血氧有帮助。

另外，治疗哮喘的支气管扩张剂本身可能引起心慌、手抖，容易被误认为“焦虑加重”。

药物、咖啡因、酒精与戒断

这一类的“线索”在病史里，不在化验单上：

- **咖啡因**：咖啡、浓茶、能量饮料、部分感冒药和止痛药。每天几杯、什么时候喝、停了会不会好，都值得记录。
- **减肥药、兴奋剂**：部分成分会明显加快心率、加重焦虑。
- **激素、甲状腺素、支气管扩张剂、含麻黄碱的制剂**：可能引起心慌、失眠。
- **抗抑郁药早期**：部分人开始服药时会出现焦虑、心慌、恶心，通常会随适应减轻，但需要医生评估。
- **酒精**：喝酒当下放松，代谢后反跳性焦虑、失眠、心跳快；长期大量饮酒后突然停酒，可能出现手抖、大汗、幻觉、抽搐，**这是急症，不能自行硬戒**。
- **苯二氮䓬类**：长期使用后突然减停，可能出现焦虑反跳、失眠、心慌、震颤，严重时抽搐。**必须在医生指导下缓慢减量。**

前庭疾病

眩晕、天旋地转、走路不稳、恶心，常被当成“焦虑发作”。区别点：

- 真正的旋转性眩晕，常伴眼震、耳鸣、听力下降；
- 体位改变诱发（如起床、翻身）提示良性阵发性位置性眩晕；
- 突然听力下降伴眩晕，需尽快耳鼻喉科就诊；
- 焦虑相关的头晕多是“头重脚轻、飘、站不稳”，较少真正的旋转。

三、哪些症状必须查

以下情况，不建议先按焦虑处理，应先做躯体评估：

- ☐ 首次出现的心悸、胸痛、气短，尤其年龄偏大或有心血管危险因素。
- ☐ 活动时诱发、休息缓解的胸闷胸痛。
- ☐ 晕厥或差点晕厥。
- ☐ 心跳持续过快（安静时也快）或明显不规则。
- ☐ 不明原因体重下降、怕热、多汗、手抖、腹泻。
- ☐ 阵发性血压骤升伴头痛、大汗。
- ☐ 反复低血糖样发作，尤其是糖尿病患者。
- ☐ 喘鸣、夜间憋醒、咳血、单侧腿肿。
- ☐ 旋转性眩晕伴耳鸣、听力下降。
- ☐ 长期饮酒或使用镇静药，准备减停。
- ☐ 正在服用可能引起心悸、焦虑的药物。

“必须查”不等于“全套查”。 查什么、查到什么程度，由医生根据病史、体征和风险因素决定。过度检查也有代价：增加焦虑、浪费资源、可能发现无意义的“小异常”而引发新的担心。

四、什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 突发剧烈胸痛、压榨感，持续不缓解，或放射到手臂、下颌；
- 突然严重气短、口唇发紫、咳血；
- 晕厥、抽搐、意识障碍；
- 心跳极快且伴胸痛、头晕、眼前发黑；
- 血压骤升伴剧烈头痛、大汗、呕吐；
- 低血糖后意识模糊、行为异常，进食后不缓解；
- 酒精或镇静药戒断出现幻觉、抽搐、高热。

尽快到相应专科就诊：

- 反复心悸、胸闷，普通心电图正常但症状频繁；
- 体重下降、怕热、手抖、腹泻；
- 反复低血糖样发作；
- 喘鸣、活动后气短；
- 旋转性眩晕、耳鸣、听力下降；
- 正在用药，怀疑与症状有关。

五、常见问题与容易踩的坑

“我查了心电图正常，是不是就说明心脏没问题？”普通心电图只记录几十秒，阵发性问题可能抓不到。如果症状频繁或伴晕厥，需要和医生讨论更长时间的监测。但也不意味着要无限查下去，具体由心内科判断。

“是不是所有心悸都是焦虑？”不是。心悸的原因很多，焦虑只是其中之一。反过来，焦虑也确实会引起心悸。**两者可以同时存在**，所以要“边查边治”，而不是二选一。

“我查了很多次都没事，还需要查吗？”如果已经做过规范评估、风险因素低、症状模式稳定，反复检查的收益会下降，反而可能强化焦虑。可以和医生明确问：“以我的情况，还需要查什么？查完之后，如果正常，我们怎么处理这个担心？”

“甲亢查一次正常，是不是就永远没事？”甲状腺功能会变化。如果症状持续或出现新线索，医生可能复查。是否复查、多久复查，由医生决定。

“我是不是应该先治焦虑，还是先查身体？”多数情况可以并行：先做必要的排查，同时开始焦虑的评估和干预。**急症优先，排查与治疗不冲突。**

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 5：心理治疗

心理治疗是焦虑障碍的一线治疗之一。核心不是“讲道理”，而是改变威胁评估、停止回避、学会面对不确定性。

5.1 心理治疗总览与证据

决定做心理治疗之后，最常见的问题不是“要不要做”，而是“做哪一种、找谁做、做多久、怎么知道有没有用”。这一页把主流取向、证据强弱、频率疗程和判断标准放在一起讲，帮你在挂号前心里有数。它不替你做选择，但能让你在诊室里问出更具体的问题。

心理治疗是什么，不是什么

心理治疗不是“找人聊聊”，也不是“被劝一顿就好了”。它有几个可以观察的特征：

- 有理论模型：治疗师知道自己在用什么方法，为什么这么做。
- 有结构：会谈有主题、有议程、有先后顺序，不是想到哪说到哪。
- 有目标：通常在前几次就和你商定要改变什么，比如“能独自坐地铁”“减少每天担忧的时间”。
- 有练习：会谈之外有作业，因为改变发生在日常生活里。
- 有评估：会用量表或记录跟踪进展，而不是只凭感觉。
- 有边界：固定时间、固定时长、保密条款、不发展私人关系。

反过来说，如果一个人只是听你倾诉、给你讲道理、鼓励你“想开点”，没有任何结构和练习，那更接近支持性咨询，不是针对焦虑障碍的规范治疗。支持性咨询不是没用，但它通常不足以单独处理中重度的焦虑障碍。

主流取向一览

取向	主要做什么	更适合谁	证据强度
认知行为治疗（CBT）	识别并检验威胁性想法，配合行为实验与暴露	各类焦虑障碍，尤其是惊恐、社交焦虑、广泛性焦虑	最强，指南一线
暴露疗法	有计划地面对回避的情境，停止安全行为	恐惧、回避明确的人；常作为 CBT 的核心成分	强，指南一线
接纳承诺治疗（ACT）	不消除想法，练习接纳与按价值行动	反复与想法搏斗、回避体验的人	中等，研究增长中
元认知治疗（MCT）	改变对“担忧本身”的信念与应对方式	广泛性焦虑、担忧停不下来的人	中等，有随机对照研究
心理动力治疗	探索早期关系模式与重复的冲突	想理解“为什么会这样”、人际关系议题突出的人	中等偏弱，指南多不列一线
正念与正念认知治疗	训练注意力的觉察与去中心化	广泛性焦虑、反复担忧、预防复发	中等，效应通常温和

取向	主要做什么	更适合谁	证据强度
支持性治疗	提供稳定支持、现实建议、危机陪伴	急性危机、暂时无法做结构化治疗的人	基础性，核心症状改善有限

表中的“证据强度”是相对说法，不是排名。一个人适合哪种治疗，取决于诊断、症状特点、既往治疗史、可及性和个人偏好，个体差异很大。

证据：哪些更硬，哪些更软

CBT 的证据最充分。 对广泛性焦虑、惊恐障碍、社交焦虑、特定恐惧，CBT 都有多项随机对照试验和系统综述支持，NICE 指南把它列为一线的心理治疗。【指南】CBT 的优势不只是“有效”，还包括效果相对持久、可结构化、可团体、可数字化。

暴露是核心成分，不只是 CBT 的附属。 对恐惧和回避明显的焦虑，暴露几乎是所有有效方案里都有的部分。去掉暴露、只做认知讨论，效果通常打折。【研究】

ACT 的证据在增长。 多项随机对照试验和 meta 分析显示 ACT 对焦虑障碍有效，部分研究里与 CBT 相当。【研究】但研究数量、样本量和随访时间还不如 CBT 充分，NICE 的焦虑指南目前没有把它列为一线推荐。它适合那些“越努力消除焦虑越失败”的人，但不宜被宣传成“比 CBT 更好”。

元认知治疗（MCT） 针对的是“对担忧的担忧”。在广泛性焦虑的随机对照试验里，MCT 的效果与 CBT 相近，部分研究随访表现不错。【研究】它的优势是疗程较短、聚焦明确；劣势是受过训练的治疗师较少。

心理动力治疗 有随机对照研究支持，尤其是短程动力治疗对焦虑和抑郁的混合样本。【研究】但研究异质性大，指南通常不把它列为焦虑障碍的一线。它可能更适合想理解重复模式、人际议题突出的人，作为辅助或长程选择。

正念与正念认知治疗 对焦虑有帮助，效应通常温和到中等，对反复担忧和预防复发可能更有价值。【研究】它不是“放松一下”，而是训练注意力和对想法的关系；如果只当作睡前冥想，效果有限。

支持性治疗 是很多治疗的底色，尤其在危机期。但把它当作中重度焦虑的唯一治疗，通常不够。【临床经验】

频率、疗程与形式

频率：常见是每周一次，每次 45–60 分钟。前几次偏评估和建立目标，中间是核心练习，后段是巩固和预防复发。

疗程：结构化的 CBT 通常安排在 12–16 次左右，广泛性焦虑可能需要更长。【指南】这不是硬性规定，而是让你有一个大致预期：如果做了三四次还在“随便聊”，可以提出疑问。

形式：个体、团体、家庭、伴侣治疗都有适用场景。社交焦虑的团体治疗有独特优势，因为团体本身就是一个社交场景；广泛性焦虑的个体治疗更常见；青少年治疗常需要家长参与。

强度：多数人每周一次；少数人适合密集形式（比如连续几天的集中治疗），适合症状重、住得远、或想快速启动的人。密集不等于更有效，只是把同样的剂量压缩。

数字化：有引导的网络 CBT（有治疗师支持的自助程序）对轻中度焦虑有研究支持，可作为等待期的过渡或轻症选择。【研究】完全无指导的自助程序脱落率高，效果通常不如有人指导。

轻度可单用，中重度常联合药物

这是最常被问的问题，答案取决于严重度和功能损害：

轻度（症状存在，但工作、社交、睡眠基本维持）：心理治疗可以单独使用，CBT 或结构化暴露是合理起点。规律运动、睡眠调整、减少咖啡因可以同时进行。

中度（明显影响工作或社交，但仍能勉强维持）：心理治疗仍是核心，可与医生讨论是否加药。很多人先做心理治疗，观察 8–12 周再决定。

重度（无法上班上学、频繁惊恐、明显抑郁、体重下降、失眠严重）：通常建议药物与心理治疗联合。联合在部分研究中优于单一治疗，尤其在症状重、慢性化的情况下。【研究】药物先降低警觉和症状强度，让暴露和认知工作变得可行；心理治疗则帮助长期维持和减少复发。

需要强调的是：**这不是“二选一”的道德问题**。有人把吃药看成“不够努力”，有人把心理治疗看成“浪费时间”，两种偏见都会耽误治疗。选哪条路，看的是证据、严重度和个人条件。

怎么判断自己是不是在做规范治疗

下面这份清单可以直接拿去对照，也可以拿去问治疗师。能对上大部分，说明方向是对的；对不上很多，值得沟通或考虑换人。

- ☐ 前 1–3 次有系统评估：症状、病程、诱因、回避清单、既往治疗、躯体疾病、用药、自杀风险。
- ☐ 有明确的治疗目标，而且是可以观察的（“能独自坐地铁”，不是“变得自信”）。
- ☐ 会谈有议程，治疗师会说明今天做什么、为什么。
- ☐ 有会谈外的作业，且下次会回顾，不是布置了就忘。
- ☐ 针对焦虑，包含暴露或行为实验，而不只是放松和聊天。
- ☐ 有阶段性评估，用量表（如 GAD-7）或记录看变化。
- ☐ 有保密说明、时间边界、费用说明，不发展私人关系。
- ☐ 不承诺“包治”“几次就好”，不推销保健品、课程或“能量疗法”。
- ☐ 与你的精神科医生有沟通（在你同意的前提下），不是两边各说各话。

如果治疗师从不布置作业、从不谈暴露、每次都在听你讲本周发生的事、也从不评估进展，那可能不是针对焦虑的规范 CBT。你可以直接问：“我们接下来的计划是什么？暴露大概什么时候开始？”

常见问题

心理咨询和心理治疗有什么区别？在国内，心理治疗通常指医疗机构内由取得资质的心理治疗师提供的治疗，心理咨询更多在机构或社会机构进行。名称之外，更该看的是：受训背景、是否受过 CBT 或暴露的系统训练、有没有督导、有没有评估和计划。

做几次没感觉，是不是没用？前几次以评估和建立关系为主，效果常在 6–8 次后显现。但如果 8 次之后仍然没有目标、没有作业、没有暴露计划，就值得提出疑问，而不是继续“聊下去”。

可以只做心理治疗、不吃药吗？轻中度可以，尤其是愿意投入练习、能定期就诊的人。中重度、或伴明显抑郁和功能损害时，单用心理治疗可能不够快，建议和医生讨论联合方案。

治疗师让我做暴露，我很害怕，能拒绝吗？可以讨论节奏，但不建议一开始就拒绝整个方向。规范的做法是分级、协商、可退出，而不是硬闯。如果你感到被强迫、被羞辱，或治疗师无视你的安全边界，那是需要换人的信号。

什么时候需要联系医生或寻求额外帮助

- 治疗过程中症状明显加重，出现持续失眠、无法进食、无法工作：及时复诊，让医生和治疗师沟通。
- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划：不要独处，立即联系信任的人，拨打 120 或去急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 治疗师有越界行为（私下约会、索要财物、言语羞辱、泄露隐私）：停止治疗，向机构或当地卫生监管部门反映。
- 治疗数月无进展：可以要求重新评估诊断（是否共病抑郁、双相、PTSD、躯体疾病），或考虑换治疗师/换方案。
- 经济压力导致无法继续：询问医院社工、医保政策、团体治疗或低强度网络 CBT 等替代方案。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.2 CBT 的认知重构与行为实验

CBT 常被误解成“劝人想开点”或者“正能量训练”。实际上，它更像一套检验方法：把你对危险的预测写成可以被检验的假设，然后用证据和实验去看它准不准。这一页讲认知重构怎么做、行为实验怎么设计、注意力怎么训练，也讲 CBT 不是什么。读完你能看懂治疗师在做什么，也能判断自己有没有真的在做 CBT。

CBT 的基本思路：把信念当假设

CBT 的出发点是：让人痛苦的往往不是事件本身，而是事件被赋予的意义。这句话容易被误读成“事实不重要，想法最重要”。更准确的版本是：**事实和解释都会影响情绪，而解释这一层是可以被检验的**。

举例：同事在走廊里没跟你打招呼。

- 解释 A：“他讨厌我，我肯定哪里得罪他了。”→ 焦虑、反复回想。
- 解释 B：“他在想事情，没看见我。”→ 基本无感。
- 解释 C：“他可能对我有意见，也可能只是没注意，我需要更多信息。”→ 略不安，但能行动。

CBT 不要求你选最乐观的解释，而是要求你**把解释当成假设**：它有多少证据？有没有别的可能？如果换一种解释，我的感受和行为会怎样？如果事实证明是 A，我又能做什么？

这就是认知重构的本质：不是换一个更开心的想法，而是把评估校准到更接近事实的位置。

认知重构：四步和一个表

认知重构通常分四步：

1. **抓住自动想法**：在情绪明显波动的那一刻，问“我刚才脑子里闪过什么？”
2. **标注情绪**：是什么情绪，强度几分（0–100）。
3. **检验证据**：支持这个想法的证据是什么？反对的证据是什么？有没有被忽略的信息？
4. **形成平衡想法**：不是“没事”，而是“更完整、更准确的说法”，然后决定下一步行动。

想法记录是这四步的载体。它不需要写得很漂亮，只需要诚实、具体。

情境与情绪	自动想法	支持与反对的证据	更平衡的想法
明天部门会议要发言，焦虑 80	我一定会说错，大家会觉得我很蠢	支持：上次说错一个数字；反对：上次整体讲完了，同事还追问细节，没人提那个数字	我可能会紧张、说错一句，但不至于被当成蠢人；准备过就能讲完
朋友两小时没回消息，不安 65	他是不是生我气了	支持：最近一次聊天结束得有点仓促；反对：他常在开会，上次也是隔很久才回	可能只是忙；如果在意，可以晚点直接问一句
心跳有点快，恐惧 85	心脏要出问题了	支持：刚才确实心悸；反对：上周心电图正常，刚爬	更像是运动加咖啡因；如果持续或伴胸痛，再去查

情境与情绪	自动想法	支持与反对的证据	更平衡的想法
		了楼，喝了咖啡	

写的时候有两个常见错误：

写得太抽象。“我总是很焦虑”不是自动想法，没法检验。“我肯定会在会上出丑”才是。

只写支持证据。人一旦进入焦虑状态，会自动收集威胁证据、忽略安全信息。检验的意义就在于把被忽略的那一半找回来。

证据检验：不是找借口

“找证据”听起来简单，做起来容易走偏。两种走偏都要避免：

走偏一：只找支持自己的证据。 这叫确认偏误。焦虑的人尤其擅长记住失败、忘记成功。检验时要主动问：“如果我最好的朋友遇到这件事，我会提醒他注意哪些信息？”

走偏二：把“没有证据”当成“不可能”。 正确的表述是“目前没有证据支持它一定会发生”，而不是“它绝对不会发生”。CBT 追求的是准确，不是绝对安全。

一个实用的做法是把证据分成三类：

- **事实**：可以被第三方核实的事（“上周心电图正常”）。
- **推测**：你的解释（“医生可能没查仔细”）。
- **感受**：身体的反应（“我一想到就心慌”）。

焦虑状态下，这三类常常被混在一起，感受被当成事实，推测被当成证据。把它们分开写，很多纠结会立刻清楚一些。

行为实验：把预测拿到现实里测

认知重构在桌上完成，行为实验在现实里完成。它的逻辑是：如果你的预测是真的，那么在设计好的情境里，应该能看到相应的结果；如果看不到，预测就需要修正。

行为实验一般有六步：

1. **写下预测**：具体到“谁、什么时候、会发生什么、我怎么能看出来”。
2. **评估信心**：你有多相信它（0–100）。
3. **设计实验**：怎样的行动能检验它？要观察什么？
4. **执行**：尽量只改变一个变量，不要一次试太多。
5. **记录结果**：实际发生了什么？和预测差在哪？
6. **更新结论**：新的信心分数是多少？下次可以怎么调整？

一个例子：

- 预测：“如果我在会上发言时手抖，同事一定会注意到，并且觉得我不行。”（信心 85）
- 实验：例会上主动发言两分钟，不刻意把手藏起来，观察三位同事的反应，会后问一位关系好的同事“我刚才讲得清楚吗”。
- 结果：没有人提手抖；一位同事问了数据来源；关系好的同事说“有点紧张，但内容清楚”。
- 更新：手抖可能被看到，但别人更关注内容；信心降到 40。下次可以试着在更大的会上发言。

行为实验和暴露的区别在于：**实验是为了获取信息，暴露是为了反复练习**。实验中你可能只做一次就得到答案；暴露需要重复很多次，直到身体和大脑习惯“这里安全”。两者常常配合使用。

设计实验时要注意几点：

- 不要设计“注定成功”的实验，那样学不到东西；也不要设计“注定失败”的，那会加重挫败。
- 结果不如预期时，不要急着否定自己，先看实验设计有没有问题（变量太多、时间太短、状态太差）。
- 实验前不要用安全行为“保底”，否则结果会被解释成“因为我准备了才没出事”。

注意力训练：从向内扫描到向外

焦虑的人常把注意力放在自己身上：心跳、呼吸、脸有没有红、手有没有抖、刚才那句话说得对不对。这种自我监控会放大身体信号，也会让你错过环境里的安全信息。

注意力训练的方向是**把注意力从内部调到外部**：

- 在社交场合，把注意力放在对方说的话、表情、话题上，而不是自己的表现。
- 在公共场所，练习注意三种声音、三种颜色、三种物体，把注意力锚定在环境里。
- 当发现自己又开始扫描身体时，不批评自己，只是把注意力带回外部，重复练习。

还有一类练习叫“注意转向”：先注意一个声音，再注意另一个声音，再注意呼吸，再回到环境。目的是训练注意力的灵活性，而不是消灭焦虑。注意力训练不能替代暴露，但能减少“越关注越紧张”的循环。

CBT 不是什么

不是积极思考。 不是把“我可能会失败”换成“我一定会成功”，而是换成“我可能会失败，也可能不会；我能做的是准备和尝试”。

不是讲道理。 知道和做到是两套系统。CBT 的重点在练习，不在说服。

不是一次谈话就能解决。 它需要每周的会谈加上每天或每周的作业，通常以周和月计。

不是否认现实。 如果你的处境真的危险、真的不公平，CBT 不会让你“调整心态接受”。它帮你分清哪些是可控的，哪些需要改变环境或寻求帮助。

不是把责任推给你。 “你的想法有问题”这种说法本身就是误用。认知偏误是全人类共有的，只是在焦虑时被过度使用。

不是只有认知、没有行为。 只做想法记录、不做行为实验和暴露，效果通常有限。行为改变往往比想法改变更有力。

家庭作业：剂量和卡点

CBT 的效果很大程度取决于会谈之外做了什么。作业不是“额外任务”，它是治疗的主体部分。

剂量：通常每周 1–2 个具体任务，比如“每天记录一次最强烈的担忧”“本周做两次行为实验”“每天十分钟注意转向练习”。任务要小到能完成，而不是大到让人拖延。

卡点一：忘了做。 把练习和已有习惯绑定（刷牙后、通勤时、睡前），比靠意志力可靠。

卡点二：追求完美。 记录写得潦草没关系，做了一半也比不做强。治疗师更关心“你观察到了什么”，不是“格式对不对”。

卡点三：做了但没效果。 先别下结论，把记录带给治疗师看。可能是任务设计得太难、太易，或者安全行为没去掉。

卡点四：不想做。 这本身值得讨论。有时是治疗关系的问题，有时是任务太可怕，有时是抑郁导致动力下降。说出来比默默放弃有用。

可照做的清单

- ☐ 这周选一个反复出现的担心，用想法记录表写一次，不要求写得好。
- ☐ 把担心写成一句可以被检验的话，包含“会发生什么”和“我怎么知道”。
- ☐ 给这个预测打一个 0–100 的信心分。
- ☐ 找一个成本低、可重复的小实验去测它，不要一上来就挑战最怕的。
- ☐ 实验后记录“预测—实际—差别”，而不是只记“我今天很紧张”。
- ☐ 每天做一次五分钟的外部注意练习。
- ☐ 把记录带到下一次会谈，和治疗师一起看，而不是自己评判对错。

什么时候需要联系医生或寻求额外帮助

- 行为实验或暴露后出现持续数小时以上的强烈焦虑、失眠、无法恢复：告诉治疗师，调整节奏，必要时复诊。
- 练习中反复出现解离、闪回、自伤冲动：暂停自行练习，找受过创伤治疗训练的专业人员评估。
- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划：不要独处，立即联系信任的人，拨打 120 或去急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- 做了一段时间后症状明显加重，或伴随体重下降、持续失眠、兴趣丧失：需要重新评估是否合并抑郁。

- 治疗师要求你做让你感到被羞辱、被强迫或涉及性边界的事情：停止治疗并反映，这不是治疗的一部分。

常见问题

我找不到“自动想法”，怎么办？从身体反应入手：心慌的那一刻，你脑子里闪过的第一句话是什么？如果还是找不到，可以先记录情境和情绪，等平静一点再回看。也可以先记录“我在担心什么”，不必强求逐字复现。

如果我的想法确实是真的呢？那就承认它是真的，然后问下一个问题：“即使是真的，我能做什么？”CBT 不要求你把真事想成假事，它帮你区分“已经发生的事实”和“对未来的预测”，并把精力放在可行动的部分。

写完想法记录，反而更焦虑了。有可能。把威胁写下来会短暂提高警觉，尤其是刚开始练习时。可以缩短记录时间、一次只写一件事、写完后做十分钟散步或注意转向练习。如果持续加重，和治疗师讨论。

行为实验失败了，是不是说明我的担心是对的？不一定。先看实验设计：是不是同时改变了好几个变量？是不是状态特别差？是不是用了安全行为？一次结果不足以定论，重要的是记录和学习。

CBT 要做多久？结构化的 CBT 通常 12–16 次，广泛性焦虑可能更长。【指南】有些人需要巩固期或阶段性复诊。频率和时长应随进展调整，不是固定套餐。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.3 暴露疗法：分级、重复与停止回避

暴露疗法是焦虑治疗里最有效、也最容易被误解的方法。有人以为它是“把人吓到不怕”，有人以为它是“硬扛”，还有人做了一次就放弃，说“没用，我还是怕”。这一页讲暴露到底在做什么、恐惧阶梯怎么搭、一次练习怎么设计、安全行为为什么要撤，以及什么情况下不能硬来。

暴露在做什么：重新学习，而不是习惯害怕

暴露疗法的核心，是让人在**安全但真实**的情境里，反复获得“我预想的灾难没有发生”或“即使发生了，我也能应对”的经验。

过去常用“习惯化”解释：反复接触恐惧刺激，焦虑会自然下降。这个解释只对了一半。更完整的解释是**抑制性学习**：旧的恐惧记忆不会被删除，但大脑会新建一条“这个情境其实是安全的”的记忆，并学会根据情境调用新记忆。【研究】这解释了很多现象：

- 为什么在治疗室不怕了，回家又怕——新学习没有在足够多的情境里建立。
- 为什么压力大时恐惧会回来——旧记忆还在，压力让它重新占上风。
- 为什么“待久一点”有用——时间足够长，身体才有机会发现“峰值会过去”。

所以暴露不是“把自己吓坏”，也不是“靠意志力忍住”，而是**有计划地收集反证据**。

恐惧阶梯：从 30 分开始，不从 90 分开始

做暴露之前，先把回避的场景列出来，给每个场景打一个焦虑分（0–100，叫主观不适单位，SUDs）。然后按分数从低到高排成阶梯。

以“不敢坐地铁”为例：

阶梯	场景	预期焦虑（0–100）
1	看地铁进站的视频，看五分钟	20
2	走到地铁站入口，站十分钟，不进去	30
3	刷卡进站，在站台等一辆车过去，不上车	40
4	有人陪同，坐一站	55
5	独自坐三站，非高峰时段	65
6	高峰期独自坐五站，不带水、不带药	75
7	独自坐完全程，中途换乘一次	85

搭阶梯有几个要点：

起点不要太高。 从 30–40 分的项目开始，成功率高，能建立信心。从 90 分开始，多半是一次挫败。

项目要具体。 “坐地铁”太笼统；“非高峰独自坐三站，不带水”才是可执行的。

要有变化。 同一个难度，换时间、换线路、换同行者、换座位，避免只在“最舒服的条件”下练习。

不要跳级。 阶梯不是必须严格按顺序，但跳太多会让失败率上升。

一次暴露怎么设计

一次规范的暴露练习，通常包含这些要素：

明确的目标：这次要检验什么？“我要在车厢里待满二十分钟，看焦虑会不会从 70 降到 40 以下。”

足够的时长：通常 20–45 分钟，具体看情境。关键是待够，让焦虑有机会自然下降，而不是在峰值时逃走。如果在峰值逃走，身体学到的可能是“只有逃走才安全”。

重复的频率：每周 2–3 次，持续数周。一次成功不等于学会，重复才有巩固。

去掉安全行为：不带上“保命”的水、药、护身符，不坐在门口，不一直看手机，不找人陪（除非阶梯本身要求）。

记录：练习前、中、后的焦虑分数，预期发生了什么，实际发生了什么。记录比“感觉好点”更能指导下一步。

复盘：练习结束后，和治疗师一起看：预测和实际差在哪？下次调整难度还是换情境？

停留时间与重复：为什么“待够”比“待久”重要

很多人问：“我要在里面待多久？”更准确的问题是：“我有没有待到大灾难没有发生这件事变得可信？”

焦虑通常在进入情境后的几分钟到十几分钟内达到峰值，然后开始下降。如果每次都在峰值时离开，身体学到的是“这个情境危险到必须逃”，而不是“这个情境其实会过去”。所以练习的关键不是“待很长时间”，而是**不要在最怕的那一刻逃走**。

但这不等于“必须待到完全平静”。有时候焦虑只降到一半，也算一次有效的学习，尤其是刚开始。判断标准可以是：焦虑比峰值下降至少一半，或者待满了预定时间且没有发生预想的灾难。

重复的节奏也很重要。集中几天做很多次，和每周两三次做几周，效果可能不同。多数人适合后者，因为需要时间消化，也需要在不同状态下重复（睡不好时、累的时候、心情差的时候），这样新学习才更稳。

安全行为：半暴露的陷阱

暴露最难的部分，往往不是“去”，而是“去了之后不做那些让自己安心的小动作”。

常见的隐蔽安全行为：

- 随身带水、带药、带糖，虽然从没用上；
- 必须坐在靠门的位置，必须知道出口在哪；
- 一直看手机、听音乐、找人聊天来分散注意；
- 提前踩点、反复确认路线；
- 只在有人陪的时候去；
- 喝酒或吃药之后才敢去；
- 练习时偷偷检查心跳、呼吸、手心有没有出汗。

这些行为会让焦虑立刻下降，但它们同时传递了一个信息：“这个情境本身不安全，是我做了准备才没事。”于是恐惧的预期没有被推翻，只是被绕过去了。

撤安全行为要一步一步来。一次只撤一个，从最容易的开始。比如先试着不带水，再试着不坐门口，再试着独自去。撤得太快，可能变成硬闯；一直不撤，就是半暴露。

放松与暴露的关系

放松训练对焦虑有帮助，但它不是暴露的前提，也不该成为暴露中的必需品。

原因很简单：如果你必须“先放松才能进电梯”，那放松就变成了安全行为。你学到的是“有放松技巧才安全”，而不是“电梯安全”。一旦哪天放松不了，恐惧就会回来。

更合理的安排是：

- 把放松当作日常调节工具，单独练习，不绑在暴露上。
- 暴露时允许自己紧张，不需要先把自己弄平静。
- 如果焦虑高到无法开始，可以先做几分钟呼吸，但目标是“能开始”，不是“必须平静”。
- 对惊恐障碍，呼吸和过度换气实验是**内感受暴露**的一部分，用来主动制造身体感觉并学习“这些感觉不危险”，这和“用呼吸压住焦虑”是两回事。

不要硬闯：什么时候该停、该退阶

暴露不是“越狠越有效”。以下几种情况需要谨慎，甚至先不做：

没有准备好的突袭式暴露。比如家人突然把你推进电梯、把你关在房间里“练胆”。这不是治疗，可能造成新的创伤，也会破坏信任。

严重的躯体疾病未稳定。心脏病、未控制的哮喘、癫痫、严重高血压、孕期，做会明显提高心率或呼吸的练习前，先和医生讨论。

严重抑郁、自杀风险、精神病性症状。这些情况需要先处理，暴露不是当前优先项。

创伤后应激障碍。创伤相关的暴露需要创伤聚焦的方案，由受过训练的治疗师进行，不能简单套用恐惧阶梯。

解离或强烈闪回。练习中出现“不真实感”“灵魂出窍”“回到过去”的体验，应暂停，做接地练习（把注意力带回当下），并告诉治疗师。

用暴露惩罚自己。如果练习的动机是“证明我不行”“我活该难受”，那方向已经错了。暴露的目标是学习，不是受苦。

退阶的信号：连续几次练习后焦虑不降反升、睡眠明显变差、开始回避练习本身、出现自伤念头。这时候不是“再加把劲”，而是停下来和治疗师重新设计。

暴露不是“把人吓坏”

这句话值得单独说，因为它是很多人的第一印象。

暴露的本质是**可预测、可控制、可退出**的。规范的暴露会提前告诉你做什么、做多久、可能出现什么感觉、什么时候可以停。它不搞突然袭击，不隐瞒目的，不拿恐惧取乐。

“把人吓坏”式的做法（也叫冲击疗法）在少数情况下会被使用，但它需要严格评估、知情同意和专业监护，不是常规首选，更不是家属可以自行操作的。

对患者来说，判断一次暴露是否规范，可以看：治疗师有没有提前说明？有没有和你商量难度？有没有给你退出的方式？有没有在练习后复盘？如果答案都是“没有”，那不是暴露疗法，是冒险。

开始暴露前的检查清单

- ☐ 我已经做过评估，知道自己的诊断和需要处理的目标。
- ☐ 我有一张写好的恐惧阶梯，每项都有具体的场景和分数。
- ☐ 我从 30–40 分的项目开始，而不是最怕的那一项。
- ☐ 我知道这次练习要待多久、什么时候可以停。
- ☐ 我列出了这次要撤掉的安全行为，只撤一个。
- ☐ 我准备了记录表：练习前、峰值、结束时的分数。
- ☐ 我告诉了一个信任的人我要做什么，但不是让他来“救”我。
- ☐ 如果我有心脏病、哮喘、癫痫或怀孕，我已经和医生讨论过。
- ☐ 我知道练习后可能会累、会反复，这不等于失败。

什么时候需要联系医生或寻求额外帮助

- 练习中出现胸痛、明显气短、晕厥、心悸持续不缓解：立即停止，拨打 120 或去急诊，先排除躯体急症。
- 有哮喘发作、癫痫发作、严重过敏：按既定急救方案处理并就医，不要继续练习。
- 练习后出现持续解离、闪回、严重失眠或自伤冲动：暂停练习，尽快联系治疗师或精神科医生。
- 暴露后焦虑连续数天不回落，或明显加重：需要复诊，调整方案，不要自行加码。

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做出计划：不要独处，立即联系信任的人，拨打 120 或去急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

常见问题

暴露会不会造成新的创伤？规范的、分级、可退出、有复盘的暴露，通常不会。造成伤害的往往是突袭式、无法退出、被强迫的“练胆”。如果你感到被强迫或羞辱，停止并反映。

做了一次没用，是不是不适合我？一次几乎不可能见效。暴露需要重复和变化，通常以周计。一次练习后的感受，更多反映当天的状态，不反映方法的有效性。

为什么我越练越怕？常见原因：起点太高、撤安全行为太快、每次都在峰值逃走、只在一个情境练、练习后没有复盘、或者同时有抑郁/创伤未处理。把记录带给治疗师，通常能找到原因。

能不能自己练？轻度的恐惧和回避，可以在了解原理后自己设计小步骤。但如果你有惊恐障碍、社交焦虑较重、创伤史、躯体疾病或自杀风险，建议在专业指导下进行。自助不等于独自硬扛。

暴露和“脱敏”是一回事吗？日常说法里常混用。严格说，脱敏是早期行为疗法的一种技术，暴露是更广的概念，包含习惯化和抑制性学习等机制。对患者来说，重要的是方法是否分级、重复、去掉安全行为，而不是名字。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.4 惊恐障碍的 CBT 与内感受暴露

这一页讲惊恐障碍的认知行为治疗（CBT），重点解释最让人困惑的一步——内感受暴露：为什么治疗师会让你故意心慌、头晕。适合反复惊恐发作、正在接受或准备接受心理治疗的人，也适合想帮忙但怕帮倒忙的家属。读完你会明白惊恐的恶性循环、内感受暴露到底在做什么，以及哪些情况必须先把躯体急症查清楚。

一、先把三件事分开：惊恐发作、惊恐障碍、躯体急症

惊恐发作是一阵突然出现的强烈恐惧，常在几分钟内达到高峰，伴随心悸、出汗、发抖、气短、胸闷、窒息感、头晕、手脚发麻、胃部不适，以及“我要死了”“我要失控”“我要疯了”的念头。它来势很凶，但本身通常不会造成心脏或大脑的器质性损伤。【指南】

惊恐障碍则是指：反复出现意想不到的惊恐发作，并且持续担心再次发作、担心发作的后果，或者因此明显改变生活，比如不敢出门、不敢独处、反复跑医院检查。判断的关键不是“发作有多吓人”，而是“你是不是开始围着它生活”。【指南】

第三件事最重要：**惊恐发作通常不致命，但不能因此忽略第一次、突发的胸痛、气短和晕厥。** 首次出现压榨性胸痛、胸闷伴大汗、呼吸困难、晕厥或接近晕厥、口唇发紫、心跳极快且不规律，尤其是有高血压、糖尿病、吸烟、家族早发心脏病史的人，应先到急诊或心内科排除急性冠脉综合征、肺栓塞、严重心律失常等。【指南】 如果已经反复检查、医生明确排除了心脏问题，你仍然每次发作都怀疑“这次不一样”，这本身就是惊恐障碍的典型表现，需要治疗，而不是被责备“想太多”。

下面这张表只适用于“已经被医生评估过、仍然反复出现类似感觉”的情形，不能拿来自我诊断，更不能代替首次就诊。

身体感觉	常见的灾难化解释	更可能的解释	可以怎么核对
心跳很快、心悸	心脏病发作了	焦虑、咖啡因、运动后、发热都可能让心跳加快	医生已排除心律失常后，记录发作前喝了什么、做了什么
呼吸急促、胸闷	马上要窒息了	过度换气会让胸口发紧、头晕，这是呼吸方式造成的	放慢呼气，观察几分钟内是否缓解
头晕、手脚发麻	要晕倒、要中风了	快速呼吸会降低血中二氧化碳，引起头晕和发麻	回忆发作时是不是呼吸又浅又快
喉咙堵、吞咽困难	喉咙肿了、要憋死	焦虑时喉部肌肉紧张，吞咽动作会变得不自然	小口喝水，看是否只是紧张时明显
失控感、恍惚	我要疯了	恐惧本身会带来不真实感，并不等于精神失常	发作结束后能否正常对话、认人、记事

二、惊恐的恶性循环：灾难化解释如何把不适变成发作

惊恐障碍的认知模型认为，真正把一次普通身体波动推成惊恐发作的，是中间那层“解释”。心跳快本来可以只是爬楼、咖啡或紧张；一旦大脑把它解释成“心脏要出事”，恐惧立刻升高，心跳更快、呼吸更急，新的感觉又反过来证明“果然出事了”。这个圈越转越快，人就以为自己是“突然发作、毫无预兆”。【研究】

这个模型有几个关键点，理解了才知道治疗为什么这样设计。

第一，感觉本身不是敌人，对感觉的解释才是。治疗不是让你“感觉不到心慌”，而是让你在心慌的时候不再自动跳到“我要死了”。

第二，回避和安全行为会让循环更牢固。因为每次躲开，大脑都学到“幸亏我躲了，不然就出事了”，而不是“原来不躲也没事”。

第三，注意会越缩越窄。惊恐障碍的人往往对身体信号高度警觉，能在嘈杂环境里准确捕捉到自己的心跳，却忽略了“刚才只是走快了两步”。

CBT 的第一阶段通常是心理教育：把上面这个圈画给患者看，让他知道发作有过程、有高峰、会过去，而不是“随机袭来的灾难”。很多人光是理解这一点，发作时的恐惧就下降了一截。【临床经验】

三、内感受暴露：故意制造感觉，学会“它不会把我怎么样”

内感受指的是对身体内部信号的感知，比如心跳、呼吸、胃蠕动、头晕、发麻。内感受暴露，就是有计划、可重复地诱发这些感觉，在安全的环境里停留，直到大脑学会“这些感觉不等于灾难”。【研究】

它的原理不神秘：恐惧是靠回避维持的。你越怕头晕，就越不敢去会头晕的地方；越不敢去，大脑越确信头晕危险。只有反复体验“感觉来了—我没死—感觉退了”，威胁预期才会一点点下降。这个过程叫习惯化，也叫 inhibitory learning，翻成大白话就是“学到一个新的、更安全的联想”。【研究】

常见的练习包括：原地快走或上下楼梯让心跳加快；快速呼吸让头晕和发麻出现；屏气几十秒；用细吸管呼吸制造“吸不上气”的感觉；绷紧全身肌肉再放松；原地转圈；看快速移动的画面。不是每个人都适合全部练习，治疗师会根据你的症状挑最相关的那几项。

内感受暴露有几个容易做错的地方。

- 不是“越难受越成功”。目标是可承受、可重复、能核对，不是把自己吓到崩溃。
- 不是“硬扛到感觉消失”。一般是在感觉出现后停留一段时间，让身体自己回落，而不是靠看手机、找人说话把它赶走。
- 不是“做一次就够”。同一项练习通常要重复多次，还要换场景、换时间，才能把学到的东西带到生活里。

- 不是“瞒着医生做”。有心脏病、未控制的高血压、心律失常、癫痫、哮喘、妊娠、严重贫血、低血糖或近期手术的人，要先让医生评估。【指南】

一次内感受暴露可以这样安排

1. 和治疗师一起选一个你平时最怕、又和你的发作最像的感觉，比如心跳快或头晕。
2. 练习前写下预测：“如果我心跳到这么快，我会……”并给相信程度打分（0 到 100）。
3. 在治疗师在场、环境安全、随时能停的条件下开始，不一个人偷偷试。
4. 感觉出现后停留，观察它会不会一路升级到灾难，还是会在几分钟内回落。
5. 练习中尽量不做安全行为：不摸脉搏、不坐下、不找人说话、不偷偷放慢动作。
6. 结束后核对：实际发生了什么？预测命中了多少？相信程度从多少降到多少？
7. 记录这次学到的一句话，比如“心跳快本身不会让我晕过去”。
8. 隔几天重复，并逐渐把练习移到家里、户外、地铁等不同场景。

四、呼吸、过度换气实验与“发作时不要对抗”

过度换气是指呼吸又快又深，排出过多二氧化碳，血液偏碱，脑血管收缩，于是出现头晕、手脚发麻、胸口发紧、视线模糊，甚至手脚抽搐。这些症状和惊恐发作高度重叠，所以很多人第一次发作时以为自己“缺氧”，于是更用力地大口吸气，结果越吸越晕。【研究】

治疗中的过度换气实验，是在治疗师指导下快速呼吸一小段时间，主动复制这些感觉，然后停下来，让患者亲眼看到“症状是我自己呼吸出来的，不是器官坏了”。这个实验有体验和教育的作用，但不建议在家里自行尝试，尤其是心脏病、癫痫、哮喘、妊娠或血压控制不好的人。【指南】

由此引出两条很实用的结论。

第一，惊恐发作时不要拼命大口深呼吸。过度深呼吸可能加重头晕、发麻和窒息感，让人更慌。更稳的做法是：把呼气放慢一点，不憋气，不追求“吸满”，把注意力放到脚底、手边的物体、房间里的颜色和声音上，允许这阵浪过去。

第二，呼吸训练在惊恐障碍的 CBT 里是辅助工具，不是核心。它能帮你降低日常紧张，但单独靠“深呼吸”通常不足以治好惊恐障碍。【指南】 真正起作用的是改变灾难化解释、做暴露、撤掉安全行为。

“不要对抗”还有一层意思：发作时越命令自己“不能慌、快停下”，越容易把注意力锁在身体上，形成二次恐慌。可以换成这样的内心台词：“这是惊恐，不是心脏病；它会在几分钟内到顶，然后下来；我现在不需要做任何危险的事。”这句话不是咒语，而是把解释从灾难换成事实。

五、减少回避与安全行为，以及怎么和药物配合

安全行为是那些“为了防出事”而做的小动作：出门必须带水、带药、带手机；必须有人陪；一有心跳就摸脉搏；开会一定坐靠门的位置；发作时掐自己、扇风、猛喝水。它们在当下确实能降低焦虑，但长期会让大脑更相信“没有它我就会出事”，于是恐惧的地图越画越大。【研究】

回避则更直接：不去超市、不坐地铁、不独自在家、不运动、不喝咖啡。每回避一次，短期舒服，长期把生活切掉一块。

处理办法不是“一次全撤”，而是列清单、排等级、做行为实验。先挑一个难度适中、你愿意试的场景，撤掉一个安全行为，看看预测会不会发生。比如“不带水出门十分钟”“不摸脉搏走完一段路”“独自在咖啡馆坐十五分钟”。做完记录结果，再决定下一步。

安全行为	它想防的结果	长期代价	可以先试的替代
反复摸脉搏、测心率	及时发现心脏异常	越测越关注心跳，焦虑越高	规定每天只在固定时间测一次，其余时间记录冲动
出门必须有人陪	出事没人帮忙	独立性下降，家人也被拖住	先短时间、近距离独处，逐步拉长
随身带“救命药”	发作时失控	把安全感寄托在物件上	在医生指导下按需使用，而不是靠它壮胆
只去有出口、好逃的地方	被困住	活动范围越来越小	先在有出口的地方多停留十分钟
发作时坐下、扇风、猛喝水	防止晕倒	症状被强化，发作更频繁	原地站稳、放慢呼气，观察几分钟

和药物的关系，不是“二选一”。SSRI 类药物和 CBT 都是惊恐障碍的一线治疗。【指南】 对中重度、发作频繁或合并抑郁的人，联合治疗可能比单用一种更好。【研究】 苯二氮䓬类起效快，但只适合短期、按需、在医生指导下使用，需要讲清依赖、耐受、戒断、跌倒和认知方面的风险；这类药可能让暴露练习“学不进去”，也可能掩盖症状，所以不建议自行长期服用或自行加量。【指南】

治疗顺序因人而异。有人惊恐太频繁、连门都出不了，先用药稳定一点再开始暴露；也有人愿意先做 CBT。药物通常需要几周才起效，CBT 也需要反复练习，两者都不是“做一次就见效”。任何减量、停药都要和医生商量，不要自行决定。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊

- 首次突发的剧烈胸痛、压榨感，或胸痛放射到左臂、下颌、背部。
- 明显气短、喘不上气、口唇发紫、大汗淋漓。
- 晕厥、快要晕倒、意识模糊、抽搐。
- 心跳极快且明显不规律，伴胸闷或黑矇。
- 出现自杀念头、自伤行为，或连续几天几乎不能睡、不能吃。

尽快联系医生

- 发作频率明显增加，或开始不敢独自出门、不敢上班上学。
- 准备做内感受暴露，但有心脏病、心律失常、未控制的高血压、癫痫、哮喘、妊娠、严重贫血或低血糖。
- 服药后出现明显副作用，或想调整药物。
- 合并抑郁、酒精或镇静药使用，需要重新评估方案。

常见问题与容易踩的坑

“内感受暴露是不是故意吓自己？” 不是。它是有预测、有核对、有重复的学习，目的是让身体感觉和“灾难”脱钩。吓自己是没有计划、没有复盘、做完更确信危险。

“发作时必须深呼吸才安全？” 不一定。过度深呼吸可能加重头晕和发麻。放慢呼气、不憋气、站稳、把注意力放到环境上，往往更稳。

“CBT 就是劝自己往好处想？” 不是。CBT 要求你写出具体的预测，再用实验去检验它，而不是用一句“没事的”压过去。

“做了两三次没效果，是不是没用？” 内感受暴露和现实暴露都需要重复和分级，通常以周为单位看变化。如果四周仍无改善，和治疗师讨论是不是方案不适合，或有没有共病没处理。

家属可以做什么？ 可以陪着去医院、帮忙记录发作、在练习时待在旁边但不替对方做决定。不要说“别想了”“这有什么好怕的”，也不要强迫对方立刻去最怕的地方。稳定、不过度保护、按计划推进，比讲道理有用。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NIMH. Anxiety Disorders：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.5 社交焦虑的 CBT 与注意力训练

这一页讲社交焦虑障碍的认知行为治疗（CBT），包括自我关注、负面评价恐惧、行为实验、视频反馈和社交暴露。适合在聚会、发言、面试、吃饭、见陌生人时紧张到回避的人，也适合想理解“为什么越准备越紧张”的家属。读完你会知道社交焦虑和内向的区别、CBT 具体练什么，以及为什么治疗师通常不会一上来就让你“当众表演”。

一、社交焦虑不是内向，也不是“胆小”

内向是一种偏好：独处能恢复精力，社交多了会累，但并不害怕被看、被评价，也不因社交而明显痛苦或回避。社交焦虑障碍的核心是**对负面评价的强烈恐惧**：怕自己说错话、脸红、手抖、出汗、冷场，怕别人觉得自己奇怪、无能、可笑，于是回避社交，或者在社交中极度紧张、提前担心、事后反复回想。【指南】

判断是否构成障碍，看三点：害怕是否与实际威胁不相称；是否持续相当一段时间；是否明显影响生活，比如不敢上课发言、不敢面试、不敢约会、不敢在同事面前吃饭。偶尔紧张不是病，影响到选择才值得处理。

社交焦虑常被误认为“性格问题”，于是患者被劝“多练练就好了”“你就是太在意别人”。这类话通常没用，因为它没有处理“被评价”的核心恐惧，还可能让人更自责。社交焦虑有明确的心理和药物治疗方法，是可以改善的。【指南】

还要区分几种情况。表演焦虑只出现在需要“表演”的场合，比如演讲、演奏、比赛，平时社交不受影响；广泛性社交焦虑则在多数社交场景都紧张。回避型人格障碍、孤独症谱系、抑郁、惊恐发作也可能表现为回避社交，治疗重点不同，需要专业评估。把“社恐”当网络梗说说无妨，但真影响到生活时，值得认真看一次医生。

二、自我关注与负面评价恐惧：聚光灯其实没那么亮

社交焦虑的人进房间时，常有一种“所有人都在看我”的感觉，心理学叫聚光灯效应。真实情况通常是：别人也在担心自己，注意你的时间远没有你以为的多。【研究】

更关键的是，注意力去了哪里。普通人社交时，注意力在对方的表情、话题、环境；社交焦虑的人则把注意力转回自己身上：我脸是不是红了、声音抖不抖、刚才那句话是不是很蠢、手该放哪里。这种自我关注会占满工作记忆，让人听不清对方说什么、接不上话，于是真的出现“冷场”，又反过来证明“我不会社交”。【研究】

同时，脑子里会有一幅“负面自我形象”：觉得自己看起来紧张、可笑、明显不正常。这幅形象往往和真实样子差得很远，但当事人把它当事实。治疗里常用视频反馈来打破这一点。

还有两个隐形的维持因素。

一是**预期性焦虑**：活动前几天就开始想“到时候会出丑”，越想越怕，最后干脆不去。

二是**事后反刍**：活动结束后反复回放，专挑自己觉得不好的细节，把别人的中性反应解读成“他肯定觉得我很怪”。这种反刍会让下一次更紧张。【研究】

CBT 的目标不是把你变成外向的人，而是让你在需要社交时，能把注意力放在外面，能承受“可能被评价”的不确定，不必靠回避和安全行为过日子。

三、安全行为与行为实验：越想不出丑，越像“出丑”

安全行为是社交时用来“防止出丑”的小动作：一直看手机、躲在角落、提前背好每句话、说话时盯着地板、用手遮脸、喝酒壮胆、穿高领遮住脖子、反复去洗手间检查镜子。它们能短暂降低焦虑，但代价很大：注意力更向内、表现更不自然、别人更难接近你，于是“我果然不行”的信念被加固。【研究】

安全行为	它想防的结果	长期代价	可以试的替代
全程看手机	避免和人对视、被搭话	显得冷淡，错过连接	抬头看对方几秒，再自然移开
提前背逐字稿	怕说错、冷场	一被打断就慌，听起来僵硬	只准备三个要点，允许即兴
用手遮脸、低头	怕脸红、手抖被看见	姿态更紧张，别人更难回应	手放桌上，允许轻微发抖
喝酒才敢社交	怕紧张被看出来	依赖、次日更焦虑、说错更多	先在小场合不喝，观察结果
反复照镜子、整理头发	怕形象出问题	注意力全在自己身上	出门前整理一次，之后不补

行为实验是 CBT 的核心工具：把“如果我……就会……”写成一个可以检验的预测，然后主动做一次，看看结果。比如“如果我在会上发言时声音发抖，同事就会觉得我很无能”，实验可以是“发言时故意不压着声音，结束后问两个同事对内容怎么看”。重点不是证明“没人注意你”，而是收集真实数据，让预测松动。

行为实验设计清单

1. 写下具体预测：“如果我做 X，就会发生 Y。”
2. 给相信程度打分（0 到 100）。
3. 设计一个安全、可退出、不违法的小实验，最好只改变一个变量。
4. 提前想好：如果结果真的不好，我能承受吗？有没有人可求助？
5. 做完记录实际发生了什么，包括别人的原话和反应。
6. 对比预测和结果，重新给相信程度打分。
7. 换场景重复，而不是做一次就下结论。
8. 和治疗师复盘，决定下一步加难度还是先稳住。

视频反馈是行为实验的一种。治疗师会让你录一段几分钟的日常对话或发言，然后一起看。第一遍你可能会盯着自己最不自然的地方，觉得“果然很糟”；治疗师会引导你像看别人一样看整体：对方有没有明显不适？你的紧张别人能不能看出来？大多数人事后会发现，自己看起来比想象中自然得多，或者至少没有“那么明显”。【研究】 视频反馈不适合所有人，尤其是对外貌或自我形象极度敏感、曾有创伤的人，需要治疗师评估和保护。

四、注意力训练与社交暴露：把注意力放到外面

注意力训练不是教你“分散注意力逃避”，而是练习**灵活地控制注意力**。常见做法包括：在嘈杂环境里专注听一种声音，再切换到另一种；观察房间里不同颜色的物体；与人对话时刻意把注意力放在对方脸上、语气和内容上，发现自己飘回自我评判时，再拉回来。目标是让你在社交中“有余力听别人说话”，而不是全程监控自己。【研究】

注意力训练通常作为 CBT 的一部分，配合暴露使用。单独做几次放松或注意力练习，一般不足以改变社交焦虑。

社交暴露则是按难度分级，反复进入那些你平时回避的场合，并且停留足够久，直到焦虑下降、预测被修正。暴露的关键是**可预期、可重复、可退出**，不是突然袭击。

难度	例子	练习重点
低	向店员问路、在便利店问价格、和邻居打招呼	抬头、对视两秒、听清回答
中	在小组里发言一次、打电话咨询、在餐厅要求换座位	允许声音抖，不道歉、不解释
较高	在会议上提一个问题、参加聚会并主动介绍自己	把注意力放在对方反应，而不是自我监控
高	做一次短演讲、面试、约会	提前准备要点，不背逐字稿，结束后不反刍

不要强迫“当众表演”。 暴露不是把最怕的事直接扔给你，也不是让你在没准备好的情况下被围观。强迫上台、突然点名、以“练胆”为名的羞辱式练习，可能造成创伤，让恐惧更深。合格的暴露是治疗师和你一起设计、你知情同意、可以随时停下来讨论的。如果治疗师让你做你明确拒绝的事，或者用“你不做就是逃避”施压，你有权说不，也可以换人。

暴露后容易出现“事后反刍”：反复回想自己哪句话说错了。可以给自己设一个短时间的“复盘窗口”，只记录事实和学到的点，然后主动把注意力转到别的事，而不是整晚回放。

五、药物、共病与什么时候需要就医

社交焦虑障碍的一线治疗包括 CBT 和 SSRI 类药物。【指南】 对广泛性社交焦虑，药物起效通常需要几周，不能按需吃一片就指望立刻不紧张。β 受体阻滞剂有时用于表演焦虑，但不等于能治疗广泛

性社交焦虑，心跳过慢、哮喘、低血压的人要特别小心，必须由医生评估。【指南】 苯二氮䓬类只适合短期、按需、医生指导，有依赖和戒断风险，也可能让人在社交中更迟钝，不建议自行使用。

CBT 可以个体做，也可以团体做。团体 CBT 的优势是能在真实的小组里练习，还能看到别人也紧张，减少羞耻感；缺点是刚开始可能压力较大。NICE 指南认可团体 CBT 用于社交焦虑。【指南】

社交焦虑常和抑郁、酒精使用、惊恐障碍同时出现。有人靠喝酒应付聚会，短期有效，长期会让焦虑和睡眠更糟，还可能发展为酒精依赖。如果出现持续情绪低落、兴趣丧失、自杀念头，需要优先处理。青少年被霸凌、职场排挤、外貌羞辱等现实问题，也不是单靠暴露能解决的，需要家庭、学校或法律层面的支持。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了伤害自己的事。
- 惊恐发作伴首次剧烈胸痛、气短、晕厥。
- 喝酒或吃药后意识模糊、呕吐不止、呼吸变慢。

尽快联系医生

- 因为害怕社交已经不上学、不上班、不出门。
- 靠喝酒或镇静药才能社交，或用量越来越大。
- 合并明显抑郁、进食问题、创伤经历。
- 治疗数月无明显改善，或出现新的躯体症状。
- 未成年人被霸凌、被排挤，需要学校和家庭一起介入。

常见问题与容易踩的坑

“社恐是不是多社交就自然好了？” 不一定。没有计划的硬撑可能加重失败体验。有效的暴露需要分级、重复和复盘。

“治疗师让我当众演讲，我不敢，是不是没救？” 不是。你可以拒绝，也可以要求从更小的步骤开始。暴露不是服从测试。

“我是不是太在意别人看法了？” 在意评价是人的共性，问题在于它是否大到让你回避生活。CBT 不要求你“完全不在乎”，而是让你能在乎的同时仍然行动。

“视频里的我真的很奇怪，怎么办？” 先别急着下结论。人对自己的录像会过度关注细节，治疗师会帮你区分“我不习惯”与“别人真的觉得奇怪”。

家属可以做什么？ 不要替对方回绝邀请，也不要在聚会上反复问“你紧张吗”。可以说“你想去就去，不想去也没关系，我陪你到门口”。减少保护，也减少施压。

参考来源

- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013：https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NIMH. Anxiety Disorders：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.6 GAD 的 CBT、正念与担忧管理

这一页讲广泛性焦虑障碍（GAD）的心理治疗：CBT 怎么处理“停不下来的担忧”，正念到底在练什么，以及为什么“清空大脑”是个误会。适合长期担心、肌肉紧、睡不好、总觉得要出事的人，也适合被家人说“你想太多”的人。读完你能分清担忧的正负信念、学会“担忧时间”的操作，也知道正念、放松和药物各自的位置。

一、GAD 不是“想太多”：担忧、紧张与功能损害

广泛性焦虑障碍的核心，是**过度、难以控制、持续时间长的担忧**。担心的内容往往很日常：工作出错、家人生病、钱不够、孩子出事、身体有小毛病就想到癌症。担心的对象可以换来换去，但“总有一件事要担心”的感觉一直在。【指南】

除了担忧，还常有三类表现。身体上：肌肉紧绷、肩颈痛、头痛、胃部不适、心慌、出汗、手抖、容易疲劳。认知上：注意力难集中、脑子空白、容易烦。睡眠上：入睡难、睡不实、早醒。儿童青少年可能更多表现为腹痛、头痛、黏人、拒绝上学。

判断是不是 GAD，要看病程和功能损害：担忧是否持续较长时间、是否几乎每天都出现、是否难以控制、是否影响到工作学习或人际关系。偶尔担心不是病；如果担忧已经变成背景噪音，让你没法专心、没法放松、没法做决定，就值得评估。【指南】

GAD 常被误解成“性格敏感”“想开点就好”。这种说法的问题是，它把“担忧”当成可以靠意志关掉的开关。实际上，GAD 的担忧有一套自己的维持机制，需要专门的方法去拆。

二、担忧的正负信念与不确定性不耐受：为什么明知没用还停不下来

GAD 的人常同时持有两套信念，它们互相打架，却一起把担忧留住。

正向信念是“担忧有用”：担忧能让我提前准备、能防止坏事发生、能证明我负责、如果我不管就会出大事。有人甚至相信“我担心得够多，坏事就不会发生”，这是一种魔法思维，但情绪上很真实。

负向信念是“担忧有害/失控”：我停不下来、我会把自己逼疯、担忧会让我得病、我永远好不了。负向信念带来恐惧，于是人开始压制担忧；越压制，担忧越反弹，最后得出“果然控制不了”的结论。【研究】

担忧类型	例子	短期作用	长期代价
正向信念	“我先想一遍，明天就不会出错”	短暂安心、感觉在准备	准备无止境，永远不够
正向信念	“我担心说明我在乎家人”	感觉自己尽责	用焦虑代替陪伴，家人也累
负向信念	“我停不下来，是不是要疯了”	提醒自己别想	越想压越反弹，更失控
负向信念	“担忧会把我身体搞垮”	促使自己关注健康	反复检查，健康焦虑加重

与担忧紧密相关的另一个因素是**不确定性不耐受**。它不是“喜欢有计划”，而是“没有百分之百确定就难受”。于是人会做很多求确定的事：反复检查、反复问家人“没事吧”、把方案改到最后一刻、拖延到信息齐全才敢决定、不敢让别人开车、不敢让孩子独自出门。这些行为短期降低不确定感，长期让大脑更害怕不确定。【研究】

CBT 会同时处理三层：检验“担忧有用”的证据；挑战“担忧会失控”的信念；以及做**不确定性暴露**——在不完全确定的情况下行动，并减少求保证。比如发一封没有反复检查的邮件、让家人独立出门一次、在信息不完整时做一个可修改的决定。重点不是“什么都不管”，而是学会和“差不多确定”共处。

三、担忧时间与刺激控制：把担忧放进一个笼子

“别想了”之所以没用，是因为它要求大脑立刻停止一个正在运行的过程。更可行的办法是给担忧安排一个固定的时间和地点，让它有地方去，而不是全天候占线。这就是**担忧时间**（worry time），属于刺激控制的一种。【研究】

具体做法是：每天固定一段 15 到 30 分钟的时间，地点固定，坐下，专门想那些担心的事；其他时间出现担忧，就记下来，告诉自己“留到担忧时间再想”，然后回到手头的事。到了担忧时间，把记录逐条过一遍，能行动的写下下一步，不能行动的标注“目前无法解决”，时间一到就结束。

这套方法听起来简单，做起来有几个坑。

第一，担忧时间不是“反刍时间”。不是把同一件事翻来覆去想十遍，而是区分“可行动的问题”和“无解的假设”。可行动的写计划，无解的练习放下。

第二，不要在床上做。床只用来睡觉，否则会把“担忧”和“床”绑在一起，加重失眠。

第三，刚开始会反弹。大脑习惯了随时担忧，突然被推迟会不适应。坚持一两周通常才会看到变化。

第四，不要用担忧时间替代治疗。它是管理工具，不是根治手段。

担忧时间操作清单

1. 选一个每天都能保证的时段，最好是傍晚，不要临睡前。
2. 固定地点：书桌、餐桌，不要沙发躺椅，更不要床上。
3. 准备一张纸，分成“能行动”和“暂时无解”两栏。
4. 白天出现担忧时，用一句话记下关键词，不展开。
5. 到点坐下，逐条读，能行动的写一个具体下一步。
6. 无解的条目写“今天不再处理”，并做一次呼气放松。
7. 时间一到就起身，做一件具体的事，比如洗碗、散步。

8. 一周回顾一次：担忧的事有多少真的发生了？有多少是重复的？

如果担忧时间让你更焦虑，比如一到点就停不下来、越写越多，可以和治疗师讨论缩短时间、换形式，或者先处理“担忧有害”的信念，而不是硬撑。

四、正念与放松：去中心化，不是清空大脑

正念常被误解成“什么都不想”“清空大脑”。真正的正念是**有意识地注意当下，并且不加评判**。念头来了，知道“我在想”，然后温和地把注意力带回呼吸、身体或手头的事。它不是让念头消失，而是让你和念头之间拉开一点距离。【研究】

这个距离在心理学里叫**去中心化**：把“我肯定会失业”看成“我脑子里出现了一个‘我会失业’的念头”，而不是“事实就是如此”。这一步对 GAD 很重要，因为 GAD 的人常把担忧当成预言，越想越真。去中心化不是自欺，而是承认“想法只是想法，是否成真需要证据”。

正念练习通常包括：坐姿观察呼吸；身体扫描；正念行走；三分钟呼吸空间；把日常动作（刷牙、洗碗、走路）当作练习。关键不是“坐多久”，而是频率和态度。每天几分钟，比一周一次半小时更容易坚持。

需要说清楚的是，正念不是放松的同义词。有人练完更放松，有人练完发现脑子更吵，这都正常。正念也不是“必须盘腿、必须安静、必须信某种哲学”。它可以是世俗的、简短的、融入生活的。对曾经有创伤体验的人，闭眼静坐可能引发不适，可以睁眼、缩短时间，或改做行走练习，必要时在有经验的治疗师指导下进行。

放松训练是另一条线。**渐进性肌肉放松**是依次绷紧再放松各组肌肉，体会紧张和放松的差别；**应用放松**则是把放松练成一项能随时随地调用的技能，先学会放松，再在引发焦虑的情境里使用。对 GAD，应用放松有研究支持，NICE 指南把 CBT 和应用放松都列为可选的心理治疗。【指南】

方法	做什么	目标	常见误解
担忧时间	每天固定时段集中处理担忧	把担忧从全天候变成有时段	以为要一次想清楚所有事
不确定性暴露	在不确定中做小决定、减少求保证	提高对不确定的耐受	以为是要“什么都不管”
正念	注意当下，发现走神再带回	去中心化、降低反刍	以为要清空大脑
渐进性肌肉放松	绷紧再放松肌群	识别并降低身体紧张	以为越用力越好
应用放松	在焦虑情境中调用放松	把放松变成技能	以为能替代暴露和认知工作

正念和放松都不能保证“立刻不焦虑”。它们的作用是改变你和焦虑的关系，给你多一个选择，而不是把焦虑开关关掉。如果练完反而更关注身体、更害怕心慌，先停下来，和治疗师讨论，不要勉强。

五、药物、共病与什么时候需要就医

GAD 的一线治疗包括心理治疗和药物。CBT 和应用放松有明确证据；SSRI（如舍曲林）和 SNRI（如文拉法辛、度洛西汀）是一线药物，起效通常需要几周，不能按需吃一片就指望马上平静。【指南】 丁螺环酮、坦度螺酮、普瑞巴林等在不同指南中的位置不完全一样，需要医生根据共病和耐受性选择。苯二氮䓬类只适合短期、按需、医生指导，长期使用有依赖、耐受、戒断、跌倒和认知方面的风险，不建议自行长期服用。【指南】

药物和心理治疗不是二选一。中重度 GAD、合并抑郁、或心理治疗暂时不可及时，药物可以帮助先把焦虑降下来，让人有力气做心理练习；心理治疗则帮助掌握长期可用的方法。具体顺序和组合，需要面诊医生根据病程、共病、既往反应和偏好决定。

GAD 常合并抑郁、失眠、惊恐障碍、社交焦虑、物质使用和躯体疾病。失眠不处理，焦虑很难好转；抑郁不识别，自杀风险会被漏掉；长期喝酒或依赖镇静药，会让焦虑更顽固。评估时要一并考虑，而不是只盯着“担忧”一个症状。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了伤害自己的事。
- 首次突发剧烈胸痛、气短、晕厥，或症状与以往明显不同。
- 意识模糊、抽搐、高热、严重过敏。
- 酒精或镇静药戒断出现手抖加重、幻觉、抽搐。

尽快联系医生

- 担忧已经让你无法工作、上学或出门。
- 连续多日几乎不能睡，或失眠伴明显情绪低落。
- 反复检查身体、反复求保证，已经影响家庭关系。
- 服药后出现明显副作用，或想调整、停用药物。
- 合并抑郁、双相、创伤、强迫或物质使用，需要重新评估方案。

常见问题与容易踩的坑

“正念是不是要清空大脑？” 不是。清空大脑做不到，也不是目标。目标是发现走神，再带回来。

“担忧时间是不是自欺欺人？” 不是。它不否认问题存在，而是把担忧从“随时入侵”改成“集中处理”，让你夺回注意力。

“我知道担心没用，为什么还停不下来？” 因为担忧不只是认知，还是习惯和情绪调节方式。知道不等于会做，需要练习和重复。

“放松训练能替代吃药吗？” 不能一概而论。轻度焦虑可能靠心理治疗和生活方式改善；中重度通常需要综合治疗。不要自行停药。

家属可以做什么？ 减少反复保证（“没事的，放心”说一百遍也没用），可以改成“我们一起看看能做什么”。不要替对方做所有决定，也不要用“你就是想太多”堵住对话。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NIMH. Anxiety Disorders：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.7 ACT、元认知治疗、心理动力与团体家庭治疗

这一页把 CBT 之外几种常被问到的心理治疗放在一起比较：接纳承诺治疗（ACT）、元认知治疗、心理动力治疗，以及团体和家庭治疗。适合已经了解 CBT、想知道还有没有别的选择的人，也适合正在挑治疗师、却不知道看什么资质的家属。读完你能说出每种疗法的核心和证据强弱，知道怎么选、怎么判断治疗有没有在起效。

一、为什么需要了解 CBT 之外的疗法

CBT 是焦虑障碍研究最多、指南推荐最多的心理治疗，但“首选”不等于“唯一”。有人做 CBT 效果有限，有人更愿意从价值、关系或成长经历入手，有人所在城市找不到 CBT 治疗师，还有人需要团体的支持。了解其他疗法，不是为了否定 CBT，而是为了在需要时有备选。【指南】

选择疗法时，有几个现实因素比“哪个理论更高级”更重要：你的问题类型、共病、既往治疗反应、当地资源、费用、时间，以及你和治疗师能不能建立信任。心理治疗不是买课程，效果很大程度上取决于“方法是否匹配”和“关系是否安全”。【临床经验】

需要先说明一条底线：无论哪种心理治疗，都不能替代必要的医学评估和处方。心理治疗师一般不做诊断、不开药；精神科医生可以评估是否需要药物。若有人承诺“不用吃药、几次根治”，无论包装成什么疗法，都要警惕。

二、ACT：接纳、认知解离与价值行动

接纳承诺治疗（ACT，Acceptance and Commitment Therapy）属于“第三波”认知行为治疗。它不主张把焦虑念头消灭，而是练习两件事：一是**接纳**——允许不舒服的感觉存在，不再花全部力气推开它；二是**认知解离**——把想法看成想法，而不是事实；在此基础上，按**个人价值**方向行动。【研究】

几个核心概念可以用大白话理解。

- **认知解离**：把“我一定会失败”改写成“我注意到，我脑子里出现了‘我一定会失败’这个想法”。不是自欺，而是拉开距离。
- **接纳**：不是喜欢焦虑，而是停止和它摔跤。越不允许自己紧张，紧张往往越顽固。
- **价值**：问“如果焦虑不是问题，我想把时间花在什么上”，比如陪伴家人、学习、工作、助人。
- **承诺行动**：把价值拆成今天能做的一小步，带着焦虑也去做。

ACT 对焦虑障碍的研究逐渐增多，随机对照试验显示对 GAD、社交焦虑、惊恐障碍有一定效果，部分研究显示与 CBT 相当。【研究】 但多数指南仍把 CBT 列为首选，ACT 更多作为替代或补充，而不是所有指南的一线推荐。【指南】 对“越想控制越失控”、厌倦了反复分析想法的人，ACT 可能更合适；对希望系统检验具体灾难化预测的人，CBT 的暴露和认知重构可能更直接。

ACT 的常见误解是“接纳就是认命”。不是。接纳的是内部体验（紧张、心跳、担忧），不是放弃外部行动。你仍然可以换工作、看病、设边界，只是不再要求“必须先不焦虑才能行动”。

三、元认知治疗：把“担忧本身”当靶子

元认知治疗（MCT）由 Wells 提出，关注的不是“你在担心什么”，而是“你怎么看待担忧这件事”。它认为 GAD 的核心是**元认知信念**：比如“担忧能保护我”“担忧停不下来”“担忧会让我发疯”。这些信念让人不断进入担忧，又不断试图压制，形成“担忧—压制—更担忧”的循环。【研究】

MCT 的典型技术包括：

- **分离正念**：不分析念头的内容，只是观察它来去，不评价、不追随。
- **注意训练**：练习把注意力灵活地切换到声音、视觉、身体等不同对象，减少“自我关注”占满带宽。
- **挑战元认知信念**：通过行为实验检验“如果我停止担忧，就会出事”“如果不压制，我就会失控”这类预测。
- **减少“担忧应对”**：不再用反复分析、求保证、检查来回应担忧。

MCT 的初步研究结果不错，有些试验显示效果不亚于 CBT，治疗次数可能更少。【研究】 但研究规模总体较小，长期效果和在不同人群中的适用性还需要更多验证；目前多数指南没有把 MCT 列为一线。【待验证】 对“我知道担心的事不现实，但我控制不住担心本身”的人，MCT 的思路可能更对路。

四、心理动力治疗：关系模式、情绪与过去

心理动力治疗关注的是：早期关系经验如何塑造了你看待自己、他人和世界的方式；焦虑如何与冲突、羞耻、依恋、未处理的情绪有关；以及你和治疗师之间的互动如何重演这些模式。【研究】

它通常比 CBT 更长，频率可能每周一次或更多，过程更开放，不一定有逐次的结构化作业。短程心理动力治疗（通常十几次到几十次）在部分焦虑和抑郁人群中显示效果，但研究数量和一致性不如 CBT。【研究】 NICE 等指南通常不把心理动力治疗列为焦虑障碍的首选心理治疗，更多作为有条件时的选择，或用于共病人格、关系问题、童年创伤的情况。【指南】

心理动力治疗可能适合这样的人：问题反复出现，和关系模式明显相关；对结构化作业感到束缚；希望理解“我为什么会这样”，而不只是“怎么把它压下去”；愿意投入较长时间。它不太适合只想尽快缓解惊恐发作、需要明确步骤的人，也不适合把“探索过去”当成回避当下行动的理由。

需要提醒的是，心理动力治疗不是“随便聊聊”。合格的治疗有目标、有设置、有边界、有督导，也会关注症状变化和风险。如果治疗很久仍在原地打转，或者治疗师把一切解释都归到童年却不处理当下危机，值得重新评估。

五、团体与家庭治疗，以及怎么选治疗师

团体治疗通常由一位或两位治疗师带领，六到十二人左右，围绕特定主题进行，比如社交焦虑的团体 CBT、惊恐障碍的小组练习、GAD 的担忧管理小组。它的优势是费用通常低于个体治疗、能获得同伴支持、可以在真实的小组互动中练习暴露；缺点是隐私顾虑、个人问题深度有限、时间固定。团体 CBT 对社交焦虑有明确证据，NICE 指南也认可团体形式。【指南】 对惊恐和 GAD，团体 CBT 同样有研究支持。【研究】

家庭治疗在儿童青少年焦虑中证据较强，常与个体 CBT 结合，重点包括：调整家长的过度保护或批评、减少家庭对焦虑的“配合”、改善沟通、处理拒学。【指南】 对成年焦虑患者，家庭治疗不是一线，但家属的参与可能很重要。很多家属出于好意，会替患者回避、反复保证“没事的”、包办决定，这些“家庭配合”会无意中维持焦虑。心理教育、减少反复保证、支持患者按计划暴露，往往比讲道理更有用。【研究】

疗法	核心机制	证据强度	可能适合谁
CBT	改变灾难化解释、停止回避、行为实验	最强，多国指南一线	多数焦虑障碍，尤其惊恐、社交焦虑
ACT	接纳体验、认知解离、按价值行动	中等，研究增长中，非普遍一线	厌倦控制、愿带着焦虑行动的人
元认知治疗	改变对担忧本身的信念，减少担忧应对	初步研究较好，规模偏小	明知担忧不现实却停不下来的人
心理动力治疗	关系模式、情绪冲突、早期经验	中等偏弱，非一线	问题与关系/过去明显相关、愿意长期探索的人
团体 CBT	结构化练习 + 同伴互动	较强，部分指南认可	社交焦虑、费用有限、需要同伴支持的人
家庭治疗	调整互动、减少家庭配合	儿童青少年较强，成人辅助	青少年焦虑、拒学、家庭冲突明显

选治疗师的核对清单

1. 资质：是否有精神科医师、心理治疗师、心理咨询师等相关专业背景，是否在正规机构执业。
2. 受训：是否受过该疗法的系统培训，有没有持续督导，而不是只上过几次工作坊。
3. 评估：第一次是否问清症状、病程、共病、用药和风险，而不是直接开始“聊”。
4. 目标：是否和你一起设定具体目标，比如“能独自坐地铁”“能在会上发言”。
5. 计划：是否说明大致疗程、频率、每次做什么、怎么判断有没有进展。
6. 测量：是否用量表或记录跟踪变化，而不是只说“感觉好多了”。
7. 边界：是否守时、保密、不私下交往、不推销课程或保健品。
8. 危机：是否问过自杀风险、有没有紧急联系和转介方案。
9. 匹配：你能否感到被尊重、被听见，而不是被评判或被说教。
10. 费用：是否提前说清价格、取消规则、能否开具正规票据。

治疗是否在起效，不看“聊得开不开心”，而看几个信号：症状频率或强度下降；回避范围缩小；能做一些以前不敢做的事；对焦虑的理解变了；睡眠、工作、关系有改善。通常几周到几个月能看到初步变化，但不同疗法节奏不同。如果一段时间后完全没变化，可以和治疗师讨论，也可以寻求第二意见，不必觉得“换人就是背叛”。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了伤害自己的事。
- 首次突发剧烈胸痛、气短、晕厥。
- 意识模糊、抽搐、高热、严重过敏。

尽快联系医生或更换治疗师

- 治疗师要求你自行停用精神科药物，或承诺“包治、根治”。
- 治疗师有越界行为：私下约会、言语羞辱、索要钱财、泄露隐私。
- 治疗数月毫无进展，或症状持续加重。
- 团体治疗中感到被攻击、被强迫暴露，且带领者不处理。
- 家庭治疗中有人被指责、被边缘化，或存在暴力、控制。

常见问题与容易踩的坑

“ACT 是不是让人认命？” 不是。接纳的是紧张、担忧这些内部体验，不是放弃改变外部生活。

“元认知治疗是不是比 CBT 更好？” 目前不能这么说。它有不错的初步证据，但研究规模和研究量都不如 CBT，指南地位也不同。

“心理动力治疗是不是过时了？” 不是过时，而是适用人群和证据位置不同。它不适合被当成“唯一正确的深层治疗”，也不该被一概否定。

“团体治疗会不会没隐私？” 正规团体会明确保密规则，成员签署协议。如果带领者不设边界、允许成员私下传播他人信息，要警惕。

“怎么知道治疗师合不合适？” 看资质、受训、督导、目标和边界，也看你是否被尊重。不合适可以换，换之前尽量结清费用、说明原因，不需要编理由。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013：https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）：https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 6：药物治疗

药物不是“镇静剂”，而是调节焦虑回路。什么时候用、选哪类、用多久、怎么停，比“吃不吃”更重要。

6.1 药物总览：什么情况用药、用什么、用多久

这一页想解决三个最常被问到的问题：什么情况下需要吃药、抗焦虑药大致分几类各站在什么位置、以及药通常要吃多久。它适合刚被建议服药、正在犹豫要不要开始、或者已经拿到处方却看不懂每种药是干什么的人。读完之后，你应该能和医生讨论「为什么选这一类、大概多久见效、计划用多久」，但这里不会给出具体药名和剂量，也不会替你决定该吃哪一种。

先纠正一个印象：抗焦虑药不是「镇静剂」

很多人一听要吃药，脑子里出现的是「吃了就迷糊、反应变慢、离不开」。这个印象主要来自苯二氮䓬类，也就是常说的「安定」类。它们确实起效快，也确实有依赖和戒断风险，但只是抗焦虑药里的一类，不是全部。

目前最常用的一线药物是 SSRI 和 SNRI。它们不是当场把情绪压下去，而是通过长期调节 5-羟色胺、去甲肾上腺素等信号分子的传递，让过度活跃的威胁检测回路慢慢降下来。所以它们起效慢，常常要几周，但不会让人立刻「上头」，也不产生苯二氮䓬那种典型的依赖。【指南】

这一点很重要：**「起效慢」不等于「没用」，「吃了没感觉」也不等于「药不对」。** 不少人吃到第二周觉得毫无变化就停了，恰好停在最需要坚持的位置。

什么情况该考虑药物

不是所有焦虑都需要吃药。轻度焦虑、有明确诱因、工作生活基本能维持的人，心理治疗（尤其是认知行为治疗）往往是首选，单用心理治疗就够了。【指南】

下面这些情况，医生更可能把药物纳入方案：

- 症状达到中度以上，明显影响工作、学习、睡眠或社交；
- 已经开始回避，生活范围在缩小，比如不敢坐地铁、不敢开会；
- 心理治疗资源排不上、费用难以承担，或认真做过一段时间效果有限；
- 合并抑郁、失眠，或躯体症状特别突出；
- 需要较快控制症状，先恢复基本功能，再补心理干预；
- 以前发作过、有明确复发史，医生判断需要维持治疗。

也有几种情况需要先「等一等」或换个思路：诊断还不清楚；症状可能是甲亢、心律失常、低血糖引起的；每天大量咖啡、酒精或某些药物在维持焦虑；正在备孕或已经怀孕；合并双相障碍（抗抑郁药可能诱发转躁）；以及本人对吃药有强烈顾虑、还没和医生充分谈过。这些都不是「绝对不能用药」，而是「先把前提弄清楚」。【指南】【临床经验】

情况	首先考虑	说明
轻度、功能基本正常	心理治疗、生活方式调整	单用非药物手段常常已经足够
中度、功能受影响	心理治疗联合药物	联合治疗通常优于单用其中一种
重度、明显受损	以药物为主，尽快联合心理治疗	先恢复功能，再补心理干预
合并抑郁或失眠	能兼顾两者的药物	避免多种镇静类药物叠加

抗焦虑药物的大类：一张表看清位置

下表只做类别层面的对比，帮助你看懂处方里「这一种是干什么的」。同一类里不同药物差别也不小，具体用哪一种由医生决定。

类别	主要用途	起效速度	主要顾虑
SSRI	广泛性焦虑、惊恐、社交焦虑的一线	数周	早期恶心、性功能影响、出汗；停药需缓慢
SNRI	焦虑合并慢性疼痛、共病抑郁	数周	血压和心率升高、出汗、撤药反应
苯二氮䓬类	急性期短期救火、检查或操作前	数十分钟到数小时	依赖、耐受、戒断、跌倒、认知影响
丁螺环酮、坦度螺酮	广泛性焦虑的替代选择	一到两周起，数周才充分	起效偏慢，对惊恐和表演焦虑证据较弱
普瑞巴林	广泛性焦虑（部分地区获批）、神经痛	相对较快	镇静、水肿、滥用风险
β 受体阻滞剂	表演焦虑的躯体症状，按需使用	服药后较短时间	低血压、心动过缓、哮喘患者不宜
抗组胺药	短期助眠、急性焦虑的辅助	较快	嗜睡、口干、老年人意识混乱
曲唑酮	助眠、辅助治疗	当晚	镇静、体位性低血压、心律风险
三环类	二线选择、特定类型	数周	口干便秘、心脏毒性、过量危险
MAOI	难治性焦虑、特殊类型	数周	饮食与药物禁忌多，管理要求高

【指南】【临床经验】

看这张表时留意两件事。第一，起效快慢和「好不好」不是一回事：起效最快的苯二氮䓬类，恰恰是最不适合长期用的。第二，副作用一栏写的是「需要留意」，不是「一定会发生」，多数人只会遇到其中一两项，而且常常在几周内减轻。

「一线」「二线」这两个词，容易被误读

一线指的是：在多数病人身上，疗效证据最充分、长期使用安全性数据相对多、适用范围最广。它不等于「效果最强」，也不等于「别人吃了好你也一定合适」。

二线也不等于「差」。二线往往是三种情况之一：疗效证据稍弱；只对某类亚型更合适；或者有效但需要更多监测（比如三环类的心电图监测、MAOI 的饮食限制）。有些人在一线药物上反应不好或耐受不了，二线反而是对的那一个。【指南】

急性期、巩固期、维持期：药要用多久

「吃到什么时候」是比「吃不吃」更容易被低估的问题。一般把用药分成几个阶段：

阶段	主要目标	大致时间
急性期	控制症状、恢复基本功能	数周到两三个月
巩固期	把疗效稳住，防止刚好转就反弹	症状缓解后数月
维持期	预防复发	通常半年到一年以上，部分人更久
减停期	缓慢减量、观察反复信号	数周到数月

具体多久，看焦虑类型、严重程度、既往复发次数、有没有残留症状、生活压力是否还在。惊恐障碍和广泛性焦虑的维持时间不完全一样，合并抑郁的往往需要更长。【指南】把这张表理解成「大致地图」而不是「合同期限」比较合适。

需要提醒的是：症状好转不等于病程结束。焦虑障碍的复发并不少见，过早停药是常见原因之一。这方面可以配合阅读停药与维持相关的篇目，不要自己掐着日子停。

心理治疗和药物，不是二选一

把两者对立起来，是常见的误解，也是很多人吃亏的地方。

- 心理治疗擅长教技能：识别灾难化想法、停止回避、耐受躯体感觉、面对不确定性。这些技能学会了可以带走，停药后仍然有用。
- 药物擅长改状态：在症状很重、睡不着、无法出门、无法工作的阶段，先把状态降下来，人才有力气做心理治疗。
- 联合治疗在中重度焦虑里通常效果更好，这一点在指南里有明确推荐。【指南】

所以真正的问题不是「吃药还是做心理治疗」，而是「现在这个阶段，哪一头更急」。急性期症状压不住，先用药开路；症状稳定了，心理治疗决定能走多远。

四条红线：不要自行选药、加量、换药、停药

这四条不是客套话，每一条背后都有具体风险。

1. **自行选药**：别人吃某药效果好，不代表适合你。诊断类型、共病、年龄、肝肾功能、合并用药、既往反应，都会改变选择。

2. **自行加量**：抗焦虑药大多不是「多吃一片好得快」。加量过快会放大副作用，苯二氮䓬类还可能带来过度镇静和呼吸抑制。
3. **自行换药**：不同药物之间怎么换、要不要交叉递减，是有讲究的。直接换可能引起撤药反应或血清素综合征。
4. **自行停药**：抗抑郁药和苯二氮䓬类突然停都可能出现明显不适，苯二氮䓬类突然停还有抽搐风险。必须由医生给减量计划。

清单：第一次拿到抗焦虑药处方，可以问这几句

- ☐ 这个药是治什么的，属于哪一类？
- ☐ 大概多久能感觉到变化，早期可能出现哪些副作用？
- ☐ 如果漏服一次，应该怎么处理？
- ☐ 计划用多久，什么时候评估效果？
- ☐ 不能和哪些药、酒、保健品一起用？
- ☐ 出现什么情况要立刻联系您，什么情况要直接去急诊？
- ☐ 如果我以后想停药，应该怎么和您商量？

把答案记在手机备忘录里。复诊时如果换了药，重新问一遍。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或一两天内）

- 服药后出现皮疹、瘙痒、面部或嘴唇肿胀；
- 明显心慌、坐立不安、出汗发抖，且越来越重；
- 情绪突然变得很糟，出现自伤念头；
- 持续呕吐腹泻、吃不下东西，担心脱水；
- 怀疑自己漏服或重复服药。

立即去急诊或拨打 120

- 高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识模糊、心跳很快（可能是血清素综合征）；
- 呼吸困难、面唇肿胀、皮疹迅速蔓延（可能是严重过敏）；
- 晕厥、抽搐、剧烈胸痛；
- 有自杀念头或已经做出伤害自己的行为。

如果拿不准算不算严重，按严重处理，宁可白跑一趟。

几个常见的坑

「症状好了就可以停」：好转通常说明药在起作用，不说明病已经走完。停药时机要单独讨论。

「西药伤肝伤肾，能不吃就不吃」：长期不治疗的中重度焦虑同样消耗身体和生活。药物有风险，医生的工作是把风险控制在可监测的范围内。

「先吃点安眠药顶一顶」：镇静类药物短期有效，长期会带来耐受和依赖，尤其是老年人。

「中药或保健品更安全，可以替代」：目前没有可靠证据支持任何保健品能替代规范治疗，混用还可能增加相互作用。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（仅用于焦虑合并抑郁）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.2 SSRI：一线选择与使用要点

SSRI 是「选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂」的缩写，是目前广泛性焦虑、惊恐障碍、社交焦虑最常用的一线药物类别。这一页讲清四件事：它为什么是一线、前几周会发生什么、长期吃要留意哪些问题、以及为什么不能自己停。它适合刚被开出这类药、吃了两周觉得没效果想放弃、或者担心「吃上就停不下来」的人。文中不写具体药名和剂量，因为同类药物之间怎么选、用多少，必须由医生根据你的情况定。

为什么 SSRI 是一线

一线这个词说的是「证据最多、用的人最多、长期数据相对多」，不是「效果最强」。SSRI 能站到这个位置，主要有四个原因。【指南】

1. **疗效有扎实证据**：在广泛性焦虑、惊恐障碍、社交焦虑中，SSRI 的疗效在多项随机对照试验和系统综述中得到支持，也被主要指南列为一线。
2. **安全性轮廓相对好**：相比三环类和 MAOI，SSRI 的心脏毒性小得多，过量时的危险性也低得多。这一点对「万一某天想不开」的病人尤其重要。
3. **可以长期用**：焦虑障碍需要维持治疗，SSRI 的长期使用经验比较充分，不像苯二氮䓬类那样用几周就要担心耐受和依赖。
4. **一箭双雕**：焦虑合并抑郁非常常见，SSRI 对两者都有效，不必同时吃两种抗抑郁药。【指南】

它也不是万能的。大约有一部分人对 SSRI 反应不充分，需要换类别或联合治疗；具体比例各方研究不一致，不必拿数字吓自己。

起效时间：前两周往往是最难熬的

SSRI 的作用不是「吃下去就安静」，而是让神经递质信号慢慢改变，进而让焦虑回路的活动降下来。这个过程需要时间，通常**两到四周**才开始有可察觉的变化，**六到八周**才能判断这一次治疗到底有没有效。【指南】

麻烦在于：副作用常常比疗效先到。很多人第十天觉得「不但没好，还更难受」，就把药停了。其实恶心、头痛、坐立不安这些早期反应，多数在两周内会减轻；而疗效还在后面等着。

可以把这段时间想成修路：先挖开，再铺好。医生通常会从低剂量开始，慢慢往上调，就是为了让身体有时间适应。具体怎么加、加多少，不属于科普能给的范畴。

有一个例外需要知道：**治疗刚开始的两周，焦虑可能短暂加重，失眠可能更明显，年轻人的激越和冲动也可能上升。** 这不是「药吃反了」，但需要报告医生，让他决定是减慢加量、短期合用其他药，还是调整方案。【指南】

早期副作用：常见、多在两周内减轻

副作用	大概什么感觉	通常怎么处理
恶心、胃口差	饭后服药常能减轻	多数一两周内缓解，不必停药
头痛、头晕	起床时明显	放慢起身，多喝水，观察
坐立不安、发抖	像「心里有电流」	需要报告医生，可能需要调整加量速度
失眠或嗜睡	有人睡不着，有人犯困	和医生讨论服药时间放在早上还是晚上
出汗增多	夜间或紧张时明显	多数可控，注意补水
情绪波动	前两周起伏大	记录下来，复诊时给医生看

【临床经验】

这些反应里，最容易被误判的是「坐立不安」。它有时是药物引起的静坐不能，有时是焦虑本身的波动，两者的处理方向不同。自己分不清时，直接描述给医生听：什么时候开始、持续多久、是不是坐不住、有没有想走来走去。

长期要留意的几件事

性功能影响。 这是 SSRI 最常见、也最容易被患者默默忍受的问题：性欲下降、达到高潮困难、快感减弱。发生率在不同研究里差别较大，但确实不低。【研究】很多人不好意思提，就自己减量或停药，结果焦虑复发。其实可以做的事不少：和医生说明、评估是否与焦虑本身或抑郁有关、考虑调整药物或联合其他处理。这件事值得开口。

出血风险。 SSRI 会影响血小板对 5-羟色胺的摄取，让血小板聚集能力下降一点。单独吃 SSRI 时出血风险通常很小，但如果同时用抗凝药、抗血小板药（如阿司匹林、氯吡格雷）、非甾体抗炎药，或者本身有凝血问题、要做手术拔牙，就需要提前告诉医生。【指南】常见表现是容易淤青、牙龈出血、鼻血变多。

低钠血症。 主要是老年人、同时用利尿剂的人、以及喝水特别多的人需要留意。表现是乏力、头痛、恶心、注意力涣散、走路不稳，严重时会意识模糊、抽搐。出现这些情况要查血钠。【指南】

QT 间期延长。 心电图上的 QT 间期反映心脏复极时间，某些药物会让它变长，增加心律失常风险。SSRI 类里这一点主要与某一种药在较高剂量时相关，其他几种影响较小。有心脏病、电解质紊乱、同时在用其他延长 QT 的药物，或者有晕厥史的人，医生可能会安排心电图。【指南】

体重变化。 有人几公斤，有人没有变化，长期看差异不大。

情绪「变平」。 少数人会觉得「不那么焦虑了，但也不怎么开心」，对什么都淡。这种感觉需要如实告诉医生，不要自己忍着。

停药反应：不是「成瘾」，但确实难受

SSRI 没有苯二氮䓬那种典型的成瘾性：不会越吃越想吃、不会为了「爽」而加量、不会出现强烈的渴求。但**突然停药会出现撤药反应**，这一点是真实的。【指南】

常见表现：头晕（尤其转头时）、像「脑子里有电流」或「触电感」、恶心、乏力、易怒、失眠、多梦、情绪低落。通常在停药后一两天到几天出现，持续一到两周，少数人更久。半衰期短的药更容易出现。

关键区别在于：**撤药反应是「停药太快」，复发是「病又回来了」。** 前者在重新服药后很快缓解，后者需要重新治疗。分不清时不要自己判断，交给医生。

所以停药的原则只有一条：**缓慢减量，在医生指导下进行。** 具体减多慢、减多久，看用了多久、用的哪种、之前有没有停药反应，不给通用数字。

几个特殊人群的提醒

- **青少年和年轻成人**：治疗初期要密切观察情绪、冲动和自伤念头的变化，这一点在所有抗抑郁药上都适用。【指南】
- **老年人**：低钠、跌倒、合并用药相互作用的风险更高，起始和调整都更保守。
- **孕产期**：不是绝对禁忌，也不是绝对安全。用与不用要权衡复发风险和药物暴露，需要精神科和产科一起讨论。
- **双相障碍**：如果既往有躁狂或轻躁狂发作，单用抗抑郁药可能诱发转躁，必须先评估。这也是初诊时医生会问「有没有过一段时间特别兴奋、睡得少还不累」的原因。
- **肝功能或肾功能不全**：药物代谢会受影响，需要医生调整。

清单：开始吃 SSRI 之后，可以这样配合

- ☐ 记下开始服药的日期和当时的剂量，复诊时带上
- ☐ 前两周每天用一句话记录副作用和睡眠，不用写长篇
- ☐ 不因为「没感觉」就自行加量
- ☐ 不因为「难受」就自行停药，先联系医生
- ☐ 提前告知医生正在用的其他药、保健品和中药
- ☐ 拔牙、做手术、做胃镜前，说明自己在吃这类药
- ☐ 出现自伤念头、极度激越、皮疹，立即联系医生

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或一两天内）

- 焦虑或失眠在用药后明显加重，影响到正常生活；

- 出现坐立不安、来回走动、无法静坐；
- 情绪突然低落，出现「活着没意思」的念头；
- 明显淤青、牙龈或鼻子反复出血；
- 持续呕吐腹泻，吃不下东西；
- 皮疹、瘙痒。

立即去急诊或拨打 120

- 高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识模糊、心跳很快（可能是血清素综合征）；
- 面部或嘴唇肿胀、呼吸困难、皮疹迅速蔓延（可能是严重过敏）；
- 抽搐、晕厥、剧烈胸痛；
- 有明确的自杀计划或已经伤害自己。

拿不准算不算严重时，按严重处理。

常见问题

「吃了两周没效果，是不是药不对？」 两周通常还看不出疗效，只能看出耐受性。是否有效一般要等到六到八周。这个判断交给医生，不要自己下结论。

「会不会吃一辈子？」 多数人不是。规范治疗是「足够长的时间后，在医生指导下缓慢减停」，具体多长看复发史和残留症状。少数复发多次的人需要更长维持，这也是权衡后的选择，不是失败。

「听说会让人变傻？」 没有证据支持 SSRI 会损伤智力。焦虑本身造成的注意力下降、记忆变差反而更常见，治疗好转后往往会改善。

「能不能和酒一起？」 不建议。酒精会加重焦虑、干扰睡眠、增加镇静和判断力下降的风险，和药物叠加时更明显。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.3 SNRI：文拉法辛与度洛西汀

SNRI 是「5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂」的缩写。和 SSRI 相比，它多作用了一个系统——去甲肾上腺素，因此除了抗焦虑、抗抑郁，还可能影响疼痛感受、疲劳感和注意力。这一页讲清这类药适合什么人、文拉法辛和度洛西汀有什么不同、要盯住哪些指标、以及为什么不能突然停。文中不写剂量，具体用哪种、用多少，要由医生结合你的血压、心脏、肝肾功能和既往反应来定。

这类药在做什么

神经细胞之间靠化学信号传递信息，5-羟色胺和去甲肾上腺素是其中两种。SSRI 主要让 5-羟色胺在突触间隙停留更久；SNRI 同时让这两种递质都停留更久一些。

多出来的这一份去甲肾上腺素作用，带来了两个后果：

- **好处**：对慢性疼痛、疲劳、注意力涣散、动力不足可能更有帮助。去甲肾上腺素参与身体对疼痛信号的「下行抑制」，也就是大脑主动把疼痛调小的能力。
- **代价**：去甲肾上腺素会让心跳加快、血管收缩，所以血压和心率可能上升；也会带来出汗、口干、便秘、排尿不畅。

  这也是为什么医生开这类药时，常常会量血压、问心率，而开 SSRI 时不一定会。

什么情况下医生会考虑 SNRI

SNRI 也是一线药物，在广泛性焦虑、惊恐障碍、社交焦虑中都有证据，和 SSRI 并列。【指南】实际选择时，下面这些情况更容易倾向 SNRI：

- **焦虑合并慢性疼痛**：如纤维肌痛、糖尿病周围神经痛、慢性腰背痛、紧张性头痛。这是 SNRI 相对 SSRI 最有优势的场景。【指南】
- **焦虑合并抑郁，且疲劳、兴趣减退、动力不足突出**：去甲肾上腺素作用可能对「没劲」有帮助。
- **用 SSRI 效果不充分或耐受不了**：换到 SNRI 是常见策略。【指南】
- **焦虑伴明显躯体症状**：心慌、肌肉紧张、出汗，有些人反应较好，但个体差异大。【临床经验】

反过来，有明显高血压且控制不好、心动过速、心律失常、癫痫、闭角型青光眼、排尿困难（如前列腺增生）的人，医生会更谨慎，或者干脆选别的类别。

考量点	SSRI	SNRI
焦虑疗效	一线，证据充分	一线，证据充分
慢性疼痛	作用有限	更有优势
疲劳、动力不足	因人而异	可能更有帮助
血压心率	通常影响小	可能升高，需要监测
撤药反应	有，程度不一	通常更明显，文拉法辛尤甚
出血风险	有轻度增加	也可能增加，个体与药物差异大；合并抗凝药或 NSAIDs 时需警惕

文拉法辛和度洛西汀：同类别，不同脾气

文拉法辛的特点是「剂量越高，去甲肾上腺素作用越明显」。低剂量时它更像 SSRI，剂量上去以后才逐渐体现 SNRI 的特点。这解释了为什么有些人加量后感觉「不一样了」，也解释了为什么它的副作用常常和剂量相关。它的半衰期较短，**漏服或突然停药时撤药反应比较明显**，这一点在临床上很受重视。【指南】【临床经验】

度洛西汀的作用相对均衡，在慢性疼痛方面的研究较多，常被用于焦虑合并疼痛的情况。它同样可能升高血压，也可能引起恶心、口干、便秘、出汗。对肝功能有一定要求，有肝病或大量饮酒的人需要特别评估。

两者的共同点是：都需要几周才见效；都可能引起撤药反应；都不建议和酒同用；都可能与某些其他药物发生相互作用（尤其是影响肝药酶的药物）。

血压、心率和其他常见副作用

去甲肾上腺素作用会让部分人的血压上升、心率加快。特点是：

- 多数人升幅不大，但少数人明显；
- 与剂量相关，加量后更需要注意；
- 治疗前有高血压的人风险更高；
- 通常需要在治疗前量一次血压，治疗中定期复测。

如果本身有高血压，不代表不能用，但需要先把血压控制稳定，并在用药过程中监测。家庭血压计在这个时候很有用：固定时间、安静坐五分钟、量两次取平均，记录下来带给医生看。【指南】

需要警惕的情况：持续头痛（尤其是后枕部）、视力模糊、胸闷、心跳明显加快、鼻出血。这些可能提示血压升高，要尽快测量并联系医生。

其他常见副作用

副作用	表现	应对思路
恶心	早期明显，饭后可减轻	多在几周内缓解，持续不缓解要报告
出汗	夜间或紧张时明显	注意补水，勤换衣物
口干、便秘	持续性	多喝水、增加膳食纤维，必要时和医生讨论
头晕	起身时明显	放慢动作，避免突然站起
失眠或嗜睡	因人而异	和医生讨论服药时间
食欲下降、体重变化	早期常见	记录体重，明显下降要报告
排尿困难	尿线变细、排尿费力	需要报告，尤其老年男性

【临床经验】

撤药反应、疼痛共病与特殊人群

撤药反应：最需要认真对待的问题

SNRI 的撤药反应通常比 SSRI 更明显，文拉法辛尤其如此。原因是它的半衰期短，血药浓度下降得快，身体来不及适应。

典型表现：头晕、恶心、乏力、出汗、焦虑反跳、情绪低落、失眠、多梦、像「触电感」或「脑内电流」的感觉、走路不稳。通常在停药后一两天内出现，程度可能相当难受。

因此有几条原则：

1. **不要突然停**。哪怕觉得「已经好了」，也要和医生商量减量计划。
2. **漏服要尽快补，但不要一次吃双份**。具体怎么处理，按医生或药师的交代。
3. **减量要慢，越到后面越慢**。有些人在最后一段减量时反应最明显。
4. **撤药反应不等于复发**，但两者可以同时发生，判断交给医生。

和疼痛共病：这类药的一个实际优势

焦虑和慢性疼痛常常一起出现：长期紧张让肌肉持续收缩，睡不好让疼痛阈值下降，疼痛又反过来加重焦虑。SNRI 在这类「焦虑加疼痛」的组合里有实际价值，因为一种药可以同时照顾两头。【指南】

但要建立合理预期：这类药对疼痛的作用通常是「减轻一部分」，不是「完全不痛」。它也不是止痛药，不会像布洛芬那样半小时见效。通常需要几周，且需要配合运动、睡眠、物理治疗等综合管理。

如果疼痛是新出现的、位置固定、夜间加重、伴随体重下降或发热，要先查清楚原因，不要默认「是焦虑引起的」。

特殊人群的提醒

- **老年人**：血压波动、跌倒、低钠的风险更高，起始和调整更保守。
- **心血管疾病**：未控制的高血压、近期心梗、明显心律失常的人，需要先和医生充分讨论。
- **肝脏疾病或长期大量饮酒**：部分药物对肝脏有负担，需要评估。
- **闭角型青光眼、前列腺增生**：可能加重排尿困难或眼压问题，要提前告知医生。
- **双相障碍**：抗抑郁药可能诱发转躁，必须先评估。
- **孕产期**：需要精神科与产科共同权衡，不能自行决定停或继续。
- **青少年**：治疗初期需要密切观察情绪和冲动变化。

清单：吃 SNRI 期间可以做的事

- ☐ 治疗前量一次血压和心率，记下来
- ☐ 买一个家用血压计，每周固定时间测一两次

- ☐ 记录漏服情况，不要自行补双份
- ☐ 不突然停药，减量前先联系医生
- ☐ 手术、拔牙、做检查前，说明自己在吃这类药
- ☐ 避免和酒同用
- ☐ 出现持续头痛、胸闷、心跳很快，当天测量血压并联系医生

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或一两天内）

- 血压明显升高，或持续头痛、视物模糊；
- 心跳持续偏快、胸闷、活动后气短；
- 恶心呕吐持续不止，吃不下东西；
- 排尿困难、尿不出来；
- 情绪明显恶化，出现自伤念头；
- 皮疹、瘙痒。

立即去急诊或拨打 120

- 剧烈胸痛、晕厥、抽搐；
- 高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识模糊（可能是血清素综合征）；
- 面部肿胀、呼吸困难、皮疹迅速蔓延；
- 有明确的自杀计划或已经伤害自己。

血压高到多少算危险、要不要调药，由医生判断，不要自己加服降压药或停抗焦虑药。

常见问题

「文拉法辛是不是比度洛西汀强？」 没有这种排序。选择看的是你的症状组合、血压、肝功能、既往反应和耐受情况。

「吃了以后出汗很厉害，正常吗？」 常见，多数会随时间减轻。如果伴随心慌、体重明显下降、手抖，需要查甲状腺功能。

「能不能用来助眠？」 不合适。这类药可能让人犯困，也可能让人睡不着，且不适合当作安眠药使用。

「漏服了一次怎么办？」 想起来就补，但如果已经接近下一次服药时间，跳过即可，不要吃双份。具体按医嘱。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（仅用于焦虑合并抑郁）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.4 苯二氮䓬类：短期救火与依赖风险

苯二氮䓬类是常说的「安定」类药，吃下去几十分钟就能让人松下来，对急性焦虑、失眠、惊恐发作的即时控制确实有效。但它的代价也很明确：耐受、依赖、戒断、跌倒、认知影响和呼吸抑制。这一页想讲清两件事——它什么时候该用、为什么几乎不该长期用，以及为什么绝对不能自己突然停。适合正在吃这类药、家人长期吃、或者医生刚开了几天的人读。

它为什么起效这么快

大脑里有一种叫 GABA 的抑制性信号，作用是「踩刹车」。苯二氮䓬类不直接踩刹车，而是让刹车更好使：它结合到 GABA 受体的特定位点，让同样的抑制信号效果更强。结果是神经系统整体活动下降——紧张感减轻、肌肉放松、困意上来。

正因为作用直接，它见效快，通常几十分钟内就有感觉。也正因为作用广泛，它不只影响「焦虑的那部分脑区」，而是让整个中枢神经系统都慢下来，于是注意力、反应速度、记忆形成、平衡都会受影响。

这一点决定了它的定位：**适合当消防员，不适合当日常供电。**

什么时候可以短期用

苯二氮䓬类不是「坏药」，用对了能帮人渡过难关。指南里认可的场景大致是这些。【指南】

- **急性期开路**：焦虑非常重、睡不着、吃不下、无法工作时，先用几天到几周把状态压下来，同时开始用 SSRI 或 SNRI，等后者起效。
- **惊恐发作的临时应对**：在医生指导下按需使用，而不是每天固定吃。
- **躯体疾病或检查操作前**：如影像检查、牙科操作、内镜检查前的镇静。
- **严重失眠的短期处理**：尤其是急性应激导致的失眠，但通常不超过几周。
- **药物调整的过渡期**：换药、加量初期症状波动时短期搭桥。

场景	是否适合	关键限制
急性焦虑、无法入睡的几天	适合短期	同时启动长期方案，不单独依赖
惊恐发作按需使用	可以，需医生指导	频率上升是要警惕的信号
长期每日服用超过数月	一般不建议	疗效可能下降，依赖风险上升
老年人长期助眠	尽量避免	跌倒、意识混乱、记忆影响
与酒或阿片类同用	避免	呼吸抑制风险叠加
驾驶、操作机器前	避免	反应速度和判断力下降

判断「短期」没有统一数字，但临床上普遍的原则是：**能按需就不每天，能用几天就不拖成几周，能不长期就不长期。** 如果发现自己离不开、减一点就难受，说明已经进入需要处理的阶段。【临床经验】

四个容易混淆的概念

很多人把「依赖」「成瘾」「耐受」「戒断」当成一回事，其实不同。

概念	说的是什么	典型表现
耐受	同样剂量效果变弱	原来半片就够，后来要加量才有效
依赖	身体适应了有药的状态	停药或减量就出现不适，渴望继续吃
成瘾	失控性使用、明知有害仍继续	自行加量、囤药、多渠道找药、影响生活
戒断	减停后出现的生理反应	焦虑反跳、失眠、手抖、出汗、心慌

【指南】【临床经验】

依赖不等于成瘾。很多长期服药的人并没有「失控使用」，只是身体适应了，停不下来。但依赖本身也值得认真对待，因为它意味着减药会有难度，需要计划。

还有一个临床上很重要的信号：**两次服药之间出现焦虑、心慌、手抖，吃药后很快缓解。** 这叫「间歇性戒断」，说明身体已经在依赖药物维持，而不是焦虑本身在波动。出现这种情况要主动告诉医生。

长期使用的代价

疗效可能不如从前。 耐受会让同样剂量越来越不够用，于是有人自行加量，形成「越吃越多、效果越来越差」的循环。

戒断反应。 突然减量或停药后，可能出现焦虑反跳（比原来更焦虑）、失眠、易怒、出汗、心慌、手抖、肌肉抽动、感官过敏（声音变响、光线变刺眼）、注意力涣散。**严重时会出现抽搐、意识混乱、幻觉、高热，这是医疗急症，可能危及生命。** 所以苯二氮䓬类不能自行突然停药，这条没有例外。

跌倒和骨折。 这类药影响平衡和反应速度，老年人尤其明显。夜间起床上厕所是高风险时刻。髋部骨折对老年人来说后果严重，这是限制长期使用的重要理由。【指南】

认知影响。 注意力、工作记忆、学习新东西的能力可能下降，长期使用者的研究结果不完全一致，但「吃药期间脑子发木」是常见的主诉。多数在减停后可以改善，但需要时间。

呼吸抑制。 这类药会降低呼吸中枢对二氧化碳的敏感性。对睡眠呼吸暂停、慢性阻塞性肺病、肥胖低通气的人，风险更高。与酒精、阿片类止痛药、其他镇静药同用时，风险成倍上升，严重时可以致命。

情绪钝化。 有些人会觉得「不焦虑了，但也没什么感觉」，像隔着一层玻璃。这不等于抑郁，但需要如实告诉医生。

驾驶与操作风险。 服药初期、加量后、以及和酒同用时，反应速度和判断力下降明显。这不是「小心一点就行」的问题，而是实实在在地增加事故风险。

减停：只能慢慢来

如果你已经吃了几个月甚至几年，想停下来，正确的路径是：

1. **先和医生谈**，说明为什么想停、以前停过没有、停的时候什么感觉。
2. **制定减量计划**，通常是把总量分成若干小步，逐步减少，越到后面越慢。
3. **可能换成作用时间更长的同类药**，让血药浓度更平稳，减少戒断波动。这一步必须由医生做。
4. **配合心理治疗**，尤其是惊恐障碍和广泛性焦虑，CBT 能显著降低停药后的复发。
5. **记录反应**，出现明显不适时联系医生调整节奏，而不是自己恢复原量或硬扛。

减量的速度没有通用答案，取决于用了多久、剂量多大、哪种药、之前有没有戒断史。任何「几周减完」的通用说法都不适合套在自己身上。

关于酒精：两个方向的陷阱

- **一起吃**：镇静叠加，呼吸抑制、跌倒、判断力下降的风险明显上升，严重时可致命。
- **用酒缓解戒断**：有些人停药后难受，就用酒来压，结果形成「镇静药加酒精」的双重依赖，戒断风险更高。

如果你正在长期大量饮酒，或者同时用苯二氮䓬类，**不要自己硬戒**。酒精和镇静药的戒断都可能危及生命，需要在医疗监护下进行。

清单：正在吃这类药的人可以对照

- ☐ 知道自己吃的是哪一类、为什么吃、计划吃多久
- ☐ 不自行加量，哪怕觉得「今天特别难受」
- ☐ 不自行突然停药，减量前一定先问医生
- ☐ 不与其他镇静药、止痛药、酒同用
- ☐ 服药后不开车、不操作机器
- ☐ 夜间起床先坐一会儿，开灯，慢起身
- ☐ 把药放在固定地方，避免重复服用
- ☐ 复诊时主动说「我最近有没有出现两次服药之间难受」

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天）

- 需要不断加量才有原来的效果；
- 两次服药之间出现明显焦虑、心慌、手抖；

> - 白天嗜睡、走路不稳、记忆力明显下降；
> - 情绪变得很平，对什么都提不起兴趣；
> - 计划怀孕或已经怀孕。
>
> **立即去急诊或拨打 120**
>
> - 突然停药或减量后出现抽搐、意识混乱、幻觉、高热、大汗；
> - 服药后呼吸变慢、叫不醒、嘴唇发紫；
> - 与酒或止痛药同用后出现意识障碍；
> - 跌倒后头部受伤、意识改变；
> - 有自杀念头或已经伤害自己。
>
> 戒断引起的抽搐和意识障碍可能危及生命，不要在家「扛一扛」。

常见问题

「吃了几年了，是不是戒不掉了？」 不是。缓慢减量在多数人身上可以完成，只是需要时间和计划。失败常见的原因是减得太快，而不是「戒不掉」。

「医生说短期吃，可我吃了半年了怎么办？」 不要慌，也不要自己停。把这个情况告诉医生，重新评估是否还需要、能不能开始减量。

「能不能只在特别难受的时候吃？」 对某些人（如惊恐发作）按需使用是合理的，但频率上升说明需要重新评估整体方案。

「中药或褪黑素能不能替代？」 没有可靠证据支持它们能替代苯二氮䓬类的急性作用。突然用保健品替换处方药，可能出现戒断反应。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.5 丁螺环酮、坦度螺酮与普瑞巴林

不是所有抗焦虑药都会让人犯困，也不是所有「非苯二氮䓬」都完全没有依赖风险。这一页讲三种常被拿来替代或补充苯二氮䓬类的药：丁螺环酮、坦度螺酮和普瑞巴林。它们各自适合什么人、多久起效、要留意哪些副作用，以及为什么不能把它们当成「随手吃一片」的救急药。文中不写剂量，具体选择以面诊医生的处方为准。

它们共同的定位：不是救火队

这三者的共同点是：**不靠强镇静起效，不适合当场把一次惊恐压下去。**

丁螺环酮和坦度螺酮属于同一类，作用在 5-羟色胺 1A 受体上，属于「部分激动剂」——可以理解为给这个受体一个温和、稳定的刺激，让焦虑回路的过度活动慢慢降下来。它们不作用于 GABA 系统，所以不产生苯二氮䓬那种镇静、肌肉松弛和典型的依赖。【指南】

普瑞巴林机制不同，它结合到钙通道的一个辅助亚基上，减少兴奋性递质的释放，从而降低神经系统的「过度兴奋」。它起效比前两者快一些，但也有自己的问题。

一个常见的误解是：「不是苯二氮䓬，所以一定安全、一定没有依赖。」这句话对丁螺环酮和坦度螺酮大致成立，对普瑞巴林则不成立。

丁螺环酮：温和，但慢

丁螺环酮在广泛性焦虑中有明确证据，指南把它列为可选药物之一，尤其适合不能耐受苯二氮䓬类、或者有物质使用风险的人。【指南】

它的特点：

- **起效偏慢**：一到两周开始有变化，四到六周才能判断效果。指望它当晚就让人平静，会失望。
- **不镇静**：白天不明显犯困，不影响开车（但仍建议观察个体反应），这对需要上班、上学的人是好消息。
- **不产生典型依赖**：没有苯二氮䓬那样的耐受和戒断，突然停一般不会出现严重反应。
- **对惊恐发作、表演焦虑的证据较弱**：它更像「背景降噪」，不是「当场灭火」。

常见副作用：头晕、恶心、头痛、坐立不安、口干、疲乏。多数比较轻，几周内减轻。

需要注意的：不要和 MAOI 类抗抑郁药一起用，有血清素综合征的风险；肝功能不好的人需要医生评估；它不会阻断苯二氮䓬的戒断反应，所以不能用它「替代着突然停苯二氮䓬」。

坦度螺酮：国内的常见选择

坦度螺酮和丁螺环酮同属 5-羟色胺 1A 受体部分激动剂，在国内使用较多，常用于广泛性焦虑，也常与 SSRI 联合使用以增强抗焦虑效果。【临床经验】

它的特点和丁螺环酮接近：起效慢、镇静轻、依赖风险低。副作用以头晕、嗜睡、恶心、口干、食欲改变为主，通常不严重。

需要说明的是，这类药的研究规模和一致性不如 SSRI，指南里的推荐位置也更靠后。它适合作为「不能耐受一线药物时的替代」或「联合方案中的一部分」，而不是所有人都该首选。【指南】

普瑞巴林：起效较快，但代价不同

普瑞巴林最初用于癫痫和神经病理性疼痛，后来在部分国家被批准用于广泛性焦虑。**它在中国是否获批用于焦虑、以药品说明书为准**，这一点不要听信二手信息。

它的优势是起效相对快，有些人在几天到一周内就有感觉，对焦虑伴失眠的人也可能有帮助。

代价主要有三块：

镇静和头晕。 尤其在加量初期，白天犯困、走路发飘、注意力下降比较常见。老年人跌倒风险上升。

水肿和体重增加。 下肢水肿是典型表现，有人体重上升明显。心功能不全的人需要谨慎。

滥用和戒断风险。 这一点常被低估。普瑞巴林在部分人群中有明确的滥用潜力，尤其是有物质使用障碍史（酒精、镇静药、阿片类）的人。突然停药可能出现焦虑、失眠、出汗、疼痛、恶心、烦躁，少数人出现意识混乱。**所以它同样不能自行突然停，需要缓慢减量。**【指南】【研究】

其他副作用：视物模糊、口干、便秘、注意力下降、情绪波动。肾功能不全的人需要调整，用药前医生通常会查肾功能。

三者对比与适用人群

维度	丁螺环酮	坦度螺酮	普瑞巴林
主要适应	广泛性焦虑	广泛性焦虑	广泛性焦虑（地区差异）、神经痛
起效速度	慢，数周	慢，数周	相对较快
镇静程度	轻	轻到中	中，初期明显
依赖风险	很低	很低	存在，需警惕
突然停药	一般无明显戒断	一般无明显戒断	可能出现戒断
主要顾虑	起效慢、对惊恐弱	证据相对有限	水肿、体重、滥用、跌倒

【指南】【临床经验】

谁更适合，谁要更小心

更适合考虑丁螺环酮或坦度螺酮的人：

- 广泛性焦虑为主，症状持续但不算剧烈；
- 不能耐受 SSRI 的副作用，或医生认为需要联合；

- 有苯二氮䓬依赖史，希望避开这类药；
- 需要白天保持清醒、注意力集中的人。

要更小心的人：

- **有物质使用障碍史**：普瑞巴林需要格外谨慎，丁螺环酮相对更安全；
- **老年人**：三者都要注意头晕和跌倒，普瑞巴林的水肿和镇静更明显；
- **肾功能不全**：普瑞巴林需要调整；
- **肝功能不全**：丁螺环酮、坦度螺酮需要评估；
- **孕产期**：三者数据都有限，需要专科医生权衡；
- **正在用 MAOI**：丁螺环酮、坦度螺酮不宜合用。

一个现实问题：它们不能替代「救急」

很多人希望有一种药「难受的时候吃一片，十分钟就好」，同时又「不伤身、不上瘾」。这种药目前不存在。

- 起效快的（苯二氮䓬类）有依赖和镇静问题；
- 依赖风险低的（丁螺环酮类）起效慢，救不了急；
- 普瑞巴林介于两者之间，但既不是完全没有依赖，也不是当场见效。

现实的做法通常是组合：**用一线药物（SSRI/SNRI）打底，急性期短期用苯二氮䓬类过渡，同时做心理治疗。** 丁螺环酮类和普瑞巴林是这套组合里的备选零件，不是万能钥匙。

清单：开始用这类药时可以留意

- ☐ 明确医生给这个药的目的是「长期打底」还是「联合增强」
- ☐ 接受它不会当天见效，给它几周时间
- ☐ 记录头晕、嗜睡、水肿、体重变化
- ☐ 不同时用 MAOI，不自行叠加其他镇静药
- ☐ 普瑞巴林不自行加量、不自行突然停
- ☐ 老年人夜间起身放慢，注意防跌倒
- ☐ 复诊时说明「有没有效果、有没有难受」，不要只说「还行」

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或一两天内）

- 下肢或脚踝明显水肿、体重短期内明显上升；
- 白天嗜睡到影响工作、走路不稳；
- 情绪明显低落、出现自伤念头；
- 停药后出现焦虑反跳、失眠、出汗、疼痛；

> • 皮疹、瘙痒。
>
> **立即去急诊或拨打 120**
>
> • 意识模糊、言语不清、走路严重不稳；
> • 抽搐、晕厥；
> • 呼吸困难、面唇肿胀；
> • 有自杀念头或已经伤害自己。
>
> 如果同时喝了酒或吃了安眠药，出现叫不醒、呼吸变慢，立即呼叫 120。

常见问题

「丁螺环酮是不是没有副作用？」 有，只是相对轻。头晕、恶心、坐立不安都可能出现，多数会减轻。

「普瑞巴林是不是可以随便停？」 不可以。它有戒断风险，需要缓慢减量。

「这三种能一起吃吗？」 一般不会三种同用。是否联合、怎么联合，由医生根据你的反应决定，不要自己叠加。

「吃了两周没效果，是不是没用？」 丁螺环酮和坦度螺酮通常需要四到六周才能判断，两周下结论偏早。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.6 β 受体阻滞剂、抗组胺药与曲唑酮

有三类药常被误当成「抗焦虑药」：β 受体阻滞剂、抗组胺药和曲唑酮。它们确实能在某些场景帮上忙，但作用范围很窄，用错地方不但没效，还可能带来低血压、跌倒、白天昏沉等问题。这一页讲清三者的边界：什么情况下用对了，什么情况下是「用错工具」。文中不写剂量，具体用不用、怎么用，以医生判断为准。

β 受体阻滞剂：管的是身体的「警报器」，不是脑子里的「担心」

β 受体阻滞剂原本用于高血压、心绞痛、心律失常和甲亢的心率控制。它阻断肾上腺素在心脏和血管上的作用，让心跳慢下来、收缩力减弱、手抖减轻。

用在焦虑上，它的逻辑是：**焦虑时身体会心跳加速、手抖、出汗、声音发紧，这些外周反应会反过来加重「我很紧张」的感觉。** 把外周反应压下去，主观紧张感也会跟着降一些。

但它有一个明确的局限：**对「脑子里的担心」几乎没用。** 广泛性焦虑那种反复想、停不下来的担忧，它管不了；惊恐发作时的濒死感、失控感，它也压不住。

所以它的定位很清楚：

场景	是否适用	说明
表演前紧张（演讲、考试、面试、演奏）	较适合	证据主要集中在这一类，按需使用
社交焦虑的躯体症状	可作为辅助	对认知层面的害怕被评价作用有限
广泛性焦虑的持续担忧	不适合单用	不能替代 SSRI/SNRI
惊恐发作的急性控制	不适合	起效和机制都不匹配
焦虑伴心悸、手抖明显	可短期辅助	需先排除心脏问题

【临床经验】【研究】

需要说明一点：主要指南并不把 β 受体阻滞剂列为社交焦虑的常规推荐，认为整体证据不足；临床上它更多用于「表演前按需控制躯体症状」这一狭窄场景，而不是日常抗焦虑治疗。

要留意的事：

- **低血压**：头晕、乏力、站起时眼前发黑，老年人跌倒风险上升。
- **心动过缓**：心跳过慢、活动耐力下降。
- **哮喘和严重气道疾病**：非选择性 β 受体阻滞剂可能诱发支气管痉挛，通常禁用或慎用。
- **糖尿病**：可能掩盖低血糖的心慌、手抖等预警信号，用胰岛素或磺脲类的人要特别注意。
- **不能突然停**：长期规律使用后突然停，可能引起心率反跳、血压升高、心绞痛加重。
- **手脚发凉、噩梦、疲劳**：常见但常被忽略。

一个现实提醒：**β 受体阻滞剂不是「吃了就不紧张」的魔法药。** 它减轻的是手抖、心跳这些外在表现，如果台下准备不足、脑子里全是「我会搞砸」，它帮不了太多。对表演焦虑，认知行为治疗和充分准备的作用往往更大。

抗组胺药：能镇静，但代价不小

抗组胺药主要指有镇静作用的第一代药物，如羟嗪、苯海拉明等。它们阻断组胺受体，而组胺在脑内参与觉醒调节，所以吃了会困。

在焦虑领域的用途很有限：

- **短期助眠**：尤其是急性应激导致的入睡困难；
- **术前或操作前的轻度镇静**；
- **不能耐受苯二氮䓬类时的短期替代**，但证据较弱。

【临床经验】

问题在于副作用谱：

- **嗜睡、注意力下降**：第二天「宿醉感」常见，影响驾驶和操作。
- **抗胆碱能作用**：口干、便秘、视物模糊、排尿困难，前列腺增生和青光眼患者要小心。
- **老年人风险高**：意识混乱、谵妄、跌倒、认知下降，通常不建议老年人长期使用。
- **耐受快**：连续用几天后助眠效果就下降，容易越吃越多。

所以它更像「临时工具」，不适合作为焦虑的长期治疗方案。

曲唑酮：助眠可以，抗焦虑不行

曲唑酮是一种抗抑郁药，但在低剂量时主要表现出镇静作用，常被用来改善失眠，尤其是「睡不着但不想吃安眠药」的人。用于助眠时，部分用法属于药品说明书之外的用法，需要医生评估并记录。

它的特点：

- **当晚就可能有困意**，不需要等几周；
- **不产生苯二氮䓬类的典型依赖**，突然停一般不会有严重戒断；
- **对焦虑本身作用有限**，不能替代 SSRI/SNRI 治疗焦虑障碍。

要留意的事：

- **体位性低血压**：起身时头晕、眼前发黑，老年人尤其要注意，夜间起床是高风险时刻。
- **晨起昏沉**：剂量不合适时，第二天上午像没睡醒。
- **口干、便秘、视物模糊**。
- **心律影响**：可能延长 QT 间期，有心脏病、电解质紊乱或同时用其他延长 QT 药物的人需要评估。
- **极少数男性出现异常勃起**（持续数小时、疼痛），这是急症，必须立即就医，不能等。

- **与酒、其他镇静药同用**会加重镇静和低血压。

三者放在一起看

维度	β 受体阻滞剂	抗组胺药	曲唑酮
主要用途	表演焦虑的躯体症状	短期助眠、轻度镇静	助眠
对「担忧」的作用	很有限	无	有限
起效	服药后较短时间	较快	当晚
依赖性	低，但长期用不能骤停	低，但有耐受	低
主要风险	低血压、心动过缓、哮喘禁忌	嗜睡、抗胆碱能、老年人谵妄	体位性低血压、晨起昏沉、心律
适合长期用吗	一般不是	不适合	可作为助眠长期方案之一，需评估

【指南】【临床经验】

为什么「不是所有焦虑都适用」

焦虑不是一个东西。它至少可以拆成三层：

1. **身体层**：心跳快、手抖、出汗、肌肉紧、呼吸浅；
2. **认知层**：担心、灾难化、害怕失控、害怕被评价；
3. **行为层**：回避、检查、寻求保证。

β 受体阻滞剂主要作用在第一层，抗组胺药和曲唑酮主要作用是「让你睡着」，对第二、三层几乎无效。

如果一个人的核心问题是「我总觉得要出事」「我控制不住地想」，靠这几类药解决不了，需要的是 SSRI/SNRI 加心理治疗。如果核心问题是「一上台就手抖到拿不住稿子」，β 受体阻滞剂可能真的有用。

用错工具，比不用更让人失望。 很多人试了 β 受体阻滞剂觉得「没用」，就推断「药物对我都没用」，其实是选错了靶点。

清单：考虑用这几类药之前

- ☐ 先明确自己的核心问题是躯体反应、担忧，还是睡不着
- ☐ 有哮喘、慢阻肺、严重心动过缓，主动告知医生
- ☐ 有低血压、体位性头晕史，主动告知医生
- ☐ 老年人同时用多种镇静药，请医生做一次用药梳理
- ☐ 服 β 受体阻滞剂期间不自行骤停
- ☐ 服曲唑酮后夜间起身先坐一会儿，开灯
- ☐ 服药后不开车、不操作机器，直到确认自己的反应

- ☐ 不把这几类药当作焦虑的唯一治疗

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或一两天内）

- 站起时反复头晕、眼前发黑；
- 心跳过慢、活动后异常乏力；
- 晨起昏沉到影响工作；
- 排尿困难、严重便秘；
- 皮疹、瘙痒。

立即去急诊或拨打 120

- 晕厥、跌倒后头部受伤；
- 剧烈胸痛、呼吸困难、喘不上气（尤其哮喘患者服药后）；
- 意识模糊、言语不清；
- 男性出现持续数小时、疼痛的异常勃起；
- 有自杀念头或已经伤害自己。

拿不准算不算严重时，按严重处理。

常见问题

「考试前吃一片 β 受体阻滞剂安全吗？」 对没有哮喘、没有严重心动过缓、没有低血压的健康人，短期按需使用在医生指导下通常可以。但它可能让你「身体不紧张了，脑子还是慌」，也可能引起乏力、头晕。第一次使用最好不是在大事当天。

「抗组胺药能不能长期当安眠药？」 不建议。耐受快，抗胆碱能副作用累积，老年人风险尤其高。

「曲唑酮是不是没有依赖，可以一直吃？」 依赖风险确实低，但不等于没有风险。长期使用需要定期评估低血压、心律和是否仍然必要。

「这几类药能替代 SSRI 吗？」 不能。它们各自解决的是某个局部问题，不是焦虑障碍的规范治疗。

参考来源

- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.7 三环类、MAOI 与难治性焦虑

在 SSRI 出现之前，三环类抗抑郁药和单胺氧化酶抑制剂（MAOI）是治疗焦虑的主要武器。它们至今仍在用，但位置已经后移：多用于一线药物效果不好、不能耐受，或者症状类型比较特殊的人。这一页讲清它们的疗效与代价、为什么有那么多饮食和药物禁忌，以及「难治性焦虑」到底该怎么评估。这一页不提供换药方案——老药的启用和调整，必须由精神科医生做。

老药没有过时，只是位置变了

三环类和 MAOI 的疗效是确切的，在惊恐障碍、社交焦虑、广泛性焦虑中都有研究支持，部分场景下疗效不弱于新药。【指南】【研究】它们退到二线，主要不是因为「效果不行」，而是因为：

- 副作用更多、更难受；
- 过量时危险性高；
- 与其他药物的相互作用复杂；
- 需要更多监测（心电图、血压、血药浓度）；
- MAOI 还有严格的饮食限制。

所以它们今天的角色是：**在一线方案走不通时，由有经验的医生使用的「第二梯队」。**

三环类：有效，但要管得住副作用

三环类通过阻断 5-羟色胺和去甲肾上腺素的再摄取起作用，但它不只作用在这两个系统，还会阻断乙酰胆碱、组胺和 α1 肾上腺素受体。这些「顺带」的作用，就是大部分副作用的来源。

作用	带来的副作用	怎么应对
阻断乙酰胆碱	口干、便秘、视物模糊、排尿困难	多喝水、增加纤维，排尿困难要报告
阻断组胺	嗜睡、体重增加	调整服药时间，监测体重
阻断 α1 受体	体位性低血压、头晕	慢起身，老年人防跌倒
心脏传导影响	心电图 QRS 增宽、心律失常	治疗前和治疗中做心电图
降低癫痫阈值	抽搐风险上升	有癫痫史者慎用

【指南】

最需要知道的一点：三环类过量非常危险。 它可能引起严重心律失常，少量过量就可能致命。如果家里有自杀风险的人，这类药的保管、取药量需要特别安排，这一点医生通常会主动考虑。这不是危言耸听，而是这类药与 SSRI 最关键的安全差别之一。

其他注意事项：

- **治疗前要做心电图**，有心脏病、传导阻滞的人通常不宜；
- **可能需要监测血药浓度**，尤其老年人和合并用药多的人；

- **不能与 MAOI 合用**，也不能在停 MAOI 后立刻开始；
- **与酒精、其他镇静药同用**会加重镇静和低血压；
- **青光眼、前列腺增生、严重便秘**的人要提前告知医生；
- **突然停药**会出现类似流感的撤药反应（乏力、恶心、头痛、失眠），需要缓慢减。

常用的几种三环类各有侧重：有的镇静作用强，适合伴失眠的人；有的激活作用强，适合伴迟滞、乏力的人；有的在惊恐障碍和强迫症状中用得较多。选哪一种，取决于症状组合和耐受情况。

MAOI：禁忌最多，但也最不能被误解

MAOI 通过抑制单胺氧化酶，减少 5-羟色胺、去甲肾上腺素和多巴胺的分解。它对难治性抑郁、社交焦虑、非典型抑郁有独特价值，在惊恐障碍中也有证据。【指南】

它的问题主要来自「酶被抑制后，别的物质降解也变慢」：

饮食禁忌（酪胺反应）。 某些发酵、腌制、陈放的食物含较多酪胺，正常情况下会被单胺氧化酶分解，用药后分解受阻，可能引起血压急剧升高，表现为剧烈头痛、心悸、恶心、视物模糊，严重时脑出血。需要避免或严格限量的包括：陈年奶酪、腌肉腌鱼、发酵豆制品、部分酱油和酵母制品、生啤和部分红酒、过熟的水果等。具体清单医生会给，且不同药物、不同剂量要求不同。

药物禁忌。 不能与 SSRI、SNRI、曲马多、右美沙芬、部分感冒药和鼻喷剂、拟交感药物、圣约翰草等合用，否则可能引起血清素综合征或高血压危象。**换药时需要「洗脱期」**——停一种药后等一段时间再开始另一种，具体多久由医生根据药物种类决定，不能自己想当然。

其他副作用：体位性低血压、失眠、水肿、性功能影响、肝损伤（少见但需监测）。

需要说明的是：MAOI 并不是「毒药」，在合适的人、合适的管理下，它可以让难治性患者明显好转。但它要求患者配合度高、能记住禁忌、能及时报告不适。如果你生活节奏混乱、同时用多种药、经常饮酒，医生可能会更犹豫。

什么叫「难治性焦虑」，以及怎么处理

很多人说自己「治不好」，其实还没到难治的程度。临床上判断难治，通常要看这几条：

1. **诊断是否正确**：是不是焦虑障碍？有没有被漏掉的躯体疾病、药物或咖啡因/酒精因素？
2. **疗程是否足够**：一线药物是否用了足够长的时间（通常数月，而不是两周）？
3. **剂量是否足够**：是否在可耐受范围内达到了有效剂量？
4. **依从性如何**：有没有漏服、自行减量、因为副作用偷偷停药？
5. **有没有共病**：抑郁、双相、PTSD、OCD、物质使用、人格问题、慢性疼痛、失眠，都会影响疗效。
6. **心理治疗是否到位**：有没有做过结构化的 CBT，包括暴露和行为实验？
7. **生活因素**：持续的压力、家暴、工作环境、睡眠剥夺、酒精，是否还在持续？

只有这些都被认真处理过，仍然效果不佳，才谈得上「难治」。在此之前换药，往往只是把同一个问题换一种药再试一遍。

难治性焦虑的处理路径

- **复核诊断与共病**：这是第一步，也是最容易被跳过的一步。
- **优化现有治疗**：确认剂量、疗程、依从性，考虑联合心理治疗。
- **换用或联合其他一线药物**：如 SSRI 换 SNRI，或联合丁螺环酮类。
- **考虑二线药物**：三环类、MAOI、普瑞巴林等，由有经验的医生评估。
- **考虑增效策略**：部分情况下医生会联合其他药物，但这属于专科决策，证据强度不一。
- **转诊**：到精神科专科门诊、焦虑障碍专病门诊或难治性情绪障碍门诊。转诊不是「被放弃」，而是换一个更有经验的团队。

  【指南】【临床经验】

安全提醒：这几类药绝对不能自己动

- 不自行开始三环类或 MAOI，这类药的启动需要评估心脏、血压、饮食和合并用药。
- 不自行把 SSRI 换成 MAOI，也不自行把 MAOI 换成 SSRI，中间需要洗脱期。
- 不自行加量。三环类的过量风险很高，MAOI 的高血压危象也和剂量相关。
- 不自行停药。三环类突然停会出现撤药反应，MAOI 突然停可能出现反跳。
- 不自行服用感冒药、止痛药、保健品、中药，先问医生或药师。

清单：准备看「难治性」门诊前

- ☐ 列出所有吃过的药：名称、起止时间、剂量、效果、副作用
- ☐ 列出所有正在吃的药、保健品、中药
- ☐ 记录最近一个月的睡眠、饮酒、咖啡因摄入
- ☐ 带上既往的心电图、甲功、血常规、肝肾功能
- ☐ 写下「最影响生活的三个症状」
- ☐ 写下做过几次心理治疗、做的什么类型、做了多久
- ☐ 想清楚自己最想解决的问题是什么
- ☐ 如果曾经有过自杀念头，如实告诉医生

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天）

- 开始新药后出现明显头晕、站不稳、心跳异常；
- 严重便秘、排尿困难、视物模糊；
- 情绪明显恶化，出现自伤念头；

- 需要加用任何新药（包括感冒药、止痛药）之前。

立即去急诊或拨打 120

- 剧烈头痛、血压明显升高、心悸、视物模糊（可能是酪胺反应或高血压危象）；
- 高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识模糊（血清素综合征）；
- 晕厥、抽搐、严重心律失常；
- 药物过量，或有人误服了这些药；
- 有明确的自杀计划或已经伤害自己。

三环类过量可能在几小时内迅速恶化，不要在家观察。

常见问题

「老药是不是更伤身体？」 副作用确实更多，也需要更多监测。但在合适的人身上，它们可能带来新药给不了的改善。关键是「有人管、有监测」。

「MAOI 是不是一辈子不能吃奶酪？」 用药期间需要遵守饮食限制，停药后经过足够长的洗脱期可以恢复。具体范围由医生交代。

「医生建议转诊，是不是没救了？」 不是。转诊通常意味着需要更专业的评估和更复杂的方案，而不是放弃。

「能不能自己把两种药一起吃，效果更好？」 绝对不能。老药之间的相互作用可能很严重。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.8 起效、疗程、副作用与危险反应

吃上药之后，最折磨人的往往不是副作用本身，而是「不知道现在这样算正常还是异常」。这一页给出一条可对照的时间线：前两周会发生什么、四周该看什么、八周该评估什么；然后讲清哪些副作用可以观察、哪些必须报告、哪些是必须立刻去急诊的危险反应。它适合刚开始服药、正在加量、或者吃药后出现不适不知道要不要停药的人。

一条大致的时间线

不同药物起效速度不同，但抗抑郁类抗焦虑药（SSRI、SNRI 等）的节奏大体相似。下面这张表是「大致地图」，不是精确时刻表。

时间	常见发生的事	你该做什么
第 1–3 天	恶心、头晕、口干、困或睡不着	观察、记录，不急着下结论
第 1–2 周	副作用最明显，焦虑可能短暂加重	不自行停药，难受就联系医生
第 2–4 周	睡眠、食欲先有变化，焦虑开始松动	继续按医嘱，记录变化
第 4–8 周	疗效逐渐显现，可判断是否有效	复诊评估，讨论是否调整
第 8–12 周	多数人达到缓解	进入巩固期，不急着减药
数月到一年以上	维持治疗、预防复发	和医生一起决定维持多久

【指南】

需要强调：**「两周没感觉」是常见现象，不是失败。** 但「两周后越来越糟」也不是正常现象，需要报告。

怎么判断「有没有效」

不要只凭「今天心情好不好」下判断。更可靠的做法是看三个层面：

1. **症状强度**：担心是否还那么频繁？惊恐发作次数有没有减少？入睡时间有没有缩短？
2. **功能**：能不能上班、上学、出门、社交？回避的范围有没有缩小？
3. **主观痛苦**：同样的事情发生时，难受的程度有没有下降？

可以用 GAD-7 之类的量表每隔两三周自评一次，看趋势而不是看单次分数。分数下降几分不代表「好了」，分数没变也不代表「没用」，要结合功能一起看。

临床上常说的「有效」，通常指症状明显减轻（比如减轻一半左右）、功能恢复；「缓解」指症状基本消失、功能基本正常。这两个词不一样，治疗目标也不一样。

常见副作用：哪些可以观察，哪些要报告

副作用	常见程度	处理方向
恶心、腹泻、胃口差	很常见，早期明显	饭后服药，多数几周内减轻
头痛、头晕	常见	慢起身、多喝水，观察

副作用	常见程度	处理方向
口干、便秘	常见	补水、增加纤维，持续则报告
出汗增多	常见	注意补水，多数可耐受
困倦或失眠	常见，因人而异	和医生讨论服药时间
性功能影响	常见但少被提及	主动报告，有处理办法
体重变化	因人而异	记录体重，明显变化要报告
情绪变平	少数	如实报告，不要自己忍
坐立不安、手抖	需要留意	报告医生，可能需要调整加量速度
淤青、牙龈出血	需要留意	报告医生，尤其合并抗凝药时

【临床经验】

一个实用原则：**能忍、在减轻、不影响生活 → 观察；不能忍、在加重、影响生活 → 报告。** 但有三类例外，无论轻重都要报告：皮疹、情绪恶化、以及任何自伤念头。

需要立刻处理的危险反应

血清素综合征

这是 5-羟色胺过度活跃引起的药物不良反应，可能发生在加量、换药、合并其他 serotonergic 药物（包括曲马多、右美沙芬、圣约翰草、某些止吐药）时。

典型表现是三组症状同时或先后出现：

- **精神状态改变**：躁动、意识模糊、坐立不安；
- **自主神经不稳定**：高热、大汗、心跳快、血压波动；
- **神经肌肉异常**：肌肉僵硬、震颤、抽动、反射亢进。

这是急症，需要立即停药并急诊处理。 不要在家「观察一晚」。

严重过敏

- 皮疹迅速蔓延、瘙痒剧烈；
- 面部、嘴唇、舌头肿胀；
- 呼吸困难、喉咙发紧。

这些可能是严重过敏反应，立即呼叫 120。另外，有些药物会引起更隐蔽的过敏反应（如发热、淋巴结肿大、肝功能异常、大面积皮疹），出现「吃药后莫名其妙发烧、全身不舒服」也要报告。

QT 间期延长与心律失常

表现为心悸、头晕、晕厥、心跳不规则。有心脏病、电解质紊乱、同时在用其他延长 QT 药物的人风险更高。出现晕厥必须急诊。

低钠血症

多见于老年人、用利尿剂的人、大量饮水的人。表现：乏力、头痛、恶心、注意力不集中、走路不稳、意识模糊，严重时抽搐。需要查血钠。

出血

SSRI/SNRI 会让血小板聚集能力略降。合并抗凝药、抗血小板药、非甾体抗炎药时风险上升。表现：不明原因淤青、鼻血、牙龈出血、黑便、血尿。

转躁

如果既往有双相障碍，抗抑郁药可能诱发躁狂或轻躁狂：睡眠需求明显减少、话多、想法飞快、冲动消费、易怒。出现这些要立即联系医生。

自杀风险

治疗初期、加量期、以及情绪突然「变好」（有时是下定决心）时，风险可能上升。任何自伤念头都要认真对待，不要独自承受。

一张「危险信号」对照表

表现	可能是什么	该怎么办
高热、大汗、肌肉僵硬、意识模糊	血清素综合征	立即急诊，拨打 120
皮疹快速扩散、面唇肿胀、呼吸困难	严重过敏	立即急诊，拨打 120
晕厥、心跳不规则	心律失常、QT 延长	立即急诊
抽搐	低钠、戒断、癫痫	立即急诊
黑便、血尿、大片淤青	出血	当天就医
睡眠骤减、话多、冲动	转躁	尽快联系医生
自伤念头、计划	自杀风险	不要独处，急诊或 120

清单：用药期间的自我记录

- ☐ 每天一句：今天最难受的是什么、大概几点
- ☐ 每周一次：睡眠时长、焦虑对生活的影响（0–10 分）
- ☐ 每两周一次：GAD-7 自评，记录分数
- ☐ 记录漏服、补服、加量、换药的时间
- ☐ 记录同时吃的其他药、保健品、酒
- ☐ 记录出现的副作用和持续时间
- ☐ 复诊前把记录整理成一页纸

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或一两天内）

- 副作用明显加重，影响到吃饭、睡觉、上班；
- 焦虑或抑郁在用药后反而恶化；
- 皮疹、瘙痒、不明原因发热；
- 淤青、鼻血、牙龈出血变多；
- 持续呕吐腹泻、吃不下东西；
- 计划怀孕或发现怀孕。

立即去急诊或拨打 120

- 高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识模糊、心跳很快；
- 面部或喉咙肿胀、呼吸困难、皮疹迅速蔓延；
- 晕厥、抽搐、剧烈胸痛、心跳极快或不规则；
- 有自杀念头、计划或已经伤害自己。

不确定时按严重处理。**不要为了「等复诊」而耽误急症。**

常见问题

「副作用这么大，是不是药不对？」 不一定。早期副作用常见，多数会减轻。是否换药，要等医生评估，不要自己停。

「吃了两个月，好了一半，算有效吗？」 算部分有效，值得继续。要不要加量、联合心理治疗，由医生判断。

「症状消失了，能不能马上停？」 不能。症状消失通常意味着进入巩固期，过早停药复发风险高。

「能不能自己加一点，好得快些？」 不能。加量需要在医生指导下进行，尤其是三环类、苯二氮䓬类和普瑞巴林。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

6.9 停药、撤药与用药问答

停药是焦虑治疗里最容易出问题的一步：有人好了一点就急着停，结果几周后复发；有人停了之后头晕、心慌、睡不着，以为「病更重了」，其实是撤药反应；还有人担心「吃上就戒不掉」，一直不敢开始。这一页讲清撤药反应和复发的区别、缓慢减量的原则，然后用二十来个问答处理最常见的具体问题。所有减量方案都必须由医生制定，这一页只讲原则。

先分清：是撤药反应，还是复发

这是停药期最重要的一个判断。两者的表现可以很像，但处理方向完全不同。

对比项	撤药反应	复发
出现时间	停药或减量后数小时到数天	停药后数周到数月，也可能更久
起病速度	快，常常突然出现	相对渐近
典型表现	头晕、触电感、恶心、出汗、失眠、易怒、流感样症状	原来那种担心、回避、惊恐逐渐回来
与停药的关系	恢复原量或减量放缓后很快缓解	恢复原量后需要一段时间才见效
持续时间	通常一到两周，少数更久	不处理会持续或加重
提示	减得太快	需要重新治疗

【指南】

一个粗略的区分方法：**撤药反应「像感冒加电流」，复发「像回到从前」。** 但这只是经验，分不清时不要自己判断，记录下来给医生看。

缓慢减量：为什么不能快

抗抑郁药和苯二氮䓬类的减量，原则都是「慢」。

- 大脑已经适应了有药的状态，突然撤掉会出现反跳；
- 减得越急，撤药反应越重，越容易让人误以为「不能停」；
- 减到最后一段往往最难，因为受体适应需要时间；
- 苯二氮䓬类突然停还可能出现抽搐、意识混乱，属于医疗急症。

通常的做法是：在症状稳定一段时间后，和医生一起制定计划，把总量分成若干小步，每一步维持几周，观察反应再决定下一步。有些药需要换成作用时间更长的同类药来减少波动。**具体减多慢、减多久，取决于用药时长、剂量、药物种类和既往撤药史，没有通用数字。**

减量期间如果出现明显不适，正确的做法是联系医生调整节奏，而不是「自己恢复原量」或「硬扛过去」。前者打乱计划，后者可能演变成更严重的反应。

二十多个常见问题

关于停药

1. **感觉好了，可以自己停吗？**不建议。症状好转通常说明治疗有效，不说明病程结束。停药时机、方式需要单独评估，尤其是复发过的人。

2. **药要吃一辈子吗？**多数人不是。规范治疗是「足够长的维持期后，在医生指导下缓慢减停」。少数反复发作、残留症状明显的人需要更长维持，这是权衡后的选择，不是失败。

3. **停药需要多久？**没有统一答案。用了几个月和用了几年，减量节奏不同；半衰期短的药通常需要更慢。医生会给计划，不要自己按「一周减一半」之类的说法操作。

4. **为什么减到最后一点特别难？**因为身体已经适应，最后一段的变化比例相对更大。这时候更需要慢，而不是放弃。

5. **停药后复发了怎么办？**尽快联系医生，不要自己加回原来的量。复发通常需要重新评估治疗方案，而不只是「把药吃回去」。

6. **能不能隔天吃一次来减量？**隔天服药是医生可能采用的一种减量方式，但不适合所有药物（尤其是半衰期短的）。不要自己改成隔天吃。

关于漏服和日常

7. **漏服了一次怎么办？**想起来就补；如果已经接近下一次服药时间，跳过即可，不要一次吃双份。具体按医生或药师的交代。

8. **能不能喝酒？**不建议。酒精会加重焦虑、破坏睡眠、增加镇静和判断力下降，和镇静类药物同用还可能导致呼吸抑制。

9. **咖啡、浓茶、能量饮料呢？**咖啡因会加重心慌、手抖、失眠，尤其容易诱发惊恐。建议减量或避开下午以后。

10. **感冒了能不能吃感冒药？**先问医生或药师。部分感冒药含拟交感成分或右美沙芬，可能与抗焦虑药相互作用。MAOI 使用者尤其要严格。

11. **吃药期间能开车吗？**服药初期、加量后、以及用镇静类药物时，反应速度可能下降，建议避免或谨慎。个体差异大，以自己实际感受和医生建议为准。

12. **出差忘记带药怎么办？**不要自行用别的药替代，也不要突然停好几天。联系医生或药师，看能否就近取药或调整。

关于长期使用与成瘾

13. **会不会成瘾？**SSRI/SNRI 不产生典型成瘾（不会渴求、不会为「爽」而加量），但会有撤药反应。苯二氮䓬类有依赖和戒断风险，普瑞巴林也有滥用风险。不同药差别很大，不能一概而论。

14. **长期吃会不会伤肝伤肾？**多数药物在常规剂量下对肝肾功能影响有限，但需要定期复查，尤其是有基础肝病、肾病或合并多种药的人。真正需要担心的是「不监测」，而不是「吃药」本身。

15. **会不会让人变傻？**没有证据支持规范使用抗焦虑药会损伤智力。焦虑本身造成的注意力下降、记忆变差更常见，治疗好转后往往会改善。苯二氮䓬类长期使用可能影响记忆，这是限制其长期使用的原因之一。

16. **会不会吃了就「没有情绪」？**少数人会有情绪变平的感觉。这不是「药把人吃木了」的必然结果，出现时应该告诉医生，可能需要调整。

17. **能不能按需吃？**苯二氮䓬类在医生指导下可以按需使用（如惊恐发作时）；SSRI/SNRI 需要每天规律服用，按需吃没有意义。β 受体阻滞剂对表演焦虑可以按需。具体哪种能按需，问医生。

18. **能不能自己买来吃？**不能。抗焦虑药是处方药，需要评估诊断、共病、合并用药和风险。网购或代购的药品来源不明，风险更高。

关于特殊时期

19. **怀孕了要不要停药？**不要自己停。突然停药可能导致复发，而复发本身对母婴也有风险。需要精神科和产科一起权衡，讨论继续、调整还是减量。

20. **哺乳期能吃药吗？**部分药物进入乳汁的量较少，但是否用药要看药物种类、婴儿情况和母亲的病情。需要专科医生评估，不要自行决定。

21. **老年人用药要注意什么？**低血压、跌倒、低钠、认知影响、多重用药相互作用的风险都更高。用药宜简、宜慢，定期做用药梳理。

22. **青少年呢？**治疗初期要密切观察情绪、冲动和自伤念头的变化，家长需要参与。是否用药、用什么，需要专科评估。

清单：停药前和停药期间

- ☐ 确认自己处于稳定期，而不是「刚好一点」
- ☐ 和医生一起制定减量计划，写下来
- ☐ 知道每一步减多少、维持多久、出现反应找谁
- ☐ 记录撤药症状的出现时间和强度
- ☐ 不自行恢复原量，也不硬扛
- ☐ 减量期间保持心理治疗或至少保持练习
- ☐ 减量期间避免熬夜、大量咖啡因、酒精
- ☐ 停药后几个月内仍要观察复发信号
- ☐ 家里备着医生的联系方式

什么时候需要联系医生 / 去急诊

尽快联系医生（当天或一两天内）

- 减量后出现明显头晕、恶心、失眠、焦虑反跳；
- 情绪持续低落超过两周，或对什么都提不起兴趣；
- 原来已经消失的回避行为又回来了；
- 停药后睡眠明显变差，持续不缓解。

立即去急诊或拨打 120

- 停药或减量后出现抽搐、意识混乱、幻觉、高热；
- 严重焦虑伴胸痛、呼吸困难、晕厥；
- 有自杀念头、计划或已经伤害自己；
- 药物过量或误服。

苯二氮䓬类和酒精的戒断都可能危及生命，**不要自己硬戒**。

最后三句话

1. **停药不是意志力的考验，是一个需要计划的过程。**
2. **撤药反应不等于复发，但两者可能同时发生，判断交给医生。**
3. **「能不能停」和「什么时候停」是两个问题，先问前者，再问后者。**

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 7：物理与辅助治疗

呼吸、运动、睡眠、咖啡因这些“日常因素”会明显影响焦虑。这一模块讲哪些有证据、怎么落地、哪些被夸大。

7.1 呼吸训练与放松训练

这一页讲呼吸训练和放松训练到底能做什么、怎么做、什么时候会帮倒忙。适合经常心慌、胸闷、肌肉紧、睡不好的人，也适合被告知“多深呼吸”却越做越难受的人。读完你会明白过度换气为什么会让头晕加重、腹式呼吸和应用放松怎么练，以及哪些情况必须先去医院而不是先练呼吸。

一、呼吸和放松能帮什么，不能帮什么

呼吸和放松是焦虑管理里最常被提到的两件事，也是最容易被夸大的两件事。它们的作用是**降低身体的紧张水平、打断“越紧张越喘、越喘越慌”的循环、给你一个可执行的动作**，而不是“把焦虑治好”。【研究】

对轻度焦虑、考试或发言前的紧张、入睡困难、肌肉紧绷，呼吸和放松通常是有用的辅助。对惊恐障碍、广泛性焦虑（GAD）、社交焦虑，它们可以作为心理治疗的一部分，但单独使用往往不够。指南把 CBT、暴露、应用放松等列为治疗，而不是把“深呼吸”列为一线治疗。【指南】

需要先划清一条边界：**首次突发的胸痛、气短、晕厥，先排除躯体急症，不要先练呼吸。** 压榨性胸痛、胸闷伴大汗、呼吸困难、晕厥或接近晕厥、口唇发紫、心跳极快且不规律，可能是心脏或肺部急症，必须立即就医。已经确诊焦虑、反复出现类似症状的人，也应该在医生评估后，再把这些症状当作焦虑来处理。【指南】

还有一条常被忽略：呼吸训练不是“越深越好、越慢越好”。对某些人，尤其是对身体感觉高度敏感的人，刻意深呼吸反而会诱发头晕、发麻、胸闷，甚至触发惊恐。这不是你“练错了”，而是呼吸方式本身改变了血液中的二氧化碳水平。

二、过度换气：为什么“深呼吸”有时越做越晕

过度换气是指呼吸频率和深度超过身体需要，排出过多二氧化碳。血液偏碱后，脑血管收缩，人会出现头晕、手脚发麻、口周发麻、胸口发紧、视线模糊、心跳加快，严重时手脚抽搐。这些症状和惊恐发作几乎一样，所以很多人第一次发作时以为自己“缺氧”，于是更用力地大口吸气，结果越吸越晕。【研究】

这就解释了一个常见矛盾：别人劝你“深呼吸”，你照做后反而更慌。因为你本来就在过度换气，再加几个大口深吸，等于把二氧化碳压得更低。正确的方向不是“吸得更多”，而是**放慢呼气、减少大口喘气、让呼吸自然回落**。

治疗中的过度换气实验，是在专业指导下快速呼吸一小段时间，主动复制这些感觉，帮助患者理解“症状是呼吸造成的，不是器官坏了”。这个实验有教育价值，但不适合在家自行尝试，尤其是有心脏病、癫痫、哮喘、妊娠或血压控制不好的人。【指南】

惊恐发作时，可以记住三句话：

- 这是惊恐，不是心脏病；它会在几分钟内到顶，然后下来。
- 我不需要大口吸气，也不需要憋气；我把呼气放慢一点就好。
- 我把注意力放到脚底、手边的物体、房间里的声音上，允许这阵浪过去。

“不要对抗”不是放任，而是停止和身体摔跤。越命令自己“不能慌”，越容易把注意力锁在心跳上，形成二次恐慌。

三、腹式呼吸与慢呼吸：怎么做，什么时候不适合

腹式呼吸也叫膈式呼吸，重点是让横膈膜参与呼吸，而不是只抬肩膀、扩胸。可以用一个简单的练习找感觉：仰卧或坐直，一只手放胸口，一只手放腹部；吸气时让腹部的手轻轻抬起，胸口的手尽量少动；呼气时腹部自然回落。不要用力鼓肚子，也不要憋气。

慢呼吸则是把节奏放慢，尤其是把呼气拉长一点，让呼气比吸气稍长。具体多慢、多长，没有统一标准，以“不憋气、不头晕、能说话”为准。有人适合数拍子，有人适合跟着节律呼吸，有人用生物反馈设备辅助。关键是舒适，不是追求某种“标准频率”。【临床经验】

技术	主要目的	怎么做	注意
腹式呼吸	减少胸式浅快呼吸	一手放胸、一手放腹，吸气腹部轻起	不用力鼓腹，不憋气
慢呼吸	放慢节奏、延长呼气	呼气比吸气稍长，节奏舒适	过度放慢可能憋闷，头晕就停
过度换气实验	理解症状来源	专业指导下快速呼吸后停止	不自行尝试，有禁忌者先问医生
渐进性肌肉放松	识别并降低肌肉紧张	依次绷紧再放松肌群	抽筋、受伤部位跳过
应用放松	在焦虑情境中调用放松	先学会放松，再逐步在情境中练习	需要数周练习，不是一次就会

呼吸练习有几个不适合或需要调整的情况。

第一，哮喘、慢阻肺、肺纤维化等呼吸系统疾病患者，呼吸练习不能替代吸入药和规范治疗，练习方式要听呼吸科医生或康复治疗师的。

第二，妊娠期、严重贫血、心脏病、未控制的高血压患者，长时间屏气或过度用力可能不安全，应先咨询医生。

第三，惊恐障碍患者如果在练习中反复出现头晕、发麻，说明这项练习可能正在诱发内感受敏感，应该缩短时间、换方式，或改为在治疗师指导下进行。

第四，有创伤经历的人，闭眼静坐可能引发不适，可以睁眼、缩短时间、改做行走练习。

五分钟腹式呼吸练习

1. 找一个能坐稳的地方，背靠椅背，双脚踩地，不用躺下。
2. 一只手放胸口，一只手放腹部，先自然呼吸，观察哪只手动得多。
3. 尝试让腹部的手轻轻抬起，胸口的手尽量少动，不追求“吸满”。
4. 呼气时不用力挤，让气自然出去，可以比吸气稍长一点。
5. 走神时不用自责，发现后把注意力带回腹部的手。
6. 如果头晕、发麻、胸闷加重，立刻停止，恢复自然呼吸。
7. 每天练几分钟即可，不要在开车、游泳、洗澡时练。
8. 练完后记录一句：练前紧张几分，练后几分，有没有不舒服。

四、渐进性肌肉放松与应用放松

渐进性肌肉放松（PMR）由 Jacobson 提出，做法是依次绷紧一组肌肉几秒钟，再放松，体会“紧”和“松”的差别。常见顺序是：手和前臂、上臂、肩颈、面部、胸腹、大腿、小腿、脚。每个部位只绷到“有感觉”，不要绷到疼或抽筋；有关节损伤、肌肉拉伤、静脉血栓、近期手术的部位跳过。【研究】

PMR 的价值不只是“放松”，更是训练身体觉察。很多人长期肩颈紧、眉头皱、牙关咬，自己却不知道。通过对比，你能更早发现紧张，也就能更早处理。

应用放松（applied relaxation）是在 PMR 基础上发展出来的：先学会在安静环境里放松，再练习在越来越有挑战的情境中快速放松，比如想象焦虑场景、在人多的地方、在发言前。它的目标不是“永远放松”，而是“需要时能调用”。对 GAD 和惊恐障碍，应用放松有研究支持，NICE 指南将其列为可选的心理治疗之一。【指南】

应用放松通常需要数周到数月练习，不是听一次音频就会。它的顺序大致是：学会放松—在想象情境中放松—在真实低难度情境中放松—在真实高难度情境中放松。跳过前面的步骤直接“在演讲台上放松”，通常做不到，还会增加挫败感。

五、把练习放进日常：频率、时长与常见坑

呼吸和放松最容易被做成“应急才用”的工具：平时不练，发作时临时抱佛脚，结果因为太紧张而练不进去，得出“没用”的结论。更合理的做法是**平时规律练，发作时才有得用**。每天几分钟，比一周一次半小时更容易形成技能。【临床经验】

练习的时机也有讲究。不要在刚喝完咖啡、刚吵完架、刚做完剧烈运动时练，也不要在开车、操作机器、游泳、洗澡时练。睡前练放松可以帮助入睡，但如果练完更清醒，就改到白天。

常见的坑包括：

- **把放松当成任务**：越练越急，练不好就自责。放松不是考试，做不到就停。
- **过度深呼吸**：以为越深越好，结果头晕、发麻。呼吸要舒适，不是极限。
- **只在焦虑时练**：平时不练，发作时当然调用不出来。
- **用放松逃避暴露**：一紧张就躲进呼吸练习，反而不去面对该面对的场景。放松是工具，不是回避的借口。
- **忽略躯体疾病**：把新发的胸痛、气短当成“焦虑发作”练呼吸，延误就医。
- **依赖设备或音频**：离开 App 就不会放松。目标是脱离设备也能用。

呼吸和放松也不能替代运动、睡眠、药物和心理治疗。它们是拼图的一块，不是整幅图。如果焦虑已经明显影响工作、学习、睡眠或人际关系，应该考虑系统的心理治疗或药物治疗，而不是只靠“多呼吸”。【指南】

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊

- 首次突发剧烈胸痛、压榨感、胸闷伴大汗。
- 明显气短、喘不上气、口唇发紫。
- 晕厥、快要晕倒、意识模糊、抽搐。
- 心跳极快且明显不规律，伴胸闷或黑矇。

尽快联系医生

- 呼吸练习后反复出现严重头晕、发麻、胸闷，或练习诱发惊恐。
- 有哮喘、慢阻肺、心脏病、未控制的高血压、妊娠、严重贫血，想开始呼吸或屏气练习。
- 焦虑已经影响睡眠、工作、上学，单靠放松不够。
- 出现自杀念头、自伤行为，或酒精、镇静药使用问题。

常见问题与容易踩的坑

“深呼吸不是最安全的放松方法吗？” 对大多数人安全，但对正在过度换气的人，大口深呼吸可能加重头晕。重点是放慢呼气、自然呼吸，不是吸得越多越好。

“为什么我越练越焦虑？” 可能因为过度关注身体、呼吸节奏不合适，或练习诱发了内感受敏感。缩短时间、换方式，必要时找治疗师。

“放松训练能替代吃药吗？” 不能一概而论。轻度焦虑可能靠心理治疗和生活方式改善；中重度通常需要综合治疗。不要自行减药或停药。

“每天要练多久？” 没有统一标准。从几分钟开始，能坚持比时长更重要。具体安排可以和治疗师商量。

家属可以做什么？ 不要在旁边催“你放松啊”“别紧张”，这会让对方更紧张。可以帮忙关掉干扰、陪着散步，或者安静地待着。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NIMH. Anxiety Disorders：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- WHO. Anxiety disorders fact sheet：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.2 生物反馈与心率变异性训练

这一页讲生物反馈是什么、心率变异性（HRV）训练有没有证据、家用设备怎么选、哪些人反而不适合。适合对“用设备训练身体”感兴趣的人，也适合已经被各种手环、App 的“压力值”搞得越来越紧张的人。读完你能分清临床生物反馈和消费级设备的差别，知道它在一个完整治疗方案里的位置。

一、生物反馈是什么：把看不见的生理信号变成看得见

生物反馈（biofeedback）是把身体里原本感觉不到的生理信号——心跳、呼吸、肌肉张力、皮肤温度、出汗——用仪器测出来，实时变成屏幕上的曲线、声音或颜色，让你看到自己当下是什么状态，再尝试用呼吸、放松、注意力去影响它。【研究】

它背后的逻辑是学习，而不是治疗本身。就像照镜子能帮你调整姿势，反馈能帮你发现“原来我一紧张就屏气”“原来我肩膀一直耸着”。当你能看到变化，就更容易学会自主调节。治疗师的角色是设置任务、解释数据、防止你“越练越较劲”。

生物反馈通常不是单独使用，而是作为 CBT、放松训练或 HRV 训练的辅助。它也不能替代药物或其他治疗。对焦虑障碍，研究显示生物反馈可能有助于降低紧张、改善睡眠和情绪，但研究规模总体偏小，效果不如 CBT 稳定，指南通常不把它列为一线。【研究】

一个常见的误会是“设备能测出我有多焦虑，所以它能诊断我”。不能。消费级设备测的是脉搏、皮温、体动等间接指标，受咖啡、睡眠、运动、环境温度、皮肤颜色、佩戴松紧影响很大，不能用来诊断焦虑障碍，也不能用来排除心脏病。

二、常见类型：肌电、皮温、皮电、呼吸与心率变异性

类型	测什么	常见用途	局限
肌电反馈	肌肉电活动	放松训练、紧张性头痛、肩颈紧	电极位置影响大，出汗会干扰
皮温反馈	指尖温度	放松、外周循环	室温、手部活动影响明显
皮电反馈	皮肤出汗导致的导电变化	唤醒度、紧张监测	受情绪、咖啡、环境湿度影响
呼吸反馈	呼吸频率、胸腹起伏	慢呼吸、过度换气矫正	绑带松紧和姿势会影响读数
HRV 反馈	相邻心跳间隔的变化	压力管理、自主神经调节	心律不齐、房颤时读数不可靠

这些类型里，最容易在家庭场景落地的是呼吸反馈和 HRV 反馈，因为手机、手环、胸带都能测。肌电和皮电更常在诊所或治疗师指导下使用。

HRV 是什么？简单说，就是每次心跳之间的间隔并不完全一样，而是随呼吸、情绪、体位小幅变化。一般来说，间隔变化较丰富，说明自主神经调节较灵活；变化很少，可能与压力、疲劳、疾病有

关。但 HRV 不是“越高越好”的单一指标，它受年龄、性别、体能、睡眠、药物、疾病影响很大，正常人之间差异也很大。【研究】

所以，看到手环上的“HRV 偏低”不必惊慌，看到“偏高”也不代表没有焦虑。单次读数说明不了什么，趋势才有一定参考价值，而且趋势也要结合你的感受和生活事件来看。

三、HRV 训练：证据、合理期待与怎么做

HRV 训练（也叫 HRV 生物反馈）通常的做法是：佩戴能测心跳的设备，跟着屏幕上的节律放慢呼吸，让呼吸和心跳产生较好的同步，然后观察 HRV 曲线的变化。目标是学会在压力下也能主动放慢节奏、恢复平衡。【研究】

关于证据，可以说得谨慎一些。HRV 生物反馈对压力、考试焦虑、部分焦虑症状有一些随机对照试验支持，结果多为小到中等程度的改善；但研究样本通常不大，干预方式、次数、对照条件差异也大，长期效果还不确定。【研究】 对惊恐障碍、社交焦虑、GAD，它不是一线治疗，更多作为辅助或放松训练的一种形式。【指南】

合理的期待是：它可能帮你更快学会放松、增加对身体状态的觉察、在压力下有东西可做；它不太可能单独“治好”焦虑障碍，也不应该替代暴露、认知工作或药物。

怎么做才不容易走偏？

第一，先学“不用设备也能放松”。如果离开屏幕就完全不会，说明你依赖的是设备，不是技能。

第二，呼吸要舒适。放慢到不憋气的节奏，呼气可以稍长；不要为了追求曲线好看而过度深呼吸，否则可能头晕、发麻，甚至诱发惊恐。

第三，时间短、频率稳。每天几分钟到十几分钟，比偶尔一次半小时更容易坚持。

第四，看趋势，不看单次。今天 HRV 低，可能只是没睡好、喝了咖啡、感冒了。

第五，不追求“完美曲线”。曲线起伏是正常的，越想控制越紧张。

开始 HRV 训练前的核对清单

1. 我是否已经由医生评估过焦虑症状，排除了需要优先处理的躯体问题？
2. 我有心律不齐、房颤、起搏器吗？如果有，先问医生这类设备读数是否可靠。
3. 我是否在用 β 受体阻滞剂或其他影响心率的药？药物会改变读数，需结合医嘱理解。
4. 我是否有“反复检查身体”的倾向？如果是，天天盯着 HRV 可能加重焦虑。
5. 我是否把它当成唯一手段？如果是，先补上心理治疗、运动、睡眠等基础。
6. 我是否愿意每天花几分钟、坚持几周，而不是练两次就下结论？
7. 我是否知道设备读数不能用于诊断，也不能替代就医？
8. 我是否有一个可以讨论数据的治疗师或医生，而不是自己瞎猜？

四、设备怎么选：临床设备、消费级设备与手机 App

设备类型	优点	局限	适合谁
临床生物反馈仪	多通道、精度较高、有治疗师解读	价格高、需机构使用	诊所、医院、康复机构
胸带式心率传感器	测心跳较准，适合 HRV	佩戴麻烦，价格中等	想认真做 HRV 训练的人
手环/手表	方便、能看趋势、有呼吸引导	光学测量受肤色、佩戴、运动影响	日常监测、轻度压力管理
手机 App（摄像头/指尖）	便宜、易上手	精度有限，易受动作干扰	初学者、偶尔练习
家用放松仪（皮温/肌电）	直观、反馈简单	功能单一，可能需要电极	放松训练入门

选设备时，先问自己“我买它是为了什么”。如果是为了日常提醒自己放慢呼吸，手环或 App 够了；如果是为了系统训练 HRV，胸带的读数通常更可靠；如果是为了治疗焦虑，设备只是辅助，真正起作用的是治疗关系和练习，不是设备本身。

消费级设备有几个共同问题：光学心率在手指冰冷、出汗、深色皮肤、佩戴松时容易失真；HRV 算法各家用得不一样，数值不能跨设备比较；有些 App 用“压力分数”“身体年龄”之类的话术制造焦虑，甚至推销课程。买之前看清是否一次性买断、是否有隐私政策、是否会收集健康数据。

五、适用人群、风险与就医边界

生物反馈和 HRV 训练可能适合这样的人：喜欢结构化练习、需要看得见的反馈；容易屏气、肩颈紧，但不太能觉察；正在做 CBT，想多一个放松工具；工作压力大、睡眠浅，想学自我调节。【临床经验】

不太适合或需要谨慎的人：有严重心律不齐、房颤、起搏器，读数可能不可靠；有健康焦虑、强迫检查倾向，频繁看数据可能加重；把设备当“护身符”，离开就恐慌；期待“几次训练根治”，不愿意做暴露和认知工作；儿童青少年需要在成人陪同下使用，避免把数值当成成绩。

还有一个现实风险：**设备可能变成新的安全行为**。比如必须戴着设备才敢出门，或者一看到“压力高”就立刻停下所有活动。判断标准很简单：如果你越来越依赖它、活动范围越来越小，那它就在帮倒忙，应该和治疗师讨论怎么撤掉。

生物反馈不能替代精神科评估。首次出现的胸痛、气短、晕厥，不能靠“HRV 看起来还行”来排除；心律失常的诊断要靠心电图、动态心电图等医学检查，不是手环。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊

- 首次突发剧烈胸痛、气短、晕厥。
- 心跳极快且明显不规律，伴胸闷、黑矇或出汗。
- 意识模糊、抽搐、严重过敏。

尽快联系医生

- 有已知心律失常、起搏器，想开始 HRV 训练。
- 训练后反复头晕、发麻、胸闷，或诱发惊恐。
- 发现自己必须依赖设备才能出门、睡觉。
- 因为看设备数据而越来越焦虑，反复检查身体。
- 焦虑已经影响工作、学习、睡眠，单靠设备不够。

常见问题与容易踩的坑

“HRV 越高说明我越健康吗？” 不能简单这么说。HRV 受年龄、体能、睡眠、药物、疾病影响，正常范围很宽，单次数值参考意义有限。

“手环测的 HRV 准吗？” 日常看趋势可以，但不能当医学指标。光学测量在手指冷、出汗、佩戴松时容易失真。

“生物反馈能替代药物吗？” 不能。它是辅助手段，是否减药要由医生决定。

“为什么我越练越紧张？” 可能太在意曲线、呼吸过度用力，或把设备当成了必须完成的考试。缩短时间、放宽标准，必要时找治疗师。

“孩子能用吗？” 可以，但要在成人陪同下，避免把数值当成绩，也要先排除躯体问题。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NIMH. Anxiety Disorders：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- WHO. Anxiety disorders fact sheet：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.3 运动处方

这一页讲运动对焦虑的作用、怎么安排有氧和力量、为什么建议“从十分钟开始”，以及惊恐障碍患者运动时要避开哪些坑。适合想靠运动改善情绪却不知道怎么开始的人，也适合一运动就心慌、于是干脆不动的人。读完你能给自己排一个可执行、不过量的起步计划，也知道运动在治疗里排第几位。

一、运动为什么能帮焦虑：证据与边界

规律运动对焦虑症状有小到中等程度的改善作用，这一点在多项随机对照试验和系统综述中有支持。有氧运动、力量训练、瑜伽、太极等都可能有用，其中研究最多的是中等强度有氧运动。【研究】

运动起作用的途径可能是多方面的：降低交感神经兴奋、改善睡眠、增加自我效能感、转移注意力、提供社交机会，也可能影响与情绪调节有关的神经递质和神经营养因子。具体机制还没有完全弄清楚，但这不影响“动起来确实可能有用”这个结论。【研究】

不过，运动不是万能药。它的效果通常温和到中等，研究质量参差不齐，很多试验样本小、随访短；对中重度焦虑，运动不能替代 CBT 或药物，只能作为辅助。【指南】 把运动说成“比吃药还管用”“跑跑步就好了”，既不准确，也可能让需要治疗的人延误就诊。

运动还有一层特殊价值：它帮你重新建立“身体感觉不等于危险”的经验。心慌、出汗、喘，在运动中是正常的；反复经历“心跳快但我没事”，对惊恐障碍患者是一种学习。但这个学习需要设计，不能变成“硬扛到发作”。

二、有氧与力量：怎么搭配

有氧运动指持续、节律性、以大肌群参与为主的活动，比如快走、慢跑、骑车、游泳、跳绳、跳舞、爬楼。力量训练指对抗阻力的练习，比如自重深蹲、俯卧撑、弹力带、哑铃、器械。两者对焦虑都可能有益，搭配起来更全面。【研究】

类型	例子	建议频率	强度与注意
中等强度有氧	快走、骑车、游泳、跳舞	多数天，累计每周较长时间	能说话但不能唱歌，微微出汗
较高强度有氧	跑步、间歇训练、球类	每周少量，循序渐进	心肺负担大，新手不急着上
力量训练	自重、弹力带、哑铃、器械	每周两到三次，隔天练	动作标准优先，不憋气
柔韧与身心练习	拉伸、瑜伽、太极	每周多次	放松为主，不追求难度
日常活动	走路通勤、做家务、爬楼	每天	累积起来也算

对大多数成年人，公共卫生建议是每周累计较长时间的中等强度有氧，或较短时间的较高强度有氧，加上每周两次力量训练。这个范围是健康底线，不是“焦虑处方”。对焦虑患者，起步量可以远低于这个标准，先建立习惯，再逐步增加。【指南】

有氧和力量不必同一天做。可以这样安排：周一快走，周二力量，周三休息或拉伸，周四快走，周五力量，周六轻松活动，周日休息。具体怎么排，看你的时间、体能和喜好。能坚持下去的安排，比“最优但做三天就放弃”的安排更好。

三、频率、强度与“从十分钟开始”

焦虑患者开始运动，最常见的失败不是“不够努力”，而是“一上来太猛”。第一天跑五公里，第二天腿疼、心慌，于是得出结论“运动不适合我”。更稳的做法是**从十分钟开始**，先让身体和大脑习惯“运动是安全的”。【临床经验】

十分钟可以做什么？快走十分钟、原地踏步十分钟、骑车十分钟、跟练十分钟的低强度操。第一周只要求“每天动十分钟”，不要求强度，不要求出汗。第二周如果顺利，加到十五到二十分钟，或每周加一两次。一个月后再考虑增加强度或时长。

强度怎么判断？最简单的“说话测试”：中等强度时你还能说完整句子，但不能唱歌；高强度时说几个字就要喘。也可以用自觉用力程度打分，0 到 10 分里，中等强度大约在“有点吃力但能坚持”的范围。不要一上来就冲到最大心率，也不要迷信手环上的“燃脂区间”。【临床经验】

“从十分钟开始”还有一层心理意义：它降低了开始的门槛。焦虑的人常有一种“要么做到最好、要么不做”的思维，运动计划太大会直接触发拖延。十分钟小到无法拒绝，反而更容易形成习惯。

第一周起步清单

1. 选一种你过去不反感、场地方便的活动，比如快走或骑车。
2. 把时间定在每天固定的时段，比如午饭后或下班后。
3. 第一周每天只做十分钟，不做额外加量。
4. 运动前做两三分钟热身，活动踝、膝、肩。
5. 运动中能说完整句子，不追求大汗淋漓。
6. 运动后记录：做了几分钟、感觉如何、有没有心慌。
7. 如果某天没做，不补课、不自责，第二天继续。
8. 一周后回顾：什么时候最容易坚持？要不要换时间或地点？

四、惊恐障碍患者的运动注意

运动会带来心跳加快、呼吸变急、出汗，这些感觉和惊恐发作很像。对惊恐障碍患者，这既是机会也是风险。

机会在于：在安全、可控的条件下反复经历这些感觉，可以帮助大脑学习“心跳快不等于心脏病”。这本质上是一种内感受暴露，只不过用的是运动而不是刻意过度换气。【研究】

风险在于：如果运动强度一下子太大，或者在偏僻、无人、炎热的地方运动，可能真的诱发惊恐，甚至因为害怕而彻底放弃运动。更麻烦的是，有些人开始回避运动，而回避会让体能下降，稍微一动就心慌，形成新的恶性循环。

所以，惊恐障碍患者运动时可以注意几点。

- 先从低强度、短时间开始，让身体逐渐适应。
- 选择安全、熟悉、容易求助的场地，比如小区、操场、健身房。
- 不在空腹、极度疲劳、酒后、发热时运动。
- 运动中如果心慌，先放慢速度、调整呼吸，观察几分钟；不要立刻停下蹲下，也不要大口猛吸气。
- 把“心跳快”解释为运动反应，而不是灾难信号；如果每次都恐慌，可以和治疗师讨论把运动纳入暴露计划。
- 不要用运动作为唯一的应对方式，也不要在发作时强行加大运动量“压过去”。

需要区分的是：运动诱发的胸闷、胸痛、晕厥，尤其首次出现、伴大汗、放射痛、口唇发紫，不能按“惊恐”处理，要立即就医。已经确诊冠心病、心肌病、严重心律失常、未控制的高血压的人，运动计划要先经医生评估。【指南】

五、运动不能替代治疗：特殊人群与就医边界

运动是辅助，不是替代。对轻度焦虑，规律运动可能带来明显改善；对中重度焦虑，通常需要心理治疗、药物或两者联合，运动作为基础支持。把运动当成“不吃药的理由”，或者因为开始运动就自行减药，都是不安全的。【指南】

特殊人群需要额外注意。

- **心血管病、高血压、糖尿病**：运动前咨询医生，避免突然剧烈运动，注意监测血压、血糖。
- **哮喘**：避免在寒冷干燥、空气污染重的环境剧烈运动，随身带急救药。
- **妊娠期**：选择低冲击活动，避免仰卧过久、过热、跌倒风险高的运动，具体听产科医生。
- **老年人**：优先平衡、力量、柔韧训练，预防跌倒，避免无人陪伴下高强度运动。
- **进食障碍**：运动可能被用来补偿进食，需要与治疗团队讨论，避免过度运动。
- **儿童青少年**：以游戏、球类、骑车等有趣活动为主，不强调体重和外形。

过度运动也是一个风险。如果运动变成强迫、停不下来、受伤还继续、用运动抵消进食，或者一天不练就极度焦虑，那就不是“健康习惯”，需要寻求帮助。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊

- 运动中出现压榨性胸痛、胸闷伴大汗、放射到左臂或下颌的疼痛。
- 晕厥、快要晕倒、意识模糊、抽搐。

- 明显气短、喘不上气、口唇发紫。
- 心跳极快且明显不规律，伴胸闷或黑矇。

尽快联系医生

- 有心脏病、未控制的高血压、糖尿病、哮喘，想开始新的运动计划。
- 运动中反复心慌、胸闷，休息后不缓解。
- 因为怕发作而完全不敢运动，或运动后焦虑明显加重。
- 运动变成强迫行为，受伤或生病仍停不下来。
- 焦虑已经影响工作、学习、睡眠，单靠运动不够。

常见问题与容易踩的坑

“运动是不是越多越好？” 不是。过量运动增加受伤、疲劳和心脏风险，也会挤占睡眠和恢复。规律、适度、能坚持更重要。

“我一运动就心慌，是不是心脏有问题？” 不一定。运动本身会让心跳加快。但如果是首次、伴胸痛或晕厥，必须先就医；已确诊焦虑的人，可以从低强度开始，必要时和治疗师一起设计。

“必须去健身房吗？” 不必。快走、爬楼、在家跟练、骑车通勤都算。能融入日常的活动更容易坚持。

“运动能代替吃药吗？” 不能一概而论。轻度可能有帮助，中重度通常需要综合治疗。不要自行减药或停药。

“没时间怎么办？” 从十分钟开始，拆成两段五分钟也行。关键不是一次做多久，而是每周有没有动。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders
- NIMH. Anxiety Disorders：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.4 睡眠、咖啡因、酒精与尼古丁

这一页讲四件每天都在影响焦虑的事：睡眠、咖啡因、酒精和尼古丁。适合睡不好、靠咖啡撑白天、靠酒放松、靠烟缓解紧张的人，也适合想帮家人调整却不知道从哪下手的人。读完你能看清它们和焦虑的双向关系，知道怎么安全地减，也清楚哪些戒断反应必须去医院。

一、失眠与焦虑：双向关系

失眠和焦虑常常互为因果。焦虑让人躺下后停不下想，入睡变难、夜里易醒、早醒后再也睡不着；睡不好又让第二天更容易紧张、注意力差、脾气急，于是更担心“今晚又睡不着”，形成对睡眠的焦虑。【指南】

这种“对睡不着的担心”本身会让人更清醒。越看表、越算还能睡几小时、越命令自己“快睡”，越睡不着。很多人因此开始提前上床、白天补觉、周末睡到中午，这些做法短期舒服，长期会打乱睡眠节律，让晚上更难睡。

判断失眠是否值得处理，不只看“睡了几小时”，还要看白天功能：是否疲惫、注意力下降、情绪不稳、工作学习受影响。如果只是偶尔一两晚没睡好，不必过度反应；如果持续较长时间、每周多晚、明显影响白天，应该评估。

失眠的治疗不是“多吃安眠药”。对慢性失眠，CBT-I（失眠的认知行为治疗）是一线治疗，效果通常比单纯吃药更持久。【指南】 具体包括：固定起床时间、限制卧床时间、睡不着就离开床、减少白天补觉、纠正“必须睡够八小时”的灾难化想法、放松训练。听起来简单，做起来需要指导，尤其是睡眠限制，不是所有人都适合自己操作。

二、咖啡因：最容易被低估的加重因素

咖啡因存在于咖啡、浓茶、奶茶、可乐、能量饮料、部分巧克力和某些感冒药、止痛药里。它让人警觉、提神，也会加快心跳、升高血压、加重手抖和焦虑。对焦虑患者，咖啡因可能是“每天在给自己加一点油”。【研究】

咖啡因的半衰期个体差异很大，有人下午一杯咖啡，晚上还睡不着；有人代谢快，影响小。年龄、肝功能、吸烟、口服避孕药、某些药物都会改变代谢速度。很多人不觉得自己“喝得多”，但一天几杯茶、一瓶可乐、一罐能量饮料，加起来并不少。

咖啡因的影响不只是入睡难，还包括：心跳快、心慌、手抖、烦躁、胃部不适、夜间易醒、早醒。这些症状和焦虑高度重叠，容易被误认为“病情加重”。如果减少咖啡因后症状减轻，说明它至少是部分原因。

减咖啡因要慢慢来。突然停可能引起头痛、疲劳、注意力下降、烦躁，通常几天到一两周缓解。可以这样做：先记录每天喝了什么、多少、什么时间；把下午和晚上的含咖啡因饮料换成无咖啡因的；每次只减一杯，观察几天；用低因咖啡过渡；注意奶茶、能量饮料、可乐这些“隐形来源”。【临床经验】

物质	对焦虑/睡眠的影响	减量方法	注意
咖啡因	心慌、手抖、入睡难、夜醒、烦躁	逐杯减少，下午改低因	突然停会头痛、疲劳
酒精	先放松后反弹，夜醒、早醒、焦虑加重	记录、减量、设无酒日	依赖者不能自行硬戒
尼古丁	戒断时焦虑、易怒、注意力差	设戒烟日，用替代疗法或求助	电子烟同样含尼古丁
安眠药	短期助眠，长期耐受、依赖、跌倒	医生指导下减量	不自行加量或混用

三、酒精：先松后紧的陷阱

酒精常被当作“社交润滑剂”或“睡前放松剂”。刚喝下去时，它确实能降低紧张、让人话多、容易入睡。但几个小时后，酒精代谢会产生“反跳”：心跳加快、出汗、焦虑升高、睡眠变浅、夜醒增多。于是第二天更累、更紧张，晚上又想喝一点，形成循环。【研究】

长期饮酒会扰乱睡眠结构，让深睡减少、早醒增多；会加重焦虑和抑郁；会影响抗焦虑药、抗抑郁药的代谢和副作用；大量饮酒还可能引起血压升高、心律失常、肝损伤。用酒助眠，往往越用越多，效果越来越差。

更危险的是戒断。长期大量饮酒的人突然停酒，可能出现手抖、出汗、心慌、失眠、恶心，严重时出现幻觉、抽搐、意识模糊（震颤谵妄），可能危及生命。**不能自行硬戒。** 如果已经形成依赖，应该在医生指导下逐步减量或住院处理。【指南】

如果只是社交场合偶尔喝，想减少，可以设“无酒日”、用小杯、交替喝水和无酒精饮料、提前想好拒绝的话、避免空腹喝。如果发现自己“不喝就难受”“越喝越多”“答应自己少喝却做不到”，建议找医生或专业机构评估。

四、尼古丁与电子烟：越抽越焦虑

很多人觉得抽烟能缓解紧张，因为吸烟的动作和尼古丁的即时作用确实带来短暂放松。但尼古丁成瘾后，不抽烟时会出现戒断症状：焦虑、烦躁、注意力不集中、坐立不安、睡眠差。于是“抽烟缓解焦虑”其实是“缓解了尼古丁戒断带来的焦虑”。【研究】

长期看，吸烟与焦虑障碍相关，戒烟后焦虑和抑郁症状通常会改善，虽然戒烟初期可能暂时加重。电子烟同样含尼古丁，也有成瘾和呼吸道刺激问题，不是“无害替代”。【研究】

戒烟不容易，但可以借助方法：设定戒烟日、清理烟具、告诉家人朋友、识别触发场景（饭后、喝酒、压力大）、用尼古丁替代疗法或处方药（需医生指导）、参加戒烟门诊或热线。戒烟期间焦虑加重是常见的，通常几周内缓解；如果情绪明显低落或出现自杀念头，要及时求助。

五、CBT-I 与减量方法：怎么改，什么时候就医

睡眠、咖啡因、酒精、尼古丁这四件事，改起来都不靠“意志力硬扛”，而靠记录、逐步调整和环境设计。

先说睡眠。CBT-I 的核心不是“努力睡”，而是重建“床=睡觉”的联结和稳定的睡眠节律。常用做法包括：

- 固定起床时间，哪怕前一晚没睡好，也尽量按时起。
- 只有困了才上床，不在床上玩手机、工作、吃东西。
- 躺下较长时间睡不着，就起来到昏暗处做安静的事，困了再回床。
- 减少白天补觉，尤其避免傍晚补觉。
- 睡前留出“降速”时间，关灯前不处理工作、不刷刺激性内容。
- 纠正“必须睡够八小时”“睡不好明天就完了”这类想法。

睡眠限制是 CBT-I 的一部分，但需要专业指导，不是所有人都适合。有双相障碍、癫痫、妊娠、倒班或需要高度警觉工作的人，不要自行做睡眠限制。【指南】

睡前降速清单

1. 睡前一段时间停止处理工作消息和激烈讨论。
2. 把手机放到够不到的地方，或至少开启勿扰模式。
3. 调暗灯光，做几分钟慢呼吸、拉伸或安静的阅读。
4. 把明天担心的事写在纸上，告诉自己“留到白天处理”。
5. 只有困了才上床；躺下一段时间睡不着，就起来到昏暗处待着。
6. 夜里醒来不看表、不算还能睡多久，尽量不看手机。
7. 第二天尽量固定时间起床，不靠周末长时间补觉。
8. 白天实在困，可以短时休息，但避免睡到傍晚。

再说减量。咖啡因、酒精、尼古丁都不要“一刀切”。咖啡因逐杯减，酒精依赖者必须医学监督，尼古丁可以用替代疗法。减量期间记录症状和情绪，给自己几周时间，不要因为一两天反复就放弃。

目标	第一周做什么	第二周做什么	注意
减少咖啡因	记录所有来源，下午改低因	每天少一杯，观察头痛	头痛明显可放慢
减少酒精	记录饮酒量，设两天无酒日	无酒日增加到三天	依赖者先就医
戒烟	定戒烟日，清理烟具	用替代疗法，避开触发场景	情绪低落要求助
改善睡眠	固定起床时间，睡前降速	睡不着就离床，减少补觉	睡眠限制需指导

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊

- 大量饮酒后突然停酒，出现抽搐、幻觉、意识模糊、高热。
- 出现自杀念头、自伤行为。
- 混用酒精、安眠药或镇静药后意识模糊、呼吸变慢、呕吐不止。
- 首次突发剧烈胸痛、气短、晕厥。

尽快联系医生

- 持续失眠明显影响白天功能，或安眠药越吃越多。
- 已经形成酒精依赖，想减量或戒酒。
- 戒烟后情绪明显低落、焦虑加重，或有自杀念头。
- 咖啡因减量后头痛、心慌持续不缓解。
- 焦虑合并睡眠问题、物质使用，需要综合评估。

常见问题与容易踩的坑

“睡前喝点酒不是更好睡吗？” 入睡可能变快，但后半夜睡眠变浅、早醒、反跳焦虑更明显，长期得不偿失。

“咖啡因戒断要多久？” 因人而异，常见头痛、疲劳、烦躁，通常几天到两周缓解。逐步减比突然停舒服。

“电子烟能帮助戒烟吗？” 它不是无害的，是否作为过渡工具需要结合个人情况和医生建议，不要同时抽两种。

“失眠一定要吃药吗？” 不一定。慢性失眠一线是 CBT-I。药物有适用场景，但需要医生评估，不宜长期自行使用。

“少睡一点是不是就能不焦虑？” 不是。睡眠不足会加重焦虑和情绪不稳。目标是稳定节律，不是压缩睡眠。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders
- NIMH. Anxiety Disorders：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.5 营养补充、中医与物理治疗证据

这一页把镁、omega-3、草本、中成药、针灸、经颅磁刺激（rTMS）和经颅直流电刺激（tDCS）放在一起，讲清楚哪些有一点证据、哪些被夸大、哪些有真实风险。适合已经在吃保健品、被推荐针灸或物理治疗、又怕和药物冲突的人。读完你能判断一个说法靠不靠谱，也知道怎么和医生沟通，而不是自己停掉规范治疗。

一、为什么这类信息最容易踩坑

焦虑让人想“做点什么”，而补充剂、草本、针灸、物理治疗正好提供了“看起来无害、又能自己掌控”的选项。问题在于，这个领域的信息质量参差不齐：小样本研究被说成“科学证实”，动物实验被说成“临床有效”，个案被说成“根治”，带货软文把“可能有用”写成“一定要试”。【待验证】

判断一条信息，可以先问五个问题：研究是人还是动物？样本多大？有没有对照组？结果是“焦虑评分下降一点”还是“临床痊愈”？谁出钱做的？如果答不上来，先别掏钱。

还要记住两条底线。第一，任何补充剂和物理治疗都不能替代规范的药物和心理治疗；第二，任何“纯天然”都不等于“无副作用”，更不等于“不会和西药冲突”。【指南】

二、营养补充：镁、omega-3、维生素 D 与其他

镁参与神经和肌肉兴奋性调节，缺镁可能引起肌肉抽动、疲劳、失眠。有小型研究提示镁补充可能对轻度焦虑、经前期紧张有帮助，但证据有限，研究质量不高。【研究】 常见副作用是腹泻、腹痛；肾功能不全的人过量补镁有风险；镁还可能影响某些抗生素、甲状腺药、双膦酸盐的吸收，需要错开时间。把镁说成“天然镇静剂”“焦虑克星”，是夸大。

omega-3 脂肪酸（鱼油中的 EPA、DHA）对心血管和情绪有一定研究，但对焦虑障碍的效果研究结果不一致，部分试验显示小幅改善，部分没有差异。【研究】 常见问题是鱼腥味、胃部不适；与抗凝药、抗血小板药同用可能增加出血风险；对鱼类过敏的人要避免。它不能替代抗抑郁药。

维生素 D 缺乏与情绪问题相关，但“补维生素 D 治焦虑”没有可靠证据。更合理的做法是：有缺乏风险的人（少晒太阳、老年人、深色皮肤、肥胖、某些疾病）检测后按医生建议补充，而不是把大剂量维生素 D 当安神药。【研究】

复合维生素、氨基酸、益生菌、S-腺苷甲硫氨酸（SAMe） 等，证据更弱或研究更初步。SAMe 有潜在的情绪激活作用，与抗抑郁药同用可能增加血清素相关风险；益生菌对焦虑的影响还在研究阶段。不要把“调节肠道菌群”“平衡神经递质”这类广告词当成疗效证明。【待验证】

干预	证据情况	主要风险	建议
镁	小样本，效果有限	腹泻、肾功能不全者风险、药物相互作用	先查是否缺乏，和医生核对用药

干预	证据情况	主要风险	建议
omega-3	结果不一致，可能小幅改善	胃部不适、出血风险	不替代药物，抗凝药使用者先问医生
维生素 D	缺乏者补充有益，治焦虑证据不足	过量可致高钙血症	检测后按医嘱补，不自行大剂量
圣约翰草	对轻度抑郁有一些证据	肝损伤、光敏、大量药物相互作用	与抗抑郁药同用风险高，必须问医生
卡瓦	小型研究提示可能缓解焦虑	肝损伤风险，已有相关警告	不建议自行长期使用
缬草、西番莲	证据弱且不一致	嗜睡、胃肠不适	不作为首选，注意与镇静药叠加

三、草本、中成药与中医：证据、肝损伤与相互作用

圣约翰草（贯叶连翘） 是研究相对较多的草本之一，对轻度到中度抑郁有一些证据，对焦虑的证据较弱。它的问题是**药物相互作用**：会诱导肝药酶，降低多种药物浓度，包括部分抗抑郁药、抗凝药、口服避孕药、免疫抑制剂、抗癫痫药等；与 SSRI 同用还可能增加血清素综合征风险。【研究】 吃之前必须让医生或药师核对全部用药。

卡瓦（kava） 有一些小型试验提示可能缓解焦虑，但存在肝损伤报告，多个国家对其有警告或限制。【研究】 有肝病史、饮酒习惯或正在用其他伤肝药物的人，风险更高。

中成药和汤剂 在临床中被广泛使用，部分患者主观感受良好，但要注意几点：成分复杂，可能含重金属或未标注的西药成分；不同厂家质量差异大；与西药可能相互作用；孕妇、肝肾功能不全者、儿童要特别谨慎。不要因为“中药温和”就同时吃好几种，也不要用中成药替代抗焦虑药或自行停西药。【临床经验】

中医整体调理（辨证论治、针灸、推拿、导引）对部分人的焦虑、失眠、躯体不适可能有帮助，但研究质量总体有限，效果因人而异。找正规医疗机构、有资质的医生，主动告知正在服用的所有药物和保健品，是最低要求。如果对方要求你停掉精神科药物、或者承诺“不用西药也能根治”，要警惕。【临床经验】

四、针灸、rTMS 与 tDCS：物理治疗的证据位置

针灸 对焦虑、失眠、紧张性头痛有一些研究和临床使用经验，部分试验显示可能改善焦虑评分，但研究质量参差、对照设置困难、结果不一致。【研究】 总体来说，由合格人员操作时风险较低，常见的是局部酸胀、少量出血、瘀青；罕见但严重的风险包括感染、气胸（胸背部深刺）、神经损伤。有出血倾向、正在抗凝、安装心脏起搏器、妊娠的人，要提前告知医生。

经颅磁刺激（rTMS） 是用磁场刺激大脑特定区域的无创技术。它在抑郁症、强迫症中有较明确的证据，部分国家批准用于其中某些适应证；对焦虑障碍，研究相对少，结果不一致，通常不作为一线治

疗。【研究】 常见副作用是头痛、头皮不适、短暂耳鸣；罕见但严重的是诱发癫痫。有癫痫史、金属植入物、心脏起搏器的人需要评估。rTMS 必须在医疗机构由专业人员操作，不是家用项目。

经颅直流电刺激（tDCS） 是用微弱电流调节大脑兴奋性的技术，目前更多处于研究阶段，对焦虑的疗效证据有限，参数、疗程、长期效果都没有定论。【待验证】 自行购买家用设备、照着网上教程贴电极，存在皮肤灼伤、刺激位置错误、延误治疗等风险，不建议在没有医生指导的情况下使用。

干预	证据强度	主要风险	建议
针灸	中等偏弱，结果不一致	出血、瘀青、罕见感染或气胸	选正规机构，告知用药和病史
rTMS	抑郁/强迫症较强，焦虑较弱	头痛、头皮不适、罕见癫痫	医疗机构操作，不作为焦虑首选
tDCS	研究阶段，证据有限	皮肤灼伤、刺激不当、延误治疗	不自行家用，优先参加规范研究
推拿、导引	经验为主，证据有限	手法不当可能受伤	作为辅助放松，不替代治疗

五、不替代规范治疗：怎么和医生沟通、什么时候就医

面对任何补充剂或物理治疗，最安全的做法是“三句话”：我目前在吃什么药；我想加什么；请帮我看看有没有冲突。把药盒、保健品瓶子、处方单一起带给医生或药师，比只报名字可靠。

不要做的事：自行停用抗焦虑药或抗抑郁药；用保健品替代处方药；同时吃多种成分不明的“安神”产品；相信“排毒”“修复神经”“根治”这类说法；在没有评估的情况下做侵入性操作。

开始补充剂或物理治疗前的核对清单

1. 我为什么想用它？是症状确实困扰，还是广告、亲友推荐、病急乱投医？
2. 它宣称的效果，有没有对照研究支持，还是只有个案和动物实验？
3. 我正在吃什么药？包括处方药、非处方药、其他保健品。
4. 我有肝病、肾病、心脏病、癫痫、出血倾向、妊娠或哺乳吗？
5. 产品的成分、生产批号、厂家是否清楚，有没有正规批准文号？
6. 我是否愿意把这件事告诉医生，而不是偷偷加、偷偷停？
7. 我是否在用它替代规范治疗，或者因此推迟就医？
8. 出现不适时，我知道先停用、保留包装、尽快就医吗？

情况	建议
想试镁、omega-3	先问医生是否缺乏、是否与现有药物冲突
想用圣约翰草	必须核对全部用药，尤其是抗抑郁药、抗凝药、避孕药
想针灸	选正规机构，告知抗凝药、起搏器、妊娠
想 rTMS/tDCS	只在医疗机构评估后进行，不买家用设备自行操作
广告说“纯天然无副作用”	默认不可信，先查成分和相互作用

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊

- 服药或服用保健品后出现高热、大汗、肌肉僵硬、意识模糊、心跳很快（可能是血清素综合征）。
- 出现严重过敏：呼吸困难、面唇肿胀、全身皮疹。
- 出现黄疸、尿色变深、持续呕吐、右上腹痛（可能提示肝损伤）。
- 针灸后出现持续胸痛、呼吸困难（警惕气胸）。
- rTMS 或 tDCS 后出现抽搐、意识丧失。

尽快联系医生

- 准备开始任何补充剂、草本或中成药，尤其是正在吃抗抑郁药、抗凝药、抗癫痫药、免疫抑制剂。
- 有肝病、肾病、心脏病、癫痫、出血倾向、妊娠或哺乳。
- 焦虑症状加重，或出现新的躯体症状。
- 想减少或停用精神科药物，必须由医生评估，不要自行决定。

常见问题与容易踩的坑

“天然的就是安全的吗？” 不是。草本和重金属、农药、非法添加都可能带来风险，剂量和相互作用同样重要。

“镁能治焦虑吗？” 证据有限，可能对部分人有轻度帮助，但不能替代治疗；肾功能不全者要谨慎。

“针灸能替代吃药吗？” 不能。它可以作为辅助，但不应替代规范的药物和心理治疗。

“rTMS 是不是比吃药好？” 不能这么说。rTMS 在抑郁、强迫症中有位置，对焦虑的证据较弱，是否适合要由医生评估。

“保健品和西药要隔开吃吗？” 有些需要，有些不够。最好的办法是把所有产品拿给药师核对，而不是自己猜时间。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）：https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders
- NIMH. Anxiety Disorders：https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 8：特殊人群

儿童、老人、孕产妇、躯体疾病患者的焦虑，表现和治疗重点都不同。这一模块讲原则，不替代专科面诊。

8.1 儿童青少年焦虑

孩子的焦虑，治疗起来和成人不完全一样：家庭在房间里，学校在房间外，而孩子本人常常不觉得自己“有病”。这一页写给正在为孩子担心、又拿不准下一步该做什么的家长，也写给已经确诊、想弄清楚治疗怎么配合的青少年。读完你大概能带走四件事：治疗分哪几层、每一层具体做什么、药物什么时候才进入讨论、哪些变化必须立刻报告医生。识别细节可以配合 2.6 儿童青少年焦虑与躯体化表现一起看。

一、先认出四种常见入口

同样是焦虑，孩子很少说“我担心”，更多用身体和行为表达。四个最常见的入口是：**分离焦虑**（黏人、不肯独睡、反复确认父母安全）、**社交焦虑**（课堂不发言、怕被点名、拒绝聚会）、**拒学**（周一早晨腹痛、到校门崩溃）、**躯体化**（反复腹痛头痛、检查无异常）。

入口	孩子可能的表现	常被误解为	治疗上的重点
分离焦虑	黏人、不肯独睡、反复确认父母安全	娇气、被宠坏	分离情境的分级练习，家长一致执行
社交焦虑	不发言、拒绝聚会、怕被注视	内向、不合群	注意力转向外部、行为实验、社交暴露
拒学	早晨腹痛、校门哭闹、拖延出门	逃学、懒惰	先找回避的是什么，再做返校阶梯
躯体化	腹痛头痛、恶心心慌、检查无异常	装病、求关注	先排除器质性原因，再把症状与情绪连起来

判断“正常害怕”还是“需要评估”，看三件事：**持续多久、强度多大、有没有造成实际损害**（不能上学、交不到朋友、睡不好）。怕黑、怕分离在特定年龄是正常的；到了学龄期仍然强烈到影响功能，就值得评估。【指南】

还要留意两件事。一是**共病**：注意缺陷多动障碍（ADHD，表现为注意力不集中、冲动、坐不住）、孤独症谱系（ASD，表现为社交沟通困难、兴趣狭窄、刻板行为）、抑郁、学习障碍，都可能把焦虑藏在后面。二是**欺凌与压力事件**：被排挤、被网络攻击、家庭冲突、转学，都可能让焦虑突然加重。问一句“学校里有没有让你难受的事”，常常比多做一份量表有用。

二、家庭与学校：把配合做成具体动作

家庭能做的，不是“讲道理讲到孩子不怕”，而是把安全感和行动一点点搭起来。

- ☐ 先接住感受，再谈办法。说“我知道你害怕，我陪着你”，比说“这有什么好怕的”更容易让孩子开口。
- ☐ 记一周的观察：什么情境发作、持续多久、有没有回避、睡眠和食欲怎样。带去门诊，比临场回忆可靠。
- ☐ 和班主任、心理老师通气：座位、点名方式、上台顺序、考试安排、能不能先去洗手间。具体的小调整常常比笼统的“多关心”有效。
- ☐ 把早晨流程固定下来，减少谈判：前一晚收好书包、固定出门时间、路上不反复讨论“要不要去”。
- ☐ 不把“今天不上学”当成长期方案。短期缓冲可以有，长期回避会让恐惧越滚越大。
- ☐ 不用羞辱推动。“你再这样以后怎么办”通常只会让孩子更不敢说。
- ☐ 如果存在欺凌，先处理欺凌本身，而不是要求孩子“坚强点”。
- ☐ 家长自己的焦虑也值得处理。孩子对大人的紧张非常敏感，家里的“气压”会传过去。

拒学的处理需要一个阶梯，而不是“明天必须去”。台阶要小到孩子能迈过去，失败了就退一级，不要整段推倒重来。

阶段	这一阶段的目标	家长与学校的配合
第一步	稳住作息：固定起床、吃饭、睡觉	先不讨论“要不要上学”，把节奏修回来
第二步	靠近学校：到校门口停留一会儿	提前和班主任约好，不勉强进班
第三步	短时进班：每天一节喜欢的课	固定座位，允许中途去洗手间或心理室
第四步	半天到校	保留一个“可以找的人”，减少临场恐慌
第五步	恢复全天	每周复盘一次，遇到波动先退半步

【指南】对儿童青少年的焦虑，指南普遍强调家庭参与：家长不是“陪同者”，而是治疗的一部分。

三、心理治疗：CBT 与家庭治疗的位置

认知行为治疗（CBT）是儿童青少年焦虑证据最充分的心理治疗之一。完整的 CBT 通常包含五块：心理教育（把焦虑讲成孩子能懂的话）、认知工作（认出“危险预估”和灾难想法）、暴露练习（分级面对回避的情境）、奖励与强化（把勇敢的行为固定下来）、家长培训（家里怎么回应、怎么不替孩子回避）。【指南】

给孩子做和给成人做不一样：认知部分要具体、用比喻、借画图和角色扮演；暴露要游戏化、有梯度；每次会谈要有家庭作业，下次要回顾。**只坐在诊室里聊、回家不练，效果会打折。**

家庭治疗处理的是另一层：家庭的互动方式可能无意中维持焦虑。比如过度保护（孩子一哭就全部代劳）、过度批评（“你怎么这么没用”）、父母自身的高度警觉、全家围着症状转。把这些摆到桌面上，比单给孩子“做思想工作”更有效。【研究】

学校层面也能做事：心理老师可以提供小组干预，班主任可以调整阶段性的压力源，必要时讨论减负。对社交焦虑的青少年，NICE 社交焦虑指南明确推荐包含家长参与的 CBT。【指南】如果本地心理治疗资源紧张，可以先从学校心理老师和线上自助课程起步，但中重度病例仍应转介专业治疗。

四、药物：只在专科评估后考虑

药物不是儿童青少年焦虑的第一选择。它进入讨论，通常有这几个前提：症状中重度、功能明显受损（例如长期不能上学）、规范心理治疗无效或当地确实不可及、共病抑郁且风险较高。

- **谁来决定**：儿童精神科或青少年精神科专科医生，评估发育水平、体重、共病、家族史、既往反应之后决定。不是普通门诊“顺手开一点”。
- **用什么类别**：临床上常用 SSRI 类抗抑郁药，但不是所有药物在这一年龄组都有充分证据，具体用哪一种由专科医生判断。【指南】
- **必须监测“激活”**：开始用药或加量后的前几周，部分孩子会坐立不安、冲动、话多、睡眠变差、情绪激动。这不一定是“病情变重”，但必须报告。
- **必须监测自杀念头**：部分国家和地区的药监机构对儿童青少年使用抗抑郁药设有警示，认为可能增加自杀相关念头和行为的风险。绝对风险不高，但这正是“必须定期复诊、家长要观察”的理由。不要因为害怕而隐瞒，也不要因为用了药就放松看护。
- **不要自行停药**：突然停用可能出现头晕、恶心、烦躁、睡眠紊乱等撤药反应，也可能增加复发。减量由医生安排。
- **苯二氮䓬类**一般不作为儿童青少年焦虑的长期方案，短期使用也要非常谨慎。

【研究】药物与 CBT 联合，在中重度病例中通常优于单独一种；轻度病例多从心理治疗开始。用药期间，家长可以准备一张简单的观察表：睡眠时长、情绪高低、有没有异常兴奋或易怒、有没有提到“不想活”。复诊时带上，比“最近还行”有用得多。【临床经验】

五、什么时候需要联系医生 / 去急诊

出现以下情况，立即拨打 120 或去最近医院急诊：

- 孩子说出自杀念头、写遗书、告别、分送物品，或有自伤行为；
- 出现攻击行为、伤害他人，或离家出走且失联；
- 意识不清、抽搐、高热、严重过敏（皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难）；
- 连续拒食拒水，或出现明显脱水、虚弱。

出现以下情况，24–48 小时内联系医生：

- 用药后新出现或加重的自杀念头、自伤冲动；
- 明显的“激活”表现：异常兴奋、话多、冲动、几乎不睡、坐不住；
- 情绪突然高涨或极度易怒，与平时判若两人；
- 症状快速恶化，或出现幻觉、明显的现实感丧失。

尽快预约门诊：

- 连续一周以上无法到校；
- 躯体症状反复就诊查不出原因，孩子越来越回避；
- 体重明显下降、睡眠长期紊乱；
- 家长已经无法用原有方式安抚，家庭冲突升级。

可以拨打 12356 心理援助热线。涉及未成年人安全时，不要让孩子独处。

六、常见问题与容易踩的坑

“长大就好了，不用管。” 一部分孩子的焦虑会随发育缓解，但持续到青春期的焦虑，与后来的抑郁、物质使用、学业中断风险相关。观察可以，“什么都不做”最好有期限。

“吃药会上瘾、会伤脑子。” SSRI 类不是苯二氮䓬，不具有典型成瘾性，但确实有副作用和撤药反应，需要监测。把它说成“毒药”和说成“糖豆”一样不负责。

“先休学一年，等好了再回去。” 短期减负可以是策略，长期脱离学校会同时失去同伴、结构和成就感，回避反而固化。休学与否要和医生、学校一起评估。

“孩子说不怕了，就是好了。” 要看行为：有没有恢复上学、有没有参加原来回避的场合。只说不动，常常只是学会了不说。

“是不是我们当父母的做错了。” 焦虑的成因是遗传、气质、环境和学习经验叠加，不是单一养育失误。内疚帮不上忙，稳定的配合能帮上。

“多报几个班，忙起来就不胡思乱想了。” 结构化的活动有帮助，但把日程排满也可能是一种回避。关键是孩子有没有机会练习面对，而不是被填满。

“治疗几次没效果，就是没用。” CBT 通常以周计，需要课后练习；药物通常数周才起效。给治疗一点时间，也给自己一点耐心。

参考来源

- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. 链接
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NIMH. Anxiety Disorders. 链接

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；儿童青少年的评估、用药与停药须由专科医生面诊决定。

8.2 老年焦虑

这一页写给家里有老人的读者，也写给正被焦虑困住、却觉得“这把年纪了没什么好说”的老年人自己。老年焦虑最容易被两句话化解掉：一句是“人老了都这样”，一句是“这就是身体病”。读完你大概能分清：哪些躯体不适要先去内科排查，哪些药可能正在加重问题，家人能做什么、不该做什么，以及什么情况必须马上就医。

一、老年焦虑常常“穿着身体的外衣”

老年人很少说“我焦虑”，更多说“心慌”“胃里不舒服”“浑身不得劲”“睡不着”“总觉得要出事”。躯体化在老年焦虑里很常见，原因有三层：这一代人不习惯谈情绪；身体确实带着慢性病，症状本来就重叠；就诊时医生也更容易先查身体、后问心情。

晚发（老年才第一次出现）的焦虑，要更积极地排查躯体与认知原因。下面这些“模仿者”必须先排掉：

常见“模仿者”	容易混淆的表现	该做什么
甲状腺功能异常	心慌、怕热、多汗、体重下降、手抖	查甲状腺功能
心律失常、心衰	心悸、气短、活动后加重、下肢浮肿	心电图、心脏评估
慢阻肺、哮喘	气短、咳嗽、夜间憋醒	肺功能检查
低血糖	心慌、出汗、手抖、饥饿感，与进食或降糖药相关	发作时测血糖
药物副作用	新加药后坐立不安、心慌、失眠	带上药盒核对
抑郁、认知障碍	兴趣减退、记忆下降、焦虑与糊涂同时出现	情绪与认知评估

老年焦虑还常和这些处境绑在一起：丧偶、退休后角色丧失、独居与孤独、经济压力、照顾生病的老伴、对跌倒和失能的恐惧、对“成为负担”的担心。这些不是“想不开”，是真实的处境，需要被当成治疗的一部分来谈。

【指南】对老年人，焦虑的评估必须同时看躯体疾病、用药和认知状态，不能只靠一张量表。焦虑也可能是认知障碍的早期表现之一，反过来，认知障碍也会带来焦虑；两者同时出现时，需要专业评估来分辨。

二、多重用药与苯二氮䓬：最需要谨慎的两件事

同时吃五种以上药物，就叫多重用药。在老年人身上，它带来的问题往往比焦虑本身更危险：药物相互作用、抗胆碱能负担（口干、便秘、排尿困难、糊涂）、体位性低血压、跌倒、认知下降。

就诊时请带一张清单，写清：

- ☐ 所有处方药：药名、剂量、一天几次、谁开的、吃了多久；

- ☐ 所有非处方药：感冒药、止痛药、晕车药、助眠药；
- ☐ 中成药、保健品、外用药、眼药水；
- ☐ 最近停掉或换掉的药；
- ☐ 喝酒、喝浓茶、喝咖啡的习惯与量；
- ☐ 吃药后出现的任何新症状和时间点。

不要自行停降压药、降糖药、抗凝药。很多感冒药和助眠药含有抗组胺或镇静成分，会让老人更糊涂、更容易跌倒，买之前先问药师。

苯二氮䓬类（常说的“安定”这一类）起效快，对急性焦虑和失眠很有效，但在老年人身上代价更高：

- **跌倒与骨折**：镇静、肌肉松弛、夜间起夜时的头晕，都会增加跌倒风险，而老年人跌倒后髋部骨折的后果很重。
- **认知与谵妄**：可能加重记忆问题，也可能诱发突然的糊涂、幻觉、昼夜颠倒（谵妄）。谵妄是急症，不是“老糊涂”。
- **呼吸抑制**：与阿片类止痛药、酒精同用，风险明显上升。
- **依赖与戒断**：长期使用会耐受、依赖；突然停药可能出现焦虑反跳、失眠、抽搐、谵妄。

老年人代谢慢，同样的剂量在体内停留更久。所以“我吃了十几年都没事”不等于安全；但**也绝不能自行突然停**——戒断可能比焦虑本身更危险。【指南】老年人潜在不适当用药清单（如 Beers 标准）建议老年人避免长期使用苯二氮䓬类。

三、治疗原则：心理治疗与药物

选择	适合谁	要特别注意
CBT 等心理治疗	轻中度、愿意谈、认知功能尚可	需适配听力视力、节奏放慢、交通与家属陪同
SSRI 类	中重度、合并抑郁	低钠、跌倒、出血、与其他药的相互作用
苯二氮䓬类	仅短期、严格评估后	跌倒、认知、依赖，不作为长期方案
其他非苯二氮䓬类	不能耐受一线药物者	起效慢，个体差异大

心理治疗对老年焦虑是有效的，但需要调整：语速慢一些、材料字大一些、多结合具体生活场景、把家属或照护者纳入、把练习安排在老人熟悉的环境里。【研究】

用药原则可以概括为：**种类尽量少、起始更低、加量更慢、复查更勤**。具体用哪一种、用多少，必须由医生结合肝肾功能、心脏情况、合并用药和既往反应决定。

同时别忽略“非药物”的部分：规律作息、白天见光、适度活动、减少咖啡因和酒精、保持社交、处理孤独。这些不是安慰话，它们直接影响睡眠和焦虑水平。跌倒风险也要单独管，具体做法可以参考10.4 血清素综合征、跌倒与驾驶风险。

四、照护者：能做什么、不该做什么

- ☐ 陪同就诊，带上药盒和用药清单；
- ☐ 记录夜间起夜次数、有没有跌倒、有没有突然糊涂；
- ☐ 家里做防滑、装夜灯、加扶手，清理地面杂物；
- ☐ 观察谵妄信号：突然糊涂、看见不存在的东西、昼夜颠倒、注意力飘忽；
- ☐ 帮老人保留掌控感：能自己决定的事，尽量让他自己决定；
- ☐ 照护者自己也要喘息。长期照护的耗竭，最后常常变成不耐烦和忽视。

不该做的：替老人决定停药；把“记性差”一律当成正常老化；一个人硬扛全部照护而不求助。

【个人体验】很多家属说，最难的不是陪看病，而是被老人反复说“我没事”挡在门外。一个有用的做法是不争论“有没有事”，而是说“那我们一起去问问医生，让他判断”，把决定权交给第三方。

五、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 突发胸痛、气短、大汗、晕厥、心悸；
- 突然糊涂、幻觉、极度躁动、昼夜颠倒（可能为谵妄）；
- 跌倒后髋部或腰部疼痛、站不起来；
- 抽搐、高热、严重过敏；
- 出现自杀念头或自伤行为；
- 苯二氮䓬类突然停药后出现抽搐、意识混乱、极度兴奋。

24–48 小时内联系医生：

- 新加药后出现坐立不安、过度嗜睡、走路不稳；
- 乏力、意识模糊、恶心、抽搐（可能是低钠血症）；
- 焦虑突然加重，或完全不能入睡。

尽快预约门诊：

- 体重下降、食欲明显变差；
- 反复跌倒，或因为怕跌倒而不敢出门；
- 焦虑开始影响吃饭、洗澡、按时服药这些基本事情。

六、常见问题与容易踩的坑

“人老了都这样，忍忍吧。” 焦虑不是正常老化的一部分。老年焦虑可以被识别、被治疗，忍着只会增加失能和跌倒风险。

“精神科的药不能吃，吃了会变傻。” 这个担心有现实基础：某些药确实会影响认知和平衡。但正因如此，才需要专科医生选药和随访，而不是一律拒绝。不治疗的焦虑同样损害认知和生活能力。

“睡不着就吃片安眠药。” 长期用安眠药会耐受、依赖、增加跌倒。失眠首选的是行为治疗（CBT-I），药物只是短期工具。

“记性差就是老年痴呆。” 焦虑、抑郁、睡眠差、药物副作用、甲状腺问题都会影响记忆。先排查可逆原因，再谈认知障碍。

“多买点保健品补补。” 保健品可能与处方药相互作用，也可能延误治疗。加任何东西之前，先问医生或药师。

“把老人接到身边就没事了。” 搬迁可能带来新的失落：老朋友、老邻居、熟悉的菜场都没了。陪伴重要，但也要帮他在新环境里重新建立连接。

“老人不愿意看精神科，就算了。” 可以先从“看睡眠”“看心慌”入手，去老年科或心身科；很多老人更能接受“调理身体”的说法。关键是先建立联系，再慢慢谈情绪。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. 链接
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. 链接
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；老年人的用药调整与停药须由专科医生面诊决定。

8.3 孕产期与哺乳期焦虑

怀孕和当妈妈，本来就被期待成“人生最幸福的时候”，所以焦虑常常说不出口——怕被说矫情，怕被说“不像个妈妈”。这一页写给正在备孕、已经怀孕、刚生完孩子，或者正在哺乳期、却不知道自己该不该继续治疗的女性，也写给她们的伴侣和家人。读完你大概能明白：哪些风险需要认真权衡，哪些决定必须由精神科和产科一起做，哪些信号必须马上就医。

这一篇不推荐任何具体药名，也不给个体化方案。 孕产期的每一个用药决定，都要结合孕周、病情严重度、既往治疗反应、产科情况和哺乳计划，由精神科医生与产科医生（必要时加儿科医生或临床药师）联合评估。本文只讲原则，以及你该带着哪些问题去面诊。

一、孕前规划与“治不治”的权衡

最理想的情况，是在备孕前就把治疗方案讨论清楚，而不是等验孕棒出现两条杠才慌。如果你已经在治疗中，备孕前要谈的是：目前控制得怎么样、稳定多久了；过去停药后有没有复发、多久反弹、反弹时有多重；孕期如果需要调整，什么时候调、由谁随访；心理治疗能不能同步接上；产科有没有高危因素。

如果你还没开始治疗，但焦虑已经影响到吃饭、睡觉、工作和生活，备孕前正是评估的好时机。带着“我打算怀孕”这句话去看精神科，医生给出的方案会和平时不一样。

已经怀孕、正在服药的人，最要紧的一件事是：不要自己停。 突然停药可能带来撤药反应和病情反弹，而反弹的焦虑、失眠、拒食同样会影响孕期。正确做法是尽快联系开药的医生，说明孕周，一起决定下一步。

孕产期讨论里最常见的一句话是“为了孩子，我什么药都不吃”。这句话的出发点是爱，但它默认了一个不存在的前提：不吃药等于零风险。真实情况是：**不治疗有风险，治疗也有风险，没有零风险的选项，只有“哪种风险更能接受”。**

决策维度	需要问清的问题
病情严重度	目前症状对吃饭、睡眠、产检、工作影响多大？
既往史	以前停药后有没有复发？复发后多久变重？
孕周与产科情况	现在孕几周？产检有没有并发症？
哺乳计划	打算纯母乳、混合喂养还是配方奶？
可用支持	有没有人能夜里替手、陪同就诊、帮忙带娃？

不治疗的风险包括：长期失眠、进食差、体重增长不理想、产检不规律、与抑郁共病、产后抑郁风险升高；严重时还包括自伤、自杀念头，以及无法照顾自己和婴儿。治疗的风险包括：药物对胎儿发育的潜在影响、新生儿适应问题、乳汁中的药物暴露；不同药物的研究数据差别很大，有些药用得久、数据相对多，有些药几乎没有孕期数据。【指南】【研究】

有一点需要说清楚：关于孕期焦虑与早产、低出生体重之间的关系，不同研究结果并不一致，不能简单说“焦虑一定会导致早产”。可以确定的是，严重到影响进食、睡眠和产检的焦虑，本身就值得处理。【待验证】

二、孕期与产后的焦虑面貌

孕期常见三种样子。**产前焦虑**：反复担心胎儿畸形、胎停、分娩意外，频繁查资料、反复做检查、不断求证，明知结果正常还是放不下。**分娩恐惧**：对疼痛、失控、撕裂、剖宫产、死亡的强烈恐惧，可能强烈到想要回避分娩。**强迫性清洁与检查**：反复洗手、反复消毒、反复确认门锁和煤气，明知过度还是停不下来。此外，妊娠剧吐、先兆流产、卧床保胎、高危妊娠住院，都会同时增加身体负担和心理压力。

生完孩子以后，情绪问题不只一种。分清它们很重要，因为处理方式完全不同。

状态	常见时间	主要表现	怎么办
产后情绪低落	产后 3–5 天	想哭、脆弱、情绪起伏，通常两周内减轻	休息、支持、观察，多数自行缓解
产后焦虑与强迫	产后数周内，也可更晚	心慌、失眠、过度警觉、反复检查婴儿呼吸；侵入性想法	需要评估与治疗，心理治疗有效
产后精神病	产后两周内最常见	幻觉、妄想、极度混乱、严重失眠、行为异常	**急症，立即急诊**

产后焦虑的典型样子是：明明孩子睡着了，自己却整夜竖着耳朵；反复起床确认婴儿还有没有呼吸；一听到哭声就心跳加速、出汗；害怕自己带不好、害怕出门。这些不是“太紧张”，是症状。

产后强迫更需要被说清楚。很多新妈妈会突然冒出“万一我把孩子摔了”“万一我拿刀伤到他”这类画面，吓到自己，觉得“我是不是个坏妈妈”。这里有一个关键区别：**侵入性想法不等于意图。** 这类画面通常是突然冒出来的、违背你意愿的、让你极度痛苦的，你并不想去做，甚至拼命想赶走它；越害怕、越压抑，它出现得越频繁。真正需要警惕的是另一种情况：你开始觉得“也许这样也不错”，或者已经开始做计划、做准备——那需要立即求助。

产后精神病是完全不同的紧急情况：出现幻觉、妄想（坚信孩子被替换了、被监视、被要求伤害孩子）、极度混乱、几乎不睡、行为反常。这种情况可能在短时间内迅速恶化，必须立即去急诊，不能等门诊。

三、哺乳期：没有零风险选项

哺乳期用药的核心问题是：药物会不会进入乳汁，对婴儿有什么影响。可以确定的是：多数用于焦虑和抑郁的药物会少量进入乳汁，但通常远低于孕期通过胎盘的量；不同药物之间差别很大，研究数据

也很不均衡。【研究】换句话说，“哺乳期完全不能用药”不准确，“哺乳期用药绝对安全”也不准确。

决策时通常要一起看：婴儿的月龄与是否早产（早产儿、新生儿对药物更敏感）；母亲病情的严重度，以及不治疗对照顾婴儿能力的影响；以前用过什么、效果如何、副作用如何；是否可以用心理治疗作为主要手段或辅助；家庭的夜间分工与支持。

有几句话值得记住：

不哺乳，是完全合理的选择。 配方奶可以养活孩子，一个稳定、能睡、能抱孩子的妈妈，比“坚持纯母乳但崩溃”更重要。混合喂养也是选项。

不要为了母乳而硬扛重度焦虑。 严重失眠、拒食、无法照顾婴儿，本身就是风险。

不要自己把药停了“试试看”。 停药后的反弹往往发生在产后最脆弱的那几周。

具体用哪种药、要不要哺乳、要不要暂停哺乳，必须由精神科与产科（必要时加儿科或临床药师）一起定。 本文刻意不点名任何药物，因为选择取决于上面这些具体条件，而不是某种“通用最优解”。

四、必须与专科联合评估的点

去面诊前，可以把下面这张清单写下来，逐条和医生确认：

- ☐ 目前用药清单：药名、剂量、吃了多久、谁开的；
- ☐ 备孕或已孕的周数，产科有没有并发症；
- ☐ 过去停药后有没有复发，复发时是什么样子；
- ☐ 目前的睡眠、进食、体重变化；
- ☐ 有没有自杀念头、自伤行为；
- ☐ 有没有伤害婴儿的念头（区分“吓到自己的侵入性想法”和“真的想做”）；
- ☐ 哺乳计划：纯母乳、混合还是配方奶；
- ☐ 家里的夜间分工：谁能替手，谁能陪同就诊；
- ☐ 产后随访安排：产后两周、六周分别由谁看、看什么；
- ☐ 心理治疗的衔接：本地有没有可预约的 CBT 资源。

【指南】孕产期的精神科用药决策，指南一致强调多学科共同评估与充分告知，而不是由单一科室决定。伴侣可以做的事很具体：陪同就诊、记住医生的话、夜里替一次手、在她说“我没事”的时候仍然留一只耳朵。

五、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**

- 有伤害自己或婴儿的念头、计划或行为；
- 出现幻觉、妄想、极度混乱、坚信孩子被替换或被要求伤害孩子（可能为产后精神病）；
- 抽搐、剧烈头痛伴视物模糊、明显水肿（需排除子痫前期）；
- 产后大量出血、胸痛、气短、晕厥；
- 连续几天几乎不睡、行为明显反常。

24–48 小时内联系医生：

- 焦虑急剧加重，完全无法入睡；
- 强迫症状耗时数小时，无法照顾婴儿；
- 服药后出现皮疹、高热、肌肉僵硬、意识改变；
- 情绪持续低落、对婴儿完全没有感觉、无法进食。

尽快预约门诊：

- 发现怀孕，正在服药，需要评估方案；
- 备孕中，想提前规划；
- 哺乳期想调整治疗；
- 产后焦虑持续两周以上没有减轻。

可以拨打 12356 心理援助热线。如果担心自己会伤害孩子，请立刻让另一个人接手照看，并联系医生——这不是失败，是保护。

六、常见问题与容易踩的坑

“怀孕不能吃任何药。” 有些情况确实可以不用药，靠心理治疗和支持度过；但也有些情况，不治疗的风险更高。答案不在口号里，在评估里。

“为了孩子，我必须母乳，所以不能吃药。” 母乳是选择，不是道德考试。母亲的状态也是孩子环境的一部分。

“产后焦虑是矫情，出了月子就好了。” 一部分会缓解，但持续两周以上、影响照顾能力的焦虑需要治疗。

“冒出伤害孩子的念头，说明我是坏妈妈。” 侵入性想法与意图不是一回事。越把它当禁忌，它越缠人。说出来，才有机会处理。

“我自己把药停了最安全。” 突然停药可能带来撤药反应和复发，而复发往往比药物风险更难处理。

“哺乳期吃药就得断奶。” 不一定。是否继续哺乳、如何安排喂奶时间，可以和医生一起讨论，不是非此即彼。

“等孩子大一点再说。” 拖延的代价是症状慢性化、亲子互动受影响、伴侣关系紧张。越早评估，选项越多。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. 链接
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NIMH. Anxiety Disorders. 链接

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；孕产期与哺乳期的任何治疗决定，均须由精神科与产科联合面诊后确定。

8.4 躯体疾病、ASD 与 ADHD 共病

有心脏病、糖尿病、哮喘、甲状腺问题的人，也会焦虑；有孤独症谱系（ASD）或注意缺陷多动障碍（ADHD）的人，焦虑往往更常见，也更难被认出来。这一页写给这几类人及其家属。重点不是“该吃什么药”，而是：怎么把焦虑和躯体病、神经发育差异分开来看；哪些药会互相打架；治疗顺序大概怎么排；哪些事必须由专科医生决定。

这一篇只讲原则。 具体用药、剂量、停药与换药，必须由了解你全部病史和用药的医生面诊决定。

一、先分清三件事，再看四种躯体疾病

同样是“心慌、气短、手抖”，可能来自三个完全不同的方向：

1. **躯体疾病本身的症状。** 甲亢会心慌怕热，心律失常会心悸，哮喘会气短，低血糖会出汗手抖。
2. **对疾病的焦虑反应。** 确诊后的恐惧、对复发的担心、对检查结果的反复揣摩。适度的警觉是正常的，持续到影响生活才构成障碍。
3. **药物或物质引起的。** 咖啡因、浓茶、能量饮料、支气管扩张剂、激素、部分感冒药、减肥药、酒精戒断，都可能制造出“像焦虑”的状态。

这三件事不是非此即彼。一个人可以既有冠心病，又有惊恐障碍，还同时在喝大量咖啡。真正危险的做法，是认定“我的心慌一定是焦虑”或者“我的焦虑一定是心脏病”，然后停止排查。详细的鉴别思路可以参考4.4 鉴别诊断：甲亢、心律失常、低血糖等。

疾病	容易和焦虑混淆的表现	治疗时要特别说清的事
心血管病	心悸、胸闷、气短、乏力、濒死感	部分抗抑郁药影响 QT、血压、出血风险；需与心内科共同评估
糖尿病	心慌、出汗、手抖、乏力（也可能是低血糖）	焦虑影响血糖管理；某些降压药会掩盖低血糖警示症状
哮喘	气短、胸闷、夜间憋醒、过度换气	非选择性 β 受体阻滞剂可能诱发支气管痉挛，通常需避免
甲状腺疾病	心慌、怕热、多汗、体重下降、手抖、坐立不安	先查甲状腺功能；甲亢控制后焦虑仍在，才考虑焦虑障碍

心血管病。 惊恐发作和心脏病的关系是双向的：心脏病患者中焦虑很常见，反复惊恐发作的人也会更担心心脏。原则通常是：首次、突发的胸痛、气短、晕厥，先按急症排查；已确诊的心脏病患者出现新发或变化的症状，也要先排查心脏，而不是默认“又焦虑了”。用药上，三环类在心脏病患者中风险较高，SSRI 类相对更常用，但仍需评估 QT 间期、药物相互作用，以及与抗凝、抗血小板药同用时的出血风险。【指南】

糖尿病。 焦虑会通过睡眠、饮食、运动和依从性影响血糖，血糖波动又会带来心慌、出汗、手抖——和焦虑发作几乎一样。分辨的办法很朴素：**发作时测血糖，而不是靠猜。**

哮喘。 焦虑会加重对气短的感知，哮喘控制不好又会加重焦虑。要分清两件事：哮喘急性发作是急症，需要按哮喘方案处理，不能用“放松训练”代替支气管扩张剂；而长期共存的控制性焦虑，可以用心理治疗和必要的药物处理。

甲状腺疾病。 甲亢的很多表现和焦虑障碍几乎一样。所以第一次出现明显焦虑时，查甲状腺功能是常规动作。反过来也要注意：甲亢治好了，焦虑却没走，那可能本来就存在焦虑障碍。【指南】

二、药物相互作用：为什么“各看各的”会出问题

最常见的场景是：心内科医生开心脏药，精神科医生开抗焦虑药，两个人都很负责，但没有人把所有药放在一张桌子上看一遍。

需要留意的相互作用包括：

- **QT 间期叠加**：多种影响 QT 的药同用，可能增加心律失常风险，尤其在心功能不全、电解质紊乱、老年人身上。
- **出血风险**：SSRI 类与抗凝药、抗血小板药同用，出血风险上升。
- **低钠血症**：SSRI 类可能引起低钠，老年人、合用利尿剂的人风险更高，表现为乏力、意识模糊、恶心，严重时抽搐。
- **5-羟色胺综合征**：与某些止痛药、偏头痛药、部分抗生素、圣约翰草等合用时有风险，表现为高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识改变。
- **代谢酶抑制**：部分抗焦虑药会抑制肝药酶，让华法林、部分降压药、部分抗心律失常药的血药浓度升高。

患者能做的很具体：

- ☐ 每次就诊都带**全部**药盒，包括中成药、保健品、外用药；
- ☐ 主动告诉每一位医生“我在吃精神科的药”和“我在吃心脏/降糖/平喘的药”；
- ☐ 加任何新药（包括感冒药、止痛药、助眠药）之前，问一句“和我现在的药会打架吗”；
- ☐ 不自行停慢病药，也不自行停精神科药；
- ☐ 出现新的心慌、头晕、出血、意识模糊，记录下来并尽快报告。

【临床经验】把药盒装在一个袋子里、每次复诊整袋带上，是成本最低、最有效的防错办法。

三、ASD 与 ADHD：识别与“先治哪个”

ASD 中的焦虑表现和一般人不同：不是“我担心明天的事”，而是**重复行为明显增加**（来回踱步、摇晃、反复排列物品）；**对变化的容忍度骤降**，路线改了、座位换了就崩溃；**躯体不适**（肚子痛、头痛、睡不着，说不清来源）；**攻击或自伤**（抓自己、撞头、摔东西，可能是焦虑过载的外显）；**退行**（原本会说的话、会做的事突然不做了）。这些变化常被误读为“退步”“行为问题”“青春期叛逆”，真正的原因却是焦虑。

识别上有几个难点：自评量表往往不适合，需要熟悉 ASD 的医生结合家长或照护者的描述；焦虑与感觉过载、强迫样行为、ADHD 症状容易混在一起；有些人无法用语言描述内心状态。治疗上，CBT 可以被改造后使用：更具体、更视觉化、节奏更慢、更多重复、家长或照护者参与、把练习放在可预测的环境里；同时处理环境因素，比如提前预告变化、提供视觉日程、减少感觉刺激。药物证据比一般人群更有限，用于严重焦虑、攻击或自伤时需专科医生谨慎评估并密切监测。【待验证】

ADHD 中的焦虑常互相伪装：坐不住，是 ADHD 的多动，还是焦虑带来的坐立不安？注意力差，是 ADHD 的注意缺陷，还是焦虑把“内存”占满了？一个有用的线索是**情境依赖性**：ADHD 的注意力问题跨情境存在，在喜欢的事情上也会漏；焦虑相关的注意力下降，往往在压力大、被评价、担心结果时更明显。

先治哪个	线索	处理原则
先治 ADHD	焦虑随任务受挫、无聊、被批评而起伏，ADHD 症状更早出现	行为管理、家长培训、必要时药物；观察焦虑是否随之减轻
先治焦虑	焦虑独立于注意问题，回避和躯体症状突出	CBT、必要的药物；稳定后再评估注意力
同时处理	两者都重度，互相维持	一次只调整一个变量，记录变化，避免同时加多种药

【研究】有一部分研究提示，当 ADHD 是原发问题、焦虑是继发时，规范治疗 ADHD 后焦虑会减轻；但并非所有人如此，个体差异很大。用药上需要注意的是：兴奋剂类可能加重焦虑、失眠、心悸，也可能影响食欲；非兴奋剂类起效较慢，早期可能有嗜睡或情绪波动。加药、换药、加量都由专科医生决定。【临床经验】

四、治疗顺序的一般原则

- **安全优先。** 先处理会危及生命的事：心脏病急性症状、哮喘发作、甲亢危象、低血糖、戒断反应。焦虑的评估可以稍后，但不能忘。
- **先减少“可避免的加重因素”。** 咖啡因、能量饮料、酒精、尼古丁、自行加服的中成药、长期用镇静药。这些改动不需要处方，但常常有效。
- **指定一个“主责医生”。** 躯体科和精神科都参与时，明确谁负责统筹用药清单，避免各开各的。
- **一次只改一个变量。** 同时换三种药，好转或恶化都说不清原因。
- **心理治疗与躯体病管理结合。** 对慢性病相关的焦虑，CBT 常和疾病自我管理（按时服药、监测、复诊）一起做，效果更稳。【研究】
- **不把“放松”当成万能药。** 放松能降低唤醒，但不能替代对疾病的规范治疗，也不能替代暴露和认知工作。

五、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 突发胸痛、胸闷、大汗、气短、晕厥、心悸；
- 哮喘发作，按平时方案处理后仍不缓解，说话困难、嘴唇发紫；
- 低血糖后意识模糊、抽搐、无法进食补糖；
- 甲亢危象的表现：高热、心跳极快、烦躁、呕吐、意识改变；
- 抽搐、意识不清、严重过敏；
- 出现自杀念头或自伤行为。

24–48 小时内联系医生：

- 新加药后心慌加重、头晕、皮疹；
- 出血倾向（牙龈出血、皮下瘀斑、黑便）；
- 乏力、恶心、意识模糊（需排除低钠）；
- 高热、大汗、肌肉僵硬或抽动（需排除 5-羟色胺综合征）。

尽快预约门诊：

- 甲状腺功能异常，或甲亢控制后焦虑仍持续；
- 血糖控制变差，找不到原因；
- ASD 或 ADHD 者的行为、睡眠、情绪明显变化；
- 焦虑开始影响按时服药和复诊。

六、常见问题与容易踩的坑

“心慌一定是焦虑。” 也可能不是。首次、突发、伴随胸痛或晕厥的心慌，先排查心脏。

“有躯体病就不能吃精神科的药。” 不是。是要选对药、调整剂量、监测相互作用。因噎废食的代价，可能是焦虑拖垮慢病管理。

“ADHD 治好了，焦虑自然就好了。” 一部分人会，一部分人不会。两者可以并存，需要分别评估。

“ASD 的孩子不会焦虑，只是不会表达。” 他们会焦虑，而且可能更强烈，只是表达方式不同。

“保健品没有副作用，也不会和药打架。” 圣约翰草、部分中成药、大剂量维生素都可能影响肝药酶或 5-羟色胺水平。

“先把焦虑治好，再管血压血糖。” 通常是并行的。慢病管理本身就能降低焦虑，焦虑缓解也能改善慢病管理。

“换个医生就不用讲那么多药了。” 每换一个医生，都要重新对一遍药单。信息断层是用药错误最常见的来源。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. 链接
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. 链接
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；合并躯体疾病、ASD 或 ADHD 时的用药与治疗顺序，须由相关专科医生共同面诊决定。

模块 9：共病

焦虑很少单独出现。抑郁、双相、PTSD、OCD、失眠、物质使用都会改变治疗选择。

9.1 焦虑合并抑郁

焦虑和抑郁一起出现，是精神科门诊里最常见的情形之一。很多人先是长期担心、睡不好、心慌，过了几个月，变成什么都不想做、觉得自己没用、早上起不来。这一页写给同时有这两类症状的人，也写给想搞清楚“到底先治哪个”的家属。读完你大概能明白：为什么不能只治一头；SSRI/SNRI 为什么常被同时用于两者；合并时最需要盯住的危险是什么。

一、它们为什么总一起出现

焦虑和抑郁共享很多东西：睡眠差、注意力下降、容易累、坐立不安、对未来悲观。症状重叠，量表也会互相“串门”——一个重度焦虑的人，抑郁量表往往也不低。

机制上，两者都涉及压力反应系统、5-羟色胺和去甲肾上腺素通路、睡眠与生物钟的紊乱。它们还会互相喂养：焦虑带来回避，回避带来失能和孤立，失能和孤立带来抑郁；抑郁带来无力和绝望，无力又让人更担心、更不敢动。

【研究】在临床样本中，两者同时出现非常常见，有研究估计超过一半的焦虑障碍患者一生中会经历抑郁发作。数字在不同研究里差别不小，但“常见”这个结论是稳的。

先后顺序重要吗

重要，但不是为了贴标签，而是为了判断治疗的重心和风险。

起病顺序	常见提示	治疗上的影响
焦虑先、抑郁后	长期担心、回避，之后出现无力和兴趣减退	两者都要治；抑郁出现后自杀风险上升，需重新评估
抑郁先、焦虑后	兴趣减退、精力下降在前，担心在后	以抑郁为主线，焦虑常随抑郁改善而减轻
几乎同时出现	症状交织，难以区分先后	选对两者都有效的治疗，如 SSRI/SNRI 联合 CBT
治疗中焦虑突然加重	可能是药物早期激活，也可能是病情变化	尽快复诊，不要自行加药或停药

【临床经验】问清“最早是什么时候、当时最难受的是什么”，常常比量表分数更能帮医生定方案。

二、SSRI/SNRI 的“一箭双雕”与边界

SSRI 和 SNRI 之所以常被选作合并焦虑抑郁的第一梯队，是因为它们对两类症状都有效，不需要为了治焦虑加一种药、为了治抑郁再加一种。【指南】

但“一箭双雕”有边界，需要说清楚：

第一，起效有先后。 通常需要 2–4 周才开始有感觉，4–8 周才能判断效果。睡眠和食欲可能先改善，情绪和焦虑随后。太早下结论，容易误判为“没用”。

第二，早期可能先“激活”。 部分人在开始服药或加量后的前两周，会出现坐立不安、心慌加重、失眠、情绪激动。这不一定是药不对，但必须报告医生，由医生判断是继续观察、调整时间还是换方案。

第三，精力恢复可能早于情绪恢复。 这是一个需要被认真对待的窗口：当一个人从“连起床都费劲”变成“有力气做事”，但绝望感还没消退时，自杀风险可能升高。这段时间需要更密的随访、更严的手段管理和更多的陪伴。【临床经验】

第四，不是所有抗抑郁药都同样抗焦虑。 有些药主要作用于去甲肾上腺素和多巴胺，对焦虑的证据较少，甚至可能让焦虑更明显。所以“抗抑郁药”不是一类可以随便互换的药，选哪种要看症状结构。

第五，残留的焦虑会拖后腿。 抑郁好转了、但焦虑还在的人，复发风险更高；反过来也一样。所以评估不能只看“心情好点没有”，还要看睡眠、担心、回避和躯体症状。

三、自杀风险：合并时最需要盯的一件事

焦虑合并抑郁，自杀风险高于单纯的焦虑或单纯的抑郁。原因不神秘：焦虑带来强烈的痛苦和失控感，抑郁带来绝望和无力，两者叠加，人既痛苦又觉得没有出路。

几件必须知道的事：

- **直接问，不会“诱导”。** “你有没有想过不想活了？”“有没有想过具体怎么做？”这类问题不会把念头塞进别人脑子里，反而常常让人松一口气。
- **问细节，不问口号。** 有没有计划、有没有准备手段、以前有没有尝试过、最近有没有喝酒、身边有没有人能陪着。
- **手段限制是有效的。** 家里收起多余药物、刀具、农药，不是“监视”，是给冲动留出缓冲时间。
- **安全计划要写下来。** 出现念头时先做什么、联系谁、去哪里，写在纸上比记在心里可靠。具体做法可参考10.2 自杀风险与安全计划。
- **随访要密。** 开始用药、加量、换药、减药，都是风险可能波动的节点。

四、治疗怎么联合：药物、心理治疗与“不要只治一头”

药物解决的是“阈值”和“速度”，心理治疗解决的是“模式”和“复发”。对焦虑合并抑郁，CBT 通常同时做两件事：**行为激活**（把床、屋子、人、活动一点点加回来，不等有动力才行动）和**暴露**（面对被回避的情境，停止用回避换取短暂安心）。这两件事的方向一致：都是让人从“躲”转向“做”。【指南】

顺序上，常见的做法是：先稳住基本盘（睡眠、进食、安全、减少酒精和咖啡因）；用行为激活把活动量拉起来，哪怕每天只做一件小事；等活动量和精力恢复一些，再加入暴露，处理回避；最后做复发预防，识别早期信号、写下应对步骤。

中重度的情况下，药物与心理治疗联合通常优于单独一种；轻度的情况，心理治疗可以作为起始。【研究】

- ☐ 两个方向都评估：焦虑量表（如 GAD-7）和抑郁量表（如 PHQ-9）都做，不只看一个；
- ☐ 记录起病顺序和最难受的症状，复诊时告诉医生；
- ☐ 每次复诊都问一句“我的焦虑和抑郁分别到什么程度了”；
- ☐ 不把苯二氮䓬当成唯一方案——它缓解焦虑，但不治抑郁；
- ☐ 不因为“心情好点了”就自行减药，也不因为“焦虑还在”就自行加药；
- ☐ 酒精、熬夜、咖啡因，三件事一起管；
- ☐ 让家人知道哪些话不能说（“你想开点”“别人比你惨”），哪些事可以帮（陪着就诊、收好危险物品、夜里陪着）。

五、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 有自杀念头并已有计划，或正在准备手段；
- 已经自伤、服毒、吞药；
- 出现“交代后事”“告别”“分送物品”的行为；
- 出现幻觉、妄想，或完全无法照顾自己。

24–48 小时内联系医生：

- 用药后焦虑急剧加重、坐立不安、完全不能睡；
- 情绪突然变得异常高涨或极度易怒；
- 抑郁明显加重，出现“活着没意思”的念头但尚无计划；
- 出现新的躯体症状，如心悸、出血、意识模糊。

尽快预约门诊：

- 量表分数持续上升，或治疗 4–8 周仍无改善；
- 兴趣完全丧失、无法工作或上学；

- 反复请假、卧床时间越来越长。

可以拨打 12356 心理援助热线。如果身边有人处于危险中，不要让他独处。

六、常见问题与容易踩的坑

“抑郁好了，焦虑自然就好了。” 不一定。残留焦虑是复发的常见预测因素，需要单独评估和处理。

“焦虑只是抑郁的一部分，不用管。” 两者可以独立存在，也可以互相维持。只治一头，另一头常把病情拉回去。

“抗抑郁药会让人自杀，所以不能吃。” 更准确的说法是：用药早期和剂量调整期需要密切监测，尤其是年轻人。监测是为了安全使用，不是拒绝治疗的理由。

“只做心理治疗就够了。” 轻度可以；中重度通常需要联合。反过来，只吃药不改变回避模式，复发率也高。

“喝酒能助眠、能放松。” 酒精短期让人放松，长期会加重焦虑、破坏睡眠结构，还可能和药物相互作用。

“感觉好点了，就可以停了。” 症状缓解不等于病程结束。停药时机和方式需要医生评估，突然停可能带来撤药反应和复发。

“两个病，得吃两种药。” 不一定。SSRI/SNRI 常常同时覆盖两类症状；需要加药时，医生会说明加的是什么、为什么加。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. 链接
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. 链接
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体用药方案与停药计划以面诊医生为准。

9.2 焦虑合并双相

有一类人，长期被当作“焦虑症”治疗，吃了几年抗抑郁药，却越来越不稳定：情绪忽高忽低，睡得更少反而更精神，有时候烦躁到摔东西。这背后可能藏着双相障碍。这一页写给被诊断为焦虑、但情绪起伏明显的人，也写给想弄清楚“为什么不能只按焦虑治”的家属。读完你大概能明白：轻躁狂长什么样；抗抑郁药为什么可能“帮倒忙”；治疗顺序为什么是先稳心境。

一、为什么不能只按焦虑治

双相障碍的核心，是情绪在“低落”和“高涨（或混合）”之间摆动。焦虑常常是这个摆动的一部分，或者与它同时存在。如果只看到“焦虑”，治疗方向可能从一开始就偏了。

焦虑可能不是独立的问题。 坐立不安、思绪飞快、话多、睡不着，既像焦虑，也像轻躁狂或混合状态。把它们当成焦虑去加大抗抑郁药，可能让摆动更剧烈。

抗抑郁药可能诱发转躁。 对双相患者单用抗抑郁药，有诱发躁狂、轻躁狂、混合状态或加快循环的风险。这不是“药物过敏”，而是治疗方向与疾病机制不匹配。

只治焦虑会漏掉真正需要防的东西。 双相的自杀风险、冲动行为、物质使用、治疗依从性问题，都需要单独处理。只盯着“别那么紧张”，会错过更重要的目标。

反复治疗失败本身就是一个信号。 多种抗抑郁药效果不好、一吃就“变了一个人”、停药就反弹，这些都值得请医生重新评估诊断。

【研究】双相障碍与焦虑障碍的共病很常见，不同研究报告的比例差别较大，但普遍认为明显高于一般人群。这意味着：在焦虑门诊里，确实有一批人需要被重新看一眼。

双相中的“焦虑”可能来自不同源头，处理方向完全不同：

看起来像焦虑	可能是	处理方向不同
坐立不安、思绪飞快	轻躁狂或混合状态	调整心境稳定剂，而非加抗抑郁药
心慌、手抖、怕热	甲状腺问题、药物副作用	先查躯体原因
担心、回避、躯体紧张	独立的焦虑障碍共病	心境稳定后再针对性处理
突然的惊恐、失眠	物质使用、咖啡因、戒断	先处理物质问题

二、先筛查：是不是双相

筛查的核心是**终身轻躁狂史**，而不是“现在开不开心”。问的时候要具体：

- 有没有过一段时间，睡得很少（比如每天三四个小时）却一点都不累？
- 有没有过话比平时多很多、停不下来、别人插不上嘴？
- 有没有过脑子里想法一个接一个、跳得特别快？
- 有没有过特别想花钱、想投资、想做大事，事后后悔？

- 有没有过性欲明显增强、冲动决定、冒险行为？
- 有没有过特别容易发火、一点就炸，和平时不一样？
- 那段时间持续了几天？别人有没有觉得你“不对劲”？

关键是三个限定：**与平时不同、持续数天、造成实际后果**（吵架、辞职、超支、住院、被送急诊）。偶尔睡少一天、偶尔特别高兴，不算。

轻躁狂的信号	常被当成	要问清什么
睡三四个小时不累	“精力好”“失眠好转”	持续几天？白天困不困？
话多、思维快、停不下来	“想通了”“状态好”	别人能不能插话？被打断会不会烦？
花钱、投资、做大计划	“有魄力”	事后后悔吗？超出承受能力吗？
易怒、坐不住、摔东西	“焦虑加重”	同时有没有话多、睡少、想法多？
目标活动明显增多	“终于振作了”	同时有没有风险行为？

【指南】临床上常用心境障碍问卷（MDQ）等工具做初筛，但量表只是提示，诊断要靠系统的临床访谈，通常还需要家属提供旁证。家属的观察常常比本人更准：本人觉得“那阵子状态好”，家人记得的是“那阵子差点出事”。

三、抗抑郁药的转躁风险

这件事需要说得准确，既不能淡化，也不能夸大。

哪些人风险更高： 既往有过转躁或轻躁狂史；双相障碍家族史；起病年龄早；快速循环（一年多次发作）；混合特征明显；既往抗抑郁药一用就“变样”。【研究】

哪些药风险不同： 三环类被认为转躁风险相对较高；SSRI 和 SNRI 相对较低，但不等于零。任何抗抑郁药在双相患者身上单用，都不是推荐做法。【指南】

同时用心境稳定剂能降低风险吗： 通常会降低，但不能完全消除。所以即使联用，也需要密切观察情绪、睡眠和行为变化。【研究】

患者和家属能做的： 记录。用一本小册子或手机备忘录，每天记睡眠时长、情绪高低（从很低到很高打个分）、有没有异常兴奋或易怒、吃了什么药。复诊时给医生看，比临场回忆可靠得多。【临床经验】

一个容易被忽略的信号： 吃了抗抑郁药以后“感觉特别好”“像换了个人”“突然想通了很多事”，不一定是好转，也可能是轻躁狂的开始。这种“好”通常伴随睡得少、话多、花钱多、脾气大。

四、心境稳定剂优先：治疗顺序的逻辑

双相的治疗逻辑和单纯焦虑不同：**先把情绪的“摆幅”稳住，再处理残留的焦虑。**

为什么是这个顺序？如果情绪还在剧烈摆动，针对焦虑的暴露练习、放松训练很难进行；如果只加抗抑郁药，可能把摆幅拉得更大；心境稳定之后，一部分焦虑会自然减轻，剩下的才是真正需要单独处理的焦虑。

常用的心境稳定治疗包括锂盐、丙戊酸盐、拉莫三嗪、部分非典型抗精神病药等，具体用哪一种、怎么组合、怎么监测，由精神科医生根据发作类型、既往反应、身体状况和生育计划决定。**这一篇不给药名推荐，也不给剂量。**

需要定期监测的项目通常包括：锂盐的血药浓度、甲状腺功能、肾功能；丙戊酸盐的肝功能、血常规，以及育龄女性的生育风险；代谢指标和体重。这些监测不是“过度检查”，是安全使用的一部分。

焦虑的部分怎么处理：心理治疗（CBT、正念、家庭聚焦治疗、生物节律管理）帮助识别早期信号、稳定作息、减少情绪波动带来的连锁反应【研究】；苯二氮䓬类短期、按需、医生指导下可用于急性焦虑和失眠，但不作为长期方案；抗抑郁药只在医生评估后、通常与心境稳定剂联用、并且有时间限制地使用。

患者和家属可以做的：

- ☐ 建一份“情绪日历”：每天记睡眠时长、情绪分数、用药、重大事件；
- ☐ 请一位家属也记录，两个人的观察常常不一样；
- ☐ 复诊时主动说“我最近有没有睡得少但很精神”；
- ☐ 不自行停心境稳定剂，也不自行加抗抑郁药；
- ☐ 避免熬夜、倒时差、连续通宵——睡眠剥夺是躁狂的常见诱因；
- ☐ 减少酒精和兴奋剂（咖啡、能量饮料、减肥药）；
- ☐ 备孕或已孕，提前讨论用药调整；
- ☐ 写一份复发早期信号清单，和家人约定“出现这些就去医院”。

五、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 躁狂或混合状态：极度兴奋、几乎不睡、冲动行为、攻击、无法自控；
- 自杀念头伴计划，或已经自伤；
- 出现幻觉、妄想、极度混乱；
- 抽搐、意识改变；
- 锂盐中毒的表现：频繁呕吐、腹泻、手抖明显加重、走路不稳、言语含糊、意识模糊。

24–48 小时内联系医生：

- 睡眠骤减（比如连续两三天只睡两三小时）却精力旺盛；
- 情绪突然高涨、话多、花钱变多、脾气变大；

- 焦虑在加药后急剧加重，或出现明显的坐立不安；
- 抑郁加重，出现无望感。

尽快预约门诊：

- 抗抑郁药治疗后情绪变得不稳定；
- 多种抗抑郁药效果都不好；
- 家族里有人被诊断为双相或住过精神科。

六、常见问题与容易踩的坑

“我只是焦虑，不是双相。” 可能。但如果情绪起伏明显、抗抑郁药一吃就“变样”，值得请医生重新评估。筛查不是给你贴标签，是避免治错方向。

“吃了药感觉特别好，说明药对了。” 要分辨这种“好”：睡得少还精神、话多、想法多、花钱多，更像轻躁狂。

“情绪稳定剂是给‘疯子’吃的。” 它是用来减少情绪摆幅的，和降压药减少血压波动是一个思路。

“躁狂的时候效率高，我不想治。” 躁狂后的下跌往往更重，冲动决定的代价（债务、关系、工作）也常常不可逆。

“焦虑好了，就可以停心境稳定剂。” 焦虑缓解不等于双相稳定。停药的时机和方式需要医生评估。

“我自己把抗抑郁药停了就行。” 突然停药可能带来撤药反应和情绪波动，尤其是与心境稳定剂联用时，需要医生安排。

“情绪稳定剂伤肝伤肾，不如不吃。” 风险是真的，所以才有定期抽血监测。监测到位的前提下，收益通常大于风险；具体怎么权衡，要和医生一起算这笔账。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. 链接
- WHO. ICD-11 Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；双相的诊断、用药与停药须由精神科医生面诊决定。

9.3 焦虑合并 PTSD 与 OCD

有些“焦虑”治了很久不见好，因为方向从一开始就偏了：一个人反复闪回多年前的事，被当成广泛性焦虑；一个人反复检查门锁、反复求保证，被当成“太紧张”。创伤后应激障碍（PTSD）和强迫症（OCD）在外表上都像焦虑，但治疗的核心动作完全不同。这一页写给治疗效果不理想、或怀疑自己有创伤史、强迫症状的人，也写给想帮忙的家属。

一、三者不是一回事：先分清，再找创伤

三者都让人紧张、回避、睡不好，但维持问题的机制不一样，因此“什么起作用”也不一样：

	焦虑障碍	PTSD	OCD
核心	对未来的威胁过度预估	创伤记忆未被整合，反复侵入	强迫思维加仪式行为
触发	广泛的情境、身体感觉	与创伤相关的线索	特定的念头、图像、冲动
维持因素	回避、安全行为	回避创伤线索、麻木、警觉	仪式、求保证、回避触发
一线治疗	CBT、暴露	创伤聚焦心理治疗	ERP 加药物

【指南】把三者混为一谈，最常见的后果是：只做放松、只做支持性谈话，症状短期舒服、长期不动。

PTSD 的核心不是“想起往事难过”，而是四组症状同时存在：

1. **再体验**：闪回、噩梦、突然觉得事情又发生了一遍、看到画面、闻到气味就回到现场；
2. **回避**：躲开地点、人、话题、新闻、声音，甚至回避自己的感受；
3. **负性认知与情绪**：觉得自己坏了、脏了、该负责；对世界失去信任；持续恐惧、愤怒、羞耻、麻木；
4. **警觉与反应性改变**：易惊、易怒、睡不着、注意力差、过度警惕、自伤或冒险行为。

诊断意义上的“创伤事件”有明确界定，通常指实际或威胁的死亡、严重伤害、性暴力。但临床上也会关注长期忽视、欺凌、医疗创伤、反复羞辱等经历——它们不一定满足诊断门槛，却同样值得被谈。【指南】

不问，就找不到。 很多人不会主动说，因为羞耻、怕被评判、怕“说出来会更糟”，或者根本不认为那算创伤。医生需要主动问，而且问得具体：“有没有经历过让你至今想起来还很难受、会躲开的事？”患者可以做的：第一次就诊时就告诉医生“我有一段不想提的经历”，不必一次说完细节；如果医生没问，可以主动说。**治疗不需要你一次讲完所有细节，稳定和安全永远排在前面。** 量表方面，PCL-5 和 PC-PTSD 常用于筛查，但分数只是提示，不能替代访谈。

二、OCD 与焦虑的区别

强迫症有两个部件：**强迫思维**，是反复出现的念头、图像或冲动，令人痛苦，常常与自己的意愿相反（比如怕伤害孩子、怕被污染、怕自己不是好人）；**强迫行为**，是为了减轻痛苦而做的重复动作或心理仪式——洗手、检查、计数、默念、反复求保证、反复回忆确认。

关键区别在这里：

	焦虑的担心	强迫
内容	现实问题：工作、健康、家人安全	往往不合理、违背意愿、令人羞耻
行为	回避、反复求证	重复仪式、反复求保证、反复检查
感受	紧张、担心	厌恶、羞耻、“必须做，不做就受不了”
治疗	CBT、暴露	ERP 加药物

焦虑的担心通常是“现实的担忧被放大了”；强迫是“我知道不合理，但停不下来”。自知力也会波动：状态差的时候，有些人会越来越相信“不检查真的会出事”。

最容易踩的坑是“求保证”。 家属一遍遍说“门锁了”“你没病”“你不会伤害孩子”，当下很舒服，但下一次焦虑来得更快、更强。求保证是强迫循环的燃料，不是解药。

三、ERP 与创伤聚焦治疗：为什么“放松”不够

暴露与反应预防（ERP） 是强迫症的核心心理治疗：主动面对触发（暴露），同时不做原来的仪式（反应预防），让大脑学到“不做也不会出事”。它起作用的机制不是“习惯了就不怕”，而是**预期被打破**：你预计不做仪式会灾难临头，结果没有；一次次重复，这个新的学习慢慢盖过旧的恐惧。

为什么“放松”不够：

- 对 OCD，放松能降低紧张，但不做反应预防，强迫循环还在；甚至一边放松一边继续求保证，等于在加固症状。
- 对 PTSD，放松能缓解警觉，但不能加工创伤记忆；创伤聚焦治疗（如延长暴露、认知加工治疗、EMDR）才是针对核心的。【指南】
- 对焦虑障碍，放松是辅助，核心仍是面对回避的情境。

需要提醒的是：**ERP 和创伤暴露都要在专业指导下做。** 自己硬闯、一次做太猛，可能造成创伤重演或症状加重。好的治疗会有分级、有准备、有退出机制、有复盘。

药物方面，SSRI 类对 PTSD 和 OCD 都有效；OCD 通常需要更长的疗程才能判断效果，PTSD 的一线仍是心理治疗，药物更多用于共病抑郁或症状严重时的辅助。苯二氮䓬类在 PTSD 中一般不作常规推荐，因为它可能干扰暴露治疗、增加依赖，也可能让“回避”更牢固。【指南】

四、治疗顺序与就诊准备

同时有焦虑、PTSD、OCD 时，没有一套对所有人都适用的顺序。常用的判断原则是：

1. **安全与稳定优先。** 自杀风险、自伤、物质过量、现实中的危险（家暴、欺凌）要先处理。不稳定的时候做创伤暴露，可能适得其反。
2. **谁最影响功能，谁先治。** 如果强迫仪式每天耗掉几个小时、无法出门，先做 ERP；如果闪回导致完全无法工作、无法睡觉，先做创伤聚焦治疗。
3. **能整合就整合，不要无限期拖延。** 过去有一种做法是“先戒酒/先稳定，再治创伤”，一等几年。现在更倾向整合或并行治疗，尤其当物质使用是为了应对创伤症状时。【研究】
4. **一次不要开太多战线。** 同时做创伤暴露、ERP、社交焦虑暴露，容易过载。和医生商量一个主线，其他先做支持性处理。

就诊前可以准备：

- ☐ 写下最困扰你的三个症状，各举一个具体例子；
- ☐ 列出你的“回避清单”：不去的地方、不做的事、不谈的话题；
- ☐ 列出你的“仪式清单”：洗手、检查、计数、求保证、反复确认；
- ☐ 记录一次症状发作的完整过程：什么触发、想法是什么、做了什么、多久缓解；
- ☐ 告诉医生有没有创伤史，不必一次讲完；
- ☐ 家属记录：一周内你被问了几次“门锁了吗”，每次持续多久；
- ☐ 睡眠、酒精、咖啡因的量；
- ☐ 目前的药和保健品清单。

五、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 自杀念头伴计划，或已经自伤；
- 闪回、解离导致失控、走失、伤害自己或他人；
- 过量服药、酗酒后的意识障碍；
- 出现幻觉、妄想、极度混乱；
- 正处于现实危险中（家暴、性侵、被跟踪）。

24–48 小时内联系医生：

- 创伤画面频繁侵入，连续几天几乎不能睡；
- 强迫行为每天耗掉数小时，无法上班上学；
- 开始 ERP 或创伤治疗后症状骤增，难以承受；
- 新药后出现明显激活、皮疹、发热。

尽快预约门诊：

> - 焦虑治疗 8 周以上没有改善；
> - 反复求保证、反复检查已经影响家人关系；
> - 一直回避某段经历，一提起就强烈不适。

六、常见问题与容易踩的坑

“放松一下就好了。” 放松是辅助。PTSD 需要加工创伤记忆，OCD 需要反应预防，单靠放松通常不够。

“过去的事想开点就过去了。” 想开不是开关。创伤记忆需要以安全、可控、专业的方式被重新处理。

“强迫症就是爱干净、太仔细。” 强迫症的核心是痛苦和失控，不是整洁。很多人洗手洗到破皮，并不觉得干净。

“暴露就是硬扛、越狠越有效。” 不是。有效的暴露是分级的、可承受的、可复盘的。硬闯可能造成创伤重演。

“多保证几次，他安心了就好了。” 短期有效，长期加固。更好的做法是温和地说“我知道你现在很不安，我们说好不做这个确认”，然后一起做别的事。

“PTSD 不能提创伤，提了会更糟。” 在专业治疗框架下，创伤聚焦治疗是有效的；关键是谁来提、什么时候提、怎么提。无限期回避，症状往往更顽固。

“一次把创伤全讲完才算治。” 不是。分段、可控、有准备地接近，比一次倾倒更安全，也更有效。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. 链接
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. 链接
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；PTSD 与 OCD 的诊断和治疗方案须由专科医生面诊决定。

9.4 焦虑合并失眠、疼痛与物质使用

焦虑很少一个人来。它常常带着三个同伴：睡不着、身上疼、靠点什么东西撑着——酒、安眠药、咖啡、烟。这三件事看起来是“附带问题”，实际上会反过来把焦虑养大。这一页写给长期失眠、慢性疼痛，或者正在用酒精和药物“自我治疗”的人，也写给想帮忙却总被挡在门外的家属。读完你大概能明白：为什么只治焦虑不够；哪些做法看起来管用、其实在加重问题；哪些东西不能自己硬戒。

为什么总绑在一起：失眠与焦虑共享一套“过度觉醒”的系统，焦虑让人难入睡，睡不好又让人第二天更紧张；慢性疼痛与焦虑共享神经通路和认知模式，灾难化带来恐惧，恐惧带来回避，回避带来失能；酒精、镇静药、尼古丁、咖啡因短期都能“调节”情绪，长期都在制造新的问题。【临床经验】一个长期失眠的人开始每晚喝酒助眠，酒量越来越大，白天靠咖啡撑着，腰背痛又让他不敢运动——单治任何一头，其他几头都会把它拉回来。

一、失眠：为什么 CBT-I 是首选

慢性失眠的一线治疗不是安眠药，而是**失眠的认知行为治疗（CBT-I）**。【指南】它通常包含五个部分：

做法	为什么	要注意
固定起床时间	稳定生物钟，比固定入睡更容易做到	周末也尽量一致
困了才上床	重建“床＝睡觉”的联系	不在床上刷手机、办公、吵架
躺下约二十分钟睡不着就离开床	刺激控制，避免在床上“练习清醒”	做安静的事，别开大灯
暂时减少卧床时间	睡眠限制，增加睡眠压力	需专业指导，见下方禁忌
记录睡眠日记	看趋势，不被单晚体验带着走	别过度关注数字

为什么不是首选安眠药？因为它们会耐受（同样的量不管用了）、依赖（不吃就睡不着）、增加跌倒和认知影响，第二天还可能残留困倦。短期、按需、医生指导下使用是可以的，但不适合作为长期方案。

CBT-I 里的“睡眠限制”需要特别提醒：**双相障碍患者要慎用**，因为睡眠剥夺可能诱发躁狂；癫痫、严重躯体疾病、需要高度警觉的职业（如司机、高空作业）也要在医生指导下调整。不要照着一篇文章自己硬做。

还有几个常见误区：提前上床“酝酿睡意”往往越躺越清醒；白天补觉会削弱夜里的睡眠压力；喝酒助眠会破坏后半夜的睡眠结构，让人更早醒。

二、慢性疼痛：不要只加止痛药

慢性疼痛（通常指持续三个月以上）和焦虑的关系是双向的。疼痛本身是真实的，不是“想出来的”；但焦虑、灾难化思维和回避，会把疼痛的“音量”调大。

几个有用的区分：**伤害性疼痛**由组织损伤引起，活动时加重、休息缓解；**神经病理性疼痛**是烧灼、电击、针刺样，常伴麻木；**中枢敏化**则表现为范围广、程度重、与检查结果不成比例，常伴疲劳、睡眠差、焦虑。

对慢性疼痛，有效的做法通常是多学科一起：疼痛科或相关专科评估病因，康复科做渐进运动，心理治疗处理灾难化和回避，必要时用药物。

运动不是“忍痛硬练”。 渐进、规律、从很小量开始的活动，比“疼就不动”更有帮助；但具体怎么加，需要康复或疼痛专科指导。

药物方面，部分 SNRI 类抗抑郁药在神经病理性疼痛和纤维肌痛中有证据，可以作为选择之一；阿片类止痛药长期用于慢性非癌痛有依赖、耐受、便秘、跌倒和痛觉过敏的风险，不作为焦虑相关疼痛的常规长期方案。【研究】

最重要的一句话：**不要因为焦虑治不好就不断加止痛药，也不要因为疼痛查不出原因就认定“都是心理问题”。** 两方面都要处理。

三、酒精、镇静药、兴奋剂：三条不同的陷阱

物质	短期效果	长期代价	要警惕的信号
酒精	放松、助眠、暂时忘事	反跳性焦虑、早醒、依赖、戒断可致命	越喝越多、早晨手抖、为喝酒找理由
苯二氮䓬与安眠药	快速镇静、迅速入睡	耐受、依赖、跌倒、认知下降、戒断	自行加量、到处开药、停药就崩溃
咖啡因、尼古丁、兴奋剂	提神、短暂专注	心悸、焦虑、失眠、血压升高	能量饮料、减肥药、感冒药里的成分

酒精是最常见的“自我治疗”。它作用于 GABA 系统，短期确实能压住焦虑，但几小时后出现反跳，焦虑比原来更高，睡眠结构被破坏，于是第二天更需要它。长期大量饮酒后突然停酒，可能出现手抖、大汗、心跳加快、幻觉、抽搐，甚至震颤谵妄——**这是可以致命的，不能自行硬戒。**

苯二氮䓬类和安眠药的问题在“耐受—加量—依赖”的循环。它们不是不能用，而是不适合长期单独使用。突然停药可能出现焦虑反跳、失眠、抽搐、意识混乱，同样需要医生安排减量。

咖啡因常被忽略。它的半衰期有数小时，下午一杯浓茶或一瓶能量饮料，可能影响到夜里。隐藏来源还包括可乐、某些感冒药、减肥产品。对容易惊恐的人，咖啡因本身就能诱发心慌、手抖、过度换气。

尼古丁的情况有点特殊：戒烟初期焦虑、易怒、注意力差会暂时加重，但长期看，成功戒烟的人焦虑水平通常下降。【研究】所以“抽烟能缓解焦虑”是短期错觉，不是长期答案。

处方兴奋剂（用于 ADHD 等）可能加重焦虑、失眠、心悸；某些感冒药中的伪麻黄碱、部分减肥药也有类似作用。用任何“提神”产品前，先看成分。

四、整合治疗与戒断风险

这四件事如果分开治，很容易互相拆台：精神科给的药，疼痛科不知道；疼痛科开的止痛药，和安眠药叠加；患者自己还在喝酒。

整合治疗的原则是：**指定一个主责医生**，由他掌握完整的用药和饮酒清单；**同时处理，而不是无限期串行**——过去常说“先戒酒再治焦虑”，但很多人卡在这一步好几年，更现实的做法是整合治疗，一边减害一边处理焦虑；**先安全，再睡眠，再疼痛，再焦虑**，有戒断风险时先处理戒断；**一次只改一个变量**，否则好转或恶化都说不清原因；**减害也是进步**，从每天喝到隔天喝、从大量到少量，都是可衡量的改善。

戒断这件事，必须单独强调：

- ☐ 长期大量饮酒的人，停酒前先咨询医生，必要时住院监护；
- ☐ 长期服用苯二氮䓬或安眠药的人，减量由医生安排，不自行减停；
- ☐ 减量期间出现手抖、大汗、心跳加快、幻觉、抽搐、意识模糊，立即急诊；
- ☐ 不要用“自己扛过去”证明意志力，戒断反应是生理性的；
- ☐ 把家里的酒、多余药物清点一遍，必要时请家人保管；
- ☐ 记录每天饮酒量、用药量、睡眠时长，复诊时带上；
- ☐ 让家人知道你在减，出现什么情况要送医。

五、什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 停酒或停镇静药后出现抽搐、幻觉、高热、意识模糊、极度躁动；
- 过量服药、醉酒后意识不清、呕吐误吸；
- 自杀念头伴计划，或已经自伤；
- 突发剧烈疼痛、胸痛、气短、晕厥；
- 疼痛伴发热、肢体无力、大小便失禁（需排除急症）。

24–48 小时内联系医生：

- 饮酒量明显增加，或出现早晨手抖、心慌；
- 安眠药需要不断加量才能入睡；
- 停药后失眠、焦虑严重反弹；
- 疼痛突然加重，或出现新的麻木、无力。

尽快预约门诊：

- 安眠药连续使用超过数周；
- 慢性疼痛影响睡眠和日常活动超过三个月；
- 每天都在用酒精或药物“撑住”；

- CBT-I 自己尝试后无效。

六、常见问题与容易踩的坑

“喝点酒好睡觉。” 酒精让人更快入睡，但破坏后半夜睡眠，早醒和反跳性焦虑更明显。

“安眠药吃习惯了就没事。” 耐受意味着同样的量效果越来越差，加量又增加跌倒和认知风险。

“戒酒靠自己意志就行。” 重度依赖者的戒断可能危及生命，需要医疗监护。意志力解决不了生理性戒断。

“疼痛治好了，焦虑自然就好了。” 不一定。慢性疼痛常伴灾难化和回避，需要单独处理。

“咖啡不算物质，没关系。” 咖啡因能诱发心悸、手抖、惊恐发作，下午之后的摄入尤其影响睡眠。

“保健品和草药绝对安全。” 圣约翰草等会影响肝药酶和 5-羟色胺水平，与处方药可能相互作用。

“先把酒戒了，再来治焦虑。” 对一部分人，这个顺序会变成无限期拖延。整合治疗往往更可行。

“疼痛科和心理科，选一个看就行。” 慢性疼痛伴焦虑，通常需要两边一起，而不是二选一。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. 链接
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. 链接
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；合并失眠、疼痛或物质使用时的治疗方案与戒断管理，须由专科医生面诊决定。

模块 10：风险管理

焦虑本身通常不致命，但惊恐发作、自杀风险、苯二氮䓬戒断和药物相互作用需要认真处理。

10.1 惊恐发作的现场应对

> 这一页写给正在经历惊恐发作的人，也写给站在旁边、不知道该做什么的家属。它讲清发作那几分钟身体里发生了什么、现场可以怎么陪、呼吸为什么不是“越深越好”，以及哪些情况必须先把心脏病排除掉。读完你应该能分清楚：这一次是可以坐下来陪着的惊恐发作，还是需要立刻拨打 120 的躯体急症。

发作的那几分钟，身体里发生了什么

惊恐发作不是“想出来的”，也不是“演技”。它更像身体的警报系统在没有真实危险时被拉响：肾上腺素和去甲肾上腺素一下子升高，心跳加快、心肌收缩更有力，呼吸变快变浅，汗腺打开，肌肉绷紧，血液从内脏转向四肢。【指南】

这套反应原本是为了逃命。问题是，它来得太快、太猛，人来不及理解，就把这些感觉解释成“我要心脏病发作了”“我要疯了”“我要死了”。这个解释让恐惧更高，警报更响，形成一圈自我强化的循环。

呼吸的变化会把循环推得更快。大口快速喘气时，二氧化碳排出过多，血液偏碱，于是出现头晕、手脚发麻、指尖和嘴唇发紧、胸口发闷。这些新感觉又被当成“更严重的证据”。很多人正是在这一步以为自己要晕过去。

需要记住两个时间概念：惊恐发作通常在几分钟内达到高峰，多数在二三十分钟内逐渐回落，很少持续超过一小时；发作结束后，身体会有一段疲惫、发冷、肌肉酸痛的时间，这是警报解除后的正常余波。【指南】

身体感受	背后发生了什么	通常会怎样
心跳快到像要蹦出来	肾上腺素让心率加快、收缩力增强	几分钟到十几分钟，随发作回落
胸闷、胸痛、喉咙发紧	呼吸肌和胸壁肌肉紧张，过度换气加重闷感	呼吸放慢后逐渐减轻
头晕、手脚发麻、指尖僵硬	二氧化碳排出过多，血中钙离子暂时偏低	呼吸放缓后缓解，不留后遗症
出汗、发抖、发冷或发热	交感神经兴奋，皮肤血流改变	发作结束后消退
不真实感，像隔着一层玻璃	注意力被警报占满，对外界加工变浅	往往最后才消退
害怕失控、害怕死掉	灾难化解释，是症状的一部分	不是预言，也不会因此“疯掉”

这些感受很难受，但需要说清楚：惊恐发作本身通常不会损伤心脏，也不会让人死亡。不过，“通常”不等于“这一次一定”。第一次发作、症状和以往不一样、或者本来就有心脏病的人，必须先让医生排除躯体急症，再谈“这是惊恐”。【指南】

第一次发作，先排除心脏病

这是本页最重要的一节。惊恐发作和心脏问题的症状高度重叠：都可能胸闷、心慌、气短、出汗、有濒死感。凭感觉区分不可靠，凭“我以前发作过”也不可靠，因为心脏病可以在有惊恐障碍的人身上第一次出现。

以下情况，不要先按惊恐处理，直接拨打 120 或去急诊：

- 第一次出现剧烈胸痛、压榨感、胸口像被石头压住，持续几分钟不缓解
- 胸痛放射到左臂、下巴、后背或上腹部
- 胸痛伴大汗、恶心、呕吐、呼吸困难
- 突然晕倒，或眼前发黑、差点摔倒
- 静息状态下严重气短，说不完整一句话
- 嘴唇或指甲发紫
- 心跳极快且不规则，同时头晕、胸闷
- 突然撕裂样的胸背痛
- 有冠心病、心肌病、心衰、心律失常病史，这次症状和以往不同

更像惊恐发作	更需要先排除躯体急症
几分钟内到高峰，二三十分钟缓解	胸痛持续十几分钟不缓解，或越来越重
以前发作过多次，模式相似	第一次发作，或这次明显不同
与情绪、拥挤、密闭空间有关	在运动、用力、寒冷、饱餐后出现
既往心电图和心脏检查正常	有心脏病、血压控制很差、糖尿病、吸烟史
疼痛位置会变，按压胸壁有压痛	疼痛固定、压榨样，伴大汗和恶心
发作后完全恢复	晕厥、说话含糊、一侧肢体无力、视物成双

还要提醒两类人：女性、老年人、糖尿病患者的缺血性心脏病表现常常不典型，可能只是“很累”“胃不舒服”“喘不上气”，不一定有典型胸痛；有心脏基础病的人也可能同时有惊恐发作，两者可以并存，不能因为“他有焦虑”就把新发胸痛归给焦虑。【指南】

现场怎么陪，怎么呼吸

家属最常犯的错，是在对方最害怕的时候讲道理。“你放松点”“别想了”“你就是太敏感”——这些话在平时也许无害，在发作时会被听成“你不理解我，连你也觉得我有问题”。

可以做	为什么	尽量不要做	为什么
留在旁边，用平常音量说话	稳定的存在比语言更有用	围着看、按住手脚	会加重被控制感和恐惧

可以做	为什么	尽量不要做	为什么
找一个安静、不拥挤的地方坐下	减少外界刺激	强行让人躺平	有些人躺下更晕、更慌
说短句：“我在”“慢慢来”	发作时处理长句的能力下降	喊“深呼吸！快呼吸！”	快速深呼吸会加重头晕和发麻
帮忙把注意力放到外面	打断对内感觉的过度扫描	用纸袋罩住口鼻	可能缺氧，早已不推荐
记下开始时间和变化	为就医提供信息	这时讨论病因、药物、停药	信息过载，只会更慌
发作后递水、陪着静一会儿	余波期需要恢复	追问“你刚才到底在怕什么”	像审问，容易让人羞耻

纸袋重复呼吸是很多老一辈的经验，但它可能造成缺氧，尤其对有心脏病、哮喘、慢阻肺的人危险，现代急救不建议使用。正确的方向是放慢呼吸，不是把二氧化碳吸回去。

“深呼吸”这三个字害过不少人。惊恐时呼吸中枢对二氧化碳特别敏感，越用力吸气，越容易变成大口快速喘气，头晕和发麻反而更重。可以试的是把呼气拉长：用鼻子轻轻吸气，心里数一到三；再用嘴或鼻子慢慢呼气，数一到四或一到五。呼气要比吸气长，但不要憋气，不要追求“吸满”。做三到五分钟，感觉头晕就停下来，恢复自然呼吸。重点是“慢”和“不费力”，不是“深”。【临床经验】

如果呼吸法让你更紧张，可以换成把注意力放到身体外部：说出眼前看到的五种东西、能听到的四种声音、能摸到的三种质地、能闻到的两种气味、能尝到的一种味道。这套“五感着陆”不是要赶走恐惧，而是给大脑一个别的任务，让警报有机会自己降下来。【临床经验】

现场可以照着做：

- ☐ 先扫一眼有没有本节列出的危险信号，有就拨打 120
- ☐ 找一个不拥挤的位置坐下，解开领口，不必躺平
- ☐ 用短句告诉对方“我在”，不追问、不评判
- ☐ 把注意力引到外部，而不是反复问“你哪里不舒服”
- ☐ 如果对方愿意，陪着把呼气拉长，不强迫
- ☐ 记下开始时间；缓解后递水，陪着静十分钟

需要提醒：这些方法是发作时的临时工具，不是长期治疗方案。如果每次出门都必须有人陪、必须带着药、必须坐在靠门的位置才敢出门，这些“安全行为”会维持恐惧，让回避范围越来越大。长期要靠 CBT 和内感受暴露，见 5.4 惊恐障碍的 CBT 与内感受暴露。

发作之后：记录、复盘、别加码

发作结束不代表事情结束。用十分钟做三件事，比反复回想有用：

- 记下开始和结束时间、当时在哪、在做什么、前一晚睡了多久、有没有喝咖啡或酒
- 记下最早出现的一个身体感觉，以及当时脑子里闪过的第一句话
- 记下这次有没有因为害怕而取消什么安排；如果有，记下准备怎么补回来

最后一条最容易被忽略。惊恐障碍真正让人失去生活的，往往不是发作那二十分钟，而是之后几个月里不断缩小的活动范围：不敢坐地铁、不敢去超市、不敢一个人在家。每一次因为害怕而回避，都会让大脑更相信“那个地方真的危险”。【指南】

发作当天不适合做重大决定：不要因此辞职、退学、分手，也不要在惊恐中自行加药、喝酒或开车。等情绪落下来，再和医生讨论。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 首次突发剧烈胸痛、压榨感，或胸痛超过十几分钟不缓解
- 胸痛伴大汗、恶心、呼吸困难、濒死感
- 晕厥、眼前发黑差点摔倒、意识不清
- 静息时严重气短、嘴唇发紫、说不出完整句子
- 心跳极快且不规则，伴头晕或胸闷
- 抽搐、说话含糊、一侧肢体无力

尽快联系医生（当天或次日）：

- 一周内多次发作，或发作越来越频繁
- 因为害怕发作开始回避工作、上学、出门
- 夜间被类似症状惊醒
- 发作时出现伤害自己的想法
- 正在服药，发作模式明显改变

需要马上有人陪，并拨打 12356 心理援助热线或去急诊：

- 惊恐之后出现“活着没意思”“不如死了”的念头
- 用酒精或超量药物来压住恐惧

常见问题与容易踩的坑

惊恐发作会死人吗？惊恐发作本身通常不导致死亡，也不会造成心脏损伤。但“这次是不是惊恐”不能靠自己判断，尤其是第一次、症状不典型、有心脏病风险的人，必须先排除躯体急症。【指南】

发作时能不能吃医生开的“急救药”？如果医生事先给过“发作时按需使用”的方案，按医嘱用，不要自行加量，也不要配酒。没有这样的方案，不要拿家人的药来试。

每次发作都去急诊，是不是太夸张？第一次、症状不典型、或和以往不同，去急诊是合理的。反复因同样的、已被医生评估过的发作跑急诊，会强化“我很危险”的信念，可以和医生一起做一张“发作应对卡”，写清什么情况去、什么情况在家处理。

家人不信这是病，怎么办？可以请家人一起复诊，让医生解释；也可以把本页和 2.2 惊恐发作与惊恐障碍 给家人看。争论“是不是装的”没有意义，重要的是下一次发作时有人知道该做什么。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NIMH. Anxiety Disorders. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

10.2 自杀风险与安全计划

> 这一页谈一个很难开口的话题。焦虑本身不一定带来自杀风险，但焦虑合并抑郁、长期失眠、酒精使用或强烈绝望时，风险会明显升高。它教家属怎么直接问、怎么判断紧急程度、怎么把安全计划和手段限制落到具体动作上，也说明为什么“你保证不自杀”不能代替专业评估。

焦虑合并抑郁时，风险为什么会升高

焦虑和抑郁经常一起出现。抑郁带来绝望、兴趣丧失、精力下降，焦虑带来失眠、坐立不安、灾难化的想法，两者叠加，人会觉得自己被困住了：既没有力气改变，也停不下来地担心。

惊恐发作时的濒死感和失控感，也会被误解成“我撑不下去了”。长期失眠会削弱判断力和情绪调节能力，酒精则先让人放松、再把人推向更深的低落和冲动。焦虑障碍本身也与自杀意念、自杀尝试的风险升高有关，即使排除了抑郁的影响，这种关联仍然存在。【研究】

需要强调：绝大多数有自杀念头的人并不是真的想结束生命，而是想让痛苦停下来。这个区分很重要，它决定了我们该做什么——不是讲道理劝“想开点”，而是降低痛苦、争取时间、把危险手段拿远。

风险升高的信号	保护因素
既往自杀未遂（最强的预测因素之一）	有稳定的家人、朋友或伴侣
家族中有自杀史	有明确的生活责任，如孩子、老人、宠物
强烈的绝望感、“没有出路”	愿意求助，愿意把念头说出来
合并抑郁、双相、PTSD、物质使用	正在接受治疗，规律复诊
长期失眠、冲动、极度激越	有宗教信仰或坚定的价值信念
独居、近期丧亲、失业、经济压力	手段不容易获得
能轻易拿到药物、农药、利器	与医生之间有信任关系
男性、高龄、近期出院	有孩子或其他需要他照顾的人

怎么直接问：问不会“教坏”对方

很多家属不敢问，怕“本来没想到，被我一问就想起来了”。现有的研究和临床经验都提示：平静、直接地询问自杀念头，不会增加风险，反而常常让人松一口气——终于有人愿意听，而且没有被吓跑。【研究】

旁敲侧击反而更危险。“你不会想不开吧”“你别吓我”这类问法，暗示这是禁忌，对方最容易回答“没有”。直接问，是把话题从暗处拿到明处。

不要这样问	可以这样问
“你不会想不开吧？”	“最近有没有想过不想活了？”
“你别吓我，你不会做傻事吧？”	“有没有想过具体怎么做？”
“你怎么能这么想，你考虑过我们吗？”	“是什么让你觉得撑不下去？”
“你答应我，绝对不做傻事。”	“如果那个念头变强，我们可以找谁？”

不要这样问	可以这样问
“想开点，大家都很难。”	“你现在最需要我做什么？”

问的时候，注意几件事：

- 找安静、不被打断的时间，坐下来问，不要一边做别的一边问
- 语气平静、直接，不惊讶、不评判、不急着安慰
- 顺着一条线问完整：有没有念头 → 有没有计划 → 有没有准备 → 有没有尝试过 → 现在打算怎么办
- 给对方时间，允许沉默，不逼着“马上说清楚”
- 不要承诺绝对保密。涉及生命安全时，保密有例外，这一点要提前说清楚
- 问完要接住：谢谢你告诉我，我们一起想办法

一个可以照着说的版本：“我注意到你最近很累，也很少说话。我想直接问你一个问题，因为我在乎你：你有没有想过不想活了？不管答案是什么，我都不会责怪你，也不会转身就走。”

风险分级：从念头到计划到准备

自杀风险不是一个“有或没有”的开关，而是一条从模糊念头到具体行动的线。下面这张表帮助家属判断紧急程度，但它不是诊断，判断不了就按更高一级处理。

级别	常见表现	该做什么
低	偶发念头，没有计划，没有准备，能说出原因，有支持	尽快预约精神科或心理治疗；做安全计划；家属保持联系；移除手段
中	念头频繁，有模糊计划，没有具体准备，情绪激动或绝望	当天联系医生或去精神科急诊；不要独处；做手段限制；缩短复诊间隔
高	有具体计划、时间、地点、方法，或已准备工具、写过告别的话	立即拨打 120 或去急诊，全程陪同，不让其独处，移除手段，必要时请 110 协助
极高	正在实施，或已经服药、割伤、站在高处、溺水	立即拨打 120，现场急救，保持气道通畅，不要让其独处

还有一种情况要特别警惕：一个极度绝望的人突然变得异常平静，开始交代后事、送东西、道歉、说“以后你们要好好的”。这不一定是“想通了”，也可能是已经下定决心。此时要提高警惕，直接问，并尽快就医。

安全计划与手段限制

安全计划不是一张保证书，而是一份“当念头变强时，我具体做什么”的预案。它通常包含六步，可以和医生、心理治疗师一起写，也可以由家属陪着填。

- ☐ 第一步：写下我的预警信号（例如连续三晚睡不着、开始查“怎么死”、把自己关起来）
- ☐ 第二步：写下我自己能做的三件事（例如冲冷水脸、出门快走十分钟、听固定的歌单）

- ☐ 第三步：写下能让我分心的人和地方（例如去客厅找家人、去楼下便利店、给朋友发消息）
- ☐ 第四步：写下我可以联系的两个人，附上电话号码
- ☐ 第五步：写下专业资源：主治医生、就近医院急诊、12356、120
- ☐ 第六步：写下环境安全措施：哪些东西要收起来、由谁保管

手段限制是安全计划里最具体、也最容易被跳过的一步。它的逻辑不是“监视”，而是“在风险最高的这段时间，把决定推迟”。

- 药物：由家人保管，只留当天需要的那一份；不要放在床头、包里或卫生间
- 利器：刀具、剪刀、剃须刀片收进锁柜
- 绳索、农药、百草枯等：农村家庭要特别检查储藏间和仓库
- 高处：锁好通往天台、阳台的门窗，移走可以攀爬的凳子
- 车钥匙：由家人保管
- 酒精：家里暂时不存酒，也不要在风险期劝酒
- 让信任的人知道，但不要到处宣扬；知情范围控制在“能帮忙的人”

为什么“保证不自杀”不能代替评估？因为承诺不能预测行为，也挡不住冲动。更糟的是，当家属反复要求“你保证”，患者为了不让家人担心，会学会说“我保证”，然后把真实念头藏起来。真正有用的是四件事：可执行的计划、能随时找到的人、被移走的手段、被治疗的症状。

家属可以说：“我不需要你保证永远不自杀，那太重了。我需要你答应我一件事：念头变强的时候，先告诉我，或者先打这个电话，给自己十分钟。”

家属常犯的错与需要特别注意的人

常见的坑：

- 把自杀话题当禁忌，觉得“不提就不会发生”
- 相信“说了就不会做”，或者相信“真想做的人不会说”，这两种说法都不对
- 用道德绑架：“你要是有个三长两短，我们怎么办”
- 二十四小时盯着人，却不带去治疗
- 患者说“我没事”，家属就真的放心了；直觉不对时，要相信直觉并找医生
- 把自伤说成“博关注”。自伤是痛苦的表现，也是后续风险的重要信号
- 家属自己硬扛，不求助；照顾者也需要支持

几类人需要额外留意：

- **青少年**：直接问，不要用“你就是叛逆”堵回去。注意自伤、校园霸凌、网络上的自杀相关内容、家庭冲突。家长要保管好药物，并和学校沟通。
- **老年人**：老年男性的自杀死亡比例较高，求助意愿却常较低。表现可能不是“我不想活”，而是“没意思”“活着拖累你们”“身体到处不舒服”。独居、丧偶、多重用药都要留意。

- **产后**：产后焦虑和抑郁常同时出现。要问“有没有想过伤害自己，或者伤害孩子”。产后精神病（幻觉、妄想、极度混乱）是急症，立即去急诊。
- **双相障碍**：抑郁期和混合期风险高，抗抑郁药可能诱发转躁。不要只按抑郁或焦虑治，需要精神科评估。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去最近医院急诊：

- 已经有自杀计划、准备了工具、写好了告别的话
- 正在实施自杀行为，或已经服药、割伤、溺水、从高处坠落
- 出现幻觉、妄想、极度混乱，或听到命令自己去死的声音

立即拨打 110 请求协助：

- 当事人拒绝就医、正在离开、或你无法保证其安全

当天联系医生或去精神科急诊：

- 自杀念头频繁出现，或明显比之前强烈
- 情绪突然“平静”得反常，开始交代后事
- 严重失眠、激越、无法进食，或酒精使用明显增加

拨打 12356 心理援助热线：

- 你需要有人陪着梳理思路，或不知道该找谁
- 当事人愿意谈，但还不想去医院

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（仅用于焦虑合并抑郁）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

10.3 苯二氮䓬依赖、戒断与酒精

> 这一页讲三件经常被混在一起的事：苯二氮䓬类药物的依赖、停药后的戒断反应，以及酒精在焦虑里扮演的角色。很多患者一边担心“吃上就戒不掉”，一边又偷偷减药；很多家属一边劝“少喝点”，一边不知道酒精戒断可能致命。读完你能分清依赖和成瘾、认出危险信号，也知道为什么必须在医生指导下减量。

依赖不是成瘾：先把两个词分开

“依赖”和“成瘾”在生活里常被当成一个词，在医学上不是。依赖更接近“身体适应了”：长期用药后，身体调整了受体的数量和敏感度，突然停药就会出现一组不舒服的反应，这叫戒断或撤药反应。成瘾更接近“控制力出了问题”：明知有害还停不下来，剂量越用越大，花大量时间找药，工作、关系、健康都受影响。

身体依赖	成瘾（物质使用障碍）
身体习惯了药物，停药出现戒断	失控使用、强烈渴求、明知有害仍继续
按医嘱、按治疗剂量使用也可能出现	常伴囤药、撒谎、到处找药、加量
减量要慢，通常可以减下来	需要成瘾专科治疗，常需长期支持
不代表意志薄弱，也不是道德问题	同样是疾病，不是“人品差”

这个区分很重要。很多患者按医生开的剂量吃了几个月，停药后心慌、失眠、手抖，就以为自己“染上毒瘾了”，羞愧得不敢告诉医生，于是自己偷偷减、反复停，反而更危险。实际上，这更可能只是身体依赖带来的戒断反应，是可以被识别、被处理的。【指南】

苯二氮䓬类的作用点是大脑的 GABA-A 受体，它让“刹车”更强，所以起效快、抗焦虑和助眠效果明显。问题也在这里：受体长期被加强，会逐渐适应，同样的剂量效果变差，这叫耐受；停药时刹车突然变弱，神经系统反跳，就容易出现戒断。半衰期较短的药（如阿普唑仑）起效快、消退也快，反跳往往更明显；地西泮、氯硝西泮等长半衰期的药撤药相对平缓，但容易在体内蓄积，老年人更明显。【指南】

戒断反应：从反跳性焦虑到抽搐

戒断反应不只是“心里难受”。它可能涉及焦虑、睡眠、感觉、肌肉和自主神经，严重时会出现癫痫和谵妄。出现的时间取决于药的半衰期：短效药可能在停药后几小时到一两天就开始，长效药可能拖到几天后才明显。

出现时间	常见表现	危险程度
停药后数小时到数天	反跳性焦虑、失眠、心慌、出汗、手抖、怕光怕吵	很难受，通常不致命，但容易误判为复发
数天到两周	肌肉抽动、头痛、耳鸣、注意力涣散、恶心、感知异常	需要医生调整减量计划
数天到数周	抑郁加重、惊恐发作、易怒、冲动、失眠持续	需要评估，必要时暂缓减量

出现时间	常见表现	危险程度
突然停用高剂量后	癫痫发作、意识混乱、幻觉、高热、极度激越	可致命，立即拨打 120

戒断反应最麻烦的地方，是它和原来的焦虑长得太像。停了药以后心慌、失眠、担心，人很自然就认为“病又回来了”，于是把药吃回去，甚至加量。下一次再想减，身体记得上一次的难受，会更害怕。如此反复，剂量可能越走越高。

所以不能硬停，原因至少有三条：

- 突然停用高剂量苯二氮䓬可能诱发癫痫、谵妄、高热，这些是会危及生命的急症
- 反复“停了又吃”可能让戒断一次比一次难，这个现象在临床上被观察到，机制研究仍有限【待验证】
- 硬停期间的焦虑会被误认为复发，导致治疗方向被带偏

正确的做法是：在医生指导下制定减量计划，缓慢、分阶段地减；同时用抗抑郁药、心理治疗处理原本的焦虑，而不是只靠把药拿掉。

酒精：短期像药，长期是放大器

酒精是中枢神经抑制剂。喝下去的最初一两个小时，它确实能让人放松、话多、容易入睡，所以很多人把它当成“最便宜的抗焦虑药”。问题是，这种效果很短，代价很长。

酒精代谢后会出现反跳：心跳加快、出汗、焦虑回升、睡眠变浅、凌晨早醒。长期饮酒会改变 GABA 和谷氨酸系统的平衡，让大脑的“刹车”和“油门”都变得不稳定，焦虑、抑郁、惊恐反而更频繁。于是形成“越焦虑越喝，越喝越焦虑”的循环。【指南】

短期效果	几小时后的反跳	长期代价
放松、话多、容易入睡	心跳快、出汗、焦虑回升	耐受，需要更多酒才有同样效果
暂时忘记担忧	凌晨早醒、噩梦、睡眠破碎	抑郁加重，惊恐发作更频繁
社交时没那么紧张	第二天更怕被评价	社交回避加重，靠酒才能出门
暂时压住手抖	手抖反弹更明显	酒精使用障碍，肝功能损害

还有两个常被忽略的风险：酒精与苯二氮䓬、阿片类止痛药、抗组胺药一起用，会加重镇静和呼吸抑制，可能让人昏睡、摔倒、误吸，甚至呼吸停止；用酒助眠的人，往往睡得更浅、更累，第二天更需要酒。

酒精戒断可能致命，不要在家硬扛

长期大量饮酒的人突然完全停酒，可能出现酒精戒断。轻的手抖、出汗、焦虑、恶心、失眠；重的会出现幻觉、癫痫，甚至震颤谵妄——意识混乱、高热、大汗、极度激越，可能致命。

程度	常见表现	该怎么做
轻度	停酒后六到十二小时手抖、出汗、焦	尽快就医评估，不要自行硬扛

程度	常见表现	该怎么做
	虑、恶心、失眠	
中度	停酒十二到二十四小时出现幻觉、心跳快、血压高、烦躁	去急诊或住院，可能需要药物替代和补液
重度	停酒十二到四十八小时可能癫痫发作，四十八到九十六小时可能震颤谵妄，出现高热、意识混乱	立即拨打 120，可致命

酒精戒断的处理不只是“忍过去”。医生可能会用苯二氮䓬类替代并逐渐减量，补充液体和电解质，补充维生素 B1 以预防韦尼克脑病，处理低血糖、低镁等问题。这些都需要医疗监护，家里做不到。【指南】

所以有三句话要说清楚：不要自行突然停酒；不要用“少喝一点”“换啤酒过渡”来处理；不要用镇静药自己配着戒酒。如果本人不愿意就医，家属可以联系 120、110 或当地精神卫生服务机构求助。

医生指导下的减量：它长什么样

减量不是“每隔几天减一点”那么简单，它是一个需要评估、计划和随访的过程。可以期待医生做这些事：

- 评估用了多久、什么药、多大剂量、半衰期长短、以前有没有戒断史
- 评估有没有合并酒精、阿片类、其他镇静药的使用
- 评估年龄、肝功能、肾功能、跌倒风险、是否怀孕
- 制定个体化计划：可能换成长半衰期的药，可能分阶段减，速度因人而异
- 同时治疗原发焦虑：抗抑郁药、CBT、睡眠调整，避免“减下来又因为焦虑吃回去”
- 安排更密的复诊，尤其是在减量的后段
- 告诉你哪些症状要立刻报告，哪些可以观察

具体减多少、多久减一次，必须由医生根据你的情况决定，本页不给数字。可以确定的是：通常以周或月为单位，缓慢分阶段，最后阶段更慢；不要隔天吃，不要自己掰药，不要一次改好几件事。

减量期可以这样记录，复诊时带给医生：

- ☐ 每天的用药时间和实际用量
- ☐ 睡眠：入睡时间、夜醒次数、总时长
- ☐ 焦虑程度：0 到 10 分打一个分
- ☐ 戒断症状：心慌、手抖、出汗、头晕、感知异常
- ☐ 有没有喝酒、喝咖啡、吃其他药
- ☐ 有没有因为难受而自行加量

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 停药或减量后出现抽搐、意识混乱、幻觉、高热
- 停酒后出现震颤谵妄、癫痫、极度激越
- 呼吸变慢、叫不醒、呕吐后误吸
- 严重跌倒、头部外伤、大量出血

当天联系医生：

- 减量后心慌、失眠、手抖明显加重，影响进食和睡眠
- 出现新的抑郁、绝望或伤害自己的想法
- 想自己加快减量，或已经自行减了一半
- 发现怀孕，或准备怀孕

拨打 12356 心理援助热线：

- 减药过程中焦虑难忍，需要有人陪着梳理
- 对药物依赖感到羞耻、不敢面对医生

常见问题与容易踩的坑

“我是按医生开的量吃的，怎么会依赖？”依赖可以在治疗剂量下发生，尤其是连续使用数周以上。这不等于你“意志薄弱”，也不等于医生开错了，而是这类药本身的特性。发现得早、减得慢，通常可以处理。【指南】

“能不能自己先减一半？”不建议。减得太快可能诱发戒断，甚至癫痫。把想法告诉医生，让医生帮你安排节奏。

“隔天吃是不是就戒了？”隔天吃会让血药浓度忽高忽低，反跳更明显，也更容易难受。减量方案要由医生定。

“喝酒能不能帮助戒药？”不能。酒精会加重焦虑和失眠，还会和苯二氮䓬叠加抑制呼吸，是用一个更大的问题盖住另一个问题。

“抗抑郁药是不是也成瘾？”不是。SSRI/SNRI 没有苯二氮䓬那样的依赖和成瘾模式，但突然停药也可能出现撤药反应，同样需要缓慢减，见 11.3 停药计划与撤药管理。

“中药、保健品能不能替代？”目前没有可靠证据表明它们可以替代苯二氮䓬的减量管理。不要自行用保健品替换处方药，尤其是正在减量的人。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

10.4 血清素综合征、跌倒与驾驶风险

> 抗焦虑药大多数时候是安全的，但有几类风险需要提前知道：血清素综合征、心电图上的 QT 间期延长、血钠偏低、跌倒，以及服药后开车和操作机器的风险。这一页不吓人，也不轻描淡写，而是把“什么情况要立刻就医、什么情况要冲急诊、什么情况只是需要调整”分开讲清楚。读完你应该能和医生一起，把这些风险提前排掉。

血清素综合征：少见，但可以很重

血清素综合征是血清素（5-羟色胺）在体内过多引起的一组药物不良反应。它通常不是“吃一种药吃久了慢慢出现”，而是发生在几个特定时点：刚开始一种血清素能药物、加量、同时用两种以上这类药、过量服药，或者换药时间隔不够。【指南】

常见的组合包括：SSRI 或 SNRI 与曲马多（一种止痛药）、曲坦类（偏头痛药）、MAOI、圣约翰草、锂盐、亚甲蓝、部分止吐药合用；也包括可卡因、安非他命、摇头丸等娱乐性药物。有些抗生素（如利奈唑胺）也有血清素能作用。很多人不知道中成药、减肥药、感冒药里也可能含有相关成分，所以就诊时要把所有正在吃的东西都告诉医生。

它不是“血清素越高越健康”那种养生说法。血清素过多会让神经系统的兴奋性失控，轻的手抖、出汗、腹泻，重的会出现高热、肌肉强直、意识改变，甚至危及生命。

怎么认：三类症状一起看

血清素综合征的典型表现可以归成三组。三组同时出现，尤其是最近刚加药或加了新药，要高度怀疑。

三类表现	具体可能看到什么
精神状态改变	焦虑激越、坐立不安、话多、意识模糊、谵妄
自主神经不稳定	发热、大汗、心跳快、血压高、瞳孔散大、腹泻、恶心
神经肌肉异常	震颤、肌肉僵硬、反射亢进、阵挛、眼球震颤

“阵挛”是指肌肉一阵一阵地抽动，比如脚踝被快速向上扳时，脚背出现几次节律性的抽动。它是比较有特征的表现，但普通人不必自己查体，怀疑就应该去医院。

程度	表现	该怎么做
轻	震颤、腹泻、出汗、瞳孔偏大、反射活跃，人还清醒	暂停下一次服药，尽快联系医生或去急诊
中	明显激越、眼球阵挛、反射亢进、心跳快、发热	立即去急诊，不要在家观察
重	谵妄、肌肉强直、高热、休克、抽搐、横纹肌溶解	立即拨打 120

症状通常在开始用药或加量后二十四小时内出现，多数在几小时内进展。这一点很关键：如果刚换了药、刚加了量，随后出现发热、大汗、抖动、意识不对，不要等“明天看看”。

和什么区分：别把所有发抖都当成血清素综合征

血清素综合征容易被和几种情况混淆：

- **恶性高热**：与麻醉药有关，通常发生在手术中或术后，普通人日常用药不会遇到
- **抗精神病药恶性综合征**：进展较慢，以肌肉强直、意识改变、发热为主，和抗精神病药相关
- **抗胆碱能中毒**：皮肤干、不出汗、瞳孔大、尿潴留、口干明显
- **感染或败血症**：有感染灶、畏寒寒战、白细胞升高等
- **惊恐发作**：会心慌、出汗、发抖，但不会出现高热、肌肉强直、阵挛和意识改变

普通人不需要自己鉴别。要记住的是一条：**发热 + 肌肉僵硬或抽动 + 意识改变，同时最近动过药，就是急诊信号。**

QT 间期延长与低钠：两个“查血查心电图”才能看见的风险

QT 间期是心电图上的一段，代表心脏电活动“复位”的时间。某些药物会让它变长，增加一种叫尖端扭转型室速的严重心律失常风险，可能引起晕厥，极少数情况下猝死。风险不高，但可以提前识别。

可能延长 QT 的药物包括：西酞普兰和艾司西酞普兰（与剂量相关）、文拉法辛、三环类抗抑郁药、部分抗精神病药、美沙酮、昂丹司琼、部分大环内酯类和喹诺酮类抗生素、唑类抗真菌药等。风险在以下情况更高：先天性长 QT、心脏病、心跳过慢、低钾或低镁、女性、高龄、同时用多种延长 QT 的药、肝肾功能不全、进食障碍或反复呕吐。

需要警惕的症状是心悸、头晕、眼前发黑、晕厥、抽搐。**晕厥一次就要去急诊**，不要只说“我可能是低血糖”。有心脏病、晕厥史、家族中有人年轻猝死、或需要合并多种药的人，医生可能会安排心电图和电解质检查，这是常规的风险管理，不是“过度检查”。

低钠血症是另一件容易被忽略的事。SSRI 和 SNRI 可能导致抗利尿激素分泌过多，血钠被稀释，出现低钠。它更容易发生在治疗开始后的前几周、加量后、老年人、体重偏低的人、同时用利尿剂的人身上。

低钠的表现不特异：乏力、头痛、恶心、食欲差、注意力下降、走路不稳、意识模糊，严重时会抽搐、昏迷。家里有老人刚开始吃抗抑郁药，如果两三周内变得“没精神、反应慢、走路发飘”，不要只当成“年纪大了”，要查血钠。【指南】

跌倒与驾驶：每天都要面对的风险

跌倒看起来不如血清素综合征“吓人”，却是抗焦虑药最常见的实际伤害，尤其在老年人身上。苯二氮䓬类、Z 药（唑吡坦等）、抗组胺药、曲唑酮、部分镇静性抗抑郁药，都会让人嗜睡、反应变慢、平衡变差、血压偏低。夜里起夜、浴室地滑、地面有杂物、视力不好、同时吃多种药，都会把风险放大。跌倒导致的髋部骨折，对老年人可能是一次生活能力的断崖。

家里可以这样做：

- ☐ 床边放夜灯，走道不要堆杂物
- ☐ 浴室铺防滑垫，装扶手
- ☐ 起夜时先在床边坐半分钟，再站起来
- ☐ 穿合脚、防滑的鞋，不穿拖鞋走远路
- ☐ 常用物品放在伸手可及的高度，不爬凳子
- ☐ 把正在吃的所有药列一张清单，复诊时请医生看有没有重复的镇静药
- ☐ 如果最近摔过，或走路开始不稳，尽快告诉医生

驾驶和操作机器的风险来自三处：药物带来的嗜睡和反应变慢、焦虑本身占用的注意力、以及惊恐发作时突然的头晕和视线模糊。开始用一种新药、加量、换药后的头几天，风险最高；即使“吃久了习惯了”，也不代表完全没有影响。

- ☐ 开始新药或加量后，先观察自己的反应，必要时几天内不开车
- ☐ 感到困倦、头晕、反应慢、视物模糊时，不开车
- ☐ 不酒后驾车，也不用酒精去“压”药物的副作用
- ☐ 长途、夜间、恶劣天气更谨慎，必要时休息
- ☐ 职业司机、操作重型机械或高空作业的人，提前告诉医生
- ☐ 开车时如果惊恐发作，打转向灯靠边停，开双闪，等缓解再走
- ☐ 不隐瞒用药情况；具体限制以当地法规和医生意见为准

高危人群与几个常见疑问

人群	主要风险	要点
65 岁以上	跌倒、低钠、QT、多重用药	低剂量起始、加量慢、复查电解质、尽量少用镇静药
孕产期	用药与不治疗的权衡	不自行停换药，和产科、精神科一起讨论
青少年	血清素综合征、冲动、自伤	家长保管药物，留意合并用药和网络购药
肝肾功能不全	药物蓄积、QT、低钠	就诊时主动告知，按医生安排监测
心脏病或长 QT	QT 延长、晕厥	查心电图，避免自行合用延长 QT 的药
进食障碍、反复呕吐、用利尿剂	低钾低镁，放大 QT 风险	纠正电解质，别自行补钾

人群	主要风险	要点
有物质使用	血清素综合征、呼吸抑制	如实告诉医生，不要隐瞒

几个常见疑问

“吃 SSRI 是不是都会得血清素综合征？”不会。它总体少见，多数与合并用药、过量、换药间隔不足有关。按医嘱服药、不自行加药、不随便加用止痛药和保健品，是最有效的预防。

“我感觉好多了，能不能自己加一点量？”不能。加量要由医生决定，尤其是西酞普兰这类与 QT 相关的药。

“吃抗焦虑药能不能喝酒？”不推荐。酒精会加重嗜睡和判断力下降，也会加重焦虑反跳。

“开车前吃一片抗焦虑药可以吗？”如果吃了让人困倦的药，就不要开。需要长期开车的人，提前和医生讨论用药时间。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 高热，同时肌肉僵硬、抽动、意识改变，且最近加过药或换过药
- 抽搐、晕厥、意识不清
- 心跳极快且不规则，伴头晕、胸闷
- 严重过敏：皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难
- 跌倒后不能站起、髋部疼痛、头部受伤后呕吐或嗜睡

当天联系医生：

- 新加药后出现发热、大汗、抖动、腹泻
- 老年人加药后乏力、反应慢、走路不稳、意识模糊
- 心悸、头晕、眼前发黑，但还没有晕倒
- 准备开车、操作机器，或职业需要，想确认用药影响

拨打 12356 心理援助热线：

- 因为担心副作用而不敢吃药，或想自行停药
- 吃药后情绪明显变差，出现伤害自己的想法

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- 国家药品监督管理局批准的药品说明书（以当前版本为准）.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 11：疗程、复发与停药

焦虑治疗最容易被低估的是“好了之后还要走多久”。这一模块讲足疗程、维持和停药。

11.1 为什么要足疗程

> 这一页讲一个最容易被低估的问题：症状好转之后，治疗还要走多久。很多人“好了就停”，几个月后又回到原点，还以为是自己不够坚强。读完你能分清应答、缓解和复发，理解急性期、巩固期、维持期各自在做什么，也能和医生一起判断“现在够不够”，而不是凭某一天的心情决定。

先分清四个词：应答、缓解、康复、复发

治疗焦虑时，医生说的“好”，和你感觉的“好”，常常不是一回事。至少要把四个词分开。

术语	大白话	大致含义	常见误用
应答	好了一些	症状比治疗前明显减轻，常以量表下降一半左右作参考	把“好一些”当成“好了”
缓解	基本好了	症状降到很轻或消失，并持续数周	把“这几天不错”当成缓解
康复	长期稳定	缓解维持足够久，工作、学习、社交、睡眠都恢复	把“康复”当成“永不复发”
复发	又回来了	缓解期内症状再次达到诊断标准	把撤药反应当成复发

量表分数只是参考。一个人 GAD-7 从重度降到轻度，但依然不敢一个人出门，这不叫缓解；反过来，分数不算低，但已经能上班、能睡觉、能社交，也不能只看数字说“没进步”。症状、功能、回避范围，要一起看。【指南】

过早停药会发生什么

“过早”不只是“吃的时间短”，也包括：症状刚缓解就停、急性期还没结束就减、不跟医生商量自己停、因为副作用自己停。

代价通常不是立刻显现，而是过几个月才回来：

- **复发风险升高。** 焦虑障碍在停药后复发并不少见，很多发生在停药后的数月内。缓解后继续治疗一段时间，正是为了把这段高风险期度过去。【指南】
- **撤药反应被误认为复发。** 停药后头晕、心慌、失眠、易怒，可能只是撤药，却让人以为“病又重了”，于是把药吃回去、加量，治疗节奏被打乱。
- **每一次复发可能更难恢复。** 有研究提示反复发作后治疗反应可能变差，这个“kindling”假说在焦虑领域证据仍有限，但临床上确实常见“一次比一次难”的情况。【待验证】

- **功能损害会累积。** 辞职、休学、关系破裂、经济压力，这些不会因为症状后来好转就自动消失。
- **对治疗失去信心。** 反复“好了又犯”，很容易得出“这病治不好”的结论，而真正的原因可能是疗程不够。

三个阶段：急性期、巩固期、维持期

焦虑的治疗通常不是一条直线，而是分阶段推进。不同阶段的目标不一样，停药的时间点也不一样。

阶段	大致时间	主要做什么	常见误区
急性期	数周到三个月	控制症状、恢复基本功能；药物起始与调整、开始CBT、排除躯体原因、处理失眠	吃几天没效就换药
巩固期	缓解后至少数月	把缓解稳住；保持有效治疗、继续暴露和认知练习、处理残留症状	感觉好了就减量
维持期	通常六到十二个月，反复发作者更长	预防复发、重建生活；继续治疗、规律复诊、做复发预防计划、调整生活方式	把维持当成“多余的治疗”

具体时长因人而异。首次发作、缓解彻底、功能恢复好的人，可能相对短一些；反复发作、有残留症状、合并抑郁或物质使用、起病早、家族史明显的人，往往需要更长。【指南】

这里要纠正一个常见误解：焦虑治疗常需数月到更久，不是“吃两周就好了”。SSRI/SNRI 起效通常要几周，心理治疗也以周为单位推进。把“几个月”当成“太久”，是很多人中途放弃的原因。

足疗程不只是吃药

足疗程不等于“把药吃够”。它至少包括三件事：药物、心理治疗、生活重建。

“感觉好了”为什么不等于“病好了”？ 症状消失，只说明警报暂时安静了；大脑对威胁的评估方式、遇到压力时的反应模式，可能还没变。回避行为还在、安全行为还在、睡眠还浅，这些都是复发的土壤。药物的起效和大脑受体的适应也不同步，血药浓度稳定了，不等于回路已经稳定。

心理治疗也有疗程。 CBT 通常每周一次，十几次到二十次左右，具体看问题和进度。暴露需要分级、重复、停留足够时间；认知练习需要变成习惯。提前结束、不做作业、只“聊聊天”，效果会打折。团体治疗、正念、ACT 也各有节奏，不是“上过几次课就学会了”。

生活重建需要练习。 回到工作、回到学校、重新坐地铁、重新参加聚会，这些不会因为症状消失就自动发生。很多人症状好了，却因为几个月的回避，仍然不敢出门，这不算真正恢复。

药物和心理治疗不是二选一。对中重度焦虑，两者联合常常比单用更有效；对轻度焦虑，心理治疗可以作为首选。【指南】

怎么判断“够不够”

不要靠“我今天感觉不错”来判断。和医生一起看四件事：症状的趋势、功能的恢复、回避范围的变化、以及过去复发的次数。

下面这份清单可以在复诊前自己过一遍：

- ☐ 我知道自己现在处在急性期、巩固期还是维持期
- ☐ 我能说出最近两周症状是在减轻、持平还是加重
- ☐ 我的睡眠、食欲、精力是否恢复
- ☐ 我能上班或上学吗？能独立出门吗？能参加社交吗？
- ☐ 我的回避范围在缩小，还是在扩大
- ☐ 我有没有因为“感觉好了”自行减量或停药
- ☐ 我有没有一份写下来的复发预警清单
- ☐ 我知道如果复发，第一步该找谁

如果其中两三项答不上来，说明还没到可以谈停药的时候，先和医生把这些问题补齐。

容易踩的坑

“是药三分毒，早点停。”药物的风险要管理，但不是靠提前停来管理。突然停可能带来撤药反应和复发，反而需要更长时间治疗。

“我已经好了，不用复诊。”复诊不只是开药。它还在看残留症状、副作用、生活变化和复发信号。巩固期和维持期的复诊可以拉长间隔，但不宜完全消失。

“心理治疗就是聊天，随时可以停。”结构化心理治疗有进度和作业。中途停下，往往停在最难的那几步之前。

“我怕依赖，所以自己减。”怕依赖是合理的，但自己减不等于安全。把担心告诉医生，让医生帮你判断是继续、调整还是减量。

“上次有效的药，这次自己买。”每次复发的情况可能不同，合并用药、身体状况、副作用风险都要重新评估。不要凭经验自行用药。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 自行停药后出现抽搐、意识混乱、高热、极度激越
- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了计划
- 严重过敏、晕厥、剧烈胸痛

尽快联系医生（当天或次日）：

- 症状明显回升，或回避范围扩大
- 因为副作用想停药，或已经自行减量
- 睡眠连续多天明显变差，情绪持续低落
- 准备怀孕、发现怀孕，或合并了新的躯体疾病

拨打 12356 心理援助热线：

- 对“要吃多久”感到绝望，想放弃治疗
- 复发后自责、不敢面对医生

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

11.2 维持治疗与复发预防

> 焦虑治疗里最容易松劲的一段，是“已经好得差不多了”的时候。症状退了，日子忙起来，复诊一拖再拖，药也慢慢停了——然后某天发现，心慌、失眠、担忧又回来了。这一页讲维持治疗到底在维持什么、哪些人需要更久、复发有哪些早期信号，以及怎么把药物、心理治疗和生活方式接成一张网。

维持治疗在维持什么

维持治疗不是“多吃一段时间”，也不是医生保守。它做的是三件事：把已经获得的缓解固定下来、让大脑的应激系统有时间恢复稳定、把因为生病而缩小的生活重新撑开。

焦虑障碍的病程常常是波动的。生活里的事件——换工作、考试、搬家、亲人去世、生病、怀孕——都会让焦虑回升。维持期的治疗像一层缓冲：同样的压力落下，有治疗撑着的人更不容易被推回诊断标准，即使回升，也更容易早发现、早处理。【指南】

还有一点常被忽略：维持期是练习期。药物把症状压下去以后，人才有力气去做暴露、去重建社交、去恢复工作。如果这时候把治疗全部撤掉，练习也往往跟着停。

维持多久：一般原则与需要更长的人

没有一个适用于所有人的天数。医生通常会看四件事：这是第几次发作、缓解得彻不彻底、有没有残留症状、生活是否稳定。下面是一张粗略的参考表，不是处方。

情况	维持时间的大致方向	理由
首次发作、缓解彻底、功能恢复好	缓解后六到十二个月	复发风险相对低，但仍需度过高风险期
反复发作两次以上	数年，甚至更久	每次复发都会增加下一次的风险
有残留症状（睡眠差、易紧张、回避）	更长，先处理残留	残留症状是复发的预测因素
合并抑郁、物质使用、失眠	更长，且分别治疗	共病会互相维持
家族史明显、起病早、病程长	更长	生物学易感性更高
生活压力大、支持少	更长，同时加强心理治疗	环境负荷高
老年人、孕产期	个体化	代谢、用药安全、激素变化都不同

“维持”不等于“终身吃药”。很多人可以在医生指导下，经过足够长的稳定期后缓慢减停；也有人需要更长期的治疗。这两者都是合理的，取决于病情，不取决于“意志力”。【指南】

复发的早期预警信号

复发很少是某天突然发生的，它通常先派几个“先遣部队”。越早认出来，处理越轻。

- ☐ 睡眠变浅、早醒、入睡困难，持续超过几天
- ☐ 担忧的时间变长，停不下来，开始影响工作
- ☐ 开始回避以前能做的事：地铁、超市、会议、聚会
- ☐ 心慌、胸闷、手抖、头晕等躯体症状回来

- ☐ 易怒、坐立不安、注意力下降
- ☐ 咖啡因、酒精、尼古丁的用量增加
- ☐ 反复查身体、反复查资料，越查越怕
- ☐ 出现“我是不是又要犯了”的念头，并因此更焦虑
- ☐ 不想复诊，想自己减药或停药
- ☐ 情绪低落、兴趣下降、觉得拖累别人

如果同时出现两三项，并持续一周以上，建议提前复诊，不要等“严重了再说”。这时候调整治疗，往往比复发后再治容易得多。

复发预防的四根柱子

支柱	具体做什么	谁来做
药物维持	按医嘱服药、不漏服、不自行减量	患者与医生
心理治疗与技能	继续暴露、认知练习、做复发预防计划	患者与治疗师
生活方式	睡眠、运动、咖啡因、酒精、压力管理	患者
支持与监测	家人、规律复诊、量表、预警清单	患者、家属与医生

四根柱子缺一根，房子未必立刻倒，但抗压能力会下降。最常见的情况是：药吃了，心理治疗停了；或者心理治疗做完了，生活方式一团糟；或者什么都做了，但不再复诊，直到复发才回来。

心理治疗的衔接尤其重要。CBT 结束前，通常会和治疗师一起做一份“复发预防计划”：列出预警信号、写一张应对卡、保留暴露练习清单、约定结束后几个月怎么自查。治疗结束后，可以在第一个月、第三个月、第六个月、第十二个月各回顾一次。遇到可预见的压力事件（比如换工作、考试、手术），提前把练习加回来，而不是等发作了再补救。

生活方式与一份自己的复发预防计划

生活方式不是治疗的配角。睡眠不足会直接放大焦虑，咖啡因会模拟心慌，酒精先压后弹，久坐和缺乏运动让压力更难代谢。这些因素单独看都很小，叠在一起足以把一个人推过阈值。

可以落地的几件事：

- 固定起床时间，比固定入睡时间更容易做到
- 每周规律运动，从快走开始，不追求强度
- 下午以后少喝咖啡、浓茶、能量饮料
- 不用酒助眠、不用酒压焦虑
- 戒烟可以安排在病情稳定期，必要时和医生讨论
- 保持固定的人际接触，哪怕只是每周一次散步
- 留出“什么都不做”的时间，而不是把日程排满

下面是一份可以自己填的复发预防计划，建议写下来，放在随手能拿到的地方：

- 我的预警信号是：_____
- 我第一时间会联系的人：_____（姓名、电话）
- 我自己能做的三件事：_____
- 我的医生和下次复诊时间：_____
- 我正在吃的药和过敏史：_____
- 复发时要避免的事：喝酒、熬夜、自行加药、独自硬扛
- 如果出现自杀念头，我的安全计划是：见 10.2 自杀风险与安全计划

容易踩的坑

“好了就停。”“好了”通常只是症状缓解，不是风险结束。停药要按计划来，见 11.3 停药计划与撤药管理。

“我怕一辈子吃药。”维持治疗不等于终身。很多人能在足够稳定后减停；也有人需要长期低强度维持。把担心说出来，和医生讨论，而不是自己停。

“复发就是前功尽弃。”复发不是回到原点。你已经有的技能、对症状的理解、和医生的关系都还在，处理起来通常比第一次快。

“上次的药这次自己买。”不建议。复发时的身体状况、合并用药、副作用风险都要重新评估。

“心理治疗做完了，就万事大吉。”技能不用会退化。把暴露和认知练习当成像刷牙一样的事，定期做。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了计划
- 自行停药后出现抽搐、意识混乱、高热
- 严重过敏、晕厥、剧烈胸痛

尽快联系医生（当天或次日）：

- 复发预警信号同时出现两三项，持续一周以上
- 症状明显加重，回避范围扩大
- 想减药或停药，或已经自行减量
- 生活里发生重大变化（丧亲、失业、离婚、重病）

拨打 12356 心理援助热线：

- 复发后自责、羞耻，不敢联系医生
- 夜里焦虑难忍，需要有人先说说话

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（仅用于焦虑合并抑郁）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

11.3 停药计划与撤药管理

> 这一页讲停药。停药不是“不想吃了就不吃”，也不是“吃够时间就必须停”，而是一次需要计划的调整：什么时候可以考虑、先做哪些准备、怎么慢减、怎么区分撤药反应和复发、停药后怎么监测。读完你能和医生一起做一份属于自己的停药计划，而不是靠感觉硬扛。

什么时候可以考虑停药

停药的前提不是“我受够了”，而是“病情稳住了，而且稳得够久”。医生通常会一起看这几条：

- 症状缓解已经持续足够久，不是刚好了两三个星期
- 工作、学习、社交、睡眠等基本功能恢复，生活能正常运转
- 近期没有可预见的大变动，比如考试、搬家、换工作、丧亲
- 残留症状很轻，或者已经处理过
- 你对停药后的监测和复诊有准备，愿意放慢速度
- 这个决定是你和医生一起做的，不是因为怕依赖、别人劝、或者药快吃完了

有些时候，还不适合谈停药：刚缓解不久、最近刚经历重大压力、复发过多次、残留症状明显、合并抑郁或物质使用还没控制、怀孕计划还没和医生讨论过。这些情况下，先稳住，比“尽快停掉”更重要。【指南】

也要说清楚：停药不是必须完成的任务。有些人需要在医生指导下长期维持，这是合理的治疗选择，不是“失败”。

停药前要做的准备

停药能不能顺利，很大程度取决于开始之前的准备。

准备	为什么	怎么做
选时间	压力期减量更容易失败	避开考试、搬家、换工作、丧亲、手术
告诉家人	需要有人观察和支持	让至少一个人知道你的计划和预警信号
记录基线	以后才能分清撤药和复发	停药前两周记录睡眠、焦虑、躯体症状
约好复诊	减量期需要更密的监测	提前预约，不要等出问题才找医生
心理治疗衔接	提供技能支持	继续暴露和认知练习，必要时加几次巩固
了解自己的药	半衰期、剂型、能否掰开	问医生或药师，不要自己处理

还有一件常被忽略的事：把家里的药量算清楚。减量期间如果药不够、临时换品牌、或者出差断了药，很容易被迫“硬停”。提前确认复诊时间和取药方式，比事后补救有用。

怎么慢减：原则，不是速度

减量的核心是“慢”和“稳”，但具体多慢，必须由医生根据你的药、剂量、用药时间、半衰期、既往戒断史、年龄、肝肾功能和焦虑严重度来定。本页不给具体数字，也不建议你照着别人的方案减。

可以期待医生做的是：

- 制定分阶段的计划，以周或月为单位推进，最后阶段通常更慢
- 必要时换成长半衰期的药，让血药浓度更平稳
- 一次只改一件事，不同时换药、减量、停另一种药
- 告诉你哪些反应可以观察，哪些要立刻报告
- 在减量后段安排更密的复诊

你可以做的是：

- ☐ 按医生给的节奏走，不因为“今天感觉不错”就多减一点
- ☐ 不隔天吃。隔天吃会让血药浓度忽高忽低，反跳更明显
- ☐ 不自己掰药或换剂型，有些药不能掰，有些剂型需要医生选
- ☐ 记录每天的用量、睡眠、焦虑评分和身体反应
- ☐ 出现明显不适时先联系医生，不自行加回或加快
- ☐ 减量期不大量喝酒、不熬夜、不接高强度新任务
- ☐ 把“减量”告诉一个信任的人，让他帮你观察

如果减到某一步特别难受，医生可能会让你在这一步多停留一段时间，或者暂时回调一点。这不是失败，是调整。硬撑着往下减，往往换来更严重的反弹。

撤药反应和复发，怎么分

这是停药期最容易被搞混的一件事。两者都可能表现为心慌、失眠、焦虑，但时间线和性质不一样。

对比	撤药反应	复发
出现时间	减量或停药后数天内	数周内逐渐出现
持续时间	通常数天到数周，逐渐减轻	持续存在，甚至加重
症状性质	头晕、电击感、恶心、出汗、流感样、易怒、失眠、感觉异常	原来的焦虑或抑郁症状回来：担忧、回避、惊恐
对重新服药的反应	恢复原有剂量后较快减轻	需要重新治疗一段时间才见效
处理方式	暂缓减量、回调、对症处理	恢复治疗、重新评估方案

“电击感”是撤药反应里比较有特点的一种：像头部突然被电了一下，或者眼前闪一下。它让人害怕，但通常不危险，会随着时间减轻。

两者也可能重叠：撤药反应把人弄得很焦虑，焦虑又触发复发。所以不要自己下判断，把时间线记下来，和医生一起看。

停药后监测、复发应对与常见问题

停药不是终点，后面还有一段需要看着的日子。

- ☐ 停药后第一周：睡眠、头晕、情绪、焦虑，每天记一笔
- ☐ 第二到第四周：撤药反应的高峰期，也是复发早期信号出现的窗口
- ☐ 第二到第三个月：功能恢复情况、回避有没有回来、按时复诊
- ☐ 第六到第十二个月：遇到生活事件时，回头看预警清单
- ☐ 每次复诊带上记录，不要只说“还行”
- ☐ 知道自己该找谁：主治医生、12356、就近医院急诊

如果复发了怎么办

先不要自责。复发是疾病的一部分，不是意志失败，也不代表之前的治疗白做了。

- 尽快联系医生，不要自己把原来的剂量加回去，也不要翻出以前的药自己吃
- 把停药的时间线、减量过程、最近的生活事件告诉医生
- 可能需要恢复治疗一段时间，起效同样需要时间
- 复盘这次停药：是不是太早、太快、减量期压力太大、残留症状没处理
- 下一次可以更慢、维持更久，这不丢人

特殊人群要更谨慎

- **孕产期**：不要因为发现怀孕就自行停药。突然停药可能引起撤药和复发，对母婴都不利；要和产科、精神科一起讨论。
- **老年人**：代谢慢、跌倒和低钠风险高，减量通常更慢，复诊更密。
- **青少年**：需要家长参与，学校配合，注意情绪波动和自伤信号。
- **肝肾功能不全**：药物可能蓄积，减量方案要结合检查结果。
- **合并酒精或其他镇静药**：先处理酒精和镇静药问题，再谈减量，否则风险叠加。

容易踩的坑

“我自己先减一半。”减太快可能诱发严重撤药，甚至抽搐。把想法告诉医生。

“隔天吃就能停。”血药浓度波动，反跳更明显，不是科学的减法。

“用保健品或中药替代。”目前没有可靠证据支持它们可以替代规范的减量管理，自行替换可能两头落空。

“怕依赖，所以硬停。”硬停不会让你更快自由，只会让戒断更重、复发更快。依赖是可以被管理的，见 10.3 苯二氮䓬依赖、戒断与酒精。

“停药后喝酒助眠。”酒精会加重反跳性焦虑和失眠，还可能和残留药物叠加。

“停了就再也不吃了。”如果复发，重新治疗是合理选择，不是前功尽弃。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 停药或减量后出现抽搐、意识混乱、高热、极度激越
- 出现自杀念头、自伤行为，或已经做了计划
- 严重过敏、晕厥、剧烈胸痛

当天联系医生：

- 撤药反应明显，影响进食、睡眠或出门
- 情绪持续低落、绝望，或焦虑明显加重
- 失眠连续多天，白天无法工作
- 想加快减量，或已经自行减量

拨打 12356 心理援助热线：

- 停药期焦虑难忍，需要有人先听你说
- 复发后羞于联系医生，不知道怎么开口

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（仅用于焦虑合并抑郁）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 12：危机、生活与权益

除了医学治疗，还有现实问题：急诊、费用、病假、隐私、家庭支持。这一模块讲操作层面的信息。

12.1 急诊指征与危机资源

这一页只回答一个很具体的问题：**眼前这个情况，能不能等到明天门诊？**它写给正在发作的人，也写给旁边那个拿着手机、不知道要不要打 120 的家属。读完你会带走三样东西：一张“哪些症状必须先当躯体急症处理”的对照表，一套在电话里把情况说清楚的顺序，一份陪护者当场就能照着做的清单。原则只有一句：**不确定的时候，按严重处理。宁可白跑一趟，不要赌。**

先分清三种“急”

焦虑相关的情况里，“急”其实有三种，处理路径完全不同，混在一起就容易耽误。

第一种是躯体急症。 心肌梗死、肺栓塞、主动脉夹层、严重心律失常、低血糖、哮喘急性发作，都可以表现为“突然心慌、胸闷、喘不上气、出大汗”。这些病和惊恐发作的症状高度重叠，靠感觉分不出来，只能靠检查和病史。**首次出现、性质与以往不同、或者本人有心血管危险因素时，先按躯体急症走。**

第二种是精神科急症。 正在实施或即将实施的自伤、自杀行为，严重兴奋躁动、伤人风险，意识混乱、谵妄，以及精神病性症状支配下的危险行为。这类情况需要急诊和精神科会诊，不是“聊一聊就好”。

第三种是戒断急症。 长期大量饮酒后突然停酒，或长期服用苯二氮䓬类、镇静催眠药后突然停药，可能出现抽搐、幻觉、意识障碍、高热，**可以危及生命**。这一类最容易被“我自己扛一扛”耽误。

类型	典型表现	第一动作
躯体急症	突发剧烈胸痛、压榨感、放射到手臂或下颌、大汗、真正晕倒、静息下喘不上气	拨打 120，不要自己开车
精神科急症	正在自伤、写好遗书、囤药、说“不想活了”并有计划、意识混乱	不要独处，拨打 120 或送急诊，同时通知可信任的人
戒断急症	停酒或停药后手抖、大汗、心跳很快、看见或听见不存在的东西、抽搐	立即急诊，并告诉医生具体用了什么、用了多久

【指南】焦虑障碍的规范治疗里，“排除躯体原因”是第一步，不是可选项。已经确诊焦虑障碍，也不等于以后所有胸痛都可以归给焦虑。

胸痛、气短、晕厥：先按躯体急症处理

惊恐发作时，心跳加快、呼吸变浅变快、胸口发紧、手脚发麻、头晕、有濒死感，这些都是真实的生理反应，不是“想出来的”。**惊恐发作本身通常不致命**，这是可以让人安心的一点【指南】。

但这句话有一个必须配套的前提：**它只适用于已经排除躯体急症、并且症状性质与以往一致的情况。** 对第一次发作的人、症状不典型的人、有心脏病史的人，先做检查再谈焦虑，是负责任的做法，不是过度医疗。

下面这些特征，更倾向于“先排除躯体急症”：

- 胸痛是压榨样、闷痛，持续十几分钟不缓解，或放射到左臂、下颌、后背。
- 伴随大汗淋漓、恶心呕吐、明显的濒死感，且与活动或情绪激动有关。
- **真正失去意识**（晕厥）。惊恐发作时头晕、腿软很常见，但真正晕倒并不常见，晕厥要单独查原因。
- 静息状态下突然喘不上气，说话只能一个字一个字往外挤，或嘴唇发紫。
- 心跳快到无法计数、伴眼前发黑，或有心脏病、高血压、糖尿病、吸烟史、早发心脏病家族史。
- 近期长期卧床、手术后、长途旅行后出现气短伴胸痛，要想到肺栓塞。
- 老年人、女性、糖尿病患者的症状可能不典型，只表现为乏力、上腹不适、气短，更容易被当成“焦虑”。

表现	更像惊恐发作	更需要先排除躯体急症
起病	常在几分钟内冲到高峰，二三十分钟后逐渐回落	持续加重，或超过半小时不缓解
诱因	常与压力、咖啡因、睡眠不足、特定情境有关	与活动、体位、外伤、手术后相关
意识	清醒，能说话，能描述“我要死了”	真正晕倒、意识模糊、叫不醒
既往	有明确的惊恐发作史，本次“和以前一样”	首次发作，或本次“从来没这么疼过”

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 首次出现突发剧烈胸痛、静息下呼吸困难、真正晕厥、抽搐、嘴唇发紫、大汗伴恶心——**立即拨打 120**。
>
> 已经确诊焦虑障碍，但本次症状与以往明显不同、持续时间明显更长、含服急救药无效——**按躯体急症处理，去急诊**。
>
> 拿不准的时候，先打 120。急救人员不会因为你“其实没事”而责怪你。

自杀念头与自伤：不要独处，也不要只靠热线

出现“不想活了”“活着没意思”“如果没有我大家会轻松些”这类念头，本身就是需要认真对待的信号，不是矫情，也不是“说说而已”。焦虑合并抑郁时，自杀风险会明显升高【指南】，这一条值得每个家属知道。

关于“要不要问”，很多人怕问了会“提示”对方。目前的共识是：**直接问不会增加风险，反而常常让人松一口气**——终于有人愿意听。可以这样问：“你最近有没有想过不想活了？”“有没有想过具体怎么做？”问完不要急着讲道理，先说“谢谢你告诉我”。

真正降低当下风险的，是几件很具体的事：

1. **不要让人独处。** 哪怕只是陪着坐在客厅，也比“你自己静一静”安全。
2. **把手段拿远。** 药物、刀具、绳索、农药，能收起来的收起来，能交给别人保管的交给别人。这一步比任何劝说都有效【指南】。
3. **陪同去急诊或精神科。** 有明确计划、已经开始准备、或已经自伤，直接去最近医院急诊，不要等预约。
4. **不要答应“绝对保密”。** 可以承诺“我只告诉能帮上忙的人”，但不能承诺一个人扛。

关于热线，需要说清楚它的位置：**心理援助热线能陪你把最难的那一个小时熬过去，但它不是急救系统。** 热线接线员通常无法定位你的位置、无法派车、无法上门。所以在“已经站在窗边”“手里已经有药”这种迫切危险里，热线不能作为唯一手段，**必须同时拨打 120，或让身边的人送你去急诊**。

号码	适合什么时候打	能做什么	不能做什么
120	胸痛、气短、晕厥、抽搐、服药过量、正在自伤、有立即生命危险	派救护车、途中急救处置、送到有急诊能力的医院	不负责长期心理治疗，不负责调解家庭矛盾
110	有人正在实施危险行为、走失、被困、需要现场协助、无法自行送医	出警到现场、维持秩序、协助送医、联系家属	不提供医疗判断，是否出警由接警单位按情况决定
12356	情绪崩溃、极度焦虑、需要有人听、需要被转介到当地资源	心理支持、危机干预、转介	不能替代急救，不能派车，不能保证即时定位

12356 是国家卫生健康委统一部署的心理援助热线，2025 年起在全国推行。各省市还有自己的心理援助热线，**具体号码和服务时间以当地卫健委公布为准**；同一个号码在不同地区的接通方式可能不同，打之前可以先在本地卫健委官网确认。

戒断：酒精、苯二氮䓬类、镇静催眠药

这一类危险最容易被低估，因为当事人往往觉得“我是在往好的方向走”。

酒精戒断。 长期大量饮酒的人突然停酒，可能在数小时到数天内出现手抖、出汗、心跳加快、焦虑加重、失眠，进一步可能出现幻觉（看见虫子、听见人声）、抽搐，最严重的震颤谵妄会出现意识模糊、高热、大汗，**有生命危险**。所以长期大量饮酒的人戒酒，应该在医疗机构评估和监护下进行，**不要自行硬戒**。

苯二氮䓬类戒断。 这类药药名多带“西泮”“唑仑”，突然减停可能出现焦虑反跳、失眠、心慌、出汗、手抖、肌肉抽动，也可能出现抽搐、意识混乱。**必须由医生制定缓慢减量计划**，不能自己掰着吃、想起来就停。

抗抑郁药的撤药反应。 SSRI、SNRI 突然停用常出现头晕、类似触电感、恶心、烦躁、睡眠变差，通常不危及生命，但很难受，也容易被误认为“病又回来了”。同样应该由医生安排减量。

下面这些情况，请立刻去急诊，并且**主动告诉医生用药和饮酒的详细情况**：

- ☐ 停酒或停药后出现抽搐，哪怕是第一次、只有几十秒。
- ☐ 停酒或停药后看见、听见不存在的东西，或说话前言不搭后语。
- ☐ 高热、大汗、心跳持续很快、意识模糊。
- ☐ 停药后出现强烈的自伤冲动。
- ☐ 不知道自己吃了多少药，或同时喝了酒。

> 到医院后，把药盒、酒的种类和大概量、最后一次使用的时间都告诉医生。这些信息直接决定怎么处理，“怕被说”而隐瞒，风险最大。

电话里怎么把情况说清楚

急救调度最需要的是**位置**和**状态**，不是完整的病史。按下面的顺序说，通常一分钟内能说完：

- ☐ 先说地址：小区名、楼栋、单元、门牌号，以及门口明显的标志物。说不清就报最近的路口或商铺。
- ☐ 再说人：几个人、大概年龄、男或女、现在有没有意识、能不能说话、有没有呼吸。
- ☐ 说最要紧的症状：胸痛？喘不上气？抽搐？吃了多少药？有没有出血？
- ☐ 说正在吃的药：药名念不出来就把药盒放在门口，或者拍照。
- ☐ 说最近的变化：这几天有没有停药、减药、喝酒、发烧、熬夜。
- ☐ 留一个能接通的电话，并保持手机畅通。
- ☐ **不要先挂电话**，等对方说可以挂。调度员可能会在电话里指导你做心肺复苏或止血。

如果是给不在身边的家人求助，除了地址，还要说清楚“门能不能进去”“有没有人陪着”“有没有养狗”，这些会直接影响救援。

陪护者做什么、不做什么

陪护者在现场的判断，往往比患者自己更可靠。下面这张表可以直接照着做。

可以做	尽量不要做
留在身边，用平稳、简短的话说明“我在”	反复争辩“你就是想太多”“这是心理作用”
降低刺激：关灯、关电视、让围观的人散开	围着患者不停追问“你到底怎么了”
帮患者放慢呼气，不强行要求“深吸一大口”	拿塑料袋罩住口鼻，或强迫大量喝水
收起药物、刀具等危险物品，代为保管	承诺“我绝对不告诉任何人”

可以做	尽量不要做
记录时间线：几点开始、什么症状、吃了什么药	因为“上次也是焦虑”就把这次也当成焦虑
带上药盒、病历、医保卡、身份证	在胸痛、晕厥、抽搐时自己开车送，而不是叫救护车
到急诊后主动告诉分诊护士“有自杀念头”	在患者面前和医生讨论“他是不是装的”

有一句话值得所有家属记住：**陪伴不等于说服。** 你不需要在当下把道理讲通，你只需要让危险的那几个小时过去。

到急诊之后会发生什么

急诊的分诊台会先判断紧急程度，所以“看起来不严重”的人可能要等。这不是不重视，而是按危及生命的可能性排序。

常见的流程是：问病史和用药史 → 量血压、血氧、做心电图 → 抽血查心肌酶、血糖、电解质、甲状腺功能等 → 必要时留观或住院。**急诊里的“焦虑”是一个排除性判断**：先排除心脏、肺、代谢、药物原因，再考虑焦虑。所以医生说“心电图没事”，不等于“你没事”，而是“心脏急症暂时排除了”，后面还需要到精神科或心理科继续评估。

如果急诊评估后建议你去看精神科门诊，请尽量在几天内去，不要拖成“下次再说”。急诊解决的是“现在有没有生命危险”，不解决“接下来怎么治”。

常见问题与容易踩的坑

“我每次都这样，还用去医院吗？”如果本次和以往完全一样、有明确的惊恐发作史、以往检查齐全，可以先按 10.1 惊恐发作的现场应对处理，并尽快联系你的医生。但只要有“这次不一样”的感觉，就按躯体急症处理。

“去了急诊说没事，是不是白花钱？”排除急症本身就是结果。一次心电图和心肌酶，买的是“可以安心”和“没有漏掉”。

“半夜没有精神科门诊怎么办？”综合医院急诊通常可以处理急性危机并联系精神科会诊；也可以拨打 12356。有立即危险时，120 优先。

“热线占线怎么办？”换一个号码，或直接去急诊。**占线不是“没人管你”的证据，只是那一刻线路满了。**

最容易踩的坑：把“不要紧”提前用在还没检查的人身上。 焦虑的知识是用来减少恐惧的，不是用来劝人不去医院的。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

12.2 费用、医保、病假与复工复学

焦虑障碍的治疗往往要持续几个月到一两年，钱、假、学业和工作这几件事，会实打实地影响能不能治下去。这一页把“要花哪些钱”“医保从哪几个口子走”“病假条怎么开”“怎么回去上班上学”拆开讲，写给患者，也写给要替家人跑手续的家属。需要先说明：**本页不写具体报销比例和金额**——医保政策由各统筹地区制定，同一个省不同城市都可能不一样，任何具体数字都可能已经过期。判断标准只有一个：**以当地医保局、单位和学校的最新答复为准。**

先看钱花在哪里

同样是“看焦虑”，账单可能差好几倍。把费用拆开看，才知道哪里能省、哪里不该省。

费用项目	大致构成	能不能省
挂号与诊查	普通门诊、专家门诊、特需门诊，价格差得最多	病情稳定期可用普通门诊，把专家号留给方案调整时
检查	甲状腺功能、心电图、血常规、生化、必要的影像	不该省。这些是排除躯体疾病、决定用药安全的前提
药物	原研药与仿制药、是否纳入集采、单片价格与月费用	可以省。可请医生在等效前提下优先选择医保目录内、集采中选品种
心理治疗	通常按次计费，单次价格高于普通门诊，多数地区自付比例较高	部分可省。团体治疗、结构化课程、正规数字 CBT 往往单价更低
住院	床位、护理、检查、治疗，按天累计	非必要不住院；需要住院时按医保流程走
往返与误工	交通、请假、异地就医住宿	可省。复诊尽量约在同一天，稳定期可用合规的互联网复诊

一个常被忽略的点：**药物费用不是越低越好，也不是越贵越好。** 真正该比较的是“这个方案能不能让我稳定下来、少跑几趟急诊”。一次急诊的费用，往往高于好几个月的门诊药费。

医保的五条通道

中国的医保不是一个口袋，而是好几个口袋，各有各的规则。下面这张表帮你判断自己该走哪条。

通道	大致适用	关键动作
普通门诊	日常复诊、开药、常规检查	持医保卡或医保电子凭证直接结算；注意当地门诊统筹的起付线、限额
门诊慢特病	病程长、需要长期门诊用药的病种	先申请资格认定，通过后门诊费用按相应政策结算
住院	需要住院治疗、急性期监护	入院时出示医保凭证，出院直接结算
大病保险	住院或门诊慢特病自付累计较高时	多数地区自动参保、自动结算，无需单独申请
商业保险与单位补充	有商业保单或单位补充医疗	保存发票、费用清单、出院小结、病历复印件

普通门诊。 职工医保和城乡居民医保都有门诊待遇，但各地在起付线、报销比例、年度限额上差别很大。焦虑障碍的复诊频率通常是每月一次到数月一次，长期下来是一笔固定支出，值得在年初就问清楚本地政策。

门诊慢特病。 这是很多患者不知道的一条通道。各地名称不同，有的叫“门诊慢性病”，有的叫“门诊特殊病种”“门诊规定病种”。**是否把焦虑障碍或严重精神障碍纳入、纳入后享受什么待遇，各地目录不一样**，必须以当地医保局公布的病种目录为准。有的地区对严重精神障碍有专门的保障政策，有的地区则主要覆盖重性精神病，焦虑障碍不一定在内——这一点要事先问清楚，不要想当然。

住院。 焦虑障碍多数情况下在门诊治疗，住院通常用于急性期、共病复杂、需要调整方案或存在自伤风险的情况。住院费用按医保目录结算，**目录外的药品和项目需要自付**，入院前可以问一句“这个方案里有没有自费部分”。

大病保险。 在基本医保报销之后，个人自付累计超过一定额度时启动，多数地区对参保居民自动覆盖、出院时一并结算。具体起付线和比例以当地公布为准。

医疗救助。 低保对象、特困人员、低保边缘家庭等困难群体，在基本医保和大病保险之后还可以申请医疗救助。**《精神卫生法》明确要求对困难精神障碍患者的医疗费用给予救助**，具体办法由地方制定；符合条件的话，可以向户籍地或居住地的民政部门、医保经办机构咨询。

异地就医。 在外地工作、上学或随子女居住的人，需要先办理异地就医备案，才能在就医地直接结算。备案渠道通常是国家医保服务平台 APP 或当地医保小程序。**没有备案就自费结算，报销比例往往会下降，甚至无法回参保地报销。**

办门诊慢特病认定，通常要准备	说明
医保凭证、身份证	本人办理；代办需按当地要求提供材料
诊断证明或出院小结	由就诊医院出具，一般需要加盖公章
门诊病历、检查报告	能体现病程和治疗经过
申请表	在医院医保办或医保经办窗口领取，多地已支持线上提交

各地流程差别很大，有的在定点医院医保办就能办，有的要跑医保经办大厅，有的可以全程线上。**先打当地医保服务电话问清楚，再准备材料**，能省很多来回。

商业保险与理赔

有商业保险的人，最容易在三个地方出问题。

第一是健康告知。 投保时是否如实告知焦虑障碍的就诊记录，直接影响后续能不能赔。已经确诊后再投保，通常会按“既往症”处理。

第二是条款里的精神疾病约定。 不少医疗险、重疾险对精神障碍设有免责、限额或等待期。**投保前请自己读一遍条款原文**，不要只听销售人员口头说明；看不懂就打客服电话，问“焦虑障碍相关的门诊和住院能不能赔”，并记下答复时间和工号。

第三是理赔材料。 门诊通常需要发票原件、费用明细、病历、处方；住院还需要出院小结、诊断证明。**病历复印件要在出院时一并复印好**，事后回医院补打往往要再跑一趟。

如果单位有补充医疗保险，记得问人事部门：门诊是否能报、需要哪些材料、有没有年度上限。这类补充险的报销范围常常比基本医保宽，但很少有人主动去用。

病假条：怎么开、写什么

病假条（也叫诊断证明、休假建议书）由接诊的执业医师根据病情出具，并加盖医疗机构公章。它不是“走后门要来的东西”，而是医生对“这段时间能不能工作”的专业判断。

几个实务要点：

- **找对你的医生。** 通常由正在给你治疗的精神科或心理科医生开具，急诊只能开短期。跨院开具可能不被单位认可。
- **说清楚用途。** 直接告诉医生“单位需要病假条，希望写明建议休息时间”。不同单位对格式要求不同，有的要写疾病名称，有的只要“建议休息若干天”。
- **诊断怎么写，由医生按规范决定。** 你可以和医生讨论措辞对工作可能的影响，但**不要要求医生写不实内容或改诊断**。出具虚假证明对医生和对你都有风险。
- **保留副本。** 病假条、挂号单、病历、缴费凭证都拍照存档，年底或发生争议时都用得上。
- **医疗期与工资。** 病假期间的工资、医疗期的长短，按国家规定、地方规定和劳动合同执行，不同单位差异很大。**这一块属于劳动法范畴，本页只讲原则，具体请咨询单位人事或当地人社部门。**

如果单位要求“必须先走内部审批才能休病假”，那就把顺序走完：先按单位流程报备，同时让医生出具证明。**不要因为流程麻烦就带病硬撑**，也不要因为担心影响考评就放弃应有的休息——急性期带病工作，往往拖长整个病程。

复工：分阶段回去

“能上班了”不是一个开关，更像一个坡度。很多人失败不是因为病没好，而是因为一回去就满负荷。

比较稳妥的做法是分三步：

1. **先恢复作息。** 在正式复工前一两周，把起床、吃饭、睡觉的时间调到接近上班的节奏，让身体先适应。
2. **再恢复部分工作。** 和单位协商阶段性安排：先上半日、先不接出差、先避开夜班、先减少需要公开汇报的场合。这些调整通常不需要说出完整诊断，可以说“正在治疗，医生建议逐步恢复”。

3. **最后回到常规。** 每上一个台阶观察一到两周，症状明显反弹就退半步，稳定后再前进。

和单位沟通时，可以只讲三件事：**我需要什么调整、大概持续多久、什么时候再评估。** 不必交代病因细节，也不必把病历给同事看。是否需要告知人事部门完整诊断，取决于单位制度和你自己的意愿；如果涉及岗位调整、劳动能力鉴定，则需要按规定提供材料。

复工阶段	常见安排	观察什么
复工前	调整作息、规律服药、提前复诊	睡眠是否稳定、是否还有晨起心慌
第一至二周	半日班、减少出差、暂缓夜班	下班后是否能恢复、是否频繁请假
第三至六周	恢复常规工时，保留弹性	会议、汇报、通勤是否引发明显回避
稳定后	常规工作	复发早期信号：睡眠变差、担忧增多、又开始回避

复学：休学与回来的路

学生的情况比上班复杂，因为涉及学籍、住宿、考试和同学关系。

休学。 一般由监护人提出申请，附二级以上医院的诊断证明和建议休息意见，按学校学籍管理规定办理。休学期限、复学条件各校不同，**办理前先找班主任或教务处问清流程和时限**，避免错过学期节点。

复学。 多数学校要求提供“可以复学”的医学证明。建议在复学前一两个月就和医生讨论，逐步调整作息和学习强度，不要等到开学前一周才准备。

在校支持。 可以和班主任、学校心理老师沟通，商量几件具体的事：是否需要暂时减免部分课程、考试是否可以申请延时或单独考场、出现急性焦虑时可以去哪个地方缓一缓。这些安排属于学校的学生支持范畴，**能否提供、怎么申请，以学校规定为准**。

关于要不要告诉同学。 这不是必须的。告知的范围越小，被议论的风险越低；但完全不告知，也可能让孩子在需要帮助时不敢开口。比较现实的做法是：**告诉一两位可信任的老师，同学层面由孩子自己决定。**

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 因为费用、请假或报销问题打算自行减药、停药——**先联系医生**，很多方案可以调整（换用目录内药物、延长单次处方、改用互联网复诊），不必硬扛。
>
> 复工复学后症状明显反弹、连续失眠、又开始回避——**尽快复诊**，这是调整方案的信号，不是“意志力不够”。
>
> 出现自杀念头、自伤行为、停药后抽搐或意识混乱——**立即拨打 120 或去急诊**，不要等门诊。

省钱但不省治疗的做法

- ☐ 问医生：现有方案里有没有医保目录内、集采中选的等效选择。
- ☐ 问医保：本地门诊统筹的起付线、限额、是否需要慢特病认定。

- ☐ 问医院医保办：本院能不能直接结算、异地就医是否需要先备案。
- ☐ 把复诊、检查、开药尽量约在同一天，减少往返。
- ☐ 病情稳定期使用合规的互联网医院复诊，但**首次诊断和方案调整仍应面诊**。
- ☐ 保留每一张发票、费用清单和病历，商业保险和单位补充医疗都用得上。
- ☐ 了解当地是否有针对困难群体的医疗救助、慈善援助或医院减免政策。
- ☐ 不买宣称“根治焦虑”的高价保健品或课程，**这部分钱几乎一定是白花的**。

常见问题

“心理治疗能报销吗？”部分地区已将部分心理治疗项目纳入医保支付范围，但**是否纳入、按什么标准支付，各地不同**，请向当地医保部门或医院医保办确认。多数情况下自付比例较高，这也是团体治疗、结构化课程更有性价比的原因之一。

“单位会不会因为病假条知道我的诊断？”病假条上通常会有诊断或休假建议。如果这是你的顾虑，可以在就诊时和医生讨论措辞；同时了解单位是谁在保管病假条、有哪些人能看到。**这一块涉及个人隐私，详见[12.3 隐私、权益与家庭支持](<12.3 隐私、权益与家庭支持.md>)。**

“医生只肯开一周的病假，怎么办？”精神科的休假建议通常按复诊周期开，一次开很长并不常见。可以按复诊节奏续开，并把“需要连续休息”的实际情况告诉医生。

“休学会不会影响升学？”休学、复学、升学资格的具体规定由学校和上级教育主管部门制定，**本页不提供这类判断**。办理前直接问学校教务部门，把书面答复留存。

参考来源

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议，也不构成法律或保险意见；具体政策以当地医保、人社部门与单位、学校规定为准。

12.3 隐私、权益与家庭支持

得了焦虑障碍，除了症状本身，还要面对一些更“社会”的问题：病历会不会被同事看到、单位知道了会怎样、家里人到底是帮忙还是在添乱。这一页把隐私泄露的常见场景、与精神卫生相关的法律原则、病耻感，以及“家属怎么帮而不控制”讲清楚。需要先说一句边界：**本页只讲原则，不提供法律意见**；涉及具体纠纷、休假待遇、入学就业争议，以现行法律条文和当地政策为准，必要时咨询律师或当地法律援助机构。

隐私通常从哪里漏出去

很多人以为“我不说，就没人知道”。实际上，信息往往不是从你自己嘴里出去的，而是从流程的缝隙里漏出去的。

场景	风险点	可以做的处理
单位收病假条	假条上的诊断、休假原因被多人传阅	事先问清“谁保管、谁能看”，必要时和医生讨论措辞
医保结算与报销	费用明细、就诊科室会显示在单据上	单据自己保管，不交给不需要的同事代办
学校请假、休学	班主任、教务处、宿舍管理多方知情	只告知“必须知道的人”，约定信息不外传
家人代为取药、陪诊	亲属、邻居、熟人圈子里扩散	和家里人约定“哪些话可以对外说”
手机与社交账号	就诊记录、量表结果、搜索记录被看到	屏幕锁、应用锁；不在家庭群里发检查单
网络社群与直播间	用真名、单位、照片发言，被截图转发	用化名，去掉可识别信息，不发病历原图
保险投保与理赔	健康告知、既往症记录	投保前自己读条款，问清精神障碍相关约定

有一点要讲明白：**隐私保护不是“隐瞒病情”**。对医生、对必要的工作对接人、对确实要帮你的人，如实说明是有用的；问题出在“不必要的人知道了，并且因此对你有了评价”。

如果单位或学校要求提供诊断证明，可以提供**必要的部分**——比如“建议休息两周”的休假建议，而不是整套病历。哪些必须提供、哪些可以不提供，取决于对方的要求有没有依据；遇到说不清的情况，先问依据，再决定给什么。

下面这份自查清单，可以在下一次请假、报销、发帖之前过一遍：

- ☐ 诊断证明只交给必须看的那一个人，并问清“谁保管、会有谁看到”。
- ☐ 家庭群里不发检查单、处方和量表截图，需要给家人看时用私聊或当面。
- ☐ 社交平台发言用化名，去掉单位、学校、住址、科室等可识别信息。
- ☐ 手机开屏幕锁，健康类应用单独加锁，避免被顺手翻到。
- ☐ 和家里人约定一句统一的对外说法，避免说法不一致引来更多追问。

精神卫生法里与你有关的几条原则

《中华人民共和国精神卫生法》2012 年通过、2013 年 5 月 1 日施行。它确立的几个原则，和每个患者都直接相关。**以下是原则性概述，不是法律条文，也不能替代法律意见。**

第一，住院治疗以自愿为原则。 精神障碍的住院治疗实行自愿原则。只有在特定情形下，才可能涉及非自愿住院，比如经诊断和评估，已经发生伤害自身的行为或有危险，或者有危害他人安全的行为或危险，并且需要按法定程序进行。这意味着：**不是家属想送就能送，也不是医院想收就能收**；认为自己或家人被不当收治时，可以要求说明依据。

第二，人格尊严和隐私受保护。 患者的姓名、肖像、住址、工作单位、病历资料，以及其他可能推断出身份的信息，有关单位和个人应当保密。**“我是为你好”不是泄露隐私的理由**，亲戚在饭桌上讲你的病情，同样属于越界。

第三，不得歧视、侮辱、虐待、遗弃。 这是底线性的规定。就业、入学中遇到明确的歧视性对待，属于可以主张权利的情形，但具体怎么主张、能不能得到支持，要看证据和当地实践。

第四，患者有权了解自己的病情和治疗方案。 包括诊断、治疗目的、可能的副作用和替代方案。这就是“知情同意”的基础：**你有权问，医生有义务解释**。签同意书之前没听懂，可以要求再讲一遍。

第五，心理咨询人员不能从事精神障碍的诊断和治疗。 这一条很实用：如果有人以“心理咨询师”“疗愈师”的身份给你下诊断、开方案、让你停药，这已经超出了其法定范围。**能够诊断和处方的，是医疗机构里的精神科执业医师。**

第六，病历资料可以查阅、复制。 按现行规定，患者本人通常可以要求查阅、复制自己的门诊病历、住院病历中的客观部分。转诊、异地就医、保险理赔、维权时都用得上。

> 法律条文会修订，地方实施细则也不同。**遇到具体争议，请以现行法律文本和当地卫生健康、人社、教育部门的答复为准**，必要时寻求律师或法律援助。

病耻感：它不是你的错

病耻感指的是“因为得了这个病，觉得自己低人一等，或害怕被别人这样看”。它有两种：一种是别人对你的歧视，一种是你自己内化了的羞耻。

它带来的实际后果，比很多人想的更硬：

- **延迟就医。** 怕被记录在案，于是一拖几年，等到影响工作生活才去。
- **隐瞒用药。** 在家偷偷吃，出差就停，导致血药浓度不稳、撤药反应反复。
- **减少社交。** 本来只是怕某几个场合，慢慢地什么场合都躲，回避范围越来越大。
- **影响家人。** 家属也跟着“不能说”，独自承担照护压力，最后一起耗竭。

松动病耻感，靠的不是“想开点”，而是几件具体的事：

1. **把“病”和“人”分开。** 焦虑障碍是一种有神经生物学基础、有治疗方法、可以缓解的疾病，和高血压、哮喘一样需要长期管理。**它描述的是你的状态，不是你的价值。**
2. **控制告知范围，而不是完全封闭。** 有一两个知道真相并且不评价你的人，比“所有人都不知道”更能减轻负担。
3. **准备一句标准回答。** 比如“我最近在调理身体，需要规律作息”，用于不想解释的场合。**不必对所有人坦诚。**
4. **接触准确的科普。** 污名常来自误解：以为焦虑等于“疯了”、吃药等于“上瘾”、看心理科等于“脑子有问题”。这些误解在1.4 常见名词与误区里有逐条拆解。
5. **允许自己慢一点。** 病耻感不会因为读了一篇文章就消失，它是在一次次“说了也没事”的经验里慢慢松动的。

家属怎么帮而不控制

家属最常见的困境是：想帮，但一帮就变成管；一管，患者就闭嘴。区别往往不在心意，而在方式。

更像帮忙	更像控制
问“你现在最难受的是什么”	说“你就是想太多，别想了”
陪着挂号、陪着进诊室、帮忙记医嘱	替患者做所有决定，包括吃不吃药
提醒复诊、提醒吃药，但允许对方自己吃	数药片、藏药、偷偷换药
尊重“暂时不想说”	追问细节，或翻手机、翻抽屉
在暴露练习时陪着，但不替对方完成	强行把人拉到人多的地方“练胆”
家属也保留自己的生活	全天候守着，把自己耗空
出现危险时果断叫 120	认为“去医院会留记录”而拖着不去

有几件事，家属做了会实实在在降低风险：

- **学会问自杀念头。** 直接问不会“教坏”人。可以问“你有没有觉得活着没意思”“有没有想过伤害自己”。10.2 自杀风险与安全计划里有完整的安全计划模板。
- **管好家里的药。** 尤其是苯二氮䓬类和止痛药，由一位家人统一保管、按次给，既防过量，也能发现“怎么吃得这么快”。
- **别当第二个医生。** 不要根据网上信息要求换药、加量、停药。有疑问写下来，复诊时问医生。
- **照顾自己。** 长期照护会让人疲惫、易怒、失眠。家属也可以有自己的心理咨询和支持团体，**这不是自私，是让帮助能持续下去。**

几句话，换个说法

同一件事，说法不同，对方的反应会完全不同。下面这些替换句可以直接用。

原来的说法	换一种说法
“这有什么好怕的”	“这个害怕对你来说很真实，我们一起看看能怎么应对”

原来的说法	换一种说法
“你就是太闲了”	“你最近是不是一直绷着？要不要说说”
“药不能吃，会上瘾”	“这类药确实有依赖风险，我们下次复诊时问清楚怎么用”
“你要坚强一点”	“现在做不到也没关系，我们先做最小的一步”
“别人都能上班，你怎么不行”	“现在这个状态上班确实吃力，我们先想办法减一点”
“你要是不去，我也不管你了”	“我希望你去看医生，我可以陪你去，什么时候去你定”

最后一句尤其重要：**威胁会让人闭嘴，不会让人好起来。**

权益受侵害时，可以做什么

以下是原则性的路径，不构成法律意见，也不保证结果。

遇到的问题	可以先找谁
医院内隐私泄露、态度不当	医院医务科或医患关系办公室，书面反映并留回执
认为被不当收治	要求医院说明诊断与收治依据；向当地卫生健康行政部门反映
医保报销争议	参保地医保经办机构，按当地流程申请复核
就业中的歧视性对待	单位工会、当地人社部门劳动监察机构；必要时申请劳动仲裁
入学、休复学争议	学校教务部门，其次当地教育主管部门
需要法律帮助但经济困难	当地法律援助中心；符合条件的可以申请法律援助
情绪上撑不住	12356 心理援助热线；有立即危险时拨打 120

做这些事的时候，**证据比道理有用**：书面申请、邮件、聊天记录、录音（注意当地关于录音取证的规定）、病历复印件、诊断证明，都留着。口头沟通之后，可以发一条信息复述“今天我们谈的是……”，形成书面痕迹。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 因为担心隐私或病耻感，打算不去就诊、自行停药、把药藏起来不吃——**先联系医生**，可以讨论记录保护、就诊安排和用药方案，不必用停药来解决。
>
> 家人之间因为“管与不管”冲突升级，患者出现明显情绪崩溃、失眠加重、回避扩大——**联系医生安排一次家庭参与的复诊**。
>
> 出现自杀念头、自伤行为、被限制人身自由、遭受暴力——**立即拨打 120 或 110**，并联系可信任的人到场。

常见问题

“单位知道了会不会被辞退？”法律禁止歧视，但现实中的做法差异很大，具体争议要按劳动合同和当地实践判断，**本页不提供结论**。能做的准备是：控制告知范围、保留书面记录、了解单位制度和当地人社部门的咨询渠道。

“病历可以不给家人看吗？”成年人通常有权决定自己的信息给谁看。**但如果是家属在承担照护、需要了解用药风险，完全不沟通会带来实际危险**。折中做法是由患者指定一位“信息共享人”，只向这一个人开放必要信息。

“家里人到处说我得了焦虑症，算不算侵犯隐私？”按精神卫生法的原则，可能推断出患者身份的信息属于应当保密的范围。但家庭内部的这类事情，通常先通过沟通解决；沟通无效且造成实际损害时，再考虑法律途径。**具体认定以现行法律和司法实践为准。**

“我要不要主动告诉伴侣？”这属于个人选择，没有标准答案。可以分层次：先说“我最近在接受治疗，需要规律作息”，等关系稳定、对方反应可预期时，再决定说多少。**隐瞒的代价和坦诚的代价都要自己评估。**

参考来源

- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议，也不构成法律意见；具体问题以现行法律、当地政策和面诊医生判断为准。

模块 13：误区、问答与工具

这一模块是可以直接打印/照抄的工具页，也集中拆掉最常见的误解。

13.1 焦虑日记与惊恐记录

焦虑有一个很难对付的特点：它在回忆里会变形。发作的时候觉得“天天都这样、越来越重”，其实一周只有两次；好转的时候又觉得“好像也没什么”，于是提前停了药。日记的作用，就是给这种变形装一个参照物。

这一页给的是可以直接照抄的模板：每天记什么、惊恐发作怎么记、担忧和回避怎么记，以及最重要的——怎么用这些记录看趋势，而不是被某一天的分数牵着走。全部记下来每天大约花五到十分钟。

> 记录是工具，不是作业。它服务于你和医生的判断，不是给你打分的考卷。漏记一天不需要补，也不需要自责。

先想清楚：记是为了什么

如果不知道为什么要记，记录很快就会变成新的负担。它至少有三个用处。

第一，给医生提供可比较的信息。 “最近特别焦虑”和“过去四周，每周发作两三次，最长一次四十分钟，因为这个推掉了两次出差”，后者能让医生做出更准确的判断。

第二，让你看见模式。 很多人的焦虑不是均匀分布的：周一早上最重、开会前最重、经期前一周最重、喝完咖啡的下午最重。看见模式，才有调整的入口。

第三，把“我很糟”拆成具体的事。 焦虑发作时，人的注意力会全部收进身体内部，感觉是“整个天都塌了”。写下来以后，它变成“心跳快、手麻、持续了二十分钟、后来坐下喝了水就好了”——具体的东西，比一团模糊的恐惧更容易处理。

需要先说清楚记录**不能**做什么：它不能替代诊断，不能证明你“病得多重”，也不能靠“记录做得好”来换好转。它只是一个观察工具。

每天三到五行：日常记录

不需要长篇大论。每天固定一个时间（建议睡前，或者第二天早上补），写五行就够。

字段	填什么	例子
睡眠	入睡大约几点、醒几次、总时长	1 点睡，醒 2 次，共 5 小时
焦虑分数	当天最高分与大致平均分（0 到 10）	最高 7，平均 4
触发	时间、地点、当时在做什么、之前发生了什么	上午开会前，被点名汇报

字段	填什么	例子
身体与念头	两三个身体感觉，加上当时脑子里冒出的第一句话	心慌、手抖；“我会说不出话”
应对	面对了、部分回避、完全回避；做了什么有用	部分回避，让别人先说；喝水有用

几个填写要点：

- **分数只写整数**，不要纠结 6.5 还是 7。分数是给自己做比较用的，不是精确测量。
- **“触发”写事实，不写评价。** 写“开会前被点名”，不写“我又不行了”。
- **“念头”写原话。** 脑子里那句“我要晕倒了”比“我有点担心”有用得多，因为后面要针对的正是这句话。
- **“应对”要区分面对和回避。** 这是全表最重要的一栏，因为它直接对应治疗目标。

如果某天什么都没发生，就写“平稳，最高 2 分”。空白的一天也是信息，别让它空着。

惊恐发作记录表（可照抄）

惊恐发作和日常焦虑要分开记，因为它的时间短、强度高、细节容易忘。建议在发作结束后半小时内填，趁记忆还清楚。

项目	填写内容
日期与时间	例如 10 月 8 日 21:40
地点与情境	例如 地铁 2 号线，人多，刚下班
从开始到顶峰	大约几分钟
总持续时间	大约多少分钟
峰值强度	0 到 10 分
身体感觉	圈出：心悸 / 胸闷 / 气短 / 出汗 / 发抖 / 头晕 / 手麻 / 恶心 / 发冷发热 / 喉咙堵
脑子里的第一句话	原话，例如“我要心梗了”“我要疯了”
我做了什么	例如 下车、坐下、给家人打电话、含了药
多久恢复	例如 二十分钟后基本平复，一小时后完全正常
之后回避了什么	例如 第二天改打车上班

填写时注意三件事：

1. **不要在现场填。** 发作时注意力应该放在“度过它”，不是“记录它”。事后补记完全够用。
2. **“身体感觉”只圈真实的，不要凑数。** 列出来的项目是为了方便，不是为了让你对号入座。
3. **“之后回避了什么”这一栏千万别省。** 发作本身会过去，但回避会留下来，而回避才是让惊恐障碍维持下去的关键。

一个提醒：第一次发作要特殊对待

如果这是你人生第一次出现突发的剧烈胸痛、严重气短、晕厥或濒死感，**先按躯体急症处理，不要先填表**。先去急诊做心电图和相关检查，排除心脏、肺部、低血糖等问题。惊恐发作本身多数不致命，但“多数”不等于“这一次”。

担忧记录与回避清单

日常焦虑和惊恐之外，还有两样东西值得单独记：反复出现的担忧，和悄悄扩大的回避。

担忧记录适合广泛性焦虑。核心不是“别担心”，而是把担忧从脑子里搬到纸上，看它经不经得起检验。

日期	担心的事（一句话）	我估的可能性	一周后回看：实际发生了吗
10.09	汇报时会被当场质疑，然后被辞退	80%	没发生，被问了一个问题，答上来了
10.11	妈妈晚归半小时，可能出事了	60%	没发生，手机没电

“一周后回看”是这张表的关键。它不靠讲道理说服你，而是靠你自己积累的证据。几周之后，你通常会看到一种模式：担心的事绝大多数没有发生，或者发生了但没有你想的那么糟。

回避清单适合所有类型的焦虑，也最容易被忽略。

我躲开的事	躲开的代价	能拆出的最小一步
坐地铁	每天多花一小时打车，费用增加	先坐一站，有人陪
公司聚餐	和同事越来越疏远	先去半小时，坐靠门位置
独自在家	必须有人陪，家人无法出差	先独自待一小时，手机开着

“最小一步”这一栏现在不用做到，写下来就行。它是给后面做暴露练习时用的，具体方法见 5.3 暴露疗法：分级、重复与停止回避。

看趋势，不要盯单次；也别记成负担

先说怎么看趋势。 一周挑一个固定时间（比如周日晚上），只花三分钟，看四个数：

1. 这一周惊恐发作了几次，最长一次多久。
2. 焦虑平均分大概是多少（把七天的平均分粗算一下）。
3. 回避清单上多了几项、少了几项。
4. 功能：这周上了几天班 / 出了几次门 / 睡了几个好觉。

只看这四项的**四周走向**，不看某一天的起伏。焦虑本来就是波动的，一次发作回到 8 分，不代表前面的努力作废。真正有意义的变化往往是这样的：发作次数没怎么变，但恢复得快了；分数没怎么降，但敢去的地方多了；还是会紧张，但不再事后反复回想三个小时。

再说别记成负担。 下面这些信号出现时，说明记录本身变成了新的焦虑源，该减量了：

- 每天花在记录上的时间超过十五分钟
- 反复翻看旧记录，越看越难受
- 为了“数据好看”而改变行为，比如硬撑着不去回避，就为了让那一栏好看
- 漏记一天就烦躁、想补记
- 记录内容越来越长，变成情绪宣泄

出现这些情况，把记录简化成“每天一行：分数＋有没有回避”。等状态稳一点再恢复。记录是为了帮你，不是为了考核你。

每周复盘清单

- ☐ 这周发作几次，最长多久
- ☐ 焦虑平均分大概几分，比上周高还是低
- ☐ 新增了哪些回避，减少了哪些回避
- ☐ 有没有出现新的身体症状（体重下降、持续发热、心悸伴消瘦）
- ☐ 酒、咖啡、安眠药的用量有没有变化
- ☐ 睡眠大概几点睡、醒几次
- ☐ 有没有出现“活着没意思”的念头
- ☐ 下周复诊要重点说哪两件事

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**首次突发的剧烈胸痛、严重气短、晕厥或濒临晕倒；意识模糊、抽搐、高热；单侧肢体无力、说话不清；出现自杀念头、自伤行为，或已经在做伤害自己的准备。
>
> **尽快联系医生：**记录显示发作频率持续上升；回避项目一周比一周多；开始靠喝酒或加量吃镇静药来应付；出现明显的情绪低落、兴趣丧失；记录里反复出现“撑不下去了”这类想法。
>
> 如果记录中出现自杀相关的念头，不要只写在日记里。把它告诉医生、告诉一个能立刻到你身边的人，或者拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- WHO. Anxiety disorders fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.2 常用量表：GAD-7、PDSS、LSAS、SPIN

在门诊、在手机应用、在各种健康文章里，你会不断遇到量表。有人拿着 GAD-7 的 12 分问：“我是不是中度焦虑？”也有人因为分数从 15 降到 9，就自己把药停了。

这一页讲清四件事：这四个量表各自测什么、怎么计分、常用界值大概在哪、以及它们共同的局限。读完你应该能判断：一个分数能说明什么，不能说明什么。

先说一句最重要的：量表是筛查和随访工具，不是诊断工具。 分数高只提示“值得找医生评估”，分数低不排除问题，任何量表都不能替代面诊。

量表能做什么、不能做什么

量表有用的地方在于**可比性**。同一个量表，隔两周、隔两个月重复做，能看出变化的方向和幅度，比“我感觉好点了”更具体。它也能在很短时间内提示医生：这个人需不需要进一步问下去。

量表做不到的地方同样明确：

- **不能下诊断。** 诊断需要病史、病程、功能损害、排除躯体疾病和物质因素，这些量表都不管。
- **不能区分原因。** 心慌气短可能是焦虑，也可能是甲亢、贫血、心律失常，量表一样给分。
- **不能跨量表比较。** GAD-7 的 10 分和 LSAS 的 50 分不可比，它们测的不是一回事。
- **受当天状态影响。** 昨晚没睡好、刚吵完架、诊室太吵，都会让分数偏高。
- **受文化和教育程度影响。** 有些条目问的是“担心”“失控感”，不同人对词的理解不一样。

所以量表正确的用法是：**在同一个量表上，看自己的变化趋势**，而不是拿自己的分数去和别人比，或拿去给自己贴标签。

GAD-7：七个条目，测过去两周

GAD-7 是使用最广的焦虑筛查工具，全名是广泛性焦虑障碍量表（Generalized Anxiety Disorder-7），由 Spitzer 等人在 2006 年发表。

测什么：过去两周里，被紧张、担忧、难以放松、坐立不安、易怒、害怕等困扰的频率。

怎么计分：7 个条目，每条 0 到 3 分——0 分表示完全没有，1 分表示有几天，2 分表示一半以上的天数，3 分表示几乎每天。总分 0 到 21 分。

常用分级：5 到 9 分提示轻度，10 到 14 分提示中度，15 分及以上提示重度。**10 分**是最常用的筛查界值，达到或超过 10 分，建议找医生做一次完整评估。

适用人群：成人一般人群和门诊人群的初筛，也常用来跟踪治疗前后的变化。老年人、孕产妇也可以用，但结果要结合具体情况解释。

局限：它对广泛性焦虑最敏感，对惊恐障碍、社交焦虑、特定恐惧的区分能力有限——因为这些障碍的人也会在“紧张、担心、难以放松”上打高分。另外，GAD-7 只覆盖两周，长期的、波动的问题可能被低估；如果最近两周刚好状态好，分数会显得很轻。有研究尝试用略低的界值去筛查惊恐障碍和社交焦虑，但这属于研究用途，临床上仍以完整评估为准【研究】。

PDSS：惊恐障碍的严重度，自评和他评要分清

PDSS 全名是惊恐障碍严重度量表（Panic Disorder Severity Scale），由 Shear 等人在 1997 年发表。

测什么：惊恐障碍的七个维度——惊恐发作的频率、发作时的痛苦程度、对再次发作的预期性焦虑、对场所的回避、对身体感觉的回避、工作或学习受影响的程度、社交受影响的程度。

怎么计分：7 个条目，每条 0 到 4 分，总分 0 到 28 分。分数越高，严重度越高。文献里常见的分段大致是：0 到 1 分基本没有，2 到 5 分轻度，6 到 10 分中度，11 到 15 分明显，16 分以上重度；不同版本的表述略有差异，以原版说明为准。

这里必须说清楚一件事：PDSS 的原始版本是他评量表。 它由受过训练的评定者通过半结构化访谈完成，不是拿张纸自己填。后来发展出了自评版本（PDSS-SR），条目内容相近，但计分口径、分数分布和可比性都和原版不同。

这意味着：

- 不要把自评版的分数，直接套到他评版的分段上，然后判断自己“重度”。
- 不要拿不同来源的 PDSS 分数互相比较，除非确认是同一版本、同一施测方式。
- 他评版需要培训，这是它准确的原因，也是它不方便的原因。

适用人群：已经诊断为惊恐障碍的人，用来评估严重度和治疗反应。它不适合用来筛查“我是不是有惊恐障碍”。

局限：条目少，对广场恐惧的覆盖不如专门的回避量表细；对共病抑郁的捕捉有限；自评版容易受回忆偏差影响。

LSAS 与 SPIN：社交焦虑的两个常用工具

LSAS（Liebowitz 社交焦虑量表，1987 年）是社交焦虑领域用得最久的量表之一。它有 **24 个条目**，其中 13 条是“表现型”情境（当众讲话、吃东西、写字、打电话），11 条是“互动型”情境（和陌生人说话、参加聚会、表达不同意见）。每条要评两次：一次评“恐惧或焦虑”的程度（0 到 3 分），一次评“回避”的程度（0 到 3 分）。所以总分是 0 到 144 分。

LSAS 的一个好处是把“怕”和“躲”分开计分。有些人主观恐惧很重但还在硬撑，有些人不怎么怕但已经完全回避，这两种情况在治疗上重点不同。

常用分段大致是：30 分以下一般不考虑社交焦虑；30 到 49 分轻度；50 到 64 分中度；65 到 79 分明显；80 分以上重度。不同来源的分段有出入，而且 30 分这个界值主要用来筛查，不是诊断线。

SPIN（社交恐惧症量表，Connor 等人 2000 年）只有 **17 个条目**，每条 0 到 4 分，总分 0 到 68 分。它把社交焦虑拆成三个维度：对负面评价的恐惧、回避、生理上的不适（脸红、心慌、出汗）。条目少、填得快，适合反复测量。

SPIN 最常用的筛查界值是 **19 分**，达到或超过 19 分建议进一步评估。分段大致为：20 分以下轻或没有；21 到 30 分中度；31 到 40 分重度；41 分以上很重。同样，这些分段用于描述严重程度，不用于确诊。

两者的区别：LSAS 更细，覆盖的情境多，适合评估和治疗随访；SPIN 更快，适合筛查和频繁追踪。两者都测“怕被评价”，都不测抑郁、不测惊恐。

四个量表放在一起

量表	测什么	条目与计分	常用界值
GAD-7	近两周的紧张、担忧、难以放松	7 条，每条 0 到 3 分，总分 0 到 21	5 / 10 / 15 分为轻 / 中 / 重；10 分常用筛查线
PDSS	惊恐障碍的严重度（七个维度）	7 条，每条 0 到 4 分，总分 0 到 28	分数越高越重；原版为他评，自评版需分别解释
LSAS	社交情境的恐惧与回避	24 条，每条评恐惧与回避各 0 到 3 分，总分 0 到 144	30 分左右为常用筛查线；50 分以上多为中度以上
SPIN	社交焦虑的三个维度	17 条，每条 0 到 4 分，总分 0 到 68	19 分为常用筛查线；分数越高越重

看这张表时请记住：四列里的数字不能互相换算。GAD-7 的 10 分不是“中度焦虑”的通用定义，只是这个量表自己的分段。

拿到分数之后

第一步，看它是不是同一个工具的前后对比。 如果你三个月前做过 GAD-7 是 16 分，现在是 9 分，这个变化有意义。如果你是第一次做，分数只能当作起点。

第二步，看具体条目，不只看总分。 比如 GAD-7 里“坐立不安”一直高分，但“担心失控”很低，说明躯体性的坐立不安更突出，这在治疗上可能有不同的侧重。

第三步，把分数带进诊室，而不是带进搜索引擎。 告诉医生“我做了 GAD-7，是 12 分，其中最难的是第 2 条和第 5 条”，比问“12 分是不是很严重”有用得多。

第四步，不要为了分数好看而答题。 有些人会不自觉地往轻里填，怕被说“矫情”；也有人往重里填，怕医生不重视。两种都会让后续判断失真。

用之前先确认这几件事

- ☐ 用的是哪个版本，中文版是否经过验证
- ☐ 时间范围是“过去一周”还是“过去两周”
- ☐ 是自评还是他评，他评是否由受过训练的人完成
- ☐ 计分规则是否照原版，有没有被网络工具改过
- ☐ 作答环境是否安静、有没有人围观
- ☐ 这是第几次做，和上次间隔多久
- ☐ 分数是给医生做参考，不是给自己下结论

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊**：首次突发的剧烈胸痛、严重气短、晕厥；意识模糊、抽搐、高热；单侧肢体无力、说话不清；出现自杀念头或自伤行为。
>
> **尽快联系医生**：量表分数持续升高，或症状已经影响工作生活；出现新的躯体症状（体重下降、持续发热、心悸伴消瘦）；情绪低落超过两周；准备根据分数自行调整药物——这一步必须由医生来做。

容易踩的坑

- 把筛查界值当诊断线。达到 10 分不等于“确诊广泛性焦虑障碍”。
- 拿不同量表的分数量化比较，比如“我 GAD-7 是 12，他 LSAS 是 60，谁更重”。
- 只做一次就下结论。量表的价值在重复测量，不在单次得分。
- 用分数决定停药。分数下降说明症状减轻，不说明可以停药，减量方案要医生定。

参考来源

- Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Archives of Internal Medicine, 2006.
- Shear MK, et al. Multicenter collaborative panic disorder severity scale. American Journal of Psychiatry, 1997.
- Liebowitz MR. Social phobia. Modern Problems of Pharmacopsychiatry, 1987；Connor KM, et al. Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN). British Journal of Psychiatry, 2000.
- 施慎逊, 吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.3 复诊沟通单

精神科门诊的一个现实是：你准备了很久，坐下以后可能只有十几分钟。医生要在这十几分钟里判断病情变化、调整方案，而你常常一紧张就忘了最要紧的那句。

这一页是一张可以打印、可以存进手机备忘录的沟通单。它把复诊拆成三段：诊前三分钟准备、诊中必须说和必须问、诊后确认。照着走一遍，信息就不会漏在诊室门外。

十几分钟的复诊，最怕什么都说了又什么都没说清

复诊和初诊不一样。初诊是“从头讲一遍”，复诊是“讲变化”。医生最想知道的不是“我很难受”，而是三件事：比上次好了还是差了、差在哪里、有没有新出现的问题。

而患者最常给出的信息是模糊的：“还行吧”“就那样”“有时候好点”。这不是不配合，是因为焦虑本身就是一团没有边界的感受，很难自动整理成句子。

所以准备的重点不是“想清楚该说什么”，而是**提前写下来**。写下来的东西不会因为紧张而消失，也不会因为医生说“我们时间不多”而被压缩掉。

一个可用的时间分配：出门前花三分钟填单子，进诊室先递单子再说两句话，把剩下的时间留给提问。

诊前 3 分钟：把纸填好

不需要写作文，填六个空就够。

第一个空：这四周的整体走向。 用一个词概括——明显好转、略有好转、差不多、略差、明显变差。再补一句为什么。

第二个空：发作或难受的次数。 一周几次，最长一次多久，最重的时候 0 到 10 分是几分。不要写“经常”，写数字。

第三个空：最影响生活的一件事。 只写一件。比如“不敢坐地铁，改打车，每月多花八百”“开会不敢发言，已经推掉两次汇报”。

第四个空：药。 现在吃的每一种，药名、怎么吃、有没有漏服、有没有不舒服。副作用要写清三件事：什么时候开始的、持续多久、影响到什么程度（能不能上班、能不能睡）。

第五个空：酒、咖啡、烟、其他药。 包括中药、保健品、朋友给的“助眠药”。这一栏最容易被省略，也最容易出问题。

第六个空：情绪和安全。 有没有持续低落、兴趣丧失、觉得活着没意思、有过伤害自己的念头。这一栏必须主动说，不要等医生问。

诊中：必须说清的八件事、必须问的六个问题

必须说清的八件事

1. **走向**：这四周是好转、持平还是变差。
2. **频率与强度**：发作几次、每次多久、峰值几分。
3. **诱因**：什么情境下最容易出现，有没有新的诱因。
4. **回避**：这阵子多躲开了什么，有没有因此影响工作、上学、出门。
5. **睡眠**：几点睡、醒几次、白天困不困。
6. **药物**：怎么吃的、漏没漏、有没有副作用、有没有自己减过。
7. **物质**：酒、咖啡、烟、其他药和保健品。
8. **安全**：有没有低落、绝望、自杀或自伤的念头。这一条不丢人，也不能省。

必须问的六个问题

1. 我现在的诊断依据是什么，有没有需要再排除的其他原因？
2. 现在的治疗大概多久能看到变化，用什么标准判断有没有效？
3. 出现哪些副作用需要立刻联系你，哪些可以再观察？
4. 我需要同时做心理治疗吗，去哪里找靠谱的？
5. 下次复诊前，我需要记录什么、注意什么？
6. 什么情况下要提前来，或者直接去急诊？

如果时间实在不够，就挑三个问：诊断依据、疗效判断、危险信号。这三个问题的答案，决定了你接下来几个月怎么走。

怎么把模糊的话说具体

项目	模糊的说法	医生能用的说法
频率	最近老是发作	这周发作三次，周二、周四、周日，都在晚上
强度	特别难受	峰值 8 分，最难受的时候觉得要晕过去
时长	好久才缓过来	从开始到平复大约四十分钟，之后一小时还发虚
诱因	没什么原因	三次里有两次是在地铁上，一次是在开会前
回避	我不太出门	一个月没坐地铁，超市只在人少时去，聚会全推了
副作用	吃药后不舒服	加药第三天开始恶心，早饭后明显，持续两周，没影响上班
情绪	心情不好	近三周每天大部分时间低落，原来喜欢的球赛也不想看

诊后：用自己的话复述一遍

离开诊室前，用三十秒做一次复述。这一步能挡掉大量“回家才发现没听懂”的情况。

复述四句话：

- “我的诊断是……”
- “药我打算这样吃……”（说清时间、和饭的关系、漏了怎么办）
- “下次复诊是……”
- “如果出现……我就联系你或者去急诊”

如果这四句里有任何一句说不出来，当场问清楚。医生不会因为你多问一句而不耐烦，真正麻烦的是三个月后才发现一直吃错了。

几个实操建议：

- **带家属或朋友一起去。** 两个人在场，一个负责说，一个负责记，比一个人硬撑好。
- **录音。** 先征得医生同意。焦虑状态下，人对信息的接收会明显变差，录音能补上。
- **核对处方。** 拿药后把处方和医生的口头说明对一遍，不一致就打电话问。
- **别改口头约定。** 医生说“先这样吃四周”，就不要两周后自己觉得好了而停掉。
- **记下医生的原话。** 尤其是“什么情况必须回来”这一句。

一张纸模板（可打印）

复诊沟通单

栏目	填什么	我的情况
这四周走向	明显好转 / 略好 / 持平 / 略差 / 明显变差	
发作次数与强度	每周几次、最长多久、峰值 0 到 10 分	
最影响生活的一件事	只写一件，带具体数字	
正在吃的药	药名、怎么吃、有没有漏、有没有不适	
副作用	何时开始、持续多久、影响到什么程度	
酒 / 咖啡 / 烟 / 其他药	大概量，包括中药和保健品	
睡眠	入睡时间、醒几次、白天困不困	
情绪与安全	低落、兴趣、有无自杀或自伤念头	
我最想问的三个问题	按重要程度排序	

出门前检查清单

- ☐ 沟通单填好了，字迹自己能看懂
- ☐ 医保卡、就诊卡、身份证

- ☐ 正在吃的药，或者药盒照片
- ☐ 最近的检查单、化验单
- ☐ 上次的处方和病历
- ☐ 手机电量够，能录音
- ☐ 家属或朋友同行（如果需要）
- ☐ 想好的三个问题写在最上面

什么时候需要提前联系医生 / 去急诊

> **立即拨打 120 或去急诊：**首次突发的剧烈胸痛、严重气短、晕厥；意识模糊、抽搐、高热；单侧肢体无力、说话不清；出现自杀念头、自伤行为或具体计划；严重过敏表现（面唇肿胀、呼吸困难）；突然停用镇静药后出现发抖、大汗、心跳极快、幻觉。
>
> **在下次复诊之前就联系医生：**症状明显加重、无法工作或出门；出现新的副作用且影响生活；漏服或误服药物；饮酒量明显增加；情绪持续低落两周以上；对治疗方案有疑问、想调整。

容易踩的坑

- **报喜不报忧。** 怕被说“不配合”，就把漏服、喝酒、加量的事藏起来。医生按不完整的信息调整方案，风险由你承担。
- **只讲感受，不讲事实。** “我很焦虑”很难处理，“每周三次、都在地铁上”可以直接变成治疗目标。
- **把问题留到下次。** 三个问题这次没问，下次可能就问别的了。
- **不核对处方。** 药名相近、规格不同的事故，多半发生在“没多看一眼”的时候。
- **自行调整后再告诉医生。** 已经调了，也要如实说，不要因为怕批评而隐瞒。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.4 常见误区与高频问答

关于焦虑，流传最广的那些说法，往往听着像常识，实际上会让人错过该做的事：有人因为“吃药会上瘾”硬扛了五年，有人因为“深呼吸就好”把惊恐发作当成意志力问题，有人因为“怀孕绝对不能吃药”在孕期整夜睡不着。

这一页集中处理三十条误区和二十个高频问题。每条都给出实质澄清，而不是一句“这是错的”。它适合从头读，也适合在被人用某句话堵回来时，翻到对应那一条。

三十条误区

关于“焦虑是什么”

序号	误区	澄清
1	焦虑就是想太多、性格软弱	涉及气质、神经回路、应激激素和学习性条件反射；不是靠“想开”能关掉的开关
2	焦虑不是病，忍忍就过去	达到诊断标准并有功能损害时，需要治疗；长期硬扛更容易慢性化
3	焦虑久了会变成精神病	焦虑障碍不会转成精神分裂症；“我要疯了”是惊恐发作时的主观体验
4	焦虑症是矫情，是想逃避责任	回避是症状的一部分，不是策略；多数人是硬撑到撑不住才就诊
5	焦虑症只有女人才得	男性同样患病，只是更少求助，更常用喝酒、发火、硬扛来表达
6	焦虑是闲出来的，忙起来就好	忙碌能暂时转移注意，但不改变威胁评估和回避；不少人越忙越重
7	焦虑症一辈子好不了	多数人经规范治疗可以缓解，复发可以预防；波动不等于失败
8	小孩子不会焦虑	儿童常以腹痛、头痛、拒学、黏人表现，容易被当成纪律问题

关于吃药

序号	误区	澄清
9	吃抗焦虑药会上瘾	一线药物 SSRI / SNRI 不属于成瘾性药物；停药可能有撤药反应，需缓慢减量，与成瘾不是一回事
10	苯二氮䓬见效快，能吃就吃	只适合短期、按需、医生指导；长期有依赖、耐受、戒断、跌倒和认知风险
11	精神科药物含激素，会吃坏脑子	不是激素；长期未控制的焦虑本身就会损害睡眠、注意力和记忆
12	吃药是软弱的表现	药物调节的是神经递质和回路，性质接近眼镜和降压药，不是意志力比赛
13	感觉好了就可以停药	过早停药复发风险明显升高；何时减、怎么减由医生评估

序号	误区	澄清
14	副作用太可怕，不如不吃	多数副作用可管理或随时间减轻；要权衡的是副作用与疾病本身的损害
15	中药和保健品更安全，可以替代	成分与相互作用常不明确，不能替代规范治疗；用了要告诉医生
16	吃药期间喝一点酒没事	酒精加重焦虑、破坏睡眠，与镇静药叠加会抑制呼吸；没有安全量
17	怀孕哺乳绝对不能吃药	不是绝对；不治疗的重度焦虑也有风险；需精神科与产科共同评估
18	抗抑郁药会让人自杀或转躁	少数人早期可能出现激活或自杀念头，需要监测和及时报告，尤其青少年和有双相史的人

关于治疗

序号	误区	澄清
19	心理治疗就是聊聊天	结构化治疗，有目标、有作业、有评估；CBT 和暴露疗法有明确证据
20	心理治疗没用，不如吃药	它是一线治疗之一，疗效与药物相当，缓解后复发率较低；重症常需联合
21	深呼吸就好了	呼吸调节能降低唤醒，但对中重度焦虑不构成治疗；过度深呼吸反而会头晕手麻
22	放松训练可以替代治疗	是辅助手段，帮助降唤醒；不能替代暴露、认知干预和必要的药物
23	想开点、改变心态就行	认知工作确实重要，但需要方法和技术，不是靠劝
24	暴露就是硬闯，一次就能好	需要分级、重复、可耐受；硬闯可能加重恐惧，也容易中途放弃
25	治了几周没效就是没用	药物通常数周起效、一到两个月评估；心理治疗也需数周才见变化
26	量表分数高就是有病	量表是筛查工具；诊断要靠面诊、病史、功能损害和排除其他原因
27	治好了就永远不会再犯	复发可以预防，但不能保证不复发；学会识别早期信号比“保证”更有用

关于生活与人群

序号	误区	澄清
28	咖啡和酒能缓解焦虑	短期像有效，长期加重；咖啡因可能直接诱发心悸和惊恐发作
29	运动能治好焦虑	运动有证据支持，是有效的辅助手段；但不能替代规范治疗，过度运动也可能是回避
30	焦虑的人不能工作、不能开车、不能生孩子	多数人在治疗下可以正常生活；个别情况需要评估，而不是一刀切禁止

二十个高频问答

1. **我只是有点紧张，需要看医生吗？**看功能。如果它已经让你推掉事情、睡不好、效率下降，或者持续数周不缓解，就值得看一次。不需要“够严重”才有资格就诊。

2. **应该挂哪个科？**精神科、心理科、心身医学科都可以作为入口。躯体症状突出时，也可以先到内科或全科做基础排查，再带着结果去精神科。

3. **焦虑症会遗传吗？**有家族聚集现象，遗传因素参与其中，但不是单基因决定。遗传提高的是易感性，环境、经历和应对方式同样重要。

4. **需要做哪些检查？**常见的是甲状腺功能、血常规、血糖、心电图，必要时加做心脏或呼吸方面的检查。不是每个人都要全套，由医生根据症状决定。

5. **不吃药能好吗？**轻中度焦虑可以先从心理治疗入手，很多人效果很好。中重度、功能损害明显、或合并抑郁时，常需要药物参与。选择由医生和你一起定。

6. **药要吃多久？**通常不是几周的事。起效后还需要一段巩固和维持时间，具体多长取决于诊断、病程、复发史和耐受情况，由医生评估。

7. **吃药后反而更焦虑了怎么办？**部分药物在早期可能引起短暂的激活、心慌、恶心。不要自行停药或加量，把开始时间、症状和程度记下来，尽快联系开药的医生。

8. **可以喝酒吗？**不建议。酒精短期像能放松，长期加重焦虑、破坏睡眠，与镇静药同用还有呼吸抑制的风险。已经在喝的人，不要自行突然停，长期大量饮酒的戒断可能危及生命。

9. **咖啡要戒吗？**不一定要全戒，但值得减量试试。心悸明显、容易惊恐的人，下午以后不喝，往往就能看到差别。

10. **惊恐发作时怎么自救？**坐下来，把注意力放到“它会过去”上，放慢呼吸，不要对抗身体感觉；找一个具体的物体描述它。发作通常在十几分钟内到顶，然后回落。

11. **惊恐发作会死吗？**惊恐发作本身多数不致命。但第一次突发的胸痛、气短、晕厥，必须先排除心脏和肺部问题，不能默认是惊恐。

12. **焦虑和抑郁同时有，先治哪个？**通常一起处理。很多药物对两者都有效，心理治疗也有重叠。需要特别注意的是自杀风险，这一条要主动告诉医生。

13. **心理治疗要多久、怎么找？**常见是每周一次、每次约一小时，持续数周到数月。可以问医院心理科、精神科转介，或正规平台；先确认对方资质和擅长的方法。

14. **家人能做什么，不能做什么？**能做的是陪着、听、帮忙记录、鼓励就诊。不能做的是反复保证“没事”、替对方回避、责备“想太多”，以及擅自劝停药。

15. **焦虑会影响怀孕和哺乳吗？**会。不治疗的焦虑本身也影响孕期和胎儿。用药与否需要精神科和产科一起评估，不要自行停，也不要自行加。

16. **孩子焦虑怎么办？**先别急着讲道理。观察在什么情境下出现、持续多久、影响了什么；和学校沟通；必要时找儿童精神科或心理科评估。家长的态度比说教重要。

17. **老人焦虑要注意什么？**优先排查躯体疾病、药物副作用、抑郁和认知下降。用药要特别小心跌倒、镇静和药物相互作用，剂量调整必须由医生做。

18. **焦虑会影响记忆力吗？**会。注意力被担忧占满时，记不住、想不起来很常见。多数人在焦虑缓解后会有改善，不必急着担心“脑子坏了”。

19. **复发的前兆是什么？**常见的是睡眠先变差、又开始反复确认、回避悄悄增加、身体感觉变得敏感。把这些写下来，比等“全面复发”再处理要好。

20. **什么时候必须去急诊？**首次突发的剧烈胸痛、严重气短、晕厥；意识模糊、抽搐、高热；自杀念头或自伤行为；突然停用镇静药后的严重戒断反应。这些都不要等。

需要立刻处理的几种情况

以下任何一条出现，都不要等到下次复诊：

- ☐ 首次突发的剧烈胸痛、压榨感，或放射到手臂、下颌的疼痛
- ☐ 突然严重气短、咯血、嘴唇发紫
- ☐ 晕厥、差点晕倒、眼前发黑
- ☐ 意识模糊、抽搐、高热
- ☐ 单侧肢体无力、口角歪斜、说话不清
- ☐ 面唇肿胀、呼吸困难等严重过敏
- ☐ 出现自杀念头、自伤行为，或已经在准备
- ☐ 突然停用镇静药后出现发抖、大汗、心跳极快、幻觉

什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即拨打 120 或最近医院急诊：**上面清单里的任何一条。
>
> **24 到 72 小时内联系医生：**焦虑明显加重、无法工作或出门；服药后出现新的不适；饮酒或镇静药用量增加；情绪持续低落两周以上；准备自行减药或停药。
>
> 也可以拨打 12356 心理援助热线；地方热线以当地卫健委公布为准。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159

- WHO. Anxiety disorders fact sheet.
  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

附录：术语与参考文献

本模块的篇目可以按顺序读，也可以按问题单独查。

A 术语表

这一页收 60 个焦虑相关词条，按主题分组，编号从 1 到 60 连续。每个词条用大白话写，2–4 句，目的是让你在看医生、读指南、和家人解释的时候，知道对方在说什么。它按“概念 → 机制 → 药物 → 疗程 → 心理治疗 → 相关障碍 → 量表 → 权益”排列，可以顺着读，也可以直接跳到你要查的词。词条只是解释，不是诊断标准：**任何一条都不能拿来给自己或家人“对号入座”式确诊**。

一、基本概念与类型（1–10）

1. **焦虑**：一种以紧张、担心、身体警觉升高为主的状态，表现为心慌、肌肉紧绷、睡不好、总往坏处想。它本身是正常的保护反应；只有强度过高、持续时间过长、明显影响生活时，才可能构成障碍。
2. **恐惧**：面对眼前具体威胁时的强烈反应，来得快、去得也快，伴随强烈的逃跑冲动。焦虑更多指向“还没发生的事”，恐惧更多指向“现在就在眼前的东西”。
3. **惊恐发作**：突然出现的一阵强烈恐惧，几分钟内冲到高峰，伴心慌、气短、胸闷、出汗、手抖、头晕、手脚发麻、濒死感或失控感。它非常吓人，但通常在几十分钟内会回落，也通常不造成身体伤害。【指南】
4. **惊恐障碍**：反复出现“没想到就来了”的惊恐发作，并且持续担心再次发作，或因此明显改变生活（不敢单独出门、不敢运动、不敢离家）。诊断的关键是“反复”加上“担忧与行为改变”，不是发作过一次就算。
5. **广泛性焦虑障碍（GAD）**：长期、弥散、难以控制的担忧，涉及工作、健康、家人、钱、小事等很多方面，伴肌肉紧张、容易累、注意力差、易怒、睡眠差。病程常以月、年计。
6. **广场恐惧**：害怕处在“不好逃出去”或“发作了没人帮”的场所，比如地铁、商场、排队、空旷处、独自远行。它常和惊恐障碍同时出现，也有人只有回避、没有明显的惊恐发作。
7. **社交焦虑障碍**：害怕在可能被评价的场合出丑或被负面评价，比如发言、当众吃饭、见陌生人、被注视。关键不是“内向”，而是“怕被评价”加上“回避或硬撑着忍受”。
8. **特定恐惧**：对某一个特定对象或情境的强烈恐惧，如高处、飞行、血、针、动物、封闭空间。当事人通常知道自己“怕过头了”，但真的靠近时还是控制不住。
9. **分离焦虑**：与依恋对象分开时过度痛苦，担心对方出事、拒绝独处或外出、反复确认。它在儿童中常见，成年人也可能出现，不是只属于孩子。

10. **选择性缄默**：在某些场合（如学校）持续说不出话，在另一些场合（如家里）却能正常说话。它不是“不肯说”或“故意作对”，而是焦虑导致的“说不出”，应按焦虑问题处理。

二、焦虑是怎么维持下去的（11–17）

11. **回避**：为了避免焦虑而躲开某些场合、活动或想法。短期非常有效，长期会让恐惧范围越来越大，是焦虑得以维持的核心机制之一。【指南】
12. **安全行为**：在焦虑场合里用来“保命”的小动作，比如一直攥着水瓶、反复摸脉搏、必须有人陪、先查好逃生路线。它让人撑过去，却也让人误以为“是我准备充分才没事”，妨碍真正学会面对。
13. **灾难化**：把一个可能性很低、后果不确定的事，直接想成“最坏的结果一定会发生，而且我扛不住”。比如心跳快一点，就想到心脏病发作。
14. **不确定性不耐受**：对“不知道会发生什么”特别难忍受，于是反复确认、反复计划、反复查资料，试图把不确定变成确定。它在 GAD 中很常见。
15. **焦虑敏感**：对自己身体和情绪的“警报信号”特别敏感，倾向于把心慌、头晕解释成“要出大事”。焦虑敏感高的人更容易发展成惊恐障碍。【研究】
16. **过度换气**：呼吸过快过深，二氧化碳排出过多，导致手脚发麻、口周发麻、头晕、胸闷，反而更像“要窒息”。它常是惊恐发作的一部分，而不是原因。
17. **躯体化**：心理压力以身体症状的形式表现出来，如头痛、腹痛、胸闷、乏力，检查却查不出明确的器质性原因。这不是“装病”，症状是真实存在的。

三、神经生物学（18–23）

18. **GABA**：γ-氨基丁酸，脑内主要的抑制性递质，作用像“刹车”，让神经活动降下来。苯二氮䓬类正是通过增强 GABA 的作用来快速抗焦虑。
19. **5-HT（5-羟色胺）**：参与情绪、睡眠、食欲和焦虑调节的递质。SSRI、SNRI 都作用于它，但“缺血清素所以焦虑”这种说法过于简化，焦虑的机制远不止一种递质。
20. **NE（去甲肾上腺素）**：与警觉、心跳、血压和应激反应有关。它升高时会心慌、手抖、出汗；SNRI 通过影响它来抗焦虑，也可能带来血压和心率的变化。
21. **杏仁核**：大脑里的“威胁探测器”，负责快速判断危险并启动恐惧反应。焦虑障碍常与它对威胁过度敏感、以及前额叶对它的调节不足有关。【待验证】
22. **HPA 轴**：下丘脑—垂体—肾上腺轴，身体的应激激素系统，最终促使皮质醇分泌。长期压力下它可能调节失衡，与焦虑、失眠和代谢变化相关。
23. **交感神经**：自主神经里“踩油门”的那一半，让心跳加快、瞳孔放大、血流转向肌肉，为“打或逃”做准备。焦虑时的大部分身体感觉，就是它被激活的结果。

四、药物（24–36）

24. **SSRI**：选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂，如舍曲林、帕罗西汀、艾司西酞普兰等。它是多数焦虑障碍的一线药物，起效常需数周，早期可能有恶心或焦虑加重，需要医生随访。【指南】
25. **SNRI**：5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂，如文拉法辛、度洛西汀。除焦虑外也常用于慢性疼痛，需留意血压和心率变化。【指南】
26. **苯二氮䓬类**：一类快速抗焦虑、镇静催眠药，药名多带“西泮”“唑仑”。起效快，但长期使用有依赖、耐受、戒断、跌倒和认知影响，通常只短期、按需、在医生指导下使用。【指南】
27. **丁螺环酮**：一种非苯二氮䓬类抗焦虑药，不会立刻见效，通常要连续服用一两周以上才逐渐起效。优点是不易产生依赖，缺点是不能用来“当场救急”。
28. **坦度螺酮**：与丁螺环酮同类的抗焦虑药，作用较温和，起效也偏慢。常用于 GAD 的辅助治疗，个体反应差异较大。
29. **普瑞巴林**：原本用于神经痛和癫痫，也被用于广泛性焦虑。它有滥用和依赖风险，停药需缓慢；具体适应证与使用范围以药品说明书和医生判断为准。
30. **β 受体阻滞剂**：如普萘洛尔，主要减轻手抖、心跳快、出汗这类“表演性”躯体症状，对“心里的担心”作用有限。哮喘、心跳过慢、低血压的人要慎用。
31. **MAOI**：单胺氧化酶抑制剂，老一代抗抑郁药，对部分难治性焦虑有效，但与多种食物和药物有严重相互作用，可能引起血压骤升，必须严格遵医嘱。
32. **TCA**：三环类抗抑郁药，如氯米帕明、阿米替林。疗效明确，但口干、便秘、心律影响和过量中毒风险较突出，现在多作为二线或用于特定情况。
33. **血清素综合征**：5-羟色胺过多引起的一组症状，表现为高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、心跳快、意识改变、躁动。多与同时使用多种增加 5-HT 的药物有关，属于急症，需立即就医。
34. **依赖**：身体或心理上需要某种物质才能维持正常状态，停药会出现不适，并有强烈的使用冲动。它是可以预防和处理的医学问题，不是“意志薄弱”。
35. **耐受**：同样剂量下效果变弱，需要更大剂量才能达到原来的效果。苯二氮䓬类长期使用容易出现耐受，这也是不建议长期使用的原因之一。
36. **戒断**：停药或减量后出现的一组症状，如焦虑反跳、失眠、心慌、出汗、手抖、头晕、触电感。酒精和镇静药的戒断可能引起抽搐、意识混乱，**不能自行硬戒**，需医生指导。

五、疗程与结局（37–39）

37. **复发**：症状缓解后再次达到诊断标准。常见诱因包括过早停药、重大生活事件、长期睡眠不足和酒精使用。复发不等于前面的治疗白做了。
38. **缓解**：症状基本消失、功能恢复，通常要持续一段时间才算稳定缓解。缓解不等于“彻底好了”，之后仍有维持治疗和复发预防的事要做。

39. **维持治疗**：症状缓解后继续用药或继续心理治疗一段时间，目的是降低复发风险。维持多久取决于病程、既往复发次数、共病和停药反应，由医生个体化决定。【指南】

六、心理治疗（40–48）

40. **CBT（认知行为治疗）**：结构化的心理治疗，核心是识别并修正失真的想法、减少回避、增加面对。它是焦虑障碍证据最充分的心理治疗之一，通常需要十几次以上的系统练习。【指南】
41. **暴露**：主动、反复、可控地接触自己害怕的情境或感受，并且不靠回避和安全行为“逃掉”，让大脑重新学习“其实没事”。关键是分级、重复、停留，而不是硬闯。【指南】
42. **内感受暴露**：有意制造心慌、气短、头晕等身体感觉（如原地快走、过度换气练习），学会把它们当作“不舒服但无害”的信号。主要用于惊恐障碍。
43. **认知重构**：把自动跳出来的想法写下来，检验支持和反对它的证据，再形成更平衡的看法。它不是“积极暗示”，而是让想法更接近事实。
44. **行为实验**：把担心当成一个可以检验的预测，设计一个小实验去验证。比如“如果我不反复检查，真的会出事吗”，用实际结果修正原来的信念。
45. **ACT（接纳承诺疗法）**：不追求消灭焦虑，而是练习接纳不舒服的感受、澄清自己在意什么，并带着焦虑朝价值方向行动。适合长期回避、与症状对抗消耗很大的人。【研究】
46. **元认知治疗**：针对“担忧本身”的治疗，处理“担忧是有用的”“我控制不住担忧”这类信念，减少反复思考。对 GAD 有研究支持。【研究】
47. **正念**：有意识地把注意力放在当下的呼吸、身体感觉和念头上，不加评判。它不是“放空”，而是练习“发现走神了，再回来”。
48. **ERP（暴露与反应预防）**：强迫症的一线心理治疗，既暴露于引发焦虑的线索，又刻意不做强迫行为（如洗手、检查），让焦虑自然下降。它也用于部分焦虑相关问题，但侧重与一般暴露不同。【指南】

七、相关障碍与共病（49–51）

49. **PTSD（创伤后应激障碍）**：经历或目睹严重创伤后出现闯入性回忆、噩梦、回避、警觉增高和负性认知情绪。它和焦虑障碍有重叠，但治疗重点不同，创伤聚焦的心理治疗是核心。
50. **OCD（强迫症）**：以反复出现的强迫思维，和为了缓解焦虑而做的强迫行为为特征。它与焦虑障碍关系密切，但诊断和治疗路径独立，首选含 ERP 的 CBT 和 SSRI。
51. **共病**：同一个人同时存在两种或以上障碍，如焦虑合并抑郁、焦虑合并失眠或物质使用。共病很常见，会影响治疗顺序和用药选择，需要一起评估而不是分开治。

八、常用量表（52–56）

52. **GAD-7**：7 个条目的自评量表，按过去两周的情况打分，用于筛查和评估广泛性焦虑的严重程度。它适合看趋势、辅助沟通，**不能用来给自己下诊断**。

53. **PDSS**：惊恐障碍严重程度量表，评估惊恐发作的频率、对发作的担忧、回避和功能影响。常用于治疗前后对比。
54. **LSAS**：Liebowitz 社交焦虑量表，评估社交和表演情境下的恐惧与回避程度，条目较多，常用于社交焦虑的评估和疗效观察。
55. **SPIN**：社交恐惧量表，17 个条目，操作简单，适合筛查和随访社交焦虑的严重程度。
56. **SCARED**：儿童焦虑性情绪障碍筛查表，由儿童和（或）家长填写，用于筛查儿童青少年的焦虑症状，覆盖分离焦虑、社交焦虑、躯体化等维度。

九、权益与安全（57–60）

57. **病耻感**：因为患有精神障碍而觉得自己低人一等，或害怕被别人这样看。它会导致延迟就医、隐瞒用药和社交退缩，是需要被处理的实际问题，不是“想太多”。
58. **安全计划**：在危机来临前就写好的一份具体清单，包括预警信号、可以联系的人、能让自己分心的事、要远离的危险物品和求助电话。它不承诺“不再想自杀”，而是让最危险的那几个小时有路可走。【指南】
59. **知情同意**：在了解诊断、治疗方案、可能的收益与风险、以及替代方案之后，自愿作出同意或拒绝的决定。你有权提问、有权要求再解释一遍。
60. **数字 CBT**：通过手机应用、网页或远程会话提供的结构化认知行为治疗，通常有练习模块和（或）治疗师支持。对轻中度焦虑有一定证据，但不能替代中重度和高风险情况的面对面评估。【研究】

最容易混的三组词

这组词	区别在哪
惊恐发作 vs 惊恐障碍	发作是一次事件；障碍是“反复发作 + 持续担心 + 行为改变”
焦虑 vs 恐惧	焦虑指向未来的、模糊的威胁；恐惧指向眼前的、具体的威胁
依赖 vs 耐受 vs 戒断	依赖是“离不开”；耐受是“同样剂量不管用了”；戒断是“停了之后出现症状”

怎么用这份术语表

- ☐ 只查你现在遇到的问题，不要一次读完 60 条，信息过载会加重焦虑。
- ☐ 看到医生写在病历上的词，先在这里查一遍，下次复诊时确认“是不是这个意思”。
- ☐ 用词条里的说法向家人解释，比“我得了焦虑症”更容易被听懂。
- ☐ 注意词条后面的标签：【指南】是有明确推荐，【研究】是有研究支持但未必进入所有指南，【待验证】是机制推测或争议观点。
- ☐ 任何词条都不能替代面诊；看到与自己情况不符的描述，以医生的判断为准。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 查词条时发现自己的症状和描述差距很大，或最近明显加重——**联系医生**，不要靠对照词条自我诊断。
>
> 出现自杀念头、自伤行为、停药或停酒后的抽搐与意识混乱、服药后高热大汗肌肉僵硬——**立即拨打 120 或去急诊**。
>
> 情绪上撑不住又暂时约不到医生——可拨打 **12356** 心理援助热线；有立即危险时，120 优先。

参考来源

- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Text Revision (DSM-5-TR), 2022.
- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- 量表原始文献：GAD-7（Spitzer et al., 2006）、PDSS（Shear et al., 1997）、LSAS（Liebowitz, 1987）、SPIN（Connor et al., 2000）、SCARED（Birmaher et al., 1997）.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

B 参考文献与指南版本

这一页列出本资料库主要依据的指南、机构文件与量表原始文献，说明每条来源的用途、年份和证据分量，也说明版本记录和“怎么判断信息过时”。它写给想追根问底的患者和家属，也写给需要核对引用是否可靠的同道。读完之后，你应该能判断：**某一条说法是“指南明确推荐”，还是“临床常见做法”，还是“还在研究阶段”。**

这份清单怎么用

本资料库不是论文，不在每句话后面挂引用。做法是：**正文用方括号标签标出信息的分量，来源集中列在每篇末尾和这一页。** 所以你看到一条说法时，可以按三步核对：

1. 看标签：是【指南】【研究】【临床经验】【待验证】还是【个人体验】。
2. 回到这一页，找对应的来源，看它的年份和用途是否覆盖这条说法。
3. 如果标签和来源不匹配（比如标了【指南】却找不到对应指南），**按更低的分量看待它**，并向维护者反馈。

这样做的好处是正文可读，坏处是个别句子没有精确到页码。**对精确性要求高的场合（写论文、做患教材料、医疗决策），请直接查阅原始指南，不要以本资料库为最终依据。**

主要来源一览

来源	年份	主要用途	分量
NICE CG113《成人广泛性焦虑障碍与惊恐障碍：管理》	2011 发布，2020 更新	分级治疗路径、心理治疗与药物选择、苯二氮䓬定位	高（指南）
NICE CG159《社交焦虑障碍：识别、评估与治疗》	2013	社交焦虑的识别、CBT 与药物推荐	高（指南）
《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》	2023	中国人群的评估、治疗流程与用药习惯	高（指南）
NICE NG222《成人抑郁：治疗与管理》	2022	仅用于焦虑合并抑郁的部分	高（指南，适用范围有限）
WHO 焦虑障碍事实清单	持续更新	疾病负担、通用定义、公共健康视角	中高（机构文件）
NIMH 焦虑障碍专题页	持续更新	面向公众的症状与治疗概述	中（机构科普）
DSM-5-TR	2022	诊断标准与共病描述	高（诊断分类）
ICD-11 临床描述与诊断指南	2019 通过，2022 生效	另一套诊断分类，用于对照	高（诊断分类）
《中华人民共和国精神卫生法》	2012 通过，2013-05-01 施行	自愿住院、隐私保护、不得歧视等原则	高（法律）
国家卫生健康委 12356 心理援助热线	2025 起全国推行	危机时的心理支持与转介	中（公共服务）
量表原始文献（GAD-7、PDSS、LSAS、SPIN、SCARED）	1987 – 2006	量表条目、计分与临界值的出处	中高（工具文献）

逐条说明

NICE CG113。 这是本资料库在“成人广泛性焦虑与惊恐障碍”上最主要的指南依据。它按病情严重程度给出分层路径：轻度优先心理治疗（尤其是 CBT）、中重度考虑药物与心理治疗联合、苯二氮䓬类只建议短期使用，对抗精神病药用于焦虑也持保留态度，不列为常规一线。【指南】

NICE CG159。 社交焦虑障碍的专门指南，核心推荐是结构化的 CBT（含暴露与注意力训练），药物方面推荐 SSRI（尤其是舍曲林、艾司西酞普兰一类），并建议不要用苯二氮䓬类长期治疗社交焦虑。【指南】

《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》（2023）。 国内临床实践最主要的参考，覆盖评估、药物治疗、心理治疗、特殊人群和长期管理，用药习惯与国内可及性比 NICE 更贴近实际。引用时注意：**指南版本会影响推荐，第二版与第一版之间已有变化，不要混用。** 具体分级方法见该书方法学章节。

NICE NG222。 本资料库只在“焦虑合并抑郁”的语境下引用它，因为抑郁与焦虑常同时出现，治疗顺序和药物选择会互相影响。**它不是焦虑障碍指南，不能拿它替代 CG113。**

WHO 与 NIMH。 两者都是面向公众的机构材料，适合用来说明“焦虑障碍常见、可治疗”这类总体判断，**不适合用来支撑具体用药方案**。它们的页面会随网站改版更新，引用时应记录访问日期。

DSM-5-TR 与 ICD-11。 两套国际诊断分类，条目和阈值不完全一致。DSM-5-TR 是 2022 年的文本修订版，ICD-11 在 2019 年世界卫生大会通过、2022 年生效。**本资料库的描述以临床常见表述为主，不逐条复述诊断标准**；需要精确对照时请查原书。

《中华人民共和国精神卫生法》。 只用于说明原则：住院治疗以自愿为原则、隐私与人格尊严受保护、不得歧视、心理咨询人员不得从事精神障碍的诊断和治疗。**本资料库不提供法律意见**，条文会修订，具体问题以现行法律文本和当地主管部门答复为准。

12356。 国家卫生健康委统一部署的心理援助热线，2025 年起在全国推行。它能提供心理支持、危机干预和转介，**但不是急救系统**，不能派车、不能保证定位。地方还有各自的热线，**号码与服务时间以当地卫健委公布为准**。

量表原始文献。 GAD-7（Spitzer 等，2006）、PDSS（Shear 等，1997）、LSAS（Liebowitz，1987）、SPIN（Connor 等，2000）、SCARED（Birmaher 等，1997）。本资料库只引用量表名称与作者年份，不复刻完整条目，**也不建议读者自行用这些量表下诊断**。

证据等级怎么读

“证据等级”不是一个统一的标尺，不同机构的分法不一样。读的时候抓住两件事：**证据质量**（这个结论有多可靠）和**推荐强度**（值不值得照着做）。

层级	大致含义	在本资料库中的标签
指南推荐	系统检索证据后形成的规范建议，通常	【指南】

层级	大致含义	在本资料库中的标签
	标注推荐强度	
系统综述与 Meta 分析	把多个研究合起来算，结论比单项研究稳	【研究】
随机对照试验	能说明“因果”，但受人群、疗程、实施质量限制	【研究】
观察性研究	能说明“相关”，不能直接说明“因果”	【研究】或【待验证】
专家意见与临床常规	有经验基础，缺少高质量对照研究	【临床经验】
机制推测与小样本研究	提示方向，尚不足以指导决策	【待验证】

几点提醒：

- **指南之间会不一致。** NICE 更强调成本效果和分级路径，国内指南更贴近本地用药习惯与可及性。不一致时，不要把两边的话混着用。
- **“有研究支持”不等于“指南推荐”。** 很多干预有小型试验支持，但还没进入指南，这类信息只适合作为和医生讨论的素材。
- **推荐强度弱，不等于没道理。** 它往往意味着“证据还不够硬，或者要看个体情况”。
- **GRADE 只是方法之一。** NICE 在方法学上借鉴 GRADE 思路，区分证据质量与推荐强度；国内指南多采用自己的分级体系。**具体分级以各指南的方法学章节为准，本页只做通俗说明，不复述具体分级表。**

版本记录

版本	日期	内容
V1.0	2026-10	建立 13 个模块、64 篇正文；统一体例、证据标签与安全声明；附录收录 60 条术语与来源清单

维护约定：

- 建议每 **12 个月**复核一次，重点看 NICE CG113、CG159、中国焦虑障碍防治指南和药品说明书的更新。
- 发现错误时，先在对应篇目顶部标注“待核”，再集中修订，**不要把未核实的改动直接扩散到多个文件**。
- 每次修订在版本记录里加一行，写清改了什么、依据是什么。

怎么判断信息过时

网上关于焦虑的内容，最大的问题不是错，而是“曾经对”。用下面这份清单快速判断：

- ☐ **看年份。** 超过 5 年的治疗推荐要谨慎；药物适应证和安全信息以最新说明书为准。
- ☐ **看它有没有说来源。** 只写“国外最新研究”而不给期刊、作者、年份的，基本无法核对。

- ☐ **看它有没有把话说死。** “根治”“永不复发”“保证有效”“三天见效”——出现这类词，直接降低可信度。
- ☐ **看它是否在卖东西。** 带课程、保健品、仪器购买链接的“科普”，结论往往服务于销售。
- ☐ **看它是否忽略禁忌。** 不谈孕妇、老人、肝肾功能、合并用药的内容，通常不完整。
- ☐ **看指南是否已更新。** 旧版指南的推荐可能已被推翻，比如某些药的一线地位变化、某些联合用药的风险提示。
- ☐ **看诊断分类是否过时。** ICD-10 与 ICD-11、DSM-IV 与 DSM-5-TR 之间，诊断名称和阈值都有变化。
- ☐ **热线与政策类信息要现查。** 号码、医保政策、报销流程都可能调整，**以当地卫健委、医保局最新公布为准**。

本资料库刻意不写的内容

为了守住安全边界，以下内容本资料库一律不写：

- **具体剂量方案**：起始剂量、加量速度、减量速度、血药浓度目标。这些必须由医生结合诊断、年龄、体重、肝肾功能、合并用药和既往反应决定。
- **“某药最好”式的推荐**：只比较类别特点，并注明“个体差异大，以处方为准”。
- **自行停药、换药、加量的方法**：包括“怎么自己减苯二氮䓬”这类看似贴心的内容。
- **用保健品、草本、仪器替代规范治疗的建议**。
- **具体报销比例、具体病假天数、具体法律结论**：这些属于地方政策和法律范畴，本资料库只讲原则和办理路径。
- **未经核实的统计数据**：宁可写“目前证据有限”“研究结果不一致”，也不编造数字。

免责声明

本资料库是科普材料，**不能替代精神科医生面诊、诊断与处方**。不可依据它判断病情、自行选药、增减或停用药物，也不可依据它处理法律、保险、劳动争议。

所引指南与机构文件的**中文表述为编写者的转述，不是原文翻译**；如与原文冲突，以原文为准。链接可能失效，**失效时请以机构官网的现行版本为准**，并在维护记录里标注“待核”。

如果本资料库的内容与你的面诊医生判断不一致，**以医生的个体化判断为准**，并把差异告诉医生——这往往是一次有价值的沟通。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> 核对资料后发现自己的治疗方案与指南差距较大，想调整用药——**先联系医生**，不要自行更改。
>
> 出现自杀念头、自伤行为、意识障碍、高热、抽搐、严重过敏、胸痛、晕厥——**立即拨打 120 或去急诊**，这类情况不需要先查资料。
>
> 情绪上撑不住又暂时约不到医生——可拨打 **12356** 心理援助热线；有立即危险时，120 优先。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113), 2011（2020 更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Social anxiety disorder: recognition, assessment and treatment (CG159), 2013. https://www.nice.org.uk/guidance/cg159
- 施慎逊，吴文源 主编.《中国焦虑障碍防治指南（第二版）》. 2023.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。